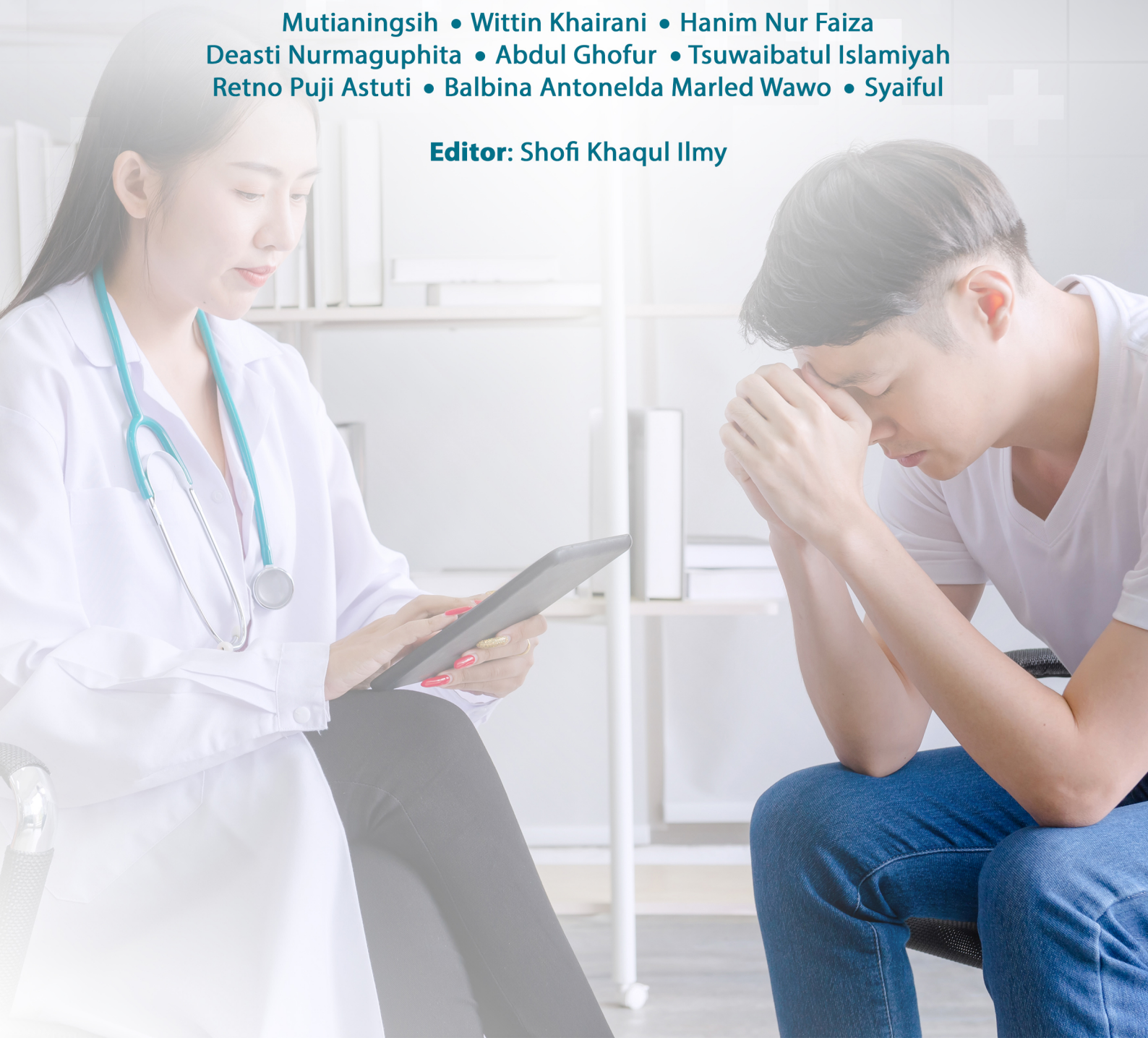


Buku Rampai

ASUHAN KEPERAWATAN JIWA KOMPREHENSIF PENDEKATAN BERBASIS EVIDENCE-BASED PRACTICE (EBP)

Mutianingsih • Wittin Khairani • Hanim Nur Faiza
Deasti Nurmaguphita • Abdul Ghofur • Tsuwaibatul Islamiyah
Retno Puji Astuti • Balbina Antonelda Marled Wawo • Syaiful

Editor: Shofi Khaqul Ilmy



BUNGA RAMPAI

ASUHAN KEPERAWATAN JIWA KOMPREHENSIF: PENDEKATAN BERBASIS EVIDENCE-BASED PRACTICE (EBP)

Penulis:

Ns. Mutianingsih, M.Kep.
Wittin Khairani SPd., MPH.
Hanim Nur Faiza, S.Kep., Ns., M.Kep.
Deasti Nurmaguphita, S.Kep.Ns., M.Kep., Sp.Kep.J.
Dr. Abdul Ghofur, SKp., M.Kes.
Tsuwaibatul Islamiyah, S.Kep., Ns., M.S.
Retno Puji Astuti, S. Kep., Ns., M.Kep.
Balbina Antonelda Marled Wawo, Ns., M.Kep., Sp.Kep.J
Syaiful, Skep., Ns., MPd., MKes.

Editor:

Ns. Shofi Khaqul Ilmy, S.Kep., M.Kep.



BUNGA RAMPAI ASUHAN KEPERAWATAN JIWA KOMPREHENSIF: PENDEKATAN BERBASIS EVIDENCE-BASED PRACTICE (EBP)

Penulis: Ns. Mutianingsih, M.Kep.

Wittin Khairani SPd., MPH.

Hanim Nur Faiza, S.Kep., Ns., M.Kep.

Deasti Nurmaguphita, S.Kep.Ns., M.Kep., Sp.Kep.J.

Dr. Abdul Ghofur, SKp., M.Kes.

Tsuwaibatul Islamiyah, S.Kep., Ns., M.S.

Retno Puji Astuti, S. Kep., Ns., M.Kep.

Balbina Antonelda Marled Wawo, Ns., M.Kep., Sp.Kep.J

Syaiful, Skep., Ns., MPd., MKes.

Editor: Ns. Shofi Khaqul Ilmy, S.Kep., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7294-81-4

Cetakan Pertama : Agustus, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Buku "Asuhan Keperawatan Jiwa Komprehensif: Pendekatan Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)" hadir sebagai referensi penting yang ditujukan untuk memperkuat pemahaman serta meningkatkan kompetensi profesional para perawat dalam bidang kesehatan mental. Buku ini secara khusus disusun untuk menyediakan panduan mendalam bagi perawat, mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi kesehatan, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan berbasis bukti ilmiah.

Mengadopsi pendekatan evidence-based practice, buku ini memadukan hasil-hasil penelitian terkini dengan pengalaman klinis nyata untuk menghasilkan rekomendasi dan pedoman yang jelas, terukur, serta dapat diterapkan dalam berbagai konteks pelayanan kesehatan jiwa. Setiap bab dalam buku ini memberikan penjelasan mendetail mulai dari tahap pengkajian yang menyeluruh, diagnosis keperawatan yang akurat, perencanaan intervensi yang efektif, implementasi praktik klinis, hingga evaluasi hasil intervensi yang telah dilakukan. Selain itu, buku ini memperkaya pembahasan dengan penyajian studi kasus nyata, ilustrasi praktis, serta berbagai strategi intervensi keperawatan yang telah terbukti efektif berdasarkan penelitian ilmiah.

Buku ini menggarisbawahi pentingnya peran perawat dalam menyediakan layanan dukungan emosional, psikososial, dan terapeutik yang tidak hanya efektif tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan individual dan keluarga pasien. Dalam buku ini, dibahas pula berbagai tantangan yang sering dihadapi dalam praktik klinis sehari-hari serta cara-cara mengatasi tantangan tersebut dengan pendekatan yang sistematis dan ilmiah. Dengan demikian, buku ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi klinis, tetapi juga memperkuat kemampuan para perawat dalam berkomunikasi secara empatik, membangun hubungan terapeutik yang kuat dengan pasien, serta bekerja sama secara interprofesional dalam tim pelayanan kesehatan jiwa.

Harapan utama dari hadirnya buku ini adalah terciptanya pelayanan keperawatan jiwa yang lebih aman, efektif, serta berorientasi pada hasil optimal bagi pasien dan keluarganya. Diharapkan pula bahwa buku ini mampu berkontribusi nyata dalam mendukung pengembangan praktik klinis yang berbasis bukti, meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan jiwa, serta mendorong peningkatan standar pelayanan

kesehatan mental di Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan utama yang mampu menginspirasi dan mendukung upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa yang optimal dan manusiawi.

Agustus, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
CHAPTER 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN JiWA	1
Ns. Mutianingsih, M.Kep.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Definisi dan Ruang Lingkup Keperawatan Jiwa	2
C. Sejarah Perkembangan Keperawatan Jiwa	4
D. Filosofi dan Nilai Dasar Keperawatan Jiwa.....	6
E. Teori-teori dalam Keperawatan Jiwa	9
F. Peran dan Fungsi Perawat Jiwa.....	11
G. Standar Asuhan Keperawatan Jiwa	13
H. Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan Jiwa	16
I. Aspek Legal dan Etik dalam Keperawatan Jiwa	18
J. Simpulan	21
K. Referensi	22
L. Glosarium	23
CHAPTER 2 KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM KEPERAWATAN JiWA	25
Wittin Khairani, S.Pd., MPH.....	25
A. Pendahuluan/Prolog	25
B. Prinsip Dasar Komunikasi Terapeutik.....	27
C. Hambatan dalam Komunikasi Terapeutik dan cara mengatasi.....	34
D. Simpulan	43
E. Referensi	44
F. Glosarium	45
CHAPTER 3 PENGKAJIAN KEPERAWATAN JiWA SECARA KOMPREHENSIF	49
Hanim Nur Faiza, S.Kep., Ns., M.Kep.	49
A. Pendahuluan/Prolog	49
B. Prinsip Dasar Pengkajian Keperawatan Jiwa	50
C. Komponen Pengkajian Keperawatan Jiwa	52
D. Teknik dan Alat dalam Pengkajian Jiwa	54
E. Pendokumentasian Data Pengkajian.....	56
F. Tantangan dan Etika dalam Pengkajian Jiwa	58
G. Simpulan	59

H. Referensi	60
I. Glosarium	61

CHAPTER 4 ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN PSIKOTIK 65

Deasti Nurmaguphita, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J..... 65

A. Pendahuluan/Prolog	65
B. Konsep Dasar Gangguan Psikotik.....	66
C. Etiologi dan Faktor Risiko	69
D. Manifestasi Klinis Gangguan Psikotik	69
E. Proses Keperawatan pada Pasien Gangguan Psikotik.....	70
F. Pengkajian Keperawatan	71
G. Diagnosa Keperawatan	72
H. Perencanaan Keperawatan	73
I. Implementasi Keperawatan.....	73
J. Evaluasi Keperawatan	74
K. Simpulan	74
L. Referensi	75
M. Glosarium	76

CHAPTER 5 ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN MOOD (DEPRESI DAN GANGGUAN BIPOLAR) BERBASIS EVIDANCE BASE 79

Dr. Abdul Ghofur, SKp., M.Kes. 79

A. Pendahuluan/Prolog	79
B. Konsep Gangguan Mood.....	80
C. Penyebab Gangguan Mood.....	80
D. Dukungan Keluarga pada Pasien Gangguan Mood.....	81
E. Pengkajian Pasien Ganggun Mood.....	84
Fase Mood.....	85
Fokus Pengkajian.....	85
Depresi.....	85
Afek datar, tidur berlebih, kurang energi, rasa bersalah	85
Mania.....	85
Euforia, bicara cepat, grandiositas, hiperaktivitas	85
Campuran	85
Cepat berubah, bingung, risiko tinggi bunuh diri.....	85
F. Intervensi Keperawatan berbasis Evidance Base	85
G. Discharge Planning Utama untuk Pasien Gangguan Mood	90
H. Pencegahan Kekambuhan Pasien Gangguan Mood	92
I. Simpulan	95
J. Referensi	96

K. Glosarium	103
--------------------	-----

CHAPTER 6 ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN KECEMASAN.....107

Tsuwaibatul Islamiyah, S.Kep., Ns., M.S.107

A. Pendahuluan/Prolog	107
B. Konsep Dasar Gangguan Kecemasan	108
C. Pengkajian Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Kecemasan	111
D. Diagnosis Keperawatan yang Lazim pada Pasien dengan Gangguan Kecemasan	113
E. Perencanaan Keperawatan	115
F. Implementasi Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Kecemasan	117
G. Evaluasi Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Kecemasan.....	119
H. Pencegahan dan Promosi Kesehatan Mental pada Pasien Gangguan Kecemasan	121
I. Simpulan	123
J. Referensi	125
K. Glosarium	126

CHAPTER 7 PENANGANAN KRISIS DAN INTERVENSI KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN PERILAKU BUNUH DIRI.....129

Retno Puji Astuti, S.Kep., Ns., M.Kep.129

A. Pendahuluan/Prolog	129
B. Konsep Dasar Perilaku Bunuh Diri.....	131
C. Identifikasi Tanda-tanda dan Gejala Krisis Bunuh Diri	133
D. Manajemen Krisis Bunuh Diri dalam Praktik Keperawatan	136
E. Intervensi Keperawatan Komprehensif pada Pasien dengan Perilaku Bunuh Diri.....	138
F. Evaluasi Efektivitas Intervensi Keperawatan pada Pasien dengan Perilaku Bunuh Diri	141
G. Pencegahan Kekambuhan dan Perencanaan Pemulangan (Discharge Planning).....	143
H. Tantangan dalam Penanganan Krisis Bunuh Diri dan Solusi Praktis	145
I. Simpulan	147
J. Referensi	149
K. Glosarium	150

CHAPTER 8 TERAPI MODALITAS DALAM KEPERAWATAN JIWA155

Ns Balbina Antonelda Marled Wawo, M.Kep., Sp.Kep.J.....155

A. Pendahuluan/Prolog	155
B. Konsep Terapi Modalitas.....	157

C. Terapi Aktivitas Kelompok.....	166
D. Terapi Kognitif-Perilaku Sederhana dalam Praktik Keperawatan Jiwa	170
E. Evaluasi hasil Terapi Modalitas Berbasis Evidence-based practice (EBP)	171
F. Kesimpulan.....	172
G. Referensi	172
H. Glosarium	174
CHAPTER 9 KEPERAWATAN JIWA BERBASIS KOMUNITAS.....	179
Syaiful, Skep., Ns., MPd., MKes.	179
A. Pendahuluan/Prolog	179
B. Konsep Dasar Keperawatan Komunitas	180
C. Strategi Pengkajian Gangguan Jiwa di Tingkat Komunitas.....	181
D. Intervensi Keperawatan Komunitas yang Efektif untuk Pasien Gangguan Jiwa	183
E. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesehatan Jiwa dan Strategi Mengatasi dalam.....	184
F. Peran Kader dan Keluarga dalam Mendukung Keperawatan Jiwa Berbasis Komunitas	185
G. Simpulan	186
H. Referensi	187
I. Glosarium	189
PROFIL PENULIS	191

CHAPTER 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN JIWA

Ns. Mutianingsih, M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan jiwa merupakan aspek integral dari kesehatan secara keseluruhan yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, berperilaku, serta kemampuan untuk menghadapi stres, menjalin hubungan sosial, dan mengambil keputusan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kesehatan jiwa tidak dapat dipisahkan dari kesehatan fisik, karena keduanya saling memengaruhi secara timbal balik. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa, baik ringan maupun berat, tidak hanya menghadapi penderitaan psikologis, tetapi juga berisiko tinggi mengalami gangguan fisik akibat gaya hidup yang buruk, pengobatan jangka panjang, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan umum. Oleh karena itu, upaya menjaga dan memulihkan kesehatan jiwa menjadi sangat penting dalam sistem kesehatan masyarakat.

Urgensi penanganan kesehatan jiwa semakin meningkat seiring dengan beban global penyakit jiwa yang terus bertambah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa depresi telah menjadi salah satu penyebab utama kecacatan di seluruh dunia, sementara bunuh diri menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian terbesar pada kelompok usia 15–29 tahun. Di Indonesia, data Riskesdas menunjukkan peningkatan prevalensi gangguan mental emosional, terutama pada populasi usia produktif. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam bidang ini, termasuk rendahnya literasi masyarakat tentang kesehatan jiwa, tingginya stigma terhadap penderita gangguan jiwa, serta keterbatasan jumlah tenaga kesehatan jiwa profesional, termasuk perawat jiwa.

Dalam konteks ini, perawat memiliki peran strategis dan esensial dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa yang komprehensif dan berkelanjutan. Perawat jiwa tidak hanya bertugas merawat pasien dengan gangguan jiwa di rumah sakit atau institusi psikiatri, tetapi juga berperan penting dalam pencegahan, promosi kesehatan jiwa, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu mengenali dan menangani masalah kejiwaan secara dini. Keperawatan jiwa menuntut keterampilan profesional dalam membangun hubungan terapeutik, menerapkan komunikasi efektif,

serta memberikan intervensi psikososial dan medis yang sesuai dengan kebutuhan individu.

Pelayanan keperawatan jiwa dapat diberikan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, baik pada tingkat primer, sekunder, maupun tersier. Di puskesmas dan layanan primer lainnya, perawat jiwa berperan dalam deteksi dini gangguan jiwa, konseling dasar, serta rujukan yang tepat. Di rumah sakit jiwa atau bangsal psikiatri rumah sakit umum, perawat memberikan asuhan secara intensif dengan pendekatan holistik, melibatkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Selain itu, dalam komunitas, perawat jiwa juga terlibat dalam program home care, kunjungan rumah, serta pendampingan pasien dan keluarga dalam proses reintegrasi sosial.

Dengan semakin kompleksnya tantangan dalam pelayanan kesehatan jiwa, maka pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar keperawatan jiwa menjadi landasan penting bagi tenaga keperawatan. Hal ini bukan hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga untuk membangun pendekatan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berbasis bukti dalam mendukung kesembuhan dan keberfungsian sosial klien dengan gangguan jiwa. Pendahuluan ini menjadi dasar untuk memahami berbagai aspek konseptual, etik, dan profesional dalam praktik keperawatan jiwa, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

B. Definisi dan Ruang Lingkup Keperawatan Jiwa

1. Pengertian keperawatan jiwa

Keperawatan jiwa adalah cabang dari ilmu keperawatan yang berfokus pada pemberian asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok yang mengalami gangguan kesehatan jiwa atau berada dalam kondisi rentan terhadap masalah psikososial. Keperawatan jiwa tidak hanya mencakup tindakan fisik, tetapi juga menitikberatkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kondisi psikologis, perilaku, dan hubungan interpersonal seseorang dalam konteks lingkungan sosial dan budaya yang memengaruhi. Tujuan utama dari keperawatan jiwa adalah membantu individu mencapai tingkat keseimbangan mental dan emosional yang optimal, meningkatkan kemampuan koping dalam menghadapi stres, serta memfasilitasi proses pemulihan dan keberfungsian sosial.

Konsep keperawatan jiwa mencakup pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual, artinya dalam memberikan asuhan, perawat harus mempertimbangkan aspek biologis seperti kondisi medis atau pengaruh obat, aspek psikologis seperti perasaan dan pikiran pasien, aspek sosial seperti dukungan keluarga atau

lingkungan tempat tinggal, serta aspek spiritual yang mencerminkan nilai, keyakinan, dan makna hidup pasien. Oleh karena itu, keperawatan jiwa memerlukan pemahaman yang komprehensif serta keterampilan interpersonal yang tinggi untuk membina hubungan terapeutik yang efektif.

2. Perbedaan keperawatan jiwa dan keperawatan umum

Meskipun keperawatan jiwa merupakan bagian dari profesi keperawatan secara keseluruhan, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan, fokus, dan metode intervensinya dibandingkan dengan keperawatan umum. Pada keperawatan umum, fokus utama sering kali berada pada diagnosis dan penanganan gangguan fisik, seperti luka, infeksi, atau penyakit sistemik lainnya, yang ditangani dengan intervensi medis langsung seperti pemberian obat, tindakan keperawatan, dan pemantauan kondisi fisiologis pasien.

Sebaliknya, keperawatan jiwa lebih menitikberatkan pada aspek non-fisik, seperti gangguan persepsi, pikiran, emosi, perilaku, dan relasi interpersonal. Perawat jiwa harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda gangguan mental, seperti delusi, halusinasi, depresi, kecemasan, atau gangguan kepribadian, serta mampu memberikan intervensi psikososial seperti terapi aktivitas kelompok, terapi kognitif-perilaku, terapi seni, atau teknik relaksasi dan konseling dasar. Komunikasi terapeutik menjadi instrumen utama dalam keperawatan jiwa, dan dibutuhkan pendekatan yang empatik, sabar, serta tidak menghakimi agar pasien merasa aman dan dimengerti.

Perbedaan lainnya terletak pada tujuan jangka panjang. Keperawatan umum cenderung fokus pada penyembuhan penyakit atau pemulihan kondisi fisik, sementara keperawatan jiwa bertujuan untuk memulihkan kualitas hidup, memperkuat mekanisme koping, dan mendukung reintegrasi sosial pasien. Selain itu, dalam keperawatan jiwa, intervensi tidak selalu dapat diukur secara langsung melalui parameter fisik, melainkan melalui perubahan perilaku, perbaikan hubungan sosial, dan stabilitas emosi pasien.

3. Ruang lingkup praktik keperawatan jiwa

Ruang lingkup praktik keperawatan jiwa sangat luas dan tidak terbatas hanya pada pelayanan rumah sakit jiwa. Praktik keperawatan jiwa dapat dilakukan di berbagai tatanan pelayanan, seperti rumah sakit umum, puskesmas, klinik kesehatan jiwa, komunitas, panti rehabilitasi, hingga lingkungan rumah pasien. Intervensi yang dilakukan pun bervariasi, mulai dari deteksi dini gangguan mental, pendampingan

pasien, edukasi keluarga, hingga pelaksanaan program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.

Di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, perawat jiwa berperan penting dalam promosi kesehatan jiwa, skrining gangguan mental, dan rujukan yang tepat. Di rumah sakit, perawat jiwa terlibat dalam observasi intensif, manajemen krisis, serta kolaborasi dengan tim multidisiplin untuk perencanaan dan evaluasi terapi. Sementara itu, dalam pelayanan berbasis komunitas, perawat memberikan pendampingan pada pasien rawat jalan, melaksanakan kunjungan rumah, serta menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesembuhan pasien.

Perawat jiwa juga memiliki peran dalam advokasi hak-hak pasien, terutama dalam melawan stigma dan diskriminasi yang sering dialami oleh penderita gangguan jiwa. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa pasien mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan mental yang layak. Di sisi lain, perawat juga perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap kebebasan individu pasien, terutama dalam situasi pasien yang mengalami gangguan jiwa berat dan berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

C. Sejarah Perkembangan Keperawatan Jiwa

1. Evolusi pelayanan jiwa dari masa ke masa

Perjalanan sejarah pelayanan keperawatan jiwa mencerminkan perubahan pandangan masyarakat terhadap gangguan jiwa dan orang-orang yang mengalaminya. Pada masa kuno, gangguan jiwa sering dianggap sebagai kutukan, dosa, atau akibat kerasukan roh jahat. Karena itu, penanganannya pun bersifat mistis dan tidak manusiawi, seperti eksorsisme, pengurungan, atau bahkan penyiksaan. Di masa Yunani Kuno, meskipun filsuf seperti Hippocrates mulai memperkenalkan konsep bahwa penyakit jiwa berasal dari ketidakseimbangan cairan tubuh (humor), pendekatan medis ini belum meluas karena masih kuatnya kepercayaan terhadap takhayul dan stigma.

Memasuki abad pertengahan di Eropa, kondisi penderita gangguan jiwa semakin memprihatinkan. Mereka sering dikurung di rumah sakit jiwa yang menyerupai penjara, seperti Bedlam di Inggris. Perlakuan terhadap pasien sangat tidak manusiawi, bahkan mereka dijadikan tontonan publik. Baru pada abad ke-18 dan ke-19, terjadi pergeseran besar dalam pendekatan terhadap gangguan jiwa,

ditandai dengan munculnya gerakan moral treatment. Tokoh seperti Philippe Pinel di Prancis dan William Tuke di Inggris menjadi pelopor reformasi pelayanan jiwa. Mereka menekankan pentingnya perlakuan yang lebih manusiawi, lingkungan yang mendukung, serta aktivitas sosial dan pekerjaan ringan sebagai bagian dari terapi.

Pada abad ke-20, dengan berkembangnya ilmu psikologi, psikiatri, dan keperawatan, pelayanan kesehatan jiwa semakin mengalami kemajuan. Terapi modern seperti psikoanalisis, terapi elektrokonvulsif, dan pengembangan obat-obatan psikotropika mulai digunakan. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas menggantikan model institusionalisasi, dengan tujuan mendekatkan layanan kepada pasien dan mengurangi stigma sosial. Evolusi ini juga berdampak pada berkembangnya peran perawat jiwa sebagai tenaga kesehatan profesional yang berperan penting dalam manajemen gangguan jiwa.

2. Perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia dan dunia

Di tingkat global, keperawatan jiwa berkembang seiring dengan profesionalisasi keperawatan secara umum. Pada awal abad ke-20, perawat jiwa lebih banyak berfungsi sebagai pelayan rumah sakit jiwa yang bertugas menjaga keamanan pasien. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan yang berfokus pada penyembuhan dan pemulihan, perawat mulai dilibatkan secara aktif dalam proses terapi, pengkajian psikososial, serta pelaksanaan intervensi keperawatan berbasis teori dan bukti ilmiah. Pendidikan keperawatan jiwa pun mulai diperkenalkan secara formal di berbagai negara.

Di Indonesia, perkembangan keperawatan jiwa mengalami dinamika tersendiri. Rumah sakit jiwa pertama yang didirikan adalah Rumah Sakit Jiwa Bogor (dulu dikenal sebagai Krankzinnigen Gesticht), yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1882. Pada masa awal kemerdekaan, perhatian terhadap gangguan jiwa masih minim, namun pada era reformasi, isu kesehatan jiwa mulai mendapatkan tempat dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Pendidikan perawat jiwa di Indonesia semula tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari kurikulum keperawatan umum. Baru kemudian berkembang menjadi spesialisasi tersendiri melalui program pendidikan lanjutan, seperti pendidikan profesi Ners dan magister keperawatan jiwa. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap kesehatan jiwa meningkat, ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014, yang mengakui hak pasien jiwa, mengatur standar pelayanan jiwa, serta mendorong keterlibatan perawat jiwa dalam sistem kesehatan nasional.

3. Tokoh-tokoh penting dalam keperawatan jiwa

Perkembangan keperawatan jiwa tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam membentuk praktik keperawatan jiwa modern. Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Hildegard E. Peplau, seorang perawat jiwa asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai “mother of psychiatric nursing”. Peplau mengembangkan teori hubungan interpersonal dalam keperawatan, yang menekankan pentingnya relasi terapeutik antara perawat dan klien sebagai dasar intervensi keperawatan jiwa. Teori ini mengubah cara pandang terhadap peran perawat dari sekadar pelaksana tindakan medis menjadi agen perubahan psikologis.

Tokoh penting lainnya adalah Dorothea Dix, aktivis sosial Amerika pada abad ke-19 yang gigih memperjuangkan perlakuan manusiawi bagi penderita gangguan jiwa. Melalui kampanyenya, Dix berhasil mendorong pendirian lebih dari 30 rumah sakit jiwa di Amerika Serikat dan memperjuangkan perlindungan hukum bagi pasien. Selain itu, Linda Richards, perawat pertama di Amerika, juga memiliki kontribusi besar dalam membentuk pendidikan perawat jiwa formal dan mempromosikan standar praktik keperawatan di rumah sakit jiwa.

Di Indonesia, meskipun belum banyak tokoh keperawatan jiwa yang dikenal secara luas, beberapa akademisi dan praktisi keperawatan telah memberikan sumbangsih besar dalam pengembangan pendidikan dan praktik keperawatan jiwa. Mereka turut serta dalam penyusunan kurikulum pendidikan keperawatan jiwa, pelatihan tenaga kesehatan mental di daerah, serta pengembangan intervensi berbasis budaya yang sesuai dengan konteks lokal.

Melalui kontribusi para tokoh tersebut, keperawatan jiwa telah bertransformasi menjadi bidang keperawatan yang ilmiah, manusiawi, dan profesional. Sejarah panjang ini menjadi landasan penting untuk memahami konteks praktik keperawatan jiwa saat ini dan untuk terus mendorong peran perawat jiwa dalam meningkatkan kesehatan mental masyarakat secara luas.

D. Filosofi dan Nilai Dasar Keperawatan Jiwa

Keperawatan jiwa sebagai salah satu cabang keperawatan profesional tidak hanya berdiri di atas dasar ilmiah dan teknis, tetapi juga berakar kuat pada filosofi kemanusiaan dan nilai-nilai etis yang luhur. Pelayanan keperawatan jiwa menuntut sensitivitas tinggi terhadap kondisi psikologis dan emosional klien, yang sering kali mengalami kerentanan dan kehilangan kendali terhadap dirinya sendiri. Oleh karena

itu, perawat jiwa tidak hanya dituntut memiliki kompetensi klinis, tetapi juga kemampuan untuk menanamkan nilai-nilai moral, penghormatan terhadap martabat manusia, serta empati dalam setiap tindakan keperawatan.

1. Prinsip humanistik dalam keperawatan jiwa

Prinsip humanistik merupakan fondasi utama dalam praktik keperawatan jiwa. Pendekatan humanistik menekankan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, tetap memiliki nilai, potensi, dan kapasitas untuk berkembang. Dalam perspektif ini, klien tidak dilihat sebagai “penyakit” atau “masalah”, melainkan sebagai manusia utuh dengan kebutuhan, harapan, dan pengalaman hidup yang kompleks. Perawat jiwa bertugas untuk membangun hubungan yang didasari oleh kepercayaan, empati, dan penghargaan terhadap identitas serta preferensi klien.

Pendekatan humanistik juga mengedepankan aspek subjektif dari pengalaman klien, termasuk perasaan, keyakinan, dan makna yang mereka berikan terhadap situasi yang dialaminya. Tugas perawat adalah membantu klien menemukan kembali rasa kendali terhadap dirinya sendiri, memberdayakan mereka untuk mengambil keputusan, serta memfasilitasi proses penyembuhan yang bermakna secara pribadi. Dalam praktiknya, prinsip humanistik tampak dalam cara perawat mendengarkan tanpa menghakimi, menyapa klien dengan nama, menyesuaikan intervensi berdasarkan latar belakang budaya dan nilai klien, serta menekankan partisipasi aktif klien dalam proses keperawatan.

2. Etika dan moralitas dalam praktik keperawatan jiwa

Etika dan moralitas memainkan peran sentral dalam keperawatan jiwa karena sifat pelayanan yang sangat personal dan sering kali menyentuh aspek-aspek sensitif dari kehidupan individu. Perawat jiwa harus menjalankan praktiknya berdasarkan prinsip etika keperawatan yang mencakup beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak membahayakan), autonomy (menghormati hak klien untuk membuat keputusan), justice (keadilan), dan fidelity (kesetiaan terhadap tanggung jawab profesional).

Dalam konteks keperawatan jiwa, dilema etis sering muncul ketika perawat harus membuat keputusan antara menghormati kebebasan klien dengan tanggung jawab untuk melindungi klien atau orang lain dari bahaya. Misalnya, dalam situasi di mana klien memiliki ide bunuh diri, perawat mungkin perlu melakukan tindakan pencegahan walaupun itu membatasi kebebasan klien. Hal ini menuntut perawat untuk memiliki kemampuan pertimbangan moral yang matang, kepekaan etis, serta

kemampuan untuk berdiskusi secara profesional dengan tim multidisiplin dan keluarga.

Perawat jiwa juga dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, membangun hubungan yang etis tanpa penyalahgunaan kekuasaan, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan. Kesadaran etis ini menjadi penting dalam menciptakan hubungan terapeutik yang aman dan efektif, serta dalam membangun kepercayaan klien terhadap pelayanan yang diterimanya.

3. Hak asasi dan martabat klien dengan gangguan jiwa

Salah satu nilai utama dalam keperawatan jiwa adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi serta martabat setiap klien, tanpa memandang diagnosis atau status sosialnya. Orang dengan gangguan jiwa sering kali menghadapi stigma, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, perawat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjadi advokat bagi klien, memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil, bermartabat, dan mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia.

Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mendapat informasi yang jelas mengenai kondisinya, hak untuk menyetujui atau menolak pengobatan, hak atas privasi dan kerahasiaan, hak atas layanan kesehatan yang layak, serta hak untuk hidup bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Perawat juga perlu memastikan bahwa intervensi keperawatan dilakukan secara sukarela, kecuali dalam kondisi tertentu yang memerlukan perawatan paksa dengan alasan keselamatan jiwa.

Menjaga martabat klien berarti menghormati mereka sebagai individu yang tetap memiliki nilai dan harga diri, bahkan dalam kondisi yang paling rentan sekalipun. Perawat harus menghindari penggunaan label negatif, tidak meremehkan pengalaman klien, serta melibatkan klien dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Sikap ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik keperawatan, tetapi juga berkontribusi dalam proses pemulihan klien melalui peningkatan rasa percaya diri, penguatan identitas diri, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan sosialnya.

Dengan mengintegrasikan prinsip humanistik, etika profesional, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keperawatan jiwa dapat memberikan pelayanan yang tidak hanya efektif secara klinis tetapi juga bermakna secara sosial dan moral. Nilai-nilai dasar ini merupakan pedoman utama dalam menciptakan praktik

keperawatan jiwa yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang bagi setiap individu yang mengalami gangguan jiwa.

E. Teori-teori dalam Keperawatan Jiwa

Teori keperawatan jiwa memberikan kerangka kerja konseptual yang penting dalam memahami perilaku manusia, membangun hubungan terapeutik, serta merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Teori-teori ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga berperan sebagai panduan praktis dalam memberikan asuhan keperawatan yang berbasis ilmiah, sistematis, dan efektif. Dalam konteks keperawatan jiwa, beberapa teori menonjol dan banyak digunakan karena relevansinya terhadap kondisi psikologis klien, seperti teori interpersonal dari Hildegard Peplau, teori keperawatan sistem, dan teori kognitif-perilaku.

1. Teori interpersonal (Hildegard Peplau)

Hildegard Peplau adalah tokoh pelopor dalam keperawatan jiwa yang mengembangkan Interpersonal Relations Theory, yang berfokus pada pentingnya hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Teori ini berlandaskan pandangan bahwa hubungan interpersonal yang dibangun dengan penuh empati, kepercayaan, dan komunikasi yang efektif dapat menjadi alat utama dalam proses penyembuhan pasien dengan gangguan jiwa.

Menurut Peplau, hubungan terapeutik terdiri atas empat fase, yaitu:

- a. Fase Orientasi, ketika perawat dan klien pertama kali bertemu, dan terjadi identifikasi masalah serta pembentukan rasa saling percaya.
- b. Fase Identifikasi, di mana klien mulai merasa nyaman dan mempercayai perawat sebagai seseorang yang memahami dan bersedia membantu.
- c. Fase Eksploitasi, saat klien memanfaatkan sumber daya yang ada dan mulai menunjukkan perubahan positif dalam pemikiran atau perilaku.
- d. Fase Resolusi, yaitu tahap akhir ketika masalah mulai teratasi dan hubungan perawat-klien secara perlahan diakhiri.

Teori ini menempatkan perawat bukan sekadar sebagai pelaksana instruksi, tetapi sebagai mitra aktif yang memfasilitasi pertumbuhan psikologis klien. Peplau menekankan bahwa perawat harus mengenali peran-peran yang dimainkan dalam hubungan tersebut, seperti sebagai konselor, guru, pengganti figur orang tua, atau sumber informasi.

2. Teori keperawatan sistem

Teori keperawatan sistem merupakan pendekatan yang melihat individu sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, baik itu sistem biologis, psikologis, sosial, maupun lingkungan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam pendekatan ini adalah Betty Neuman dengan Neuman Systems Model. Dalam model ini, manusia dipandang sebagai sistem terbuka yang terus-menerus menerima input dan berinteraksi dengan lingkungan.

Fokus utama teori ini adalah pada respons stres klien terhadap stresor internal dan eksternal, serta bagaimana perawat dapat memperkuat pertahanan klien melalui upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks keperawatan jiwa, teori ini sangat berguna untuk memahami bagaimana gangguan psikologis dapat terjadi sebagai respons terhadap tekanan hidup, trauma, atau gangguan fisiologis, serta bagaimana perawat dapat membantu klien memulihkan stabilitas dengan memperkuat ketahanan psikologis dan sosialnya.

Pendekatan sistem ini juga mendorong perawat untuk melihat klien secara holistik, serta melibatkan keluarga dan lingkungan sosial sebagai bagian penting dalam proses penyembuhan jiwa.

3. Teori kognitif-perilaku

Teori kognitif-perilaku (Cognitive Behavioral Theory/CBT) berasal dari psikologi klinis dan telah banyak diadaptasi dalam keperawatan jiwa sebagai pendekatan intervensi yang efektif. Teori ini menyatakan bahwa emosi dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh pikiran atau persepsi yang dimilikinya terhadap suatu situasi. Gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, atau fobia, sering kali muncul akibat pola pikir yang negatif atau irasional.

Dalam praktik keperawatan jiwa, pendekatan kognitif-perilaku digunakan untuk membantu klien mengenali dan mengganti pola pikir yang maladaptif dengan pikiran yang lebih realistis dan positif. Intervensi ini dilakukan melalui konseling, diskusi terstruktur, latihan perilaku, dan penguatan keterampilan koping. Perawat berperan sebagai fasilitator perubahan kognitif dan pendamping dalam proses klien mengembangkan kontrol terhadap respon emosional dan perilakunya.

Teori ini sangat bermanfaat dalam keperawatan jiwa modern karena bersifat praktis, terukur, dan dapat digunakan dalam berbagai setting, baik rawat inap, rawat jalan, maupun komunitas.

4. Penerapan teori dalam praktik keperawatan jiwa

Penerapan teori dalam praktik keperawatan jiwa menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak bersifat intuisi semata, tetapi didasarkan pada dasar ilmiah dan hasil penelitian. Dalam praktik klinis, perawat dapat menggabungkan beberapa teori sekaligus, tergantung pada kondisi klien, tujuan asuhan, serta setting pelayanan.

Sebagai contoh, pada klien dengan gangguan cemas berat, perawat dapat menggunakan teori Peplau untuk membangun hubungan terapeutik, teori sistem untuk mengidentifikasi faktor-faktor stresor dari lingkungan, dan pendekatan kognitif-perilaku untuk membantu klien mengelola pikirannya. Dalam situasi lain, pada pasien skizofrenia yang mengalami halusinasi, perawat dapat menggunakan prinsip hubungan interpersonal untuk membina kepercayaan, serta menerapkan strategi CBT untuk membedakan kenyataan dan ilusi secara bertahap.

F. Peran dan Fungsi Perawat Jiwa

Perawat jiwa memegang peranan penting dalam sistem pelayanan kesehatan mental karena menjadi garda terdepan dalam pemberian asuhan yang komprehensif kepada individu dengan gangguan jiwa maupun mereka yang berisiko mengalaminya. Fungsi perawat jiwa tidak hanya terbatas pada aspek klinis semata, melainkan juga mencakup dimensi edukatif, advokatif, konseling, serta kolaboratif yang bersifat holistik. Dengan latar belakang pendidikan profesional dan kompetensi khusus dalam bidang keperawatan jiwa, perawat memiliki peran sentral dalam mendukung pemulihan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial klien ke masyarakat.

1. Peran perawat sebagai pemberi asuhan

Sebagai pemberi asuhan (care provider), perawat jiwa bertanggung jawab memberikan pelayanan keperawatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan individu yang mengalami gangguan jiwa. Asuhan keperawatan jiwa melibatkan proses keperawatan yang sistematis mulai dari pengkajian kondisi psikologis dan sosial klien, penegakan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi yang sesuai, pelaksanaan tindakan, hingga evaluasi terhadap hasil asuhan. Dalam proses ini, perawat memanfaatkan pendekatan bio-psiko-sosial dan memperhatikan kondisi unik setiap klien, termasuk latar belakang budaya, nilai, dan preferensi personal.

Asuhan keperawatan jiwa yang diberikan meliputi berbagai aktivitas seperti pemantauan tanda-tanda perubahan mental dan perilaku, pemberian terapi

aktivitas kelompok, terapi seni, terapi relaksasi, serta dukungan dalam pengobatan dan manajemen efek samping obat psikotropika. Perawat jiwa juga terlibat dalam manajemen krisis, terutama dalam situasi di mana klien menunjukkan risiko terhadap dirinya sendiri atau orang lain, seperti dalam kasus ide bunuh diri, agresivitas, atau gejala psikotik akut. Dalam konteks ini, perawat bertugas menjaga keselamatan pasien dan menciptakan lingkungan terapeutik yang mendukung proses penyembuhan.

2. Peran edukator, advokat, konselor, dan kolaborator

Selain sebagai pemberi asuhan, perawat jiwa juga memiliki peran sebagai edukator, advokat, konselor, dan kolaborator. Sebagai edukator, perawat jiwa memberikan pendidikan kesehatan jiwa kepada klien, keluarga, dan masyarakat. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai kondisi gangguan jiwa, pentingnya minum obat secara teratur, strategi koping yang sehat, serta mencegah kekambuhan. Edukasi juga melibatkan peningkatan literasi kesehatan mental di masyarakat untuk mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan sosial bagi penyintas gangguan jiwa.

Sebagai advokat, perawat memperjuangkan hak-hak klien untuk mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan bebas dari diskriminasi. Perawat berperan memastikan bahwa suara klien didengar dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perawatan yang diberikan. Mereka juga menjadi jembatan komunikasi antara klien dan tenaga kesehatan lainnya, serta menjamin bahwa prinsip etika dan hak asasi manusia ditegakkan dalam setiap tindakan keperawatan.

Dalam peran konselor, perawat jiwa memberikan bimbingan dan dukungan emosional kepada klien, baik secara individu maupun dalam kelompok. Perawat membantu klien mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi perasaan, dan merumuskan strategi pemecahan masalah secara sehat. Walaupun perawat bukan terapis profesional seperti psikolog klinis, keterampilan dasar konseling sangat penting untuk membangun hubungan terapeutik yang efektif dan membantu klien mencapai kesadaran diri serta pemulihan psikologis.

Sebagai kolaborator, perawat jiwa bekerja sama dengan berbagai tenaga kesehatan lainnya dalam tim multidisiplin, seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, terapis okupasi, dan konselor. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada klien bersifat menyeluruh dan terintegrasi.

Perawat berperan aktif dalam rapat tim, diskusi kasus, serta pelaksanaan intervensi lintas disiplin untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi dan pemulihan klien.

3. Kewenangan dan kompetensi perawat jiwa

Untuk menjalankan perannya secara profesional, perawat jiwa harus memiliki kewenangan dan kompetensi yang diakui secara hukum dan standar profesi. Di Indonesia, kewenangan perawat jiwa diatur melalui regulasi seperti Undang-Undang Keperawatan No. 38 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan, yang memberikan landasan hukum bagi perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan jiwa secara mandiri maupun kolaboratif.

Kewenangan tersebut mencakup pelaksanaan asuhan keperawatan jiwa sesuai standar, pemberian obat-obatan psikiatri atas instruksi dokter, serta keterlibatan dalam tindakan medis tertentu yang bersifat kolaboratif. Perawat jiwa juga berwenang melakukan penyuluhan, pendampingan, serta pemantauan terhadap perkembangan psikososial klien dalam komunitas.

Adapun kompetensi yang harus dimiliki perawat jiwa mencakup pengetahuan tentang psikopatologi, keterampilan komunikasi terapeutik, kemampuan analisis psikososial, manajemen stres dan krisis, serta pemahaman mendalam terhadap dinamika keluarga dan komunitas. Kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan formal di jenjang S1 keperawatan dan profesi Ners, serta dapat ditingkatkan melalui pelatihan spesialis, sertifikasi, dan pengalaman klinis.

G. Standar Asuhan Keperawatan Jiwa

Standar asuhan keperawatan jiwa merupakan acuan profesional dalam memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas, aman, dan beretika bagi individu yang mengalami gangguan jiwa. Standar ini meliputi aspek proses keperawatan, ketentuan pelayanan dari organisasi profesi maupun lembaga internasional, serta pedoman etik yang membentuk dasar moral dalam praktik keperawatan jiwa. Dengan berpedoman pada standar tersebut, perawat jiwa dapat memastikan bahwa asuhan yang diberikan bersifat holistik, berbasis bukti, serta menghormati martabat dan hak asasi manusia.

1. Proses keperawatan jiwa (pengkajian, diagnosis, intervensi, evaluasi)

Proses keperawatan merupakan pendekatan sistematis yang menjadi tulang punggung dalam pemberian asuhan keperawatan jiwa. Proses ini terdiri atas lima tahap utama, yaitu pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi. Setiap tahap dilakukan secara menyeluruh dan

saling berkaitan untuk menjamin kontinuitas serta ketepatan intervensi yang diberikan kepada klien.

Pada tahap pengkajian, perawat jiwa mengumpulkan data subjektif dan objektif dari klien, keluarga, dan lingkungan. Pengkajian ini tidak hanya mencakup kondisi fisik, tetapi juga aspek psikologis, perilaku, spiritual, sosial, dan budaya. Perawat menggali gejala seperti depresi, kecemasan, delusi, halusinasi, ide bunuh diri, serta kemampuan fungsi sosial klien. Teknik komunikasi terapeutik menjadi kunci dalam menggali informasi dengan penuh empati dan kepercayaan.

Tahap diagnosis keperawatan merupakan identifikasi masalah kesehatan jiwa berdasarkan data pengkajian. Diagnosis keperawatan jiwa dapat berupa isolasi sosial, gangguan persepsi sensori, risiko kekerasan terhadap diri sendiri, gangguan proses pikir, atau harga diri rendah kronis. Penetapan diagnosis harus disesuaikan dengan terminologi baku yang ditetapkan oleh NANDA-I dan mempertimbangkan konteks klien secara individual.

Setelah diagnosis ditegakkan, perawat menyusun rencana intervensi yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Rencana ini mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta tindakan keperawatan yang akan dilakukan, seperti orientasi realita, terapi aktivitas kelompok, pelatihan manajemen stres, dukungan spiritual, hingga konseling individu.

Pada tahap pelaksanaan, perawat menerapkan intervensi yang telah direncanakan dengan tetap memperhatikan respons klien dan dinamika yang terjadi di lingkungan. Pelaksanaan intervensi harus dilakukan secara konsisten dan fleksibel, serta disesuaikan dengan kesiapan klien.

Tahap terakhir adalah evaluasi, yang bertujuan menilai efektivitas intervensi serta menentukan apakah tujuan asuhan telah tercapai. Evaluasi bersifat dinamis dan dilakukan secara berkesinambungan. Jika hasil belum optimal, maka perawat melakukan modifikasi rencana asuhan berdasarkan data baru yang diperoleh.

2. Standar pelayanan keperawatan jiwa dari PPNI dan WHO

Di Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) telah mengembangkan standar praktik keperawatan jiwa yang mencakup pedoman teknis, kode etik profesi, serta kompetensi inti perawat jiwa. Standar ini disusun untuk memberikan panduan yang seragam bagi seluruh perawat jiwa dalam menjalankan praktik profesional di berbagai tatanan pelayanan. PPNI menekankan pentingnya penerapan asuhan yang berbasis bukti (evidence-based nursing), partisipatif, serta menghargai hak dan otonomi klien.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga memberikan kerangka kerja global melalui Mental Health Action Plan dan mhGAP Intervention Guide, yang mendorong negara-negara untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa berbasis komunitas, mengurangi institusionalisasi yang tidak manusiawi, serta meningkatkan kapasitas tenaga keperawatan dalam deteksi dini, manajemen gangguan jiwa umum, dan advokasi kesehatan mental.

Standar WHO mendorong integrasi keperawatan jiwa dalam layanan primer, dengan perawat sebagai ujung tombak pelayanan, terutama di negara berkembang. WHO juga merekomendasikan pemberian pelatihan berbasis kompetensi kepada perawat, peningkatan jejaring layanan, serta pemantauan berkala terhadap kualitas pelayanan keperawatan jiwa.

3. Pedoman etik profesi perawat jiwa

Etika profesi merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari standar asuhan keperawatan jiwa. Pedoman etik ini berfungsi untuk membingkai tindakan perawat dalam batasan moral yang menjunjung tinggi kemanusiaan, integritas, dan tanggung jawab sosial. Kode etik keperawatan Indonesia yang ditetapkan oleh PPNI mencakup prinsip-prinsip utama seperti menghormati martabat manusia, menjaga kerahasiaan informasi, menjalin hubungan profesional yang sehat, dan melindungi hak-hak klien.

Dalam konteks keperawatan jiwa, tantangan etik sering kali muncul, terutama ketika perawat harus mengambil keputusan dalam situasi dilematik, seperti melakukan perawatan paksa, membatasi kebebasan klien demi keselamatan, atau menjaga kerahasiaan informasi yang berpotensi membahayakan orang lain. Oleh karena itu, perawat jiwa harus memiliki sensitivitas etik, kemampuan berpikir kritis, dan ketaatan terhadap prinsip profesionalisme dalam setiap tindakan.

Pedoman etik juga mengatur bahwa perawat tidak boleh memanfaatkan hubungan profesional untuk kepentingan pribadi, tidak boleh melecehkan atau mengeksploitasi klien secara fisik maupun emosional, serta wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Kepatuhan terhadap pedoman ini bukan hanya mencerminkan tanggung jawab moral seorang perawat, tetapi juga menjadi syarat mutlak dalam membangun hubungan terapeutik yang aman, efektif, dan bermartabat.

H. Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan Jiwa

Komunikasi terapeutik merupakan salah satu kompetensi inti yang harus dimiliki oleh perawat jiwa, karena melalui komunikasi inilah hubungan profesional antara perawat dan klien terbentuk. Dalam keperawatan jiwa, komunikasi bukan sekadar pertukaran informasi, tetapi merupakan alat utama dalam membangun kepercayaan, menjalin hubungan interpersonal, serta membantu klien memahami dirinya dan proses penyembuhan yang sedang dijalani. Komunikasi terapeutik berperan penting dalam mengurangi kecemasan, meningkatkan ekspresi emosi, memperkuat harga diri, serta memfasilitasi perubahan perilaku positif.

1. Konsep dasar komunikasi terapeutik

Komunikasi terapeutik adalah bentuk komunikasi yang dirancang secara sadar dan terarah dengan tujuan membantu klien mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap masalahnya, mengekspresikan perasaannya, serta menemukan solusi atas konflik internal yang dialaminya. Komunikasi ini tidak bersifat timbal balik seperti dalam percakapan biasa, melainkan lebih difokuskan pada kepentingan dan kebutuhan klien, sementara perawat berperan sebagai fasilitator yang empatik dan tidak menghakimi.

Elemen dasar dari komunikasi terapeutik meliputi empati, rasa hormat, keaslian, kehangatan, dan kepercayaan. Perawat perlu mampu hadir secara penuh dalam percakapan, menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal secara tepat, serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi klien untuk terbuka. Dalam konteks keperawatan jiwa, di mana klien sering mengalami distorsi realitas, ketidakstabilan emosi, atau kesulitan dalam menjalin relasi sosial, komunikasi terapeutik menjadi sarana utama untuk menjembatani dunia internal klien dengan dunia eksternal yang realistis.

Hubungan terapeutik yang terbangun melalui komunikasi ini harus didasarkan pada batasan profesional yang jelas, di mana perawat menjaga keseimbangan antara kedekatan emosional dan objektivitas klinis. Komunikasi terapeutik juga membantu perawat dalam proses pengkajian, intervensi, serta evaluasi kondisi psikososial klien.

2. Teknik komunikasi terapeutik yang efektif

Dalam praktik keperawatan jiwa, terdapat sejumlah teknik komunikasi terapeutik yang digunakan untuk membantu klien mengungkapkan perasaan, memperjelas pikiran, dan menemukan makna dari pengalaman hidupnya. Teknik-

teknik ini perlu diterapkan dengan penuh kesadaran, fleksibilitas, dan ketulusan agar efektif dan tidak terkesan manipulatif.

Beberapa teknik yang umum digunakan antara lain:

- a. Mendengarkan aktif (active listening) – Perawat memberikan perhatian penuh pada apa yang dikatakan klien, menunjukkan minat melalui kontak mata, anggukan, atau ekspresi wajah yang sesuai. Mendengarkan aktif menunjukkan bahwa perawat menghargai dan menerima klien apa adanya.
- b. Refleksi – Perawat mengulang atau mencerminkan perasaan atau ucapan klien untuk mempertegas dan membantu klien mengenali emosi yang sedang dirasakannya. Misalnya, "Kamu merasa sangat kecewa karena tidak ada yang memahami kamu, ya?"
- c. Klarifikasi – Teknik ini digunakan untuk memperjelas pernyataan klien yang membingungkan atau ambigu. Misalnya, "Bisa kamu ceritakan lebih lanjut maksudmu ketika mengatakan kamu merasa 'kosong'?"
- d. Fokus – Perawat membantu klien untuk memusatkan perhatian pada isu utama atau masalah yang sedang dibicarakan, terutama jika klien menyimpang dari topik atau kehilangan arah dalam percakapan.
- e. Diam terapeutik – Keheningan yang digunakan secara sadar untuk memberi ruang bagi klien berpikir atau merasakan, tanpa tekanan untuk segera menjawab. Diam bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk membuka refleksi mendalam.
- f. Pernyataan empatik – Menggambarkan pemahaman perawat terhadap perasaan klien. Misalnya, "Saya bisa membayangkan betapa beratnya menghadapi situasi seperti itu sendirian."
- g. Konfrontasi – Digunakan secara hati-hati untuk menunjukkan kontradiksi antara ucapan dan perilaku klien, biasanya jika hubungan terapeutik sudah cukup kuat. Misalnya, "Kamu mengatakan tidak marah, tapi saya melihat kamu menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan."

Teknik-teknik ini tidak digunakan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kondisi emosional, kognitif, dan sosial klien, serta mempertimbangkan tingkat keparahan gangguan jiwa yang dialaminya.

3. Hambatan komunikasi dengan klien gangguan jiwa

Komunikasi dalam keperawatan jiwa tidak selalu berjalan lancar, karena adanya berbagai hambatan yang muncul baik dari pihak klien maupun perawat. Hambatan ini dapat mengganggu efektivitas komunikasi terapeutik, sehingga perlu dikenali dan diatasi secara bijak.

Salah satu hambatan utama adalah kondisi psikopatologi klien, seperti halusinasi, delusi, gangguan proses pikir, atau afek tumpul, yang menyebabkan klien kesulitan menangkap pesan atau mengekspresikan dirinya secara logis. Misalnya, klien dengan skizofrenia mungkin berbicara melantur (word salad) atau menghindari kontak mata, sehingga komunikasi menjadi tidak efektif. Perawat perlu bersabar dan menggunakan pendekatan sederhana, konkret, serta penuh pengulangan dalam menyampaikan pesan.

Hambatan lain adalah ketakutan dan ketidakpercayaan dari klien akibat pengalaman traumatis sebelumnya atau persepsi bahwa perawat adalah bagian dari sistem yang ingin mengontrolnya. Dalam kondisi ini, membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan konsistensi dari perawat dalam bersikap empatik dan tidak menghakimi.

Stigma dan prasangka dari perawat juga dapat menjadi penghalang komunikasi. Jika perawat memiliki persepsi negatif terhadap klien, seperti menganggapnya berbahaya atau tidak mampu berubah, maka komunikasi yang terbangun akan bersifat kaku dan tidak tulus. Oleh karena itu, perawat perlu terus mengembangkan kesadaran diri, refleksi profesional, dan sikap menghargai martabat klien.

Hambatan teknis seperti lingkungan yang tidak kondusif, misalnya tempat yang bising, kurang privasi, atau terlalu banyak gangguan, juga dapat mengganggu konsentrasi klien dan perawat dalam proses komunikasi. Perawat perlu memastikan bahwa suasana komunikasi mendukung terbentuknya relasi terapeutik yang aman dan nyaman.

I. Aspek Legal dan Etik dalam Keperawatan Jiwa

Keperawatan jiwa adalah praktik profesional yang berhadapan langsung dengan individu yang berada dalam kondisi psikologis yang sangat rentan. Oleh karena itu, aspek legal dan etik menjadi fondasi yang sangat penting dalam menjamin kualitas, keamanan, dan keadilan dalam pemberian pelayanan keperawatan jiwa. Dalam pelaksanaannya, perawat jiwa harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi kode etik profesi, serta melindungi hak klien sekaligus menjaga integritas diri sebagai tenaga kesehatan. Hal ini tidak hanya penting untuk menjamin hak-hak pasien, tetapi juga sebagai perlindungan hukum bagi perawat dari potensi gugatan atau pelanggaran etik.

1. Undang-undang kesehatan jiwa di Indonesia

Dasar hukum pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap hak-hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan jiwa yang terintegrasi, adil, dan berkelanjutan.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial secara harmonis, sehingga mampu menyadari kemampuan diri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan berkontribusi terhadap masyarakat. UU ini juga menegaskan bahwa negara wajib menjamin ketersediaan layanan kesehatan jiwa yang bermutu, terjangkau, dan merata, serta melindungi hak ODGJ dari perlakuan tidak manusiawi, diskriminatif, atau kekerasan dalam bentuk apapun.

Bagi perawat jiwa, undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam memberikan pelayanan yang sesuai standar dan profesional, termasuk di dalamnya kewajiban untuk menghormati hak pasien seperti hak untuk mendapatkan informasi, hak atas privasi, dan hak untuk menyetujui atau menolak pengobatan, kecuali dalam kondisi tertentu yang memerlukan intervensi darurat. UU ini juga mengatur tentang rehabilitasi, integrasi sosial, dan partisipasi keluarga serta komunitas dalam proses pemulihan pasien jiwa.

2. Etika profesi dan masalah etik dalam praktik

Etika profesi keperawatan merupakan seperangkat prinsip moral yang mengarahkan perilaku dan tindakan perawat dalam menjalankan praktik klinis. Dalam konteks keperawatan jiwa, prinsip-prinsip etika seperti beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak membahayakan), autonomy (menghormati hak klien), justice (keadilan), dan fidelity (kesetiaan terhadap profesi) menjadi sangat penting karena klien berada dalam kondisi rawan pelanggaran hak dan penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu dilema etik yang sering terjadi adalah ketika perawat harus memutuskan antara menghormati hak klien atas kebebasan pribadi dengan kewajiban untuk melindunginya dari bahaya. Misalnya, apakah klien yang mengalami ide bunuh diri perlu diperlakukan secara paksa demi keselamatan, atau apakah perawat boleh membocorkan informasi kepada keluarga meskipun klien tidak mengizinkan. Situasi ini menuntut perawat untuk memiliki kepekaan etik,

kemampuan reflektif, dan keterampilan membuat keputusan profesional berbasis prinsip-prinsip moral dan hukum.

Masalah etik lainnya meliputi batasan hubungan profesional dengan klien (agar tidak menjurus pada hubungan personal atau emosional), kejujuran dalam komunikasi, serta penggunaan teknik intervensi yang menghormati martabat dan kehendak klien. Dalam setiap tindakan, perawat jiwa harus menempatkan kesejahteraan klien sebagai prioritas, tanpa mengesampingkan tanggung jawab sosial dan hukum.

Kode etik yang berlaku bagi perawat di Indonesia, yang disusun oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), menjadi pedoman resmi yang harus dipatuhi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berdampak pada sanksi profesional, moral, bahkan hukum, tergantung pada tingkat pelanggarannya.

3. Perlindungan hukum bagi perawat dan pasien jiwa

Perlindungan hukum dalam keperawatan jiwa bersifat dua arah: melindungi pasien dari perlakuan tidak etis atau melanggar hak asasi, serta melindungi perawat dari potensi kriminalisasi atau tuntutan hukum atas tindakan profesional yang dilakukan sesuai prosedur.

Untuk pasien jiwa, perlindungan hukum mencakup hak untuk mendapatkan layanan yang manusiawi, bebas dari penyiksaan, eksploitasi, atau pengabaian. Pasien juga berhak atas rehabilitasi, perlindungan dari stigma, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perawatannya. Jika hak-hak tersebut dilanggar, pasien atau keluarganya memiliki dasar hukum untuk melakukan pelaporan atau pengaduan kepada instansi yang berwenang.

Bagi perawat, perlindungan hukum dapat diperoleh jika tindakan keperawatan dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO), kode etik, dan peraturan perundangan yang berlaku. Perawat yang melakukan intervensi secara benar namun kemudian menghadapi risiko hukum, dapat memperoleh pembelaan hukum dari organisasi profesi atau lembaga bantuan hukum profesi. Oleh karena itu, penting bagi perawat jiwa untuk selalu mendokumentasikan secara rinci setiap tindakan dan keputusan klinis yang diambil, sebagai bukti bahwa praktik dilakukan secara profesional dan sesuai regulasi.

Perawat jiwa juga dilindungi oleh Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, yang mengatur ruang lingkup praktik keperawatan, hak dan kewajiban perawat, serta perlindungan hukum dalam menjalankan tugas. Jika terjadi kekerasan

terhadap perawat oleh pasien atau keluarga pasien, undang-undang ini juga memberikan jalur hukum untuk penyelesaian sengketa secara adil.

Dengan pemahaman yang kuat terhadap aspek legal dan etik dalam keperawatan jiwa, perawat dapat menjalankan praktik profesional secara aman, bertanggung jawab, dan bermartabat. Aspek ini menjadi pilar penting dalam menjamin hak klien dan memperkuat peran perawat jiwa sebagai penyedia layanan kesehatan mental yang berintegritas tinggi.

J. Simpulan

Keperawatan jiwa merupakan cabang keperawatan yang sangat kompleks, dinamis, dan berorientasi pada aspek kemanusiaan. Praktik ini tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi mental seseorang, tetapi juga menekankan pada peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan klien, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dengan gangguan jiwa. Dalam konteks pelayanan kesehatan yang holistik, perawat jiwa memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan asuhan keperawatan yang menyentuh aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual klien. Tugas tersebut menuntut kompetensi tinggi, sensitivitas moral, serta pemahaman mendalam terhadap teori, standar praktik, dan nilai-nilai profesional yang berlaku.

Dari sisi definisi dan ruang lingkupnya, keperawatan jiwa melibatkan pendekatan yang lebih dari sekadar tindakan klinis; ia mencakup pemahaman perilaku, emosi, dan dinamika psikososial klien. Sejarah keperawatan jiwa menunjukkan transformasi signifikan dari pendekatan represif menjadi pendekatan humanistik yang menempatkan pasien sebagai manusia utuh. Prinsip humanistik, etika profesional, serta penghormatan terhadap martabat manusia menjadi landasan moral dan filosofi dari seluruh praktik keperawatan jiwa, termasuk dalam hubungan terapeutik dan pengambilan keputusan klinis.

Penerapan teori-teori keperawatan seperti teori interpersonal, sistem, dan kognitif-perilaku memperkaya kemampuan perawat dalam merancang intervensi yang tepat sasaran. Di sisi lain, peran perawat jiwa tidak hanya sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai edukator, advokat, konselor, dan kolaborator yang aktif dalam tim multidisiplin. Standar asuhan keperawatan jiwa dari PPNI dan WHO menjadi pedoman penting dalam menjaga mutu dan profesionalitas pelayanan yang diberikan, termasuk dalam menjamin keselamatan klien dan akuntabilitas perawat.

Komunikasi terapeutik yang efektif menjadi instrumen utama dalam membangun hubungan yang penuh kepercayaan antara perawat dan klien, sementara pemahaman

terhadap hambatan komunikasi menjadi bekal penting dalam menghadapi kompleksitas psikopatologi yang mungkin dihadapi. Aspek legal dan etik semakin menegaskan pentingnya perlindungan hak klien serta keamanan hukum bagi perawat dalam menjalankan praktik yang bertanggung jawab.

Dengan mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut, keperawatan jiwa bukan hanya berperan dalam menyembuhkan, tetapi juga dalam mengangkat kembali martabat individu, memperkuat resiliensi mental, dan membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan yang berbasis bukti, nilai kemanusiaan, dan etika profesional akan menjadi pondasi kuat bagi perawat jiwa dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan mental di masa kini dan mendatang.

K. Referensi

Hidayat, A. A. A. (2021). Keperawatan jiwa: Teori dan aplikasi dalam praktik klinik. Salemba Medika.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38745/uu-no-18-tahun-2014>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41774/uu-no-38-tahun-2014>

<https://www.litbang.kemkes.go.id/laporan-riset-kesehatan-dasar-risikesdas/>

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241506021>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Kurniawan, B. (2020). Keperawatan kesehatan jiwa: Asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan jiwa dan masalah psikososial. Media Sains Indonesia.

Mubarak, W. I., & Chayatin, N. (2019). Ilmu keperawatan komunitas: Teori dan praktik dalam keperawatan. Salemba Medika.

Peplau, H. E. (1997). Interpersonal relations in nursing: A conceptual frame of reference for psychodynamic nursing. Springer Publishing Company. (Karya asli diterbitkan tahun 1952)

Putri, A. Y., & Supriyanto, S. (2022). Keperawatan kesehatan jiwa berbasis komunitas. Deepublish.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

World Health Organization. (2013). Mental health action plan 2013–2020. WHO Press.

World Health Organization. (2016). mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings (Version 2.0). WHO Press.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790>

L. Glosarium

Gangguan Jiwa:

Kondisi kesehatan mental yang ditandai oleh perubahan signifikan dalam cara berpikir, merasa, dan berperilaku yang menyebabkan penderitaan atau gangguan fungsi dalam kehidupan sehari-hari.

Keperawatan Jiwa:

Cabang ilmu keperawatan yang fokus pada pemberian asuhan kepada individu atau kelompok dengan gangguan kesehatan jiwa atau masalah psikososial, mencakup pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual.

Hubungan Terapeutik:

Relasi profesional yang dibangun antara perawat dan klien dengan tujuan terapeutik, dilandasi oleh empati, rasa percaya, dan komunikasi efektif untuk membantu proses pemulihan psikologis dan sosial klien.

Pendekatan Bio-Psiko-Sosial-Spiritual:

Pendekatan dalam keperawatan jiwa yang memperhatikan aspek biologis (kondisi fisik), psikologis (emosi dan pikiran), sosial (hubungan interpersonal), dan spiritual (nilai, keyakinan, makna hidup) dalam pemberian asuhan.

Komunikasi Terapeutik:

Komunikasi khusus yang dilakukan secara sadar dan terarah antara perawat dengan klien untuk membantu klien mengungkapkan perasaan, memahami masalahnya, serta menemukan solusi atas konflik internal.

Koping:

Kemampuan individu dalam menghadapi stres atau tantangan hidup secara adaptif melalui mekanisme atau strategi tertentu yang membantu menjaga keseimbangan mental dan emosional.

Teori Interpersonal (Peplau):

Teori keperawatan jiwa yang dikembangkan oleh Hildegard Peplau, menekankan hubungan interpersonal antara perawat dan klien sebagai alat utama dalam proses terapi dan pemulihan.

Stigma Kesehatan Jiwa:

Pandangan negatif, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa, yang menyebabkan isolasi sosial dan hambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan mental yang layak.

Advokasi dalam Keperawatan Jiwa:

Peran perawat dalam membela hak-hak klien, memastikan perlakuan yang manusiawi, adil, serta bebas dari diskriminasi, sekaligus memfasilitasi partisipasi klien dalam pengambilan keputusan terkait perawatannya.

Perlindungan Hukum dalam Keperawatan Jiwa:

Jaminan hukum bagi perawat maupun klien jiwa dalam pelaksanaan praktik keperawatan, termasuk hak klien terhadap perlakuan yang manusiawi dan hak perawat untuk melakukan intervensi yang sesuai standar profesi tanpa takut menghadapi tuntutan hukum.

CHAPTER 2

KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM KEPERAWATAN JIWA

Wittin Khairani, S.Pd., MPH.

A. Pendahuluan/Prolog

Keberhasilan seseorang dalam berinteraksi dan menjalani kehidupannya adalah terletak pada baik-buruknya aktivitas komunikasi. Komunikasi merupakan aspek penting dalam pergaulan sosial sehari-hari. Hal ini karena kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk saling berhubungan atau berinteraksi. Hubungan manusia dengan individu, hubungan manusia dengan kelompok atau hubungan kelompok, inilah yang disebut sebagai interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, komunikasi berperan sangat penting.

Komunikasi adalah suatu bentuk interaksi manusia yang bisa mempengaruhi satu manusia dengan manusia lain yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Komunikasi tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal saja, namun juga dapat melalui bentuk ekspresi muka, seni, lukisan dan teknologi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang bertujuan untuk memberitahukan, mengemukakan pendapat dan mengubah perilaku atau mengubah sikap yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Komponen penting dalam komunikasi ada 4 unsur, yaitu: Pengirim pesan (sumber), Penerima pesan, Pesan dan Saluran.

Dalam dunia perawatan jiwa komunikasi merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Komunikasi yang dilakukan oleh perawat adalah bukan sembarangan komunikasi tetapi merupakan komunikasi yang spesifik, profesional dan mempunyai efek yang terapeutik bagi pasien. Artinya komunikasi yang diterapkan suatu kondisi yang optimal melalui pengendalian diri, peningkatan aktualisasi diri, serta selalu menggunakan coping mekanisme yang positif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan dan dilakukan untuk membantu penyembuhan/pemulihan pasien (Damaiyanti, 2008). Komunikasi terapeutik merupakan profesional bagi perawat. Perawat mempunyai keterampilan berkomunikasi terapeutik, maka akan memudahkan dalam menjalin hubungan

saling percaya dengan pasien sehingga lebih efektif dalam mencapai tujuan asuhan keperawatan yang telah diterapkan, sehingga memberikan kepuasan professional dalam pelayanan keperawatan jiwa dan mampu meningkatkan profesi.

Menurut Yosep (2007), Gangguan jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut dibagi ke dalam dua golongan yaitu: gangguan jiwa (Neurosa) dan Sakit Jiwa (Psiko). Keabnormalan terlihat dalam berbagai macam gejala, yang terpenting diantaranya adalah ketegangan (tension), rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa (convulsive), histeria, rasa lemah dan tidak mampu mencapai tujuan, takut pikiran pikiran dan sebagainya.

Gejala gangguan jiwa dapat dilihat dengan adanya tanda-tanda, sebagai berikut:

1. Ilusi, pasien mengalami salah tangkap dalam mengindera
2. Halusinasi, pasien mengalami khayalan tanpa ada rangsang
3. Obsesi, diliputi pikiran atau perasaan yang terus menerus, biasanya mengenai hal yang tidak menyenangkan
4. Kompulsi, mengalami keragu-raguan mengenai sesuatu yang dikerjakan
5. Fobia, mengalami ketakutan yang sangat terhadap sesuatu kejadian
6. Delusi, mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan
7. Keadaan emosi, merupakan bagian dari perasaan yang bergejolak sehingga dapat di observasi, seperti: sering sedih, sering merasa tegang, sering merasa girang.

Tujuan komunikasi terapeutik dalam keperawatan jiwa adalah: Perawat mampu menggali perilaku pasien dengan gangguan jiwa, Perawat dapat memahami gejala infulsif dari pasien gangguan jiwa, Perawat memahami perlunya memberi pujian pada pasien gangguan jiwa, Perawat memperoleh informasi status gangguan jiwa yang diderita pasien.

Bagi perawat komunikasi terapeutik mempunyai tujuan untuk mencapai kesembuhan pasien (Musliha & Fatmawati, 2020). Komunikasi terapeutik merupakan alat untuk mengembangkan hubungan antara perawat dengan pasien sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku pasien dalam melaksanakan asuhan keperawatan.

Komunikasi yang dilakukan oleh perawat adalah bukan sembarangan komunikasi tetapi merupakan komunikasi yang spesifik, professional dan mempunyai efek yang terapeutik bagi pasien yang dirawat. Pentingnya komunikasi bagi perawat khususnya perawat jiwa maka penulis ingin sharing menyampaikan tulisan yang berkenaan topik diatas.

B. Prinsip Dasar Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan dan dilakukan untuk membantu penyembuhan/pemulihan pasien. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi profesional bagi perawat (Damaiyanti, 2008).

Tujuan Komunikasi Terapeutik

Dengan memiliki keterampilan berkomunikasi terapeutik, perawat akan lebih mudah menjalin hubungan saling percaya dengan klien, sehingga akan lebih efektif dalam mencapai tujuan asuhan keperawatan yang telah diterapkan, memberikan kepuasan profesional dalam pelayanan keperawatan dan akan meningkatkan profesi. Tujuan komunikasi terapeutik (Purwanto, 1994) adalah:

1. Membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil Tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan.
2. Mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil Tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan ego.
3. Mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik dan diri sendiri.

Dalam prakteknya komunikasi terapeutik mempunyai tujuan, sebagai berikut:

1. Membangun hubungan terapeutik, artinya membangun hubungan yang efektif antara profesional antara perawat dan pasien.
2. Mengurangi gejala, artinya mengurangi gejala penyakit atau masalah Kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas hidup, artinya meningkatkan semangat hidup, kualitas hidup sehingga dapat meningkatkan tingkat harapan hidup pasien.
4. Mempromosikan Kesehatan, artinya dapat mempromosikan program program Kesehatan sehingga dapat menunjang Kesehatan pasien dan kesejahteraan pasien.

Menurut Christina, dkk (2003), Manfaat Komunikasi Terapeutik adalah: Mendorong dan menganjurkan Kerjasama antara perawat dengan pasien melalui hubungan perawat-klien, Mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan dan mengkaji masalah dan mengevaluasi Tindakan yang dilakukan oleh perawat.

Persyaratan dasar pelaksanaan komunikasi terapeutik supaya efektif, adalah: semua komunikasi yang dilaksanakan harus ditujukan untuk menjaga harga diri pemberi maupun penerima pesan, komunikasi yang diciptakan saling pengertian harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memberikan sarana, informasi maupun masukan atau feedback.

Pelaksanaan komunikasi yang diharapkan adalah komunikasi yang dilakukan secara efektif. Komunikasi yang efektif harus memenuhi aspek antara lain sebagai berikut:

1. *Respect*

Adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan aspek yang utama dalam berkomunikasi dengan orang lain.

2. *Empathy*

Adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Kondisi ini disebut dengan komunikasi empati yaitu: dengan memahami dan mendengarkan orang lain terlebih dahulu, kita dapat membentuk keterbukaan dan kepercayaan yang kita perlukan dalam membangun Kerjasama atau sinergi dengan orang lain.

3. *Audible*

Adalah mampu didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan.

4. *Clarity*

Adalah kemampuan berkomunikasi secara keterbukaan dan transparansi. Dalam berkomunikasi kita perlu mengembangkan sikap terbuka (tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan) sehingga dapat menimbulkan rasa percaya (trust) dari penerima pesan.

5. *Humble*

Adalah sikap rendah hati. Sikap rendah hati yang dimiliki perawat bertujuan agar pasien tidak merasa rendah hati, menolak berkomunikasi dan selalu care dengan perawat. Sikap rendah hati mutlak harus dimiliki seorang perawat. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan makna untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati dengan sikap yang penuh melayani, sikap menghargai, mau mendengarkan dan menerima kritik, tidak sombong dan memandang rendah orang lain, berani mengakui kesalahan, rela memaafkan, lemah lembut dan penuh pengendalian diri, serta mengutamakan kepentingan proses penyembuhan pasien.

Aspek komunikasi efektif diatas diharapkan dapat mendukung professional perawat jiwa dalam memberikan komunikasi terapeutik kepada pasien gangguan jiwa. Menurut Nurjannah (2001), komunikasi terapeutik merupakan seni penyembuhan, yang diartikan sebagai tindakan atau kegiatan pertukaran informasi antara perawat dan pasien yang dilakukan dengan sadar dalam rangka proses penyembuhan. Hal ini berarti bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perawat adalah mencari informasi tentang keluhan yang dirasakan pasien hingga tindakan yang dilakukan berdasarkan keluhan yang dirasakan hingga di evaluasi. Kegiatan pasien adalah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai keluhan yang dirasakan agar dapat dijadikan pegangan perawat dalam menjalankan asuhan perawatan jiwa.

Kualitas komunikasi dapat bersifat terapeutik tergantung pada kualitas komunikasi yang disampaikan, yaitu adanya keterbukaan, saling mendukung, bersikap positif, memahami perasaan orang lain dan kesetaraan. Oleh sebab itu dalam berkomunikasi terapeutik harus memperhatikan prinsip-prinsip supaya bersifat terapeutik kepada pasien jiwa. Menurut Carl Rogers (dalam Purwanto, 1994), Prinsip-prinsip komunikasi terapeutik adalah:

1. Perawat harus mengenal dirinya sendiri yang berarti menghayati, memahami dirinya sendiri serta nilai yang dianut.
2. Komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya dan saling menghargai.
3. Perawat harus menyadari pentingnya kebutuhan pasien baik fisik maupun mental.
4. Perawat harus menciptakan suasana yang memungkinkan pasien bebas berkembang tanpa rasa takut.
5. Perawat harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan pasien memiliki motivasi untuk mengubah dirinya baik sikap, tingkah lakunya sehingga tumbuh makin matang dan dapat memecahkan masalah masalah yang dihadapi.
6. Perawat harus mampu menguasai perasaan sendiri secara bertahap untuk mengetahui dan mengatasi perasaan gembira, sedih, marah, keberhasilan maupun frustrasi.
7. Mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan dapat mempertahankan konsistensinya.
8. Memahami betul arti empati sebagai Tindakan yang terapeutik dan sebaliknya simpati bukan Tindakan yang terapeutik.
9. Kejujuran dan komunikasi terbuka merupakan dasar dari hubungan terapeutik.

10. Mampu berperan sebagai role model agar dapat menunjukkan dan menyakinkan orang lain tentang Kesehatan, oleh karena itu perawat perlu mempertahankan suatu keadaan sehat fisik mental, spiritual dan gaya hidup.
11. Disarankan untuk mengekspresikan perasaan bila dianggap mengganggu.
12. Altruisme untuk mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain secara manusiawi.
13. Berpegang pada etika dengan cara berusaha sedapat mungkin mengambil keputusan berdasarkan prinsip kesejahteraan manusia.
14. Bertanggung jawab dalam dua dimensi yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri atas Tindakan yang dilakukan dan tanggung jawab terhadap orang lain.

Sikap Komunikasi terapeutik, Menurut Egan (dalam Keliat, 1992), mengidentifikasi lima sikap atau cara untuk menghadirkan diri secara fisik yang dapat memfasilitasi komunikasi terapeutik, yaitu:

1. Berhadapan

Arti dari posisi ini adalah saya siap untuk anda

2. Mempertahankan kontak mata

Kontak mata pada level yang sama berarti menghargai klien dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi.

3. Membungkuk ke arah pasien

Posisi ini menunjukkan keinginan untuk menyatakan atau mendengarkan sesuatu.

4. Memperlihatkan sikap terbuka

Tidak melipatkan kaki atau tangan menunjukkan keterbukaan untuk berkomunikasi dan siap membantu.

5. Tetap rileks

Tetap dapat mengendalikan keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi dalam memberikan respons kepada pasien, meskipun dalam situasi yang kurang menyenangkan.

Ada beberapa teknik komunikasi terapeutik menurut Wilson dan Kneist (1992) serta Stuart dan Sundeen (1998), antara lain:

1. Mendengarkan dengan penuh perhatian

Perawat bersikap untuk mengerti pasien dengan cara mendengarkan apa yang disampaikan pasien kepada perawat. Satu-satunya orang yang dapat menceritakan kepada perawat tentang perasaan, pikiran dan persepsi pasien adalah pasien sendiri. Sikap yang dibutuhkan untuk menjadi pendengar yang baik adalah: pandangan saat

berbicara, tidak menyilangkan kaki dan tangan, hindari Tindakan yang tidak perlu, anggukan kepala jika pasien membicarakan hal-hal yang penting atau umpan balik, condongkan tubuh ke arah lawan bicara.

Mendengarkan ada dua macam:

a. Mendengar pasif

Kegiatan mendengar dengan kegiatan non verbal untuk klien misalnya dengan kontak mata, mengganggu kepala.

b. Mendengar aktif

Kegiatan mendengar yang menyediakan pengetahuan bahwa kita tahu perasaan orang lain dan mengerti mengapa dia merasakan hal tersebut.

2. Menunjukkan Penerimaan

Menerima tidak berarti menyetujui. Menerima berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau ketidaksetujuan. Sikap perawat yang menyatakan penerimaan yaitu: mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan, memberikan umpanbalik verbal yang menyatakan pengertian, memastikan bahwa isyarat non verbal cocok dengan komunikasi verbal, menghindari perdebatan, ekspresi keraguan atau usaha untuk mengubah pikiran pasien.

3. Menanyakan pertanyaan yang berkaitan

Tujuan perawat bertanya adalah untuk memperoleh informasi yang spesifik mengenai apa yang disampaikan oleh pasien. Oleh karena itu, pertanyaan sebaiknya dikaitkan dengan topik yang dibicarakan dan gunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks sosial budaya pasien.

4. Pertanyaan terbuka (Open-Ended Question)

Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban Ya dan Mungkin, tetapi pertanyaan memerlukan jawaban yang luas, sehingga pasien dapat mengemukakan masalahnya, perasaannya dengan kata-kata sendiri, atau dapat memberikan informasi yang diperlukan.

5. Mengulang ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri.

Melalui pengulangan Kembali kata-kata klien, perawat memberikan umpan balik bahwa perawat mengerti pesan pasien dan berharap komunikasi dapat dilanjutkan.

6. Mengklarifikasi

Klarifikasi terjadi saat perawat berusaha untuk menjelaskan dalam kata-kata, ide atau pikiran yang tidak jelas dikatakan oleh pasien. Tujuan dari Teknik ini adalah untuk menyamakan pengertian.

7. Memfokuskan

Metode ini bertujuan untuk membatasi bahan pembicaraan sehingga percakapan menjadi lebih spesifik dan dimengerti. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ini adalah usahakan untuk tidak memutuskan pembicaraan Ketika pasien menyampaikan masalah yang penting.

8. Menyatakan hasil observasi

Perawat harus memberikan umpan balik kepada pasien dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga pasien dapat mengetahui apakah pesannya diterima dengan benar atau tidak. Dalam hal ini perawat menguraikan kesan yang ditimbulkan oleh isyarat non verbal pasien. Teknik ini seringkali membuat pasien berkomunikasi lebih jelas tanpa perawat harus bertanya, memfokuskan dan mengklarifikasi pesan. Observasi dilakukan sedemikian rupa sehingga pasien tidak menjadi malu atau marah.

9. Menawarkan informasi

Memberikan tambahan informasi merupakan Tindakan penyuluhan Kesehatan untuk pasien. Perawat tidak dibenarkan memberikan nasihat kepada pasien ketika memberi informasi, karena tujuan dari tindakan ini adalah memfasilitasi pasien untuk mengambil keputusan. Penahanan informasi yang dilakukan saat pasien membutuhkan akan mengakibatkan pasien menjadi tidak percaya.

10. Diam (memelihara ketenangan)

Diam akan memberikan kesempatan kepada perawat dan pasien untuk mengorganisir pikiran. Sikap diam memberikan kesempatan pasien untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri, mengorganisir pikiran dan memproses informasi. Diam sangat berguna terutama pada saat pasien harus mengambil keputusan.

11. Meringkas

Adalah pengulangan ide utama telah dikomunikasikan secara singkat. Metode ini bermanfaat untuk membantu mengingat topik yang telah dibahas sebelum meneruskan pembicaraan berikutnya.

12. Memberi penghargaan

Penghargaan jangan sampai jadi beban untuk pasien. Dalam arti jangan sampai pasien berusaha keras dan melakukan segalanya demi untuk mendapatkan pujian atau persetujuan atas perbuatannya. Selain itu Teknik ini tidak pula dimaksudkan untuk menyatakan bahwa yang ini bagus dan yang sebaliknya buruk.

13. Menawarkan diri

Perawat menyediakan diri tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan.

14. Memberikan kesempatan pada pasien untuk memulai pembicaraan.

Memberikan kesempatan kepada pasien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Perawat memberi stimulus untuk pasien dapat mengambil inisiatif dan merasakan bahwa ia diharapkan untuk membuka pembicaraan.

15. Mengajukan untuk meneruskan pembicaraan

Teknik ini memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengarahkan hamper seluruh pembicaraan. Teknik ini juga mengindikasikan bahwa perawat mengikuti apa yang dibicarakan dan tertarik dengan apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Perawat lebih berusaha menafsirkan daripada mengarahkan diskusi pembicaraan.

16. Menempatkan kejadian secara berurutan

Mengurutkan kejadian secara teratur akan membantu perawat dan pasien untuk melihatnya dalam suatu perspektif. Kelanjutan dari suatu kejadian akan menuntun perawat dan pasien untuk melihat kejadian berikutnya yang merupakan akibat dari kejadian sebelumnya dan juga dapat menemukan pola kesukaran interpersonal.

17. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk menguraikan persepsinya.

Pasien merasa bebas untuk menguraikan persepsinya kepada perawat. Sementara itu perawat harus waspada terhadap tanda-tanda ansietas yang mungkin muncul.

18. Refleksi

Refleksi ini memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengemukakan dan menerima ide dan perasaannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Dengan demikian perawat mengindikasikan bahwa pendapat pasien adalah berharga dan pasien mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya, membuat keputusan dan memikirkan dirinya sendiri.

19. Assertive

Assertive adalah kemampuan dengan secara menyakinkan dan nyaman mengekspresikan pikiran dan perasaan diri dengan tetap menghargai orang lain. Kemampuan asertif adalah: berbicara jelas, mampu menghadapi manipulasi pihak lain tanpa menyakiti hatinya, melindungi diri dari kritik.

20. Humor

Humor adalah sebagai hal yang penting dalam komunikasi verbal dikarenakan tertawa mengurangi ketegangan dan rasa sakit akibat stress dan meningkatkan keberhasilan asuhan keperawatan.

C. Hambatan dalam Komunikasi Terapeutik dan cara mengatasi

Hambatan berkomunikasi terapeutik merupakan kebuntuan dalam kemajuan hubungan komunikasi antara perawat dan pasien. Hambatan ini bisa terjadi dari pasien maupun dari perawat. Ada lima hambatan komunikasi terapeutik, yaitu: *resistens*, *tranferens*, *countertransference* dan *bondary violation*.

1. Resistens

Adalah suatu kondisi dimana adanya upaya pasien untuk tidak menyadari aspek dari penyebab cemas atau kegelisahan yang dialami. Ini merupakan keenggan alamiah atau penghindaran secara verbal yang dipelajari. Pasien yang resisten biasanya menunjukkan ambivalensi antara menghargai tetapi juga menghindari pengalaman yang menimbulkan cemas padahal hal ini merupakan bagian normal dari proses terapeutik. Resistensi ini sering akibat dari ketidaksediaan pasien untuk berubah. Ketika kebutuhan untuk berubah telah dirasakan. Perilaku resisten biasanya diperlihatkan oleh pasien pada fase kerja, karena pada fase ini sangat banyak berisi proses penyelesaian masalah (Stuart dan Sundeen dalam Intan, 2005). Beberapa bentuk perilaku resisten, antara lain:

- a. Pembicaraan yang bersifat permukaan/dangkal
- b. Hambatan intelektual yang mungkin tampak Ketika pasien mengatakan pasien tidak mempunyai pikiran apapun atau tidak mampu memikirkan masalahnya, saat pasien tidak memenuhi janji untuk pertemuan atau tiba terlambat untuk suatu sesi, lupa, diam atau mengantuk.
- c. Adanya penekanan atau penahanan informasi yang terkait (*Supresi*)
- d. Adanya mekanisme pertahanan diri secara psikologis dimana pasien secara tidak sadar menekan atau mengubur pikiran, perasaan atau pengalaman yang menyakitkan atau tidak menyenangkan dari kesadaran.

Mekanisme ini digunakan pasien untuk melindungi diri dari hal-hal yang dianggap mengancam atau menyakitkan (*repres*)

- e. Adanya perilaku meningkatkan gejala dengan cara memaksimalkan potensi secara internal (Intensifikasi gejala).
- f. Devaluasi diri serta pandangan dan keputusan tentang masa depan.
- g. Dorongan untuk sehat, yang terjadi secara tiba-tiba tetapi hanya kesempatan yang bersifat sementara.
- h. Hambatan intelektual yang mungkin tampak Ketika pasien mengatakan tidak mampu memikirkan masalahnya atau tidak mempunyai pikiran apapun, saat pasien tidak memenuhi janji untuk pertemuan atau tiba terlambat untuk sesi, lupa, diam atau mengantuk.
- i. Penghayatan intelektual dimana pasien memverbalisasi pemahaman dirinya dengan menggunakan istilah yang tepat namun tetap berperilaku maladaptive atau menggunakan mekanisme pertahanan intelektual tanpa diikuti penghayatan.
- j. Muak terhadap normalitas yang terlihat Ketika klien telah mempunyai penghayatan tetapi menolak memikul tanggung jawab untuk berubah dengan alasan bahwa normalitas adalah hal yang tidak penting.
- k. Reaksi transference (respon tidak sadar dimana pasien mengalami perasaan dan sakit terhadap perawat yang pada dasarnya terkait dengan tokoh dalam kehidupan yang dulu).
- l. Perilaku amuk atau tidak rasional.

2. Transference

Transference merupakan respons tak sadar berupa perasaan atau perilaku terhadap perawat yang sebetulnya berawal dan berhubungan dengan orang-orang tertentu yang bermakna baginya pada waktu dia masih kecil (Stuart dan Sundeen, 1998).

Reaksi transference membahayakan untuk proses terapeutik hanya bila hal ini diabaikan dan tidak ditelaah oleh perawat. Ada dua jenis utama reaksi transference yaitu reaksi bermusushan dan bergantung. Cara mengatasinya:

3. Countertransference

Countertransference merupakan kebuntuan terapeutik yang dibuat oleh perawat dan bukan dari pasien. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan perawat dengan pasien pada saat komunikasi berlangsung. Beberapa bentuk perilaku perawat yang bersifat *countertransference*, yaitu:

- a. Ketidakmampuan untuk berempati terhadap pasien dalam area masalah tertentu.
- b. Selama atau sesudah berkomunikasi menekankan perasaan pada setiap sesi interaksi berkomunikasi.
- c. Kecerobohan dalam mengimplementasikan kontrak dengan datang terlambat atau melampaui waktu yang telah ditentukan.
- d. Cuek dan disertai mengantung selama sesi berkomunikasi
- e. Perasaan marah atau tidak sabar karena ketidakinginan pasien untuk berubah.
- f. Dorongan terhadap ketergantungan, pujian atau afeksi pasien.
- g. Berdebat dengan pasien atau kecenderungan untuk memaksa pasien sebelum pasien siap untuk berubah.
- h. Mencoba untuk menolong pasien dengan segala hal tidak berhubungan dengan tujuan keperawatan yang telah diidentifikasi.
- i. Keterlibatan dengan pasien dalam tingkat personal dan sosial.
- j. Melamun dan memikirkan pasien
- k. Fantasi seksual atau agresi yang diarahkan kepada pasien.
- l. Perasaan cemas, gelisah atau perasaan bersalah terhadap pasien.
- m. Kecenderungan untuk memusatkan secara berulang hanya pada satu aspek atau cara memandang pada informasi yang diberikan pasien.
- n. Kebutuhan untuk mempertahankan intervensi keperawatan dengan pasien.

Dari kondisi *countertransference* menimbulkan reaksi. Ada tiga bentuk reaksi tersebut, yaitu:

- a. Reaksi sangat peduli atau mencintai (*caring*)
- b. Reaksi sangat bermusuhan
- c. Reaksi sangat cemas seringkali digunakan sebagai respons terhadap resistensi.

Ada lima cara mengidentifikasi terjadinya *countertransference* (Stuart G.W dalam Suryani, 2006).

- a. Perawat harus mempunyai standar yang sama terhadap dirinya sendiri atas apa yang diharapkan kepada pasien.
- b. Perawat harus dapat menguji diri sendiri melalui Latihan menjalin hubungan, terutama Ketika pasien menentang atau mengritik.
- c. Perawat harus dapat menemukan sumber masalahnya.
- d. Ketika *countertransference* terjadi, perawat harus dapat melatih diri untuk mengontrolnya.
- e. Jika perawat membutuhkan pertolongan dalam mengatasi *countertransference*, pengawasan secara individu maupun kelompok dapat lebih membantu.

4. Bondary Violation

Perawat perlu membatasi hubungannya dengan pasien. Batas hubungan perawat-pasien adalah bahwa hubungan yang dibina adalah hubungan terapeutik dalam hubungan ini perawat berperan sebagai peolong dan pasien berperan sebagai yang ditolong. Baik perawat maupun pasien harus menyadari batas tersebut (Suryani, 2006).

Pelanggaran batas terjadi jika perawat melampaui batas hubungan yang terapeutik dan membina hubungan sosial, ekonomi atau personal dengan pasien.

Beberapa batas hubungan perawat dengan pasien (Stuart dan Sundeen dalam Intan, 2005):

a. Batas peran;

Masalah batas peran ini memerlukan wawasan dan pengetahuan yang luas dari perawat serta penentuan secara tegas mengenai batas-batas terapeutik perawat dan klien.

b. Batas waktu;

Penetapan waktu perlu dilakukan dimana perawat mengadakan hubungan terapeutik dengan pasien. Waktu pengobatan atau hubungan terapeutik yang tidak wajar dan tidak mempunyai tujuan terapeutik harus di evaluasi Kembali untuk mencegah terjadinya pelanggaran batas.

c. Batas tempat dan ruang;

Misalnya wawancara di mana? Kapan dan berapa lama? Batas ini biasanya berhubungan dengan perawatan yang dilakukan. Pemanfaatan terapeutik di luar kebiasaan misalnya di mobil atau rumah pasien, harus dengan Tindakan terapeutik yang rasional dan mempunyai tujuan yang jelas. Perawat dalam melakukan Tindakan di kamar pasien kadang perlu menghormati batas-batas tertentu misalnya pintu terbuka atau ada pegawai lain.

d. Batas uang;

Batas ini berhubungan dengan penghargaan pasien terhadap perawat berupa uang. Di sini juga perlu adanya perhatian mengenai tawar-menawar terhadap klien miskin tentang biaya pengobatan untuk mencegah timbulnya pelanggaran batas.

e. Batas pemberian hadiah dan pelayanan;

Masalah ini masih kontroversial dalam keperawatan, namun yang pasti hal ini melanggar batas.

f. Batas Pakaian;

Batas ini berhubungan dengan kebutuhan perawat dalam berpakaian secara tepat dalam hubungan terapeutik perawat dan pasien. Dimana perawat tidak diperbolehkan memakai pakaian yang tidak sopan.

g. Batas Bahasa;

Perawat perlu memperhatikan nada bicara dan pilihan kata Ketika berkomunikasi dengan pasien. Tidak terlalu akrab mengarah sikap seksual dan memberikan pendapat dengan nada menggurui merupakan pelanggaran batas.

h. Batas pengungkapan diri secara personal;

Pengungkapan diri secara personal dari perawat yang tidak berhubungan dengan tujuan terapeutik dapat mengarah kepada pelanggaran batas.

i. Batas kontak fisik;

Semua kontak fisik dengan pasien harus dievaluasi untuk melihat apakah melanggar batas atau tidak. Beberapa jenis kontak fisik/seksual terhadap pasien tidak pernah tercakup dalam hubungan terapeutik antara perawat dan pasien.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran batas dalam berhubungan dengan pasien, perawat sejak awal interaksi perlu menjelaskan atau membuat kesepakatan bersama pasien tentang hubungan yang mereka jalin. Kemudian selama interaksi perawat perlu berhati-hati dalam berbicara agar tidak banyak terlibat dalam komunikasi sosial. Dengan selalu berfokus pada tujuan interaksi, perawat bisa terhindar dari pelanggaran terhadap batas-batas dalam berhubungan dengan pasien. Selalu mengingatkan kontrak dan tujuan interaksi setiap kali bertemu dengan pasien juga dapat menghindari terjadinya pelanggaran batas (Suryani, 2006).

Contoh bentuk pelanggaran batas yaitu (Intan, 2005):

- 1) Pasien mengajak perawat makan siang atau makan malam di luar.
- 2) Pasien mengenalkan perawat kepada anggota keluarganya.
- 3) Perawat menerima pemberian hadiah dari bisnis pasien
- 4) Perawat menghindari acara-acara sosial.
- 5) Pasien memberi perawat hadiah.
- 6) Perawat secara rutin memeluk dan memegang pasien.
- 7) Perawat menjalankan bisnis atau memesan pelayanan dari pasien.
- 8) Perawat secara teratur memberikan informasi personal kepada pasien.
- 9) Hubungan profesional berubah menjadi hubungan sosial.
- 10) Perawat menghadiri undangan pasien.

Mengatasi Hambatan Komunikasi Terapeutik

- 1) Perawat harus mengetahui pengetahuan tentang hambatan terapeutik dan mengenali perilaku tersebut.
- 2) Klarifikasi dan refleksi perasaan.
- 3) Gali latar belakang perawat-pasien.
- 4) Bertanggung jawab terhadap hambatan terapeutik dan dampak negative proses terapeutik.
- 5) Tinjau Kembali hubungan, area kebutuhan dan masalah pasien.
- 6) Bina Kembali Kerjasama perawat-pasien yang konsisten.

Selanjutnya secara umum ada beberapa hambatan dalam komunikasi terapeutik dapat terjadi karena berbagai factor. Berikut beberapa contoh hambatan dalam berkomunikasi:

- a. Bahasa dan budaya: Perbedaan Bahasa dan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman.
- b. Emosi dan perasaan: Emosi dan perasaan yang kuat dapat mempengaruhi kemampuan pasien untuk berkomunikasi efektif.
- c. Ketidakpercayaan: Pasien mungkin tidak percaya pada perawat atau proses terapeutik.
- d. Keterbatasan waktu: Keterbatasan waktu dapat menyebabkan komunikasi tidak efektif.
- e. Gangguan mental: Gangguan mental pasien dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkomunikasi.

Cara mengatasi Hambatan dalam berkomunikasi, sebagai berikut:

- a. Bahasa dan budaya
 - 1) Menggunakan penerjemah jika perlu
 - 2) Menghormati budaya dan nilai pasien
- b. Emosi dan perasaan
 - 1) Mengakui dan memvalidasi perasaan pasien
 - 2) Menggunakan Teknik empati dan refleksi.
- c. Ketidakpercayaan:
 - 1) Membangun hubungan yang percaya dan terbuka
 - 2) Menjelaskan proses terapeutik dan tujuan
- d. Keterbatasan waktu:
 - 1) Mengatur waktu yang efektif untuk berkomunikasi
 - 2) Menggunakan Teknik komunikasi yang efisien.

e. Gangguan mental:

- 1) Menggunakan Teknik komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasien.
- 2) Mengadaptasi pendekatan terapeutik dengan kondisi pasien.

Dengan memahami hambatan dan menggunakan strategi yang tepat, maka perawat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi terapeutik dan membangaun hubungan yang positif dengan pasien.

5. Dokumentasi Komunikasi Terapeutik Dalam Keperawatan Jiwa

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, penyimpanan dan pengelolaan informasi atau data yang berkaitan dengan suatu kegiatan, proses atau peristiwa. Artinya Kegiatan dokumentasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi atau data yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau proses, dilanjutkan penyimpanan informasi dari data yang telah dikumpulkan dan terakhir adalah pengelolaan informasi atau data yang telah disimpan.

Tujuan Dokumentasi adalah: mencatat informasi, mengarsipkan informasi dan menggunakan informasi atau data yang telah diarsipkan untuk keperluan tertentu.

Ada beberapa manfaat dokumentasi yaitu: meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi, meningkatkan akurasi dalam pencatatan informasi dan meningkatkan kepercayaan dalam penggunaan informasi.

Dengan melakukan dokumentasi yang baik, maka kita dapat memastikan bahwa informasi atau data yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau proses terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai acuan untuk keperluan tertentu.

Dokumentasi pada kegiatan komunikasi terapeutik dalam keperawatan jiwa sangat penting memastikan bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh perawat dengan pasien jiwa terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai acuan untuk perawatan selanjutnya.

Tujuan dokumentasi Komunikasi terapeutik adalah:

- a. Mencatat proses komunikasi yaitu: kegiatan mencatat proses komunikasi yang dilakukan oleh perawat dengan pasien jiwa.
- b. Mendokumentasikan respon pasien, yaitu: mendokumentasikan respon pasien terhadap kegiatan komunikasi terapeutik yang dilakukan.
- c. Mencatat kemajuan pasien, Yaitu: mencatat kemajuan atau kemunduran status Kesehatan jiwa pasien dalam proses perawatan.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan pasien, yaitu: mengelompokkan kebutuhan pasien jiwa yang perlu dibantu atau dipenuhi.

Manfaat dokumentasi komunikasi terapeutik adalah: Meningkatkan kualitas perawatan pasien jiwa, Meningkatkan komunikasi antara perawat dan pasien jiwa, Meningkatkan kepercayaan pasien jiwa terhadap perawat, Mencatat kemajuan pasien jiwa dalam proses perawatan.

Komponen-komponen yang harus didokumentasikan dalam kegiatan komunikasi terapeutik adalah sebagai berikut:

a. Tanggal dan waktu;

Tanggal dan waktu komunikasi terapeutik dilakukan antara perawat dan pasien jiwa.

b. Identitas pasien;

Data lengkap pasien harus lengkap meliputi: Nama, tempat tanggal lahir, Umur, Jenis kelamin, dan Alamat lengkap.

c. Tujuan komunikasi;

Menetapkan tujuan komunikasi yang dilakukan

d. Proses komunikasi yang dilakukan oleh perawat dengan pasien jiwa. Diawali proses fase preinteraksi, fase orientasi, fase kerja dan fase akhir.

e. Respon pasien jiwa terhadap komunikasi terapeutik yang telah dilakukan.

Respon pasien jiwa yang perlu di dokumentasikan dalam komunikasi terapeutik adalah:

Respon Verbal meliputi:

- 1) Pernyataan, yang dibuat oleh pasien jiwa tentang perasaan, pikiran atau pengalaman pasien saat ini atau masa lalu.
- 2) Jawaban yang diberikan oleh pasien jiwa terhadap pertanyaan atau pernyataan perawat.
- 3) Komentar, yang didapat dari pasien jiwa dari topik yang disampaikan dalam proses komunikasi terapeutik.

Respon Nonverbal meliputi:

- 1) Ekspresi wajah pasien jiwa yang menunjukkan emosi atau perasaan pasien jiwa.
- 2) Bahasa tubuh pasien jiwa dapat menunjukkan sikap atau perilaku dari pasien jiwa.
- 3) Kontak mata pasien jiwa dengan perawat apakah terfokus atau tidak.

Respon Emosional meliputi:

- 1) Perasaan yang dialami oleh pasien jiwa, seperti sedih, Bahagia atau marah.
- 2) Mood pasien jiwa yang menunjukkan keadaan emosi pasien jiwa.
- 3) Reaksi pasien jiwa terhadap situasi atau stimulus tertentu.

Respon Kognitif meliputi:

- 1) Pikiran yang dimiliki oleh pasien jiwa tentang diri mereka sendiri atau lingkungan sekitar.
- 2) Pemahaman pasien jiwa tentang informasi atau konsep tertentu
- 3) Ingatan pasien jiwa tentang pengalaman atau peristiwa tertentu.

f. Evaluasi hasil komunikasi terapeutik.

Evaluasi dalam proses komunikasi terapeutik adalah:

- 1) Efektivitas komunikasi: apakah komunikasi terapeutik yang dilakukan efektif dalam mencapai tujuan?
- 2) Kualitas Komunikasi: Apakah kualitas komunikasi yang dilakukan baik dan sesuai dengan kebutuhan pasien?
- 3) Kesiambungan komunikasi: Apakah komunikasi terapeutik yang dilakukan berkelanjutan dan konsisten?

Evaluasi respon pasien, meliputi: Perubahan perilaku: apakah pasien menunjukkan perubahan perilaku yang positif setelah komunikasi terapeutik? Perubahan emosi: apakah pasien menunjukkan perubahan emosi yang positif setelah komunikasi terapeutik? Peningkatan pemahaman: Apakah pasien menunjukkan peningkatan pemahaman tentang diri mereka sendiri atau lingkungan sekitar?

Evaluasi Tujuan Komunikasi adalah:

- a. Pencapaian tujuan: apakah tujuan komunikasi terapeutik yang ditetapkan telah tercapai?
- b. Kesesuaian tujuan: apakah tujuan komunikasi terapeutik yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pasien?
- c. Relevansi tujuan: apakah tujuan komunikasi terapeutik yang ditetapkan relevan dengan kondisi pasien?

Evaluasi Peran perawat meliputi: apakah perawat memiliki kemampuan komunikasi yang baik, apakah perawat menunjukkan kesabaran dalam berkomunikasi dengan pasien? apakah perawat menunjukkan empati dalam berkomunikasi dengan pasien?

Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap hasil komunikasi terapeutik, maka perawat dapat meningkatkan kualitas perawatan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

D. Simpulan

Permasalahan kesehatan jiwa merupakan hal krusial dimana sering pasien jiwa mengalami kekambuhan yang berulang atau rentang waktu penyembuhan yang lama. Hal ini disebabkan pasien jiwa selama dalam perawatan belum mendapatkan pelayanan yang optimal terutama pengalihan masalah melalui berkomunikasi terapeutik antara perawat dan pasien. Padahal keperawatan jiwa merupakan bentuk pelayanan keperawatan profesional yang berorientasi pada upaya peningkatan motivasi dalam mengubah perilaku maladaptif menuju perilaku adaptif dengan pendekatan bio, psiko, sosial dan kultural melalui penggunaan diri secara terapeutik yang didasarkan pada tujuan meningkatkan, mencegah dan mempertahankan status kejiwaan melalui proses hubungan interpersonal. Dengan komunikasi terapeutik yang efektif maka akan tercipta hubungan interpersonal, dengan terungkapnya masalah pasien jiwa melalui tahapan komunikasi terapeutik. Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) penerapan dan pengembangan pola komunikasi terapeutik yang efektif pada pasien jiwa dalam mengali masalah, menetapkan masalah prioritas dan menentukan masalah atau mengatasi masalah pasien sehingga dapat mempermudah proses penyembuhan pasien jiwa. 2) Diadakan program pelatihan yang terjadwal dan kontinue bagi perawat jiwa dalam melakukan komunikasi terapeutik yang efektif sehingga mempermudah mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas profesi keperawatan jiwa. 3). Pendokumentasian proses komunikasi terapeutik dalam perawatan jiwa adalah suatu hal yang penting dan sangat mendasar untuk proses dan kelanjutan perawatan pasien jiwa.

E. Referensi

- Arwani. (2003). Komunikasi dalam Keperawatan. Jakarta: EGC
- _____, 1998. Buku saku Keperawatan Jiwa (Terjemahan). Edisi 3. Jakarta: EGC
- _____, 1998. Diagnosa Keperawatan Psikiatri. Edisi 3. Jakarta: EGC.
- Budi Anna Keliat. (1996). Hubungan Terapeutik Perawat-Keliat. Jakarta: EGC.
- Christina, L.I., Untung, S & Tatik, I (2003). Komunikasi Kebidanan. Jakarta: EGC
- Ellis, R., Gates, R., & Kenworthy, N. (2000). Komunikasi Interpersonal Dalam Keperawatan: Teori dan Praktik. Alih Bahasa: Susi Purwoko, Jakarta, EGC.
- Heri Purwanto. (1994). Komunikasi untuk Perawat. Jakarta: EGC
- Intan Nurjannah. (2005). Pedoman Penanganan gangguan Jiwa: Manajemen Proses Keperawatan & Hubungan Terapeutik Perawat-Klien. Yogyakarta: Moco Media.
- Intansari Nurjannah. (2005). Komunikasi Keperawatan: Dasar-Dasar Komunikasi bagi Perawat. Yogyakarta; Moco Media
- Iyus yosep. (2007). Keperawatan Jiwa. Bandung: Refika Aditama.
- Kariyoso. (1994). Pengantar Komunikasi bagi Perawat. Jakarta: EGC.
- Keliat, B.A. dan Helena P. (2005). Proses Keperawatan Kesehatan Jiwa. Edisi 2. Jakarta: EGC.
- Keliat. B.A (2002), Hubungan Terapeutik Perawat-Klien, EGC, Jakarta.
- Maslim R (ed). 2001. Buku saku Diagnosis gangguan jiwa: Rujukan Ringkas dari PPDGJ III. Jakarta; Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya.
- Muskhriyah Damaiyanti. (2008). Komunikasi Terapeutik dalam Praktek Keperawatan: Bandung; Refika Aditama.
- Musliha and Fatmawati. (2020). Komunikasi perawatan Plus materi komunikasi terapeutik. Yogyakarta: Muha Medika.
- Nurjannah, 2001. Hubungan Terapeutik Perawat Dan Klien: Kualitas Pribadi Sebagai

Sarana, Yogyakarta: PSIK FK UGM.

Siti Sundari, HS. (2005). Kesehatan Mental Dalam Kehidupan. Jakarta: Rineka Cipta.

Smith, S. (1992). Communication in Nursing. St. Louis: Mosby Year Book.

Stuart, G.W.&Sundeen, S.J. (1998). Principle and Practice of Psyciatric Nursing.St. Louis: Mosby Year Book.

Suliswati, dkk. 2005. Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa. Jakarta: EGC.

Suryani. (2006). Komunikasi Terapeutik: Teori & Praktek. Jakarta: EGC.

Uswatun, K & Yuni, PI. (2005). Panduan Praktikum Komunikasi: Menggunakan Komunikasi dalam Praktek Keperawatan. Edisi 1. Yogyakarta: PSIK UMY.

F. Glosarium

Altruisme:

Sikap atau perilok yang dilakukan untuk menolong orang lain secara tulus tanpa mengharapkan balasan.

Assertive (Asertif):

Kemampuan seseorang dalam menyampaikan pikiran dan perasaan secara jelas, jujur, dan langsung, namun tetap menghargai orang lain.

Boundary Violation:

Pelanggaran batas dalam hubungan terapeutik antara perawat dan pasien yang terjadi ketika perawat terlibat dalam interaksi sosial, ekonomi, atau pribadi yang melampaui batas hubungan profesional.

Clarity:

Kejelasan pesan dalam komunikasi; disampaikan secara terbuka, transparan, tanpa adanya hal yang disembunyikan.

Countertransference:

Respons emosional yang tidak disadari oleh perawat terhadap pasien, yang muncul dari pengalaman pribadi perawat sendiri dan dapat mempengaruhi hubungan terapeutik secara negatif.

Dokumentasi Keperawatan Jiwa:

Proses pencatatan secara sistematis informasi yang diperoleh selama proses komunikasi terapeutik untuk digunakan dalam perawatan dan evaluasi pasien gangguan jiwa.

Empati:

Kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi atau kondisi yang dialami orang lain dengan menempatkan diri pada posisi orang tersebut.

Hambatan Komunikasi Terapeutik:

Segala sesuatu yang menghalangi atau menghambat efektivitas komunikasi terapeutik antara perawat dan pasien, misalnya resistensi, transference, atau countertransference.

Humor:

Teknik komunikasi terapeutik yang digunakan untuk menciptakan suasana nyaman dan mengurangi ketegangan dalam hubungan perawat-pasien.

Ilusi:

Gangguan persepsi berupa interpretasi atau pemahaman yang salah terhadap suatu stimulus nyata yang ada di lingkungan sekitar pasien.

Halusinasi:

Gangguan persepsi berupa pengalaman sensorik yang dialami pasien tanpa adanya stimulus nyata dari lingkungan sekitar.

Klarifikasi:

Teknik komunikasi terapeutik di mana perawat meminta penjelasan atau mengulang pernyataan pasien untuk memastikan pemahaman yang tepat.

Kompulsi:

Dorongan kuat dan tidak terkendali untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku secara berulang-ulang yang bertujuan mengurangi kecemasan.

Komunikasi Terapeutik:

Proses komunikasi yang disengaja dan direncanakan antara perawat dengan pasien, bertujuan memberikan efek penyembuhan atau pemulihan.

Delusi:

Gangguan pemikiran berupa keyakinan yang tidak sesuai kenyataan atau tidak berdasar, yang dipertahankan oleh pasien meskipun telah dibuktikan sebaliknya.

Empathy (Empati):

Kemampuan memahami perasaan atau keadaan emosi orang lain dengan menempatkan diri pada posisi atau kondisi orang tersebut.

Fobia:

Ketakutan yang tidak rasional dan sangat berlebihan terhadap objek, situasi, atau aktivitas tertentu yang sebenarnya tidak membahayakan.

Obsesi:

Pikiran atau perasaan yang terus-menerus muncul secara berulang, biasanya tidak menyenangkan, dan tidak dapat dikendalikan oleh pasien.

Respect:

Sikap menghormati, menghargai, dan menerima orang lain apa adanya dalam proses komunikasi.

Resistensi:

Keengganan atau penolakan pasien untuk menyadari atau menerima penyebab kecemasan atau masalah yang dihadapinya, sering muncul dalam proses terapi.

Refleksi:

Teknik komunikasi terapeutik berupa pengulangan kembali atau penyampaian kembali isi pembicaraan pasien dengan tujuan memperjelas dan menunjukkan pemahaman.

Transference:

Respons emosional pasien terhadap perawat yang berasal dari pengalaman masa lalu dengan orang lain, biasanya tokoh penting di masa lalu pasien, yang diproyeksikan ke perawat.

CHAPTER 3

PENGKAJIAN KEPERAWATAN JIWA SECARA KOMPREHENSIF

Hanim Nur Faiza, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Pengkajian merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses keperawatan, termasuk dalam keperawatan jiwa. Dalam konteks pelayanan keperawatan jiwa, pengkajian tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengumpulkan data dasar, melainkan sebagai fondasi utama dalam memahami kondisi psikologis, perilaku, serta fungsi sosial pasien secara menyeluruh. Proses pengkajian keperawatan jiwa memerlukan sensitivitas yang tinggi, pendekatan yang empatik, dan keterampilan profesional yang mendalam karena menyangkut aspek-aspek yang tidak selalu tampak secara kasatmata seperti pikiran, emosi, persepsi, hingga makna hidup yang dirasakan oleh pasien.

Pentingnya pengkajian dalam asuhan keperawatan jiwa terletak pada perannya sebagai jembatan antara identifikasi masalah dan penentuan intervensi keperawatan yang tepat. Seorang perawat jiwa tidak dapat merancang rencana tindakan atau terapi yang efektif tanpa terlebih dahulu memahami dengan cermat latar belakang psikososial, status mental, nilai-nilai pribadi, serta kebutuhan spiritual pasien. Misalnya, dalam menangani pasien dengan depresi berat, perawat tidak hanya mencatat gejala seperti menangis atau tidak nafsu makan, tetapi juga perlu mengeksplorasi pola pikir negatif yang muncul, relasi sosial yang menurun, pengalaman traumatik di masa lalu, serta adanya risiko bunuh diri. Semua itu menjadi bagian integral dari pengkajian yang komprehensif.

Tujuan dari pengkajian jiwa secara menyeluruh adalah untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi pasien, baik dari sisi biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual (pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual). Pengkajian ini membantu perawat dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus pasien, memahami respons pasien terhadap stres atau penyakit, serta menentukan area mana yang paling membutuhkan perhatian dalam perawatan. Selain itu, pengkajian juga bermanfaat dalam membangun hubungan terapeutik yang kuat antara perawat dan pasien. Melalui proses wawancara dan observasi yang dilakukan secara penuh perhatian dan empati, pasien akan merasa

dihargai dan aman untuk membuka diri. Kepercayaan yang terbangun dari awal ini menjadi pondasi keberhasilan intervensi keperawatan selanjutnya.

Pengkajian keperawatan jiwa juga memiliki keterkaitan erat dengan seluruh tahapan proses keperawatan yang akan dijalankan. Hasil pengkajian akan menjadi dasar dalam menetapkan diagnosis keperawatan jiwa, seperti harga diri rendah, risiko kekerasan terhadap diri sendiri, atau isolasi sosial. Setelah diagnosis ditegakkan, perawat dapat menyusun rencana intervensi yang lebih terarah, spesifik, dan relevan dengan kondisi unik pasien. Selanjutnya, selama pelaksanaan dan evaluasi, data dari pengkajian awal akan menjadi pembanding untuk menilai efektivitas intervensi serta menentukan kemajuan pemulihan pasien. Dengan kata lain, kualitas dan ketepatan pengkajian sangat menentukan kualitas keputusan klinis dan keberhasilan program asuhan keperawatan jiwa secara keseluruhan.

Di tengah meningkatnya kompleksitas gangguan jiwa dan kebutuhan pelayanan yang berbasis bukti (*evidence-based practice*), pengkajian jiwa yang komprehensif tidak hanya menjadi kewajiban teknis, melainkan juga merupakan wujud tanggung jawab moral dan profesional seorang perawat jiwa dalam memberikan pelayanan yang bermartabat, manusiawi, dan bermakna bagi pasien. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan pengkajian jiwa perlu ditanamkan sejak awal pendidikan keperawatan dan terus dikembangkan sepanjang praktik klinis perawat.

B. Prinsip Dasar Pengkajian Keperawatan Jiwa

Pengkajian dalam keperawatan jiwa tidak hanya berfokus pada aspek medis atau fisik semata, melainkan mencakup dimensi yang jauh lebih luas, yaitu aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar ini sangat penting agar proses pengkajian tidak bersifat parsial atau sempit, melainkan mampu menangkap kompleksitas kehidupan klien secara holistik. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini menjadi acuan bagi perawat jiwa dalam mengorganisasi data, membangun hubungan terapeutik, serta merumuskan intervensi yang relevan dan bermakna.

Prinsip bio-psiko-sosial-spiritual-kultural merupakan pendekatan integratif yang paling sering digunakan dalam keperawatan jiwa modern. Aspek biologis mencakup pemahaman terhadap kondisi medis pasien, pengaruh genetik, status neurologis, hingga efek farmakologis dari obat-obatan psikotropika. Sebagai contoh, perawat perlu mengetahui apakah gangguan kejiwaan yang dialami pasien berkaitan dengan gangguan neurotransmitter, efek samping obat, atau penyakit metabolik yang belum

terdiagnosis. Selanjutnya, aspek psikologis berkenaan dengan emosi, proses pikir, persepsi diri, serta kemampuan koping terhadap stres dan masalah hidup. Dalam pengkajian ini, perawat mengeksplorasi bagaimana pasien memaknai kejadian dalam hidupnya, bagaimana ia mengekspresikan emosi, serta apa yang menjadi sumber ketegangan mentalnya.

Sementara itu, aspek sosial meliputi relasi interpersonal, dukungan keluarga, peran dalam masyarakat, serta faktor-faktor lingkungan yang mungkin memengaruhi kondisi jiwa pasien. Misalnya, perawat perlu menilai apakah pasien mengalami isolasi sosial, konflik keluarga, atau kehilangan pekerjaan yang menjadi pemicu stres berat. Tidak kalah pentingnya adalah aspek spiritual dan kultural. Aspek spiritual mencakup nilai, keyakinan, dan makna hidup yang diyakini oleh pasien, yang sering kali menjadi sumber kekuatan atau justru hambatan dalam proses pemulihan. Dalam aspek kultural, perawat mempertimbangkan latar belakang budaya yang memengaruhi bagaimana seseorang memaknai gangguan jiwa, mencari pertolongan, serta menanggapi intervensi. Di beberapa budaya, gangguan jiwa masih sangat distigmatisasi atau dianggap sebagai hal mistik, sehingga strategi pengkajian dan pendekatan harus disesuaikan secara sensitif dan penuh penghormatan.

Di samping itu, prinsip penting lainnya dalam pengkajian keperawatan jiwa adalah penggunaan pendekatan humanistik dan empatik. Pendekatan ini menempatkan pasien bukan hanya sebagai subjek pengumpulan data, tetapi sebagai individu utuh yang berhak dihargai, didengarkan, dan dipahami secara tulus. Perawat yang menggunakan pendekatan ini akan menekankan penerimaan tanpa menghakimi, menjalin hubungan berdasarkan kepercayaan, serta membangun dialog yang memungkinkan pasien merasa aman untuk membuka perasaan dan pengalaman pribadinya. Empati dalam hal ini bukan sekadar memahami perasaan pasien, tetapi juga menunjukkan kehadiran emosional dan kepekaan perawat dalam setiap respons verbal maupun nonverbal. Sikap empatik menjadi penting karena banyak pasien jiwa yang merasa tersisih, takut, dan kehilangan rasa percaya terhadap lingkungan sekitarnya.

Dalam kerangka pengkajian keperawatan jiwa, komunikasi terapeutik memainkan peran yang sangat sentral. Komunikasi ini bukan sekadar alat pertukaran informasi, tetapi menjadi media utama untuk membangun hubungan terapeutik dan menggali data secara mendalam. Melalui komunikasi terapeutik, perawat dapat mengeksplorasi pikiran-pikiran klien yang terdalam, memahami konflik batin yang sedang dialaminya, serta menciptakan suasana yang aman untuk mengekspresikan emosi. Teknik komunikasi terapeutik seperti mendengarkan aktif, refleksi, klarifikasi, empati, dan diam

terapeutik digunakan secara strategis untuk membuka ruang percakapan yang bermakna. Misalnya, ketika seorang pasien menunjukkan tanda-tanda kesedihan yang mendalam tetapi menolak bicara, perawat dapat menggunakan teknik diam dan kemudian memberikan pernyataan empatik seperti “Saya bisa melihat bahwa hari ini terasa sangat berat untuk Anda” sebagai pintu masuk pengkajian.

C. Komponen Pengkajian Keperawatan Jiwa

1. Data Identitas dan Riwayat Sosial

Komponen pertama dalam pengkajian adalah data identitas dan riwayat sosial, yang meliputi nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, serta status sosial pasien. Data ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas administratif, tetapi juga memberikan konteks awal tentang latar belakang sosial pasien. Misalnya, tingkat pendidikan dapat memengaruhi cara pasien memahami kondisinya, sementara status pekerjaan dan hubungan sosial bisa berperan dalam tingkat stres dan dukungan sosial yang tersedia. Riwayat Kesehatan dan Keperawatan

- a. Riwayat penyakit jiwa dan fisik sebelumnya
- b. Penggunaan obat-obatan dan terapi sebelumnya

2. Keluhan Utama dan Kronologi Masalah

Riwayat kesehatan dan keperawatan, yang mencakup dua hal penting: riwayat penyakit jiwa dan fisik sebelumnya, serta riwayat penggunaan obat-obatan dan terapi. Dalam hal ini, perawat perlu menggali apakah pasien pernah dirawat karena gangguan jiwa, jenis diagnosis yang pernah diberikan, durasi penyakit, serta keberhasilan atau kegagalan terapi terdahulu. Riwayat penggunaan obat, termasuk obat-obat psikotropika, sangat penting untuk menilai efektivitas terapi sebelumnya, adanya efek samping, kepatuhan, atau kemungkinan ketergantungan.

3. Fungsi Mental

Fungsi mental, yang menilai secara sistematis status mental pasien saat ini. Fungsi ini mencakup penampilan umum dan perilaku (apakah rapi atau acak-acakan, tenang atau gelisah), proses pikir yang meliputi konten (isi) dan bentuk pikir (struktur dan alur logika berpikir), serta persepsi seperti halusinasi atau delusi yang mungkin dialami pasien. Afek (ekspresi emosional yang tampak) dan mood (suasana hati yang dilaporkan) juga menjadi indikator penting dari kondisi psikologis pasien. Orientasi terhadap waktu, tempat, dan orang memberi gambaran tentang kemampuan realitas pasien. Fungsi lainnya termasuk konsentrasi, daya ingat, serta insight, yaitu

kesadaran pasien terhadap kondisi dirinya—apakah ia menyadari bahwa dirinya mengalami gangguan jiwa dan memahami perlunya pengobatan.

4. Status Emosional dan Sosial

Status emosional dan sosial juga menjadi aspek penting. Perawat harus menilai sejauh mana pasien mampu terlibat dalam aktivitas sosial, apakah pasien merasa terisolasi, serta bagaimana kualitas hubungan interpersonalnya. Dukungan keluarga, keberadaan teman, dan keterlibatan dalam lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap proses pemulihan pasien. Kurangnya dukungan sosial dapat memperburuk kondisi psikologis pasien dan meningkatkan risiko kekambuhan.

5. Status Spiritual dan Budaya

Status spiritual dan budaya tidak boleh diabaikan, karena keduanya sangat memengaruhi cara pasien memandang penyakit, proses penyembuhan, serta cara mereka menghadapi penderitaan. Nilai-nilai spiritual dapat menjadi sumber ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi gangguan jiwa. Sementara itu, budaya memengaruhi keyakinan pasien tentang penyebab penyakit dan metode penyembuhan yang dipilih. Di beberapa budaya, gangguan jiwa masih dianggap tabu atau dikaitkan dengan kekuatan gaib, sehingga pendekatan keperawatan harus dilakukan dengan sensitif dan penuh penghargaan.

6. Fungsi Kognitif dan Neuropsikologis

Komponen selanjutnya adalah fungsi kognitif dan neuropsikologis, yang meliputi kemampuan konsentrasi, pemahaman terhadap situasi, serta kemampuan bernalar dan membuat keputusan. Pemeriksaan fungsi ini penting terutama dalam kasus-kasus seperti demensia, delirium, atau gangguan kognitif lainnya. Pemeriksaan sederhana seperti menghitung mundur, menyebutkan hari, atau mengulang kalimat dapat memberikan gambaran awal mengenai fungsi intelektual pasien.

7. Kemampuan ADL (Activity of Daily Living)

Kemampuan aktivitas sehari-hari (ADL/Activity of Daily Living) menjadi indikator penting dalam menilai derajat kemandirian pasien. Perawat harus menilai apakah pasien mampu mandi, berpakaian, makan, atau mengurus kebersihan diri tanpa bantuan. Penurunan kemampuan ini menunjukkan tingkat gangguan yang signifikan dan menjadi dasar untuk merancang intervensi dukungan harian.

8. Risiko Bahaya

Terakhir, komponen risiko bahaya adalah aspek yang sangat krusial dalam pengkajian keperawatan jiwa. Perawat harus mengidentifikasi adanya risiko bunuh

diri, kekerasan terhadap orang lain, atau risiko pelarian dari fasilitas pelayanan. Risiko-risiko ini memerlukan intervensi segera karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien dan orang-orang di sekitarnya. Perawat harus menggali ide bunuh diri, rencana yang mungkin dimiliki pasien, dan riwayat upaya sebelumnya. Evaluasi risiko harus dilakukan secara sistematis dan berulang untuk memastikan bahwa pasien berada dalam kondisi yang aman.

D. Teknik dan Alat dalam Pengkajian Jiwa

Pengkajian jiwa merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Untuk memperoleh data yang akurat, valid, dan mencerminkan kondisi psikososial klien secara menyeluruh, perawat jiwa memerlukan keterampilan dalam menerapkan berbagai teknik serta memanfaatkan alat bantu yang sesuai. Penggunaan teknik pengkajian yang tepat tidak hanya membantu dalam pengumpulan informasi yang komprehensif, tetapi juga memperkuat hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Pendekatan ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, serta melibatkan sumber informasi tambahan dari keluarga dan tenaga kesehatan lainnya. Berikut adalah mengenai teknik dan alat yang digunakan dalam pengkajian keperawatan jiwa:

1. Observasi perilaku

Observasi merupakan teknik dasar dalam pengkajian jiwa yang dilakukan sejak awal interaksi antara perawat dan klien. Melalui observasi, perawat dapat menangkap data nonverbal yang sangat penting, seperti ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, kebersihan diri, cara berpakaian, respons terhadap rangsangan lingkungan, dan pola bicara. Misalnya, pasien dengan depresi berat mungkin tampak murung, lamban, dan tidak menjaga kebersihan diri. Sebaliknya, pasien dalam episode manik mungkin tampak hiperaktif, berbicara cepat, dan berpakaian mencolok. Observasi memungkinkan perawat mengenali pola perilaku khas dari berbagai gangguan jiwa dan mendeteksi tanda-tanda krisis atau risiko seperti agitasi, menarik diri, atau gelagat ingin melukai diri. Observasi harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, baik selama interaksi langsung maupun saat klien beraktivitas di lingkungan.

2. Wawancara terapeutik

Wawancara merupakan teknik utama dalam menggali informasi verbal dari klien. Berbeda dengan wawancara biasa, wawancara terapeutik dilakukan dalam suasana yang mendukung, hangat, dan profesional, dengan tujuan memahami perasaan, pikiran, serta pengalaman hidup klien secara mendalam. Dalam proses ini,

perawat tidak hanya bertanya tetapi juga mendengarkan secara aktif dan reflektif. Teknik-teknik seperti klarifikasi, parafrase, konfrontasi ringan, dan penggunaan diam terapeutik menjadi bagian integral dari komunikasi. Wawancara dilakukan secara bertahap, diawali dengan pertanyaan umum dan netral, kemudian berlanjut ke pertanyaan eksploratif yang lebih dalam. Keberhasilan wawancara terapeutik sangat bergantung pada kemampuan perawat membangun rapport (hubungan saling percaya) dan mempertahankan batas profesional yang sehat. Wawancara juga dapat digunakan untuk menilai status mental, seperti orientasi, persepsi, isi pikir, dan mood.

3. Kuesioner dan skala psikometrik (GDS, MMSE, BDI, dll.)

Dalam beberapa kasus, perawat memerlukan alat ukur yang baku dan terstandarisasi untuk melengkapi data subjektif dan objektif yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Kuesioner dan skala psikometrik digunakan untuk menilai tingkat keparahan gejala psikologis, fungsi kognitif, serta kondisi emosional pasien secara lebih kuantitatif. Beberapa skala yang umum digunakan antara lain:

- a. Geriatric Depression Scale (GDS) untuk skrining depresi pada lansia.
- b. Mini-Mental State Examination (MMSE) untuk menilai fungsi kognitif dan mendeteksi penurunan daya pikir, seperti pada demensia.
- c. Beck Depression Inventory (BDI) untuk mengukur tingkat depresi pada dewasa.
- d. Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) untuk menilai tingkat kecemasan.
- e. Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) untuk mengevaluasi gejala skizofrenia.

Penggunaan skala harus dilakukan dengan mempertimbangkan validitas, reliabilitas, serta kemampuan kognitif klien dalam memahami instruksi. Perawat juga harus mampu menafsirkan hasil skala dengan hati-hati dan tidak menggantikan penilaian klinis secara keseluruhan.

4. Pemeriksaan fisik dan laboratorium pendukung

Walaupun pengkajian jiwa berfokus pada aspek psikologis dan perilaku, aspek biologis tetap menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Banyak gangguan mental memiliki komponen fisik yang menyertainya atau dipicu oleh kondisi medis tertentu. Oleh karena itu, pemeriksaan fisik dan laboratorium perlu dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab organik dari gejala kejiwaan. Misalnya, gangguan tiroid dapat menimbulkan gejala depresi atau mania, sementara gangguan elektrolit atau infeksi dapat memicu delirium. Pemeriksaan ini juga penting untuk memantau efek samping obat psikotropika seperti perubahan

berat badan, gangguan fungsi hati, peningkatan gula darah, atau efek terhadap sistem kardiovaskular. Data dari pemeriksaan fisik dan laboratorium akan melengkapi pengkajian keperawatan dan membantu dalam penetapan rencana asuhan yang lebih komprehensif.

5. Kolaborasi dengan keluarga dan tim multidisiplin

Dalam keperawatan jiwa, kolaborasi merupakan bagian penting dari proses pengkajian. Informasi dari klien sering kali terbatas, terutama pada pasien dengan gangguan persepsi, realitas terganggu, atau penurunan fungsi kognitif. Oleh karena itu, keluarga menjadi sumber informasi yang sangat penting untuk memperoleh riwayat penyakit, perubahan perilaku, pola komunikasi, serta dukungan sosial yang tersedia di rumah. Selain itu, perawat juga harus berkoordinasi dengan tim multidisiplin yang terdiri dari psikiater, psikolog, pekerja sosial, terapis okupasi, dan lainnya untuk mendapatkan data tambahan, menyelaraskan penilaian, dan menyusun rencana asuhan yang terpadu. Kolaborasi ini memperkuat kualitas pengkajian dan menjamin bahwa semua aspek kebutuhan pasien dipertimbangkan secara menyeluruh.

E. Pendokumentasian Data Pengkajian

Pendokumentasian merupakan bagian integral dari proses keperawatan, termasuk dalam keperawatan jiwa. Dokumentasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai catatan medis, tetapi juga sebagai alat komunikasi antar tim kesehatan, bukti hukum, serta dasar untuk perencanaan dan evaluasi asuhan keperawatan. Dalam konteks keperawatan jiwa, pendokumentasian memiliki keunikan tersendiri karena berkaitan dengan kondisi mental, perilaku, dan psikososial klien yang bersifat dinamis dan sering kali subjektif. Oleh karena itu, pencatatan harus dilakukan secara sistematis, akurat, obyektif, dan penuh etika.

Salah satu format pendokumentasian yang umum digunakan dalam praktik keperawatan adalah format SOAP, yang terdiri dari empat elemen utama: Subjective, Objective, Assessment, dan Plan. Dalam komponen Subjective, perawat mencatat informasi yang disampaikan langsung oleh klien, seperti keluhan perasaan, pikiran yang mengganggu, atau pengalaman halusinasi. Informasi ini sangat penting dalam keperawatan jiwa karena banyak masalah kejiwaan hanya bisa diketahui dari narasi pasien. Misalnya, seorang klien mungkin menyatakan, "Saya merasa tidak berharga dan ingin menghilang," yang menunjukkan adanya risiko bunuh diri. Dalam komponen Objective, perawat mencatat hasil observasi seperti ekspresi wajah, gaya bicara, cara

berpakaian, hingga hasil pengukuran psikometrik atau tanda vital. Kemudian, komponen Assessment berisi interpretasi klinis perawat terhadap data yang diperoleh, misalnya adanya isolasi sosial, gangguan persepsi sensori, atau penurunan harga diri. Terakhir, komponen Plan merinci rencana intervensi, edukasi, atau tindak lanjut yang akan dilakukan berdasarkan temuan pengkajian.

Dokumentasi yang dibuat harus selalu obyektif dan etis. Obyektivitas berarti bahwa informasi yang ditulis adalah hasil dari pengamatan nyata atau pernyataan langsung pasien, bukan penilaian pribadi atau asumsi perawat. Hindari penggunaan kata-kata yang mengandung stigma atau penilaian emosional, seperti "pasien menyebalkan" atau "tidak kooperatif", kecuali disertai dengan bukti perilaku yang spesifik. Misalnya, lebih tepat menuliskan "klien menolak menjawab pertanyaan dan membalikkan badan saat diajak berbicara" daripada menyatakan "klien sulit diajak kerja sama". Dari sisi etika, perawat harus menjaga kerahasiaan data klien dan tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh. Semua informasi, termasuk yang sangat pribadi, harus disimpan dan ditulis dengan mempertimbangkan kode etik profesi dan hak-hak klien sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam era digitalisasi, penggunaan catatan elektronik (Electronic Health Records/EHR) menjadi hal yang semakin umum di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk di bidang keperawatan jiwa. Sistem pencatatan elektronik memiliki banyak keunggulan, seperti memudahkan akses data antar tim kesehatan, mempercepat proses pelaporan, mengurangi risiko kehilangan data, dan meningkatkan efisiensi kerja. Namun, penggunaan EHR juga menuntut kehati-hatian tinggi, terutama dalam aspek keamanan dan kerahasiaan data. Data klien jiwa tergolong sangat sensitif karena berkaitan dengan privasi, stigma sosial, dan potensi penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, perawat harus mengikuti prosedur keamanan data, seperti penggunaan password, otorisasi akses, dan enkripsi file untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat membuka catatan klien.

Dalam situasi tertentu, terutama dalam kasus hukum atau audit klinis, dokumentasi keperawatan dapat menjadi bukti yang sangat penting. Oleh karena itu, semua catatan harus dibuat secara kronologis, tepat waktu, dan mencerminkan proses pengkajian serta pertimbangan klinis yang matang. Ketidaksesuaian dalam pencatatan, seperti kesenjangan waktu, penghapusan data tanpa keterangan, atau catatan yang tidak konsisten, dapat melemahkan kredibilitas profesional perawat dan bahkan membahayakan posisi hukum institusi.

F. Tantangan dan Etika dalam Pengkajian Jiwa

Pengkajian dalam keperawatan jiwa merupakan proses yang menuntut sensitivitas tinggi dan integritas profesional, mengingat klien yang dihadapi berada dalam kondisi psikologis yang sangat rentan. Meski pengkajian adalah fondasi dari intervensi keperawatan, proses ini tidak selalu berlangsung dengan mudah. Perawat jiwa sering kali menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi teknis, emosional, maupun etis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai tantangan serta prinsip etika dalam pengkajian jiwa sangat penting agar perawat dapat bertindak secara profesional, manusiawi, dan bertanggung jawab.

Salah satu tantangan utama dalam pengkajian jiwa adalah hambatan komunikasi dan kerahasiaan informasi. Tidak semua pasien mampu atau mau mengungkapkan perasaan dan pikirannya secara terbuka. Gangguan mental seperti skizofrenia, depresi berat, atau gangguan afektif bipolar sering kali mengganggu kemampuan verbal dan nonverbal klien. Klien dapat bersikap tertutup, curiga, tidak kooperatif, atau bahkan mengalami gangguan persepsi dan disorganisasi pikir yang membuat komunikasi menjadi tidak efektif. Perawat jiwa harus mampu menggunakan teknik komunikasi terapeutik yang tepat serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar klien merasa nyaman berbicara. Di sisi lain, semua informasi yang diperoleh selama proses pengkajian harus dijaga kerahasiaannya. Perawat tidak boleh menyebarkan informasi pribadi klien kepada pihak lain tanpa izin, kecuali jika hal tersebut berkaitan dengan risiko keselamatan klien atau orang lain. Pelanggaran terhadap kerahasiaan ini tidak hanya mencederai kepercayaan klien, tetapi juga merupakan pelanggaran etika dan hukum yang serius.

Tantangan lainnya adalah penolakan pasien terhadap proses pengkajian, terutama pada pasien dalam kondisi psikotik atau dengan gangguan realitas. Pada fase akut gangguan jiwa, seperti psikosis, klien mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sakit (*lacking insight*), menolak kehadiran petugas kesehatan, atau bahkan merasa terancam. Dalam situasi ini, perawat tidak bisa memaksakan pengkajian secara langsung tanpa menciptakan relasi terapeutik terlebih dahulu. Dibutuhkan pendekatan yang empatik, penuh kesabaran, dan fleksibel agar klien tidak merasa dimanipulasi atau diserang. Pada kasus-kasus tertentu, seperti pasien yang agresif atau dalam keadaan mengamuk, pengkajian harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan perawat dan klien itu sendiri, serta mungkin melibatkan bantuan tim keamanan atau tenaga medis lainnya. Perawat juga perlu memahami bahwa penolakan bukanlah bentuk perlawanan pribadi, tetapi bagian dari dinamika gangguan jiwa yang dialami klien.

Aspek penting lainnya adalah pertimbangan hukum dan etis saat melakukan pengkajian risiko, terutama ketika menyangkut isu-isu seperti bunuh diri, kekerasan, atau pelarian. Dalam situasi di mana terdapat indikasi bahwa klien berisiko melukai diri sendiri atau orang lain, perawat memiliki kewajiban etis dan hukum untuk bertindak demi keselamatan. Pengkajian risiko bunuh diri, misalnya, harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menggunakan alat ukur yang sesuai, serta dilengkapi dengan observasi klinis dan wawancara mendalam. Namun, dalam mengidentifikasi risiko ini, perawat tetap harus menghormati martabat dan otonomi klien. Tindakan seperti pengawasan ketat, pembatasan ruang gerak, atau penggunaan intervensi paksa (restrain) hanya boleh dilakukan jika sudah tidak ada pilihan lain yang lebih aman dan setelah berkonsultasi dengan tim multidisiplin. Etika profesional mengharuskan perawat untuk menyeimbangkan antara hak klien untuk bebas dan hak masyarakat atau dirinya sendiri untuk aman.

Selain itu, dokumentasi pengkajian risiko harus dilakukan secara rinci dan obyektif, karena hal ini bisa menjadi rujukan penting dalam pengambilan keputusan medis dan hukum. Segala tindakan harus memiliki dasar klinis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Perawat juga dituntut untuk selalu mengupdate pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan penilaian risiko melalui pelatihan profesional, supervisi klinis, dan refleksi praktik.

G. Simpulan

Pengkajian keperawatan jiwa merupakan fondasi utama dalam proses pemberian asuhan yang komprehensif, bermakna, dan berorientasi pada pemulihan klien secara menyeluruh. Tidak hanya sekadar proses pengumpulan data, pengkajian jiwa mencerminkan kemampuan profesional, empati, dan tanggung jawab moral seorang perawat dalam memahami klien sebagai individu yang utuh. Dengan mengacu pada prinsip bio-psiko-sosial-spiritual-kultural, pengkajian yang dilakukan secara holistik memungkinkan perawat mengenali kompleksitas gangguan jiwa, latar belakang psikososial pasien, serta dinamika emosi, pikiran, dan perilaku yang memengaruhi kondisi kejiwaannya.

Melalui penerapan teknik pengkajian yang tepat—seperti observasi, wawancara terapeutik, penggunaan instrumen psikometrik, pemeriksaan medis, serta kolaborasi lintas disiplin—perawat dapat memperoleh gambaran objektif dan mendalam mengenai kondisi pasien. Setiap komponen yang dikaji, mulai dari fungsi mental, status emosional, hubungan sosial, hingga potensi risiko, berkontribusi penting dalam

perumusan diagnosis keperawatan dan perencanaan intervensi yang tepat sasaran. Lebih jauh, pendokumentasian hasil pengkajian secara sistematis, akurat, dan etis menjadi landasan penting untuk menjamin kesinambungan asuhan serta perlindungan hukum dalam praktik keperawatan jiwa.

Namun, pengkajian jiwa juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti hambatan komunikasi, penolakan dari klien, serta pertimbangan etis dan hukum saat menghadapi risiko tinggi. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memiliki kepekaan profesional, integritas moral, serta kemampuan reflektif agar tetap dapat menjaga hak dan martabat klien dalam situasi yang kompleks sekalipun.

Dengan demikian, pengkajian jiwa bukan hanya langkah awal dalam proses keperawatan, tetapi juga jantung dari seluruh praktik keperawatan jiwa yang berorientasi pada keselamatan, kesejahteraan, dan martabat manusia. Perawat yang mampu melakukan pengkajian secara menyeluruh dan etis akan menjadi agen penyembuh yang tidak hanya bekerja dengan kepala dan tangan, tetapi juga dengan hati dan keadaban.

H. Referensi

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Hidayat, A. A. A. (2020). *Pengantar ilmu keperawatan jiwa*. Salemba Medika.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38745>
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. (2016). *Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (10th ed.). Pearson Education.
- Maramis, W. F., & Maramis, A. A. (2022). *Catatan ilmu kedokteran jiwa* (14 ed.). Airlangga University Press.
- Nugroho, H. (2020). *Keperawatan jiwa: Teori dan aplikasi dalam praktik klinik*. Salemba Medika.
- Peplau, H. E. (1991). *Interpersonal relations in nursing: A conceptual frame of reference for psychodynamic nursing*. Springer Publishing Company. (Karya asli diterbitkan tahun 1952)

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2020). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.

PPNI. (2017). *Kode Etik Perawat Indonesia*. Persatuan Perawat Nasional Indonesia. <https://ppni-inna.org>

Videbeck, S. L. (2021). *Psychiatric-mental health nursing* (9th ed.). Wolters Kluwer.

World Health Organization. (2013). *Mental health action plan 2013–2020*. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241506021>

I. Glosarium

Pengkajian jiwa adalah proses sistematis dalam keperawatan yang bertujuan mengumpulkan data menyeluruh tentang kondisi mental, emosional, sosial, dan spiritual klien. Data ini menjadi dasar bagi perawat dalam menetapkan diagnosis dan menyusun intervensi keperawatan jiwa.

Fungsi mental merujuk pada status psikis klien yang mencakup berbagai aspek seperti proses pikir (konten dan bentuk pikir), persepsi, orientasi terhadap waktu, tempat, dan orang, suasana hati (mood), ekspresi emosional (afek), daya ingat, konsentrasi, serta insight atau kesadaran klien terhadap gangguan jiwanya.

Status emosional dan sosial menggambarkan kondisi perasaan klien serta hubungannya dengan lingkungan sekitar, termasuk sejauh mana ia mampu terlibat dalam aktivitas sosial dan menerima dukungan dari keluarga maupun masyarakat.

Status spiritual dan budaya adalah bagian dari pengkajian yang mencakup nilai-nilai, keyakinan pribadi, dan latar belakang budaya klien. Aspek ini berpengaruh terhadap cara klien memahami dan merespons kondisi kejiwaan serta menentukan bentuk dukungan yang dibutuhkannya.

Komunikasi terapeutik merupakan proses komunikasi yang digunakan oleh perawat untuk membangun hubungan saling percaya dengan klien. Komunikasi ini membantu perawat menggali informasi secara empatik dan efektif melalui teknik seperti mendengarkan aktif, klarifikasi, refleksi, dan penggunaan diam terapeutik.

Observasi perilaku adalah teknik pengkajian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, kebersihan diri, dan pola bicara klien. Teknik ini penting untuk mengenali gejala klinis yang mungkin tidak diungkapkan secara verbal.

Wawancara terapeutik adalah interaksi verbal yang dilakukan secara profesional dan empatik, bertujuan untuk mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan pengalaman klien. Wawancara ini juga berguna dalam menilai status mental klien secara menyeluruh.

Kuesioner psikometrik adalah alat ukur terstandarisasi yang digunakan untuk menilai kondisi psikologis klien, seperti tingkat depresi, kecemasan, atau penurunan kognitif. Contohnya termasuk GDS, MMSE, BDI, HAM-A, dan PANSS.

Risiko bahaya mengacu pada potensi ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh klien terhadap dirinya sendiri (misalnya bunuh diri) atau orang lain (misalnya kekerasan fisik). Risiko ini harus dinilai secara hati-hati selama proses pengkajian.

ADL (Activity of Daily Living) adalah kemampuan klien untuk menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti mandi, makan, berpakaian, dan menjaga kebersihan diri.

Pendokumentasian SOAP adalah metode pencatatan data keperawatan yang terdiri dari empat elemen: Subjective (data dari klien), Objective (data observasi perawat), Assessment (kesimpulan klinis), dan Plan (rencana tindak lanjut).

Catatan Elektronik (EHR) adalah sistem pencatatan digital yang digunakan untuk mendokumentasikan dan menyimpan informasi kesehatan klien secara aman, sistematis, dan dapat diakses oleh tim kesehatan yang berwenang.

Insight adalah tingkat kesadaran klien terhadap kondisi gangguan jiwanya serta pemahamannya akan kebutuhan untuk menerima pengobatan.

Humanistik merupakan pendekatan dalam keperawatan yang menghargai nilai dan martabat manusia, serta menempatkan klien sebagai pusat dari pelayanan yang diberikan.

Empati adalah kemampuan perawat untuk merasakan dan memahami pengalaman emosional klien, serta meresponsnya dengan penuh kepekaan tanpa menghakimi.

Kolaborasi multidisiplin mengacu pada kerja sama antara perawat dan tenaga kesehatan lain seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, serta keluarga klien, untuk memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif.

Intervensi keperawatan jiwa adalah tindakan atau strategi yang dirancang berdasarkan hasil pengkajian, bertujuan untuk membantu klien mencapai keseimbangan mental dan meningkatkan fungsi sosialnya.

CHAPTER 4

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN PSIKOTIK

Deasti Nurmaguphita, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J.

A. Pendahuluan/Prolog

Gangguan psikotik merupakan kelompok gangguan mental serius yang ditandai dengan hilangnya kontak dengan realitas, seperti halusinasi, delusi, dan disorganisasi berpikir serta perilaku. Pasien dengan gangguan ini sering kali mengalami penurunan fungsi sosial, pekerjaan, dan personal yang signifikan. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan psikotik memiliki peranan penting dalam pemulihan pasien, mencegah kekambuhan, serta meningkatkan kualitas hidup. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien berperan dalam pengkajian, intervensi, edukasi, dan pendampingan pasien serta keluarga.

Gangguan psikotik dapat muncul secara akut maupun kronis, dan pada sebagian besar kasus, memerlukan pendekatan multidisiplin dalam penanganannya. Dalam konteks keperawatan, penting bagi perawat untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan yang komprehensif dan manusiawi. Hal ini mencakup pengenalan dini terhadap gejala, penerapan komunikasi terapeutik, hingga pelibatan keluarga dalam proses perawatan. Selain itu, perawat juga harus mampu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul selama pasien mengalami fase akut, seperti agresivitas, risiko melukai diri sendiri, atau bahkan bunuh diri. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus terstruktur, berbasis bukti, dan disesuaikan dengan kebutuhan individual pasien.

Dalam praktiknya, asuhan keperawatan pada pasien gangguan psikotik tidak hanya berfokus pada aspek psikologis, namun juga memperhatikan aspek fisik, sosial, dan spiritual pasien. Misalnya, pasien dengan gangguan psikotik kronis dapat mengalami penurunan status gizi, kebersihan diri yang buruk, serta isolasi sosial, yang semuanya perlu diintervensi melalui pendekatan interprofesional. Tujuan utama dari asuhan keperawatan ini adalah membantu pasien mencapai kondisi stabil, mengembalikan fungsi sosialnya, serta mendorong kemandirian pasien dalam

menjalani kehidupan sehari-hari. Perawat berperan sebagai advokat, pendidik, dan fasilitator dalam setiap tahap pemulihan pasien.

B. Konsep Dasar Gangguan Psikotik

Gangguan psikotik mencakup beberapa diagnosis dalam DSM-5, antara lain:

1. Skizofrenia

Definisi:

Skizofrenia adalah gangguan psikotik kronis dan berat yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Penderita sering kehilangan kemampuan untuk membedakan antara realitas dan khayalan.

Gejala utama:

- a. Halusinasi (terutama suara)
- b. Delusi (waham kejar, waham kebesaran)
- c. Pikiran kacau, sulit berbicara secara logis
- d. Perilaku motorik tidak normal (termasuk katatonika)
- e. Gejala negatif (afek datar, alogia, anhedonia)

Durasi:

Minimal berlangsung selama 6 bulan, dengan 1 bulan gejala aktif (fase akut).

Prognosis:

Cenderung kronis, dengan periode remisi dan relaps. Butuh terapi jangka panjang.

2. Gangguan Skizoafektif

Definisi:

Gangguan ini adalah kombinasi antara gejala skizofrenia dan gangguan mood (depresi berat atau mania).

Ciri khas:

- a. Episode mood berlangsung lama
- b. Gejala psikotik (halusinasi atau delusi) terjadi minimal 2 minggu tanpa gejala mood
- c. Ada perubahan suasana hati yang signifikan

Subtipe:

- a. Tipe bipolar (dengan mania ± depresi)
- b. Tipe depresif (dengan episode depresi mayor saja)

Perbedaan utama dengan skizofrenia:

Gangguan mood lebih menonjol dan menetap, sedangkan pada skizofrenia gangguan mood bisa muncul tetapi bersifat sekunder dan sesaat.

3. Gangguan Delusi (Delusional Disorder)

Definisi:

Gangguan ini ditandai dengan keberadaan delusi yang menetap selama ≥ 1 bulan, tanpa gejala skizofrenia lainnya secara signifikan.

Karakteristik:

- a. Delusi biasanya non-bizarre (masih mungkin terjadi dalam kehidupan nyata), seperti:
 - 1) Delusi kejar (merasa dikejar/diikuti)
 - 2) Delusi somatik (merasa tubuh rusak/sakit padahal tidak)
 - 3) Delusi erotomanik (percaya ada orang jatuh cinta padanya)
 - 4) Delusi kebesaran (merasa punya kekuatan istimewa)
 - 5) Delusi cemburu (percaya pasangannya tidak setia)

Fungsi sosial:

Biasanya tetap baik, kecuali dalam konteks delusinya.

Perbedaan utama:

Tidak ada gangguan besar dalam fungsi umum, tidak ada halusinasi menonjol, dan pikiran tetap terstruktur.

4. Gangguan Psikotik Singkat (Brief Psychotic Disorder)

Definisi:

Gangguan psikotik yang tiba-tiba muncul dan berlangsung kurang dari 1 bulan, diikuti dengan pemulihan total.

Ciri khas:

- a. Onset mendadak, biasanya akibat stres berat (misalnya kehilangan orang tercinta, kecelakaan)
- b. Gejala psikotik seperti halusinasi, delusi, atau perilaku kacau
- c. Biasanya terjadi pada orang dengan fungsi premorbid yang baik

Durasi:

Minimal 1 hari hingga maksimal 1 bulan

Prognosis:

Sangat baik bila ditangani cepat. Bisa hanya terjadi sekali seumur hidup.

5. Gangguan Psikotik Induksi (Induced Psychotic Disorder)

Definisi:

Gangguan di mana dua individu atau lebih yang memiliki hubungan dekat saling berbagi delusi yang sama atau mirip.

Contoh:

Seseorang dengan delusi kejar tinggal bersama pasangan atau saudara yang kemudian juga mulai mempercayai hal yang sama.

Ciri khas:

- a. Sering terjadi pada individu yang hidup bersama dalam lingkungan tertutup
- b. Individu yang “terpengaruh” biasanya akan membaik jika dipisahkan dari induk delusi

Faktor risiko:

- a. Hubungan sangat erat
- b. Salah satu individu memiliki gangguan psikotik primer

Definisi

Gangguan psikotik adalah kondisi mental serius yang ditandai dengan hilangnya kemampuan individu untuk membedakan antara kenyataan dan fantasi. Individu dengan gangguan ini mengalami perubahan signifikan dalam:

- a. Proses berpikir (seperti disorganisasi pikiran)
- b. Persepsi (misalnya halusinasi)
- c. Keyakinan (misalnya delusi atau waham)
- d. Perilaku (menjadi aneh, tak terduga, atau tidak sesuai konteks sosial)

Gangguan ini dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, bekerja, dan menjalankan fungsi sosial sehari-hari. Bila tidak ditangani, kondisi ini dapat memburuk dan mengganggu kualitas hidup secara signifikan.

Klasifikasi Gangguan Psikotik

- a. Berdasarkan Durasi: Akut vs Kronis
 - 1) Akut:
 - a) Timbul secara tiba-tiba, biasanya dalam waktu singkat (hari/minggu)
 - b) Gejala bisa sangat parah namun sementara
 - c) Contoh: Gangguan Psikotik Singkat
 - 2) Kronis:
 - a) Berlangsung dalam jangka panjang (bulan hingga bertahun-tahun)
 - b) Sering bersifat progresif atau kambuhan
 - c) Contoh: Skizofrenia, Gangguan Skizoafektif
- b. Berdasarkan Etiologi: Primer vs Sekunder
 - 1) Gangguan Psikotik Primer:
 - a) Muncul sebagai gangguan utama kejiwaan

- b) Tidak disebabkan oleh penyakit fisik atau zat tertentu
- c) Contoh: Skizofrenia, Gangguan Delusi
- 2) Gangguan Psikotik Sekunder:
 - a) Disebabkan oleh kondisi medis umum atau penggunaan zat
 - b) Bisa bersifat reversibel jika penyebab dasarnya diatasi
 - c) Contoh:
 - Psikosis akibat epilepsi lobus temporal (kondisi medis)
 - Psikosis akibat penggunaan amfetamin atau LSD (zat)

C. Etiologi dan Faktor Risiko

Gangguan psikotik bersifat multifaktorial:

1. Faktor Biologis: Ketidakseimbangan neurotransmitter (dopamin, serotonin), kelainan struktur otak
2. Faktor Genetik: Riwayat keluarga dengan gangguan jiwa
3. Faktor Psikososial: Trauma masa kecil, isolasi sosial
4. Faktor Lingkungan: Stres berat, penggunaan zat psikoaktif

D. Manifestasi Klinis Gangguan Psikotik

1. Gejala Positif

Gejala positif adalah penambahan atau distorsi dari fungsi normal. Ini adalah gejala yang tidak dialami oleh orang sehat, dan sering kali paling mencolok selama fase akut.

Jenis-jenis:

- a. Halusinasi: Persepsi sensorik tanpa rangsangan eksternal nyata.
Paling sering adalah halusinasi *auditorik*, seperti mendengar suara yang memerintah, mengomentari, atau menghina.
- b. Delusi (waham): Keyakinan yang salah dan tetap dipertahankan walaupun sudah dibantah dengan bukti nyata. Jenisnya:
 - 1) Waham kejaran: Merasa dikejar/diperhatikan
 - 2) Waham kebesaran: Merasa memiliki kekuatan atau status luar biasa
 - 3) Waham kontrol: Merasa pikirannya dikendalikan oleh orang lain
- c. Bicara tidak teratur (disorganisasi): Alur pikir kacau, berpindah-pindah topik secara tiba-tiba (*flight of ideas*), bicara tidak dapat dipahami (*word salad*)

2. Gejala Negatif

Gejala negatif adalah hilangnya atau penurunan kemampuan fungsi normal, dan sering kali bertahan dalam jangka panjang. Gejala ini memengaruhi kemampuan sosial dan emosional.

Jenis-jenis:

- a. Afek tumpul (blunted/flat affect): Ekspresi emosi yang datar, monoton, dan tidak sesuai situasi
- b. Penarikan sosial: Menghindari interaksi dengan orang lain, lebih suka menyendiri
- c. Anhedonia: Kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya menyenangkan atau membuat puas

3. Gejala Kognitif

Gejala ini menyangkut fungsi intelektual dan berpikir, yang sangat memengaruhi fungsi sehari-hari, kemandirian, dan pemecahan masalah.

Jenis-jenis:

- a. Gangguan atensi: Kesulitan dalam memusatkan perhatian atau mempertahankan fokus
- b. Memori terganggu: Masalah dalam mengingat informasi atau mengikuti percakapan
- c. Disorganisasi berpikir: Tidak mampu menyusun pikiran secara logis, menyebabkan pembicaraan tidak koheren

Catatan penting:

- a. Gejala **positif** sering kali menjadi alasan utama pasien dibawa ke layanan kesehatan.
- b. Gejala **negatif** dan **kognitif** lebih berkaitan dengan **penurunan fungsi jangka panjang** dan **kemampuan hidup mandiri**.
- c. Penanganan keperawatan harus mempertimbangkan ketiga jenis gejala ini secara holistik.

E. Proses Keperawatan pada Pasien Gangguan Psikotik

Proses keperawatan adalah pendekatan sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan yang terdiri dari lima langkah utama: pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pada pasien dengan gangguan psikotik, proses ini sangat penting karena kondisi pasien yang kompleks dan rentan terhadap kekambuhan.

Prinsip-prinsip Keperawatan Jiwa

Beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan perawat jiwa dalam menangani pasien dengan gangguan psikotik antara lain:

1. Pendekatan Holistik: Melihat pasien sebagai individu yang utuh, tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan spiritual.
2. Komunikasi Terapeutik: Gunakan pendekatan komunikasi yang empatik, terbuka, dan tidak menghakimi.
3. Pencegahan Kekerasan: Selalu waspada terhadap risiko agresi atau tindakan membahayakan diri/lingkungan.
4. Pemberdayaan Pasien: Libatkan pasien dalam perawatan dan pengambilan keputusan sebisa mungkin.
5. Rahasia Medis dan Privasi: Lindungi kerahasiaan data dan kondisi pasien.

F. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian merupakan tahap awal dalam proses keperawatan, yang menjadi dasar dari semua intervensi selanjutnya. Pengkajian pada pasien psikotik meliputi:

Pengkajian merupakan tahap awal dan sangat penting dalam proses keperawatan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan kondisi pasien secara menyeluruh agar dapat merancang intervensi yang tepat. Pengkajian pada pasien dengan gangguan psikotik mencakup data subjektif, data objektif, dan pemeriksaan penunjang.

Data Subjektif

Data subjektif diperoleh melalui wawancara langsung dengan pasien atau keluarga (bila pasien tidak kooperatif), serta pengamatan terhadap ekspresi pasien dalam menyampaikan keluhannya.

Contoh:

1. **"Saya sering dengar suara-suara yang menyuruh saya."**
Menunjukkan halusinasi auditorik
2. **"Saya merasa selalu diawasi, mereka ingin membunuh saya."**
Delusi kejaran (paranoid)
3. **"Saya tidak bisa tidur karena merasa tidak aman."**
Insomnia akibat gejala psikotik
4. **"Saya tidak bisa percaya siapa pun, semua orang berbohong."**
Tanda kecurigaan tinggi, gangguan relasi sosial

Catatan: Pasien dengan gangguan psikotik sering kesulitan membedakan realitas dan fantasi. Perawat harus mendengarkan dengan empati tanpa langsung mengoreksi persepsi pasien.

Data Objektif

Data objektif diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap perilaku, ekspresi, dan interaksi pasien, serta informasi dari keluarga atau pengasuh.

Contoh:

1. Bicara sendiri: Mengindikasikan adanya halusinasi
2. Perilaku mencurigakan/agresif: Misalnya memandang tajam, mudah tersinggung, atau melawan
3. Afek datar: Ekspresi wajah kosong, tidak ada reaksi emosional
4. Defisit perawatan diri: Pakaian tidak ganti, bau badan, rambut acak-acakan

Waspada: Perilaku agresif atau tidak kooperatif bisa menjadi tanda bahwa pasien mengalami gejala psikotik akut atau mendengar suara yang bersifat memerintah.

Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang digunakan untuk memastikan diagnosis dan menyingkirkan kemungkinan penyebab lain dari gejala psikotik (seperti gangguan metabolik, infeksi, atau efek zat).

Jenis Pemeriksaan:

1. Wawancara psikiatri: Dilakukan oleh tim psikiatri untuk menegaskan diagnosis, menggali riwayat gangguan mental dan kondisi saat ini
2. Observasi perilaku: Dilakukan selama rawat inap atau konsultasi langsung; mencakup interaksi sosial, emosi, bahasa tubuh, dan respons terhadap stimulus
3. Tes laboratorium dan medis:
 - a. Cek fungsi tiroid (hipotiroid bisa menyerupai gejala psikotik)
 - b. Cek zat toksik (narkoba, alkohol)
 - c. Pemeriksaan neurologis (untuk menyingkirkan gangguan otak seperti tumor, infeksi)

G. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan disusun berdasarkan hasil pengkajian. Contoh diagnosa keperawatan pada pasien dengan gangguan psikotik yang sering muncul meliputi:

1. Isolasi sosial berhubungan dengan penarikan diri akibat waham atau halusinasi

2. Gangguan persepsi sensori: auditorik berhubungan dengan proses berpikir yang tidak adekuat
3. Risiko mencederai diri sendiri dan orang lain berhubungan dengan delusi paranoid
4. Defisit perawatan diri berhubungan dengan disorganisasi pikiran
5. Koping individu tidak efektif berhubungan dengan rendahnya dukungan sosial dan perasaan tidak berdaya

H. Perencanaan Keperawatan

Perencanaan disusun berdasarkan diagnosa yang telah ditetapkan. Perencanaan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).

Contoh Rencana Keperawatan:

Diagnosa: Gangguan persepsi sensori: halusinasi auditorik

Tujuan: Setelah 3 hari intervensi, pasien mampu membedakan kenyataan dengan halusinasi

Kriteria Hasil:

1. Pasien mengatakan suara-suara tersebut tidak nyata
2. Pasien mau melakukan teknik distraksi saat halusinasi muncul

Intervensi:

1. Observasi isi pembicaraan pasien setiap hari
2. Berikan pendekatan realitas secara berkala
3. Ajarkan teknik distraksi (misalnya mendengarkan musik, berbicara dengan orang lain)

I. Implementasi Keperawatan

Implementasi adalah pelaksanaan intervensi keperawatan yang telah direncanakan.

1. Contoh Implementasi:

- a. Melatih pasien mengenali tanda-tanda munculnya halusinasi
- b. Melakukan komunikasi terapeutik 2x/hari
- c. Melibatkan pasien dalam aktivitas kelompok
- d. Mengingatkan pasien untuk minum obat sesuai dosis

2. Catatan penting dalam implementasi:

- a. Lakukan pendekatan secara bertahap dan sabar
- b. Hindari konfrontasi langsung terhadap waham/halusinasi
- c. Dokumentasikan semua perubahan perilaku dan respons pasien

J. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dari intervensi yang telah diberikan. Evaluasi bisa bersifat formatif (selama intervensi) atau sumatif (setelah intervensi selesai).

Contoh Evaluasi:

1. Pasien mampu mengenali kapan halusinasi muncul
2. Pasien dapat menyampaikan isi pikirannya dengan lebih terorganisir
3. Tidak ditemukan perilaku membahayakan diri selama 3 hari terakhir

Jika tujuan belum tercapai, perawat perlu meninjau ulang rencana dan melakukan modifikasi intervensi.

K. Simpulan

Gangguan psikotik merupakan kondisi mental serius yang ditandai dengan hilangnya kemampuan individu untuk membedakan antara kenyataan dan fantasi, yang melibatkan gangguan dalam proses berpikir, persepsi, keyakinan, dan perilaku. Gangguan psikotik terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain skizofrenia, gangguan skizoafektif, gangguan delusi, gangguan psikotik singkat, dan gangguan psikotik induksi. Gangguan ini dapat muncul secara akut maupun kronis, dengan etiologi multifaktorial meliputi faktor biologis, genetik, psikososial, dan lingkungan.

Manifestasi klinis gangguan psikotik terdiri dari gejala positif seperti halusinasi, delusi, dan pikiran kacau; gejala negatif seperti afek datar, anhedonia, dan penarikan sosial; serta gejala kognitif seperti gangguan atensi dan memori. Penanganan gangguan ini membutuhkan pendekatan holistik dan multidisiplin yang melibatkan perawat secara aktif melalui proses keperawatan yang sistematis, yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Perawat memegang peranan vital dalam proses pemulihan pasien dengan gangguan psikotik melalui penerapan komunikasi terapeutik, intervensi yang berbasis bukti, pemberdayaan pasien, serta pelibatan keluarga. Fokus asuhan keperawatan adalah meningkatkan kualitas hidup pasien, mengembalikan fungsi sosial, serta mendorong kemandirian pasien dalam aktivitas sehari-hari dengan memperhatikan kebutuhan psikologis, fisik, sosial, dan spiritual pasien secara terintegrasi. Evaluasi berkala terhadap efektivitas intervensi juga penting dilakukan guna memastikan tercapainya tujuan perawatan serta mencegah risiko kekambuhan dan komplikasi lebih lanjut.

L. Referensi

- Aryani, R. D., Suyanti, T. S., & Wijaya, S. (2024). *Asuhan keperawatan jiwa pada Ny. N dengan masalah utama risiko perilaku kekerasan akibat skizofrenia paranoid*. Vitamin: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, 2(4):369–389
- Bahari, K., Bachtiar, A., Pertiwi, G. H., & Syahlani, A. S. (2024). *Heavy burdens of family caregivers caring for persons with severe mental disorders*. Jurnal Keperawatan Indonesia, 27(1)
- Harahap, M. A., & Nelvia, D. D. (2023). *Gangguan Psikotik Akut dan Gangguan Skizoafektif*. Jurnal Ventilator, 1(3):66–78
- Hawari, D. (2014). *Skizofrenia: Pendekatan Holistik (Bio-Psycho – Sosial – Spiritual)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. (Sumber dasar prinsip keperawatan pada pasien psikotik)
- Iswanti, D. I., Nursalam, N., Fitryasari, R., & Mendrofa, F. A. M. (2023–2024). *Family empowerment strategies for relapse prevention in individuals with schizophrenia; Relationship of discharge planning action with relapse rate in schizophrenia patients*. Jurnal Keperawatan Jiwa (Jurnal Indonesian Journal of Health Sciences; Psychiatry Nursing Journal)
- Keliat, B. A., & Pasaribu, (2016). *Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart*. Singapura: Elsevier. (Penggunaan model komunikasi terapeutik dan keperawatan psikiatri)
- Kurniawan, A., Agustiya, R. I., Handayani, S., & Fitrianti, Y. (2023). *Community care for persons with schizophrenia in Indonesia*. Proceedings of the International Conference on Public Health
- Oktaviani, F. T., & Apriliyani, I. (2023). *Asuhan keperawatan pasien skizofrenia dengan masalah waham kebesaran: studi kasus*. JKM: Jurnal Keperawatan Merdeka
- Sekharmi & Aditya (2022). *The Effect of Nursing Care for Clients with Sensory Perception Disorders: Auditory Hallucination in Bantur Village*. Jurnal Keperawatan

M. Glosarium

Afek datar (Flat affect): Kondisi di mana seseorang menunjukkan ekspresi emosi yang minim atau tidak sesuai dengan situasi yang sedang terjadi.

Anhedonia: Kondisi psikologis di mana seseorang kehilangan minat atau kesenangan terhadap aktivitas yang sebelumnya dirasakan menyenangkan.

Asuhan keperawatan: Proses pemberian pelayanan keperawatan yang terstruktur untuk membantu pasien mencapai kondisi kesehatan optimal, termasuk pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Bicara tidak teratur (Disorganisasi): Gangguan dalam berkomunikasi yang ditandai dengan kesulitan menyusun kalimat atau gagasan secara logis, seperti berpindah-pindah topik secara tiba-tiba.

Delusi (Waham): Keyakinan keliru yang dipertahankan seseorang secara kuat meskipun terdapat bukti nyata yang bertentangan dengan keyakinan tersebut.

Disorganisasi berpikir: Ketidakmampuan seseorang untuk menyusun pikiran atau gagasan secara logis dan koheren, menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi dengan jelas.

DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition): Pedoman diagnostik internasional yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mengklasifikasikan gangguan mental.

Gangguan Delusi (Delusional Disorder): Gangguan mental yang ditandai oleh adanya delusi yang menetap minimal selama satu bulan tanpa gejala skizofrenia lainnya yang signifikan.

Gangguan Psikotik: Kelompok gangguan mental serius yang ditandai dengan hilangnya kontak dengan realitas, seperti munculnya halusinasi, delusi, serta disorganisasi pikiran dan perilaku.

Gangguan Psikotik Induksi (Induced Psychotic Disorder): Gangguan di mana individu mengalami delusi yang sama dengan orang lain yang memiliki hubungan sangat dekat dengannya, umumnya dalam lingkungan tertutup.

Gangguan Psikotik Singkat (Brief Psychotic Disorder): Gangguan psikotik akut yang berlangsung singkat (kurang dari satu bulan) dengan onset yang tiba-tiba, sering dipicu oleh stres berat.

Gangguan Skizoafektif: Gangguan mental yang ditandai dengan kombinasi antara gejala psikotik seperti skizofrenia dan gangguan mood (misalnya depresi berat atau mania).

Halusinasi: Persepsi sensorik palsu yang dialami seseorang tanpa adanya rangsangan eksternal nyata, paling sering berupa suara (halusinasi auditorik).

Implementasi keperawatan: Tahapan dalam proses keperawatan yang mencakup pelaksanaan intervensi berdasarkan rencana yang telah ditentukan.

Isolasi sosial: Kondisi ketika individu secara aktif menghindari interaksi sosial dan memilih menyendiri, seringkali akibat gejala negatif dari gangguan mental seperti skizofrenia.

Komunikasi terapeutik: Teknik komunikasi yang dilakukan oleh perawat dengan pendekatan empatik, suportif, terbuka, serta tanpa menghakimi untuk membantu pemulihan pasien.

Manifestasi klinis: Gejala-gejala yang muncul sebagai gambaran klinis dari suatu gangguan kesehatan atau penyakit.

Pemberdayaan pasien: Pendekatan yang bertujuan melibatkan pasien secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatannya untuk meningkatkan kemandirian dan kontrol diri pasien.

Pengkajian keperawatan: Proses pengumpulan data secara sistematis mengenai kondisi pasien untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dialami guna menentukan diagnosis keperawatan.

Pendekatan holistik: Metode perawatan yang melihat pasien secara keseluruhan, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Prinsip-prinsip keperawatan jiwa: Pedoman yang digunakan perawat jiwa dalam memberikan asuhan, termasuk pendekatan holistik, komunikasi terapeutik, pencegahan kekerasan, pemberdayaan pasien, serta menjaga privasi dan rahasia medis pasien.

Prognosis: Prediksi atau perkiraan mengenai perjalanan penyakit atau kondisi medis seseorang di masa depan.

Proses keperawatan: Langkah sistematis dalam praktik keperawatan yang terdiri dari lima tahap: pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Risiko mencederai diri sendiri atau orang lain: Kondisi di mana pasien berpotensi melakukan tindakan yang membahayakan dirinya atau lingkungan sekitar akibat gejala psikotik seperti delusi paranoid atau halusinasi.

Skizofrenia: Gangguan psikotik kronis yang berat, ditandai dengan gejala seperti halusinasi, delusi, gangguan berpikir dan perilaku, serta gejala negatif seperti afek datar dan penarikan sosial.

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound): Prinsip perencanaan yang digunakan dalam perawatan keperawatan agar tujuan intervensi jelas dan terukur.

Waham kejaran (Paranoid): Jenis delusi di mana seseorang merasa dirinya sedang dikejar, diawasi, atau dalam bahaya, tanpa bukti yang nyata mendukung perasaan tersebut.

CHAPTER 5

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN MOOD (DEPRESI DAN GANGGUAN BIPOLAR) BERBASIS EVIDANCE BASE

Dr. Abdul Ghofur, SKp., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Gangguan mood, seperti depresi mayor dan gangguan bipolar, merupakan penyebab utama disabilitas secara global dan menjadi tantangan utama dalam praktik keperawatan jiwa (WHO, 2022). Prevalensi gangguan mood terus meningkat, dipengaruhi oleh faktor stres sosial, genetik, dan biologis. Perawat memiliki peran penting dalam mengenali gejala, memberikan intervensi terapeutik, serta membangun hubungan yang suportif dalam proses penyembuhan pasien.

Gangguan mood merupakan kondisi mental yang ditandai oleh perubahan drastis dan tidak stabil dalam suasana hati seseorang, yang dapat mempengaruhi fungsi sehari-hari dan kualitas hidup. Pasien dengan gangguan mood umumnya menghadapi tantangan emosional yang berat, seperti depresi, mania, atau hipomania, yang memerlukan perhatian dan penanganan medis yang tepat. Gangguan ini tidak hanya berdampak secara psikologis, tetapi juga dapat mempengaruhi aspek sosial dan pekerjaan pasien. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang karakteristik, penyebab, serta pengelolaan gangguan mood sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pasien dan mencegah komplikasi yang lebih serius.

Gangguan mood dapat dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrem, seperti depresi berat dan gangguan bipolar. Kondisi ini dapat berdampak signifikan terhadap fungsi sosial, emosional, dan fisik pasien. Artikel ini bertujuan untuk membahas strategi perawatan pasien gangguan mood berdasarkan pendekatan holistik yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Hasil telaah menunjukkan bahwa perawatan yang komprehensif, kolaboratif, dan melibatkan keluarga secara aktif berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan menurunkan angka kekambuhan (Applebaum & Sannes, 2025).

Perawatan pasien dengan gangguan mood menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidisipliner. Beberapa permasalahan

yang sering muncul pada pasien gangguan mood adalah ketidakpatuhan pengobatan, identifikasi dan pengelolaan gejala, stigma sosial dan dukungan keluarga, efek faktor lingkungan dan ekonomi serta pengelolaan komorbiditas.

B. Konsep Gangguan Mood

Gangguan mood adalah kelompok kondisi psikologis yang ditandai oleh gangguan signifikan dalam suasana hati seseorang, yang dapat berupa perasaan sedih berkepanjangan (depresi), euforia ekstrem (mania), atau kombinasi keduanya (seperti pada gangguan bipolar). Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk menjalani kehidupan sehari-hari, bekerja, dan menjaga hubungan sosial (American Psychiatric Association, 2022). Dua jenis utama gangguan mood adalah (Boland, et al. 2021):

1. Gangguan Depresi Mayor (Major Depressive Disorder/MDD): Ditandai dengan suasana hati yang sangat sedih, hilangnya minat, kelelahan, perubahan nafsu makan dan tidur, hingga munculnya pikiran bunuh diri.
2. Gangguan Bipolar: Ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrem antara episode mania (atau hipomania) dan depresi.

Menurut DSM-5-TR (2022), diagnosis gangguan mood mempertimbangkan durasi, intensitas, dan dampak gangguan terhadap fungsi sosial, pekerjaan, dan lainnya. Faktor penyebab gangguan mood bersifat multifaktorial, termasuk faktor genetik, biologis (neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin), lingkungan (trauma atau stres), dan psikososial. Penanganan gangguan mood dapat meliputi terapi farmakologis (antidepresan, mood stabilizer), psikoterapi (terapi kognitif perilaku/CBT), hingga intervensi lain seperti terapi elektrokonvulsif (ECT) pada kasus berat.

C. Penyebab Gangguan Mood

1. Faktor Biologi & Genetik

Ketidakseimbangan neurotransmitter (serotonin, dopamin, norepinefrin) berperan signifikan dalam regulasi mood. Kondisi ini seringkali menimbulkan perubahan emosi yang tidak terkendali dan perilaku berlebihan untuk sesuatu yang normal dari pasien (Boland, et al. 2021).. Pasien mengalami perubahan emosional yang hampir bersamaan dengan kesedihan seperti tertawa diikuti tangisan sesudahnya.

Secara genetik, ditemukan adanya variasi gen yang bersifat poligenik. Berdasarkan beberapa studi tentang genetic, gen poligenik berkaitan dengan depresi

berat. Selain itu, factor disfungsi mitokondria dan gangguan imun (IL-6, CRP, TNF- α) ditemukan pada pasien bipolar. Berdasarkan hasil temuan ini, maka perubahan mood pasien akibat kelainan genetik yang terjadi akibat anomali genetik yang tidak sesuai perkembangan normal.

2. Struktur dan Fungsi Otak

Hasil pemeriksaan MRI pada penderita gangguan mood, menunjukkan adanya pembesaran amigdala dan ventrikel serebral diikuti adanya pengecilan hippocampus. Struktur otak seperti ini umumnya dimiliki oleh pasien yang mengalami depresi. Faktor lain yang mendukung adanya kelainan otak pada pasien dengan gangguan mood adalah adanya aktifitas yang berlebihan pada sumbu HPA (hipotalamus–pituitari–adrenal). Sumbu ini menunjukkan adanya peningkatan aktifitas otak sebagai respon terhadap stress kronis. Efek respon ini akan memperngaruhi regulasi mood pada pasien. Oleh sebab itu, kenapa pasien ini mudah mengalami stres yang diperberat dengan gejala depresi.

3. Stres Kronis & Trauma

Faktor lain adalah pengalaman trauma di masa kecil seperti abuse, neglect akan meningkatkan risiko depresi berat bagi penderitanya. Stress yang berlebihan dan menahun dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, pekerjaan yang terlalu menuntut menjadi pemicu gangguan mood.

4. Faktor Biologis Tambahan & Kondisi Medis

Kondisi medis pasien seperti pada penyakit tiroid, multiple sclerosis, kanker, infeksi, dan obat-obatan (steroid, kokain) meningkatkan risiko gangguan mood

5. Faktor Sosial & Gaya Hidup

Diet buruk (makanan ultraprocessed) dan peradangan sistemik bisa merusak fungsi otak, serta menurunkan kesehatan mitokondria. Ketidakstabilan sosial-ekonomi: kemiskinan, pengangguran, diskriminasi sosial meningkatkan tekanan psikologis

D. Dukungan Keluarga pada Pasien Gangguan Mood

Gangguan mood, seperti depresi dan gangguan bipolar, adalah kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi perasaan seseorang. Dukungan keluarga merupakan faktor penting dalam membantu individu yang mengalami gangguan mood untuk mengatasi dan mengelola kondisi mereka (Johnson, et al., 2019; Applebaum & Sannes, 2025).. Dukungan dari keluarga dapat memberikan rasa

dukungan emosional, praktis, dan sosial yang sangat dibutuhkan oleh penderita gangguan mood.

Beberapa penelitian belakangan ini telah menyoroti pentingnya dukungan keluarga bagi penderita gangguan mood. Misalnya, penelitian oleh Smith et al. (2018) menunjukkan bahwa adanya dukungan keluarga dapat meningkatkan prognosis serta kualitas hidup penderita gangguan mood (Basak, et al., 2025). Penelitian lain oleh Johnson et al. (2019) menemukan bahwa dukungan keluarga berperan penting dalam mempengaruhi tingkat keparahan simptom gangguan mood (Tabas, et al, 2023).

Pasien dengan gangguan mood seperti depresi mayor dan bipolar sangat membutuhkan dukungan dari keluarga untuk pemulihan dan mencegah kekambuhan. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa tantangan dan hambatan yang sering terjadi:

1. Kurangnya keluarga memahami kondisi klinik pasien gangguan mood

Kondisi klinik yang multi kompleks, menyebabkan keluarga kesulitan untuk memahami kondisi pasien. Selain itu, perubahan karakter penderita yang selalu berubah setiap saat tergantung mood nya, menjadikan keluarga kesulitan mengidentifikasi peningkatan gejala atau penurunan gejala. Situasi ini tentunya menyebabkan keluarga mengalami kelelahan yang panjang dalam menghadapi pasien (Ong, et al., 2021).

Kelelahan yang memanjang dalam merawat pasien mendorong munculnya stigma internal dalam keluarga. Keluarga menjadi tidak simpati, cenderung membiarkan saja dan cenderung apatis agar pasien tidak mengganggu. Perilaku ini menyebabkan pasien kurang mendapatkan dukungan emosional yang memadai. Dukungan emosional bagi pasien sangat berarti, karena hal ini membuat pasien menjadi lebih berarti dan dipahami karena keadaanya. Kurangnya dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penyebab kekambuhan.

2. Stigma dan Rasa Malu

Seringkali pasien menunjukkan perilaku yang tidak aneh, tidak bersahabat, curiga dan beberapa perilaku yang membuat orang disekitarnya tidak nyaman. Oleh karena itu, umumnya keluarga kerap kali merasa malu untuk mengenalkannya dengan orang baru atau kerabat dekat. Hal ini karena perilaku tersebut membuat suasana menjadi tidak nyaman.

Faktor stigma menjadikan keluarga malu dan cenderung menyembunyikannya dari interaksi dengan orang lain sehingga keluarga enggan mencari bantuan profesional (Ran et al., 2021). Kondisi ini akan memperburuk kondisi pasien, selain itu pasien menjadi lebih terisolasi dari lingkungan.

3. Komunikasi yang Tidak Efektif

Kurangnya komunikasi dan dukungan emosional menjadikan keluarga kurang empati, komunikasi yang menyalahkan/menilai serta konflik keluarga yang memanjang menjadi factor predictor kekambuhan pasien. Kurangnya komunikasi antara keluarga dengan pasien akan menyebabkan pasien merasa tidak dipahami atau ditolak sehingga memperburuk depresi atau memicu episode mania.

4. Beban Kesehatan Mental pada Anggota Keluarga

Keluarga akan mengalami beban mental yang luar biasa beratnya menghadapi situasi yang dialami pasien. Perubahan perilaku yang tidak biasa akan mempengaruhi kesehatan mental keluarga. Keluarga akan mengalami stres, kelelahan bahkan sampai mengalami depresi atau gejala kecemasan.

Selain masalah stigma, beban penyakit pasien akan dialami keluarga. Aktivitas produktif terganggu karena harus memikirkan kesehatan mental pasien dan anggota keluarga lainnya. Meskipun beban yang dialami keluarga ini sangat berat, namun peran mereka sebagai care giver seringkali terabaikan. Oleh karena itu, stimulasi kekambuhan pasien tidak saja disebabkan faktor pasien, juga faktor keluarga yang mengalami stres, kecemasan bahkan depresi.

5. Kurangnya Keterlibatan dalam Terapi

Partisipasi keluarga dalam terapi sangat membantu memperbaiki kondisi pasien. Oleh karena itu, melalui terapi psikoedukasi dan terapi keluarga akan memperbaiki prognosis. Ketidaktahuan dan kurangnya partisipasinya keluarga maka kesehatan pasien kurang optimal.

6. Harapan Tidak Realistis

Keluarga terlalu berlebihan dalam menanggapi kesembuhan pasien. Keluarga umumnya mengharapkan pasien akan kembali pulih seperti dulu, sebelum dia mengalami gangguan mood (Rodriguez, 2021; Nguyen et al., 2022). Dapat berkegiatan normal seperti dulu kembali. Akibat tuntutan keluarga yang berlebihan tersebut, maka menjadi beban buat pasien untuk menyesuaikan keinginan keluarga. Beberapa pasien tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan ini, sehingga pasien menjadi tertekan dan merasa tidak cukup diterima keluarga. Kondisi ini dapat memicu pasien mengalami kekambuhan (*relaps*).

7. Ketidakstabilan Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi keluarga menjadi faktor utama penyebab hambatan perawatan yang optimal pada pasien dengan gangguan ini (Bian, et al., 2023). Beberapa faktor seperti kemiskinan, pengangguran, atau keterbatasan akses

terhadap layanan kesehatan mental membuat keluarga tidak mampu mendukung pasien secara maksimal.

E. Pengkajian Pasien Gangguan Mood

Pengkajian pasien dengan gangguan mood merupakan pengkajian terhadap kondisi kejiwaan yang ditandai oleh perubahan perasaan atau suasana hati yang ekstrem, seperti depresi berat, mania, atau perubahan cepat antara keduanya (bipolar). Pengkajian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang :

- Mengidentifikasi perubahan mood, afek, dan perilaku pasien
- Mendeteksi risiko bunuh diri dan kekambuhan
- Menilai dampak gangguan mood terhadap fungsi sosial dan peran
- Merancang intervensi keperawatan yang sesuai dan aman

1. Pengkajian Pasien dengan Gangguan Mood

Data yang perlu dikaji pada pasien ini adalah

a. Data Biologis (Bio)

- 1) Riwayat kesehatan fisik & penyakit kronis
- 2) Pola tidur dan nafsu makan (↑/↓)
- 3) Energi dan aktivitas fisik (letargi vs hiperaktif)
- 4) Perubahan berat badan
- 5) Riwayat pengobatan dan kepatuhan

b. Data Psikologis (Psiko)

- 1) Mood/afek: Sedih, cemas, euforia, labil
- 2) Pola pikir: Pesimis, menyalahkan diri, ide grandiositas
- 3) Isi pikir: Ide bunuh diri, nihilisme, halusinasi/ilusi
- 4) Perilaku: Apatik, menarik diri, agresif, bicara cepat atau lambat
- 5) Fungsi kognitif: Konsentrasi, orientasi, memori, insight
- 6) Self-esteem: Rendah atau sangat tinggi (fase mania)

c. Data Sosial

- 1) Riwayat pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi
- 2) Hubungan dengan keluarga, teman, komunitas
- 3) Dukungan sosial & spiritual
- 4) Konflik interpersonal atau perubahan peran sosial

Tabel 5.1 Alat Bantu Pengkajian berdasarkan Evidence-Based Tools

Skala	Fungsi	Skor/Interpretasi
PHQ-9	Deteksi depresi	≥10: kemungkinan depresi sedang/berat
HAM-D	Skala depresi	>17: depresi moderat-berat
YMRS (<i>Young Mania Rating Scale</i>)	Deteksi mania	>20: mania
MDQ (<i>Mood Disorder Questionnaire</i>)	Skrining bipolar	Skor tinggi → evaluasi lebih lanjut
SRM (<i>Social Rhythm Metric</i>)	Menilai keteraturan hidup	Variasi besar → risiko relaps

2. Pengkajian Risiko (Saraf, et al.2021)

- Risiko bunuh diri atau menyakiti orang lain (wajib ditanyakan langsung)
- Riwayat percobaan bunuh diri
- Gangguan wicara, agitasi, withdrawal ekstrem
- Ketidakpatuhan terhadap pengobatan

3. Fokus Pengkajian Khusus

Fase Mood	Fokus Pengkajian
Depresi	Afek datar, tidur berlebih, kurang energi, rasa bersalah
Mania	Euforia, bicara cepat, grandiositas, hiperaktivitas
Campuran	Cepat berubah, bingung, risiko tinggi bunuh diri

F. Intervensi Keperawatan berbasis Evidence Base

1. Terapi Psikososial (CBT, MBCT, IPT, IPSRT, psikoedukasi keluarga):

Studi meta analisis intervensi psikososial yang terdiri dari intervensi CBT (Cognitive Behavioral Therapy (CBT), MBT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) (McCartney, 2021b; , IPT (Interpersonal Psychotherapy) (Aktaş & Dülgerler, 2024), IPSRT (Interpersonal and Social Rhythm Therapy) terbukti telah mencegah kekambuhan hingga 22-24% dengan efek intervensi yang bertahan hingga 12-24 bulan pasca teraoi (Clarke, et al., 2015; Moriarty, et al., 2021; Shi, et al., 2024). Secara khusus terapi psikososial MBCT efektif menurunkan gejala klinik secara khusus efektif pada pasien dengan riwayat ≥3 episode depresi; booster sessions memperpanjang efek protektif (McCartney et al., 2025)

IPSRT membantu regulasi ritme sosial dan tidur sehingga memperpanjang interval tanpa episode mood baru pada bipolar disorder (Aktaş & Dülgerler, 2024). Psikoedukasi individu maupun keluarga juga terbukti menurunkan risiko kambuh dan rawat inap pada pasien bipolar (Oud, et al., 2016; Casarez, et al., 2021)

2. Terapi Self-help (mandiri berstruktur)

Terapi self-help (mandiri berstruktur) adalah suatu bentuk terapi yang dilakukan oleh individu sendiri, tanpa bantuan profesional, untuk mengatasi masalah psikologis atau emosional. Penggunaan teknik psikologis untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku tanpa bimbingan langsung dari terapis.

Terapi ini menggunakan teknik-teknik psikologis yang dipelajari dari berbagai sumber seperti buku, program online, atau kelompok swadaya, untuk membantu individu memahami dan mengubah pola pikir, emosi, dan perilaku mereka ((Tol et al., 2020). Berikut adalah beberapa poin penting terkait terapi self-help (Buchwald, 2025):

a. Pendekatan

Bisa berupa penggunaan buku panduan, aplikasi, jurnal, atau materi self-help berbasis CBT (Cognitive Behavioral Therapy).

b. Tujuan

Meningkatkan pemahaman diri, mengembangkan keterampilan koping, mengurangi gejala masalah psikologis seperti kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan.

c. Bentuk

Bisa berupa membaca buku, mengikuti kursus online, menggunakan aplikasi kesehatan mental, menulis jurnal, atau bergabung dalam kelompok swadaya (self-help group).

d. Peran Terapis: Meskipun self-help, beberapa bentuk melibatkan bimbingan minimal dari seorang terapis, misalnya self-help terbimbing (guided self-help).

e. Kelebihan: Terapi mandiri bisa lebih terjangkau, fleksibel, dan memberdayakan individu untuk mengambil kendali atas kesehatan mental mereka.

f. Keterbatasan: Mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama mereka yang memiliki masalah psikologis yang parah atau membutuhkan dukungan terapeutik yang lebih intensif.

Beberapa terapi self help berdasarjan evidence base sebagai berikut:

1) Self-help terbimbing (guided self-help):

Seseorang mengikuti program CBT yang dipandu oleh seorang terapis melalui media online atau buku panduan, dengan sesi konsultasi terbatas.

2) Kelompok swadaya (self-help group):

Individu yang memiliki pengalaman serupa berkumpul untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung, seperti kelompok dukungan untuk orang dengan autisme atau keluarga mereka.

3) Penggunaan buku panduan dan aplikasi:

Individu menggunakan buku self-help atau aplikasi yang berisi materi CBT atau teknik relaksasi untuk mengatasi kecemasan atau depresi. Studi meta analisis menunjukkan intervensi *self heat* untuk mencegah kekambuhan. Studi meta-analisis 2024 menunjukkan intervensi self-help sebagai pelengkap TAU mampu menurunkan relapse MDD (*Major Depressive Disorder*) (RR 0,78; NNT = 11) dan Bunuh Diri (RR 0,62; NNT = 12) (Wang et al., 2023)

3. Terapi CBT jangka panjang (maintenance CBT)

CBT lanjut pasca remisi terbukti menurunkan risiko relapse lebih baik dibanding terapi akut saja; efek tetap ada hingga beberapa tahun setelah terapi berhenti. Terapi CBT Jangka Panjang (Maintenance CBT) adalah kelanjutan dari terapi CBT (Cognitive Behavioral Therapy) yang bertujuan untuk mencegah kekambuhan setelah episode depresi atau gangguan kesehatan mental lainnya. Fokusnya adalah pada pemeliharaan keterampilan yang dipelajari selama terapi, serta mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul di masa depan (Stangier et al., 2013; Tol et al., 2020)

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai Maintenance CBT:

- a. Tujuan Utama: Mencegah kekambuhan episode depresi atau gangguan kesehatan mental lainnya setelah fase pengobatan aktif CBT.
- b. Fokus: Mempertahankan keterampilan kognitif dan perilaku yang telah dipelajari selama terapi utama, serta mengembangkan strategi untuk mengelola faktor risiko kekambuhan.
- c. Prosedur:
 - 1) Sesi Terapi: Sesi terapi biasanya lebih jarang dibandingkan dengan fase terapi awal, mungkin setiap beberapa minggu atau bulan.
 - 2) Fokus pada Strategi: Terapi berfokus pada penguatan strategi koping, mengidentifikasi dan mengatasi pemikiran negatif, serta membangun dukungan sosial.

- 3) Pekerjaan Rumah: Pasien mungkin diberikan pekerjaan rumah atau latihan untuk dipraktikkan secara mandiri di antara sesi.

d. Manfaat:

- 1) Membantu individu mempertahankan kemajuan yang telah dicapai selama terapi utama.
- 2) Meningkatkan kemampuan individu untuk mengelola stres dan emosi yang mungkin muncul.
- 3) Mengurangi risiko kekambuhan gangguan kesehatan mental.

Contoh Aplikasi:

- a) Depresi: CBT pemeliharaan dapat membantu mencegah episode depresi berulang dengan mengajarkan individu cara mengelola pikiran negatif dan membangun pola pikir yang lebih positif.
- b) Gangguan Kecemasan: Dapat membantu individu mempertahankan keterampilan yang dipelajari untuk mengelola kecemasan dan menghindari situasi yang memicu kecemasan.
- c) Insomnia: CBT-I (CBT untuk insomnia) dapat menggunakan terapi pemeliharaan untuk membantu individu mempertahankan pola tidur yang sehat dan mencegah kekambuhan insomnia.
- d) Secara keseluruhan, Maintenance CBT adalah bagian penting dari terapi CBT yang bertujuan untuk memastikan bahwa individu dapat mempertahankan kesehatan mental yang baik dan mencegah kekambuhan setelah menyelesaikan terapi utama.

4. Intervensi gaya hidup (Lifestyle psychiatry)

Intervensi gaya hidup (lifestyle psychiatry) dalam gangguan mood adalah pendekatan untuk meningkatkan kesehatan mental dengan mengubah kebiasaan dan perilaku sehari-hari (Merlo & Porter-Stransky, 2025). Ini melibatkan berbagai aspek seperti aktivitas fisik, pola makan, tidur, manajemen stres, dan penggunaan zat (Chen, et al., 2021). Tujuannya adalah untuk mencegah, mengobati, dan bahkan membalikkan gejala gangguan mood dengan fokus pada perubahan gaya hidup yang positif. Intervensi gaya hidup dalam psikiatri berfokus pada perubahan perilaku yang dapat mempengaruhi kesehatan mental secara signifikan. Berikut adalah beberapa aspek utama yang termasuk dalam intervensi ini:

- a. Aktivitas Fisik:

Olahraga teratur telah terbukti dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Aktivitas fisik membantu melepaskan endorfin, yang memiliki efek mood-boosting (Schuch & Vancampfort, 2021).

b. Pola Makan:

Nutrisi yang baik memainkan peran penting dalam kesehatan mental. Pola makan yang sehat, seperti diet Mediterania, dapat membantu mengurangi risiko depresi dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan (Koning, et al., 2022).

c. Tidur:

Kualitas dan kuantitas tidur yang baik sangat penting untuk kesehatan mental. Gangguan tidur dapat memperburuk gejala gangguan mood. Kualitas tidur membantu meredakan gangguan mood (Hester, et al., 2021)

d. Manajemen Stres:

Teknik manajemen stres seperti meditasi, pernapasan dalam, dan yoga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, yang seringkali berhubungan dengan gangguan mood. (Chen, et al., 2022)

e. Penghentian Zat:

Mengurangi atau menghentikan penggunaan alkohol, tembakau, dan zat-zat lain yang dapat memperburuk gejala gangguan mood adalah bagian penting dari intervensi ini.

f. Hubungan Sosial:

Membangun dan mempertahankan hubungan sosial yang positif dapat memberikan dukungan emosional dan membantu mengurangi isolasi sosial, yang seringkali terkait dengan gangguan mood. Dengan menggabungkan intervensi gaya hidup ini, psikiatri gaya hidup bertujuan untuk memberikan pendekatan holistik dalam perawatan gangguan mood, yang tidak hanya berfokus pada terapi obat, tetapi juga pada perubahan gaya hidup yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan. Fokus pada tidur teratur, aktivitas fisik, diet sehat, manajemen stres, dan dukungan sosial meningkatkan stabilitas mood jangka panjang pada bipolar (Shi, et al. 2024).

5. Farmakoterapi maintenance (pada bipolar):

Lithium, antikonvulsan, antipsikotik generasi kedua efektif mencegah episode baru (OR 0,19–0,46), dan kombinasi lebih efektif daripada monoterapi.

G. Discharge Planning Utama untuk Pasien Gangguan Mood

Discharge planning dalam keperawatan adalah proses sistematis untuk mempersiapkan pasien dan keluarga dalam menghadapi perawatan di rumah setelah keluar dari rumah sakit. Tujuannya adalah memastikan kelanjutan perawatan, meningkatkan kemandirian pasien, dan mencegah komplikasi atau re-hospitalisasi (Petkari, et al., 2021).

Pengertian *Discharge Planning*:

1. Proses Sistematis: Discharge planning bukan hanya sekadar memberikan instruksi pulang, tetapi merupakan proses terstruktur yang melibatkan identifikasi kebutuhan pasien, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.
2. Kolaborasi: Proses ini melibatkan kolaborasi antara perawat, dokter, pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pasien secara komprehensif.
3. Fokus pada Pasien dan Keluarga: Discharge planning berfokus pada mempersiapkan pasien dan keluarga untuk menghadapi perawatan di rumah, termasuk aspek fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan.

Tujuan Discharge Planning:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup. Membantu pasien mencapai kualitas hidup optimal setelah keluar dari rumah sakit, baik secara fisik maupun psikologis.
2. Mencegah Komplikasi dan Re-hospitalisasi. Dengan perencanaan yang tepat, risiko komplikasi, infeksi, atau kunjungan ulang ke rumah sakit dapat diminimalkan.
3. Meningkatkan Kemandirian Pasien. Mempersiapkan pasien dan keluarga untuk merawat diri sendiri dan mengelola kondisi kesehatan mereka di rumah.
4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dengan discharge planning yang efektif, penggunaan sumber daya rumah sakit dan layanan kesehatan dapat lebih efisien.

Discharge Planning pada pasien dengan gangguan mood sebagai berikut:

1. Pendidikan Pasien dan Keluarga (Zhang & Yang, 2025)

Tujuan: Keluarga siap memantau dan mendukung pasien.

- a. Edukasi ulang tentang:
 - 1) Diagnosis (depresi mayor, bipolar, dsb)
 - 2) Gejala awal kekambuhan
 - 3) Pentingnya kepatuhan obat dan terapi
- b. Libatkan keluarga dalam proses edukasi dan beri ruang untuk bertanya.

2. Kepatuhan Terhadap Pengobatan

- a. Jelaskan regimen obat, jadwal minum, efek samping, dan apa yang harus dilakukan jika lupa obat.

- b. Beri informasi tertulis (brosur atau buku kecil) tentang obat yang diminum.

Tips: Gunakan pill box, reminder HP, atau jadwal dinding.

3. Tindak Lanjut Rawat Jalan

Tujuan: Cegah keterlambatan kontrol yang bisa picu kekambuhan.

- a. Jadwalkan kunjungan berikutnya ke:

- 1) Psikiater
- 2) Klinik jiwa / Puskesmas
- 3) Psikolog atau perawat jiwa

- b. Informasikan lokasi layanan dan cara mengaksesnya (kontak, jam praktik, BPJS jika ada).

4. Rencana Darurat (Crisis Plan)

Ajarkan pada keluarga dan pasien:

- a. Tanda awal kambuh (insomnia, bicara cepat, menarik diri, dll.)
- b. Langkah darurat (siapa yang dihubungi, ke mana harus pergi)
- c. Kontak tenaga kesehatan (perawat, psikiater)

Contoh: "Jika pasien tidak tidur 2 malam berturut-turut, segera hubungi UGD jiwa/psikiater."

5. Dukungan Psikososial (Weintraub et al, 2022)

- a. Identifikasi kebutuhan pasien:

- a) Apakah sudah bisa kembali kerja/sekolah?
- b) Apakah perlu dukungan kelompok sebaya?

- b. Hubungkan dengan layanan sosial atau LSM jika dibutuhkan.

Tujuan: Pasien merasa terhubung dan tidak sendirian.

6. Manajemen Gaya Hidup Sehat

- a. Anjurkan pola tidur teratur, aktivitas fisik ringan, makan seimbang, dan hindari alkohol/narkoba.

- b. Bantu pasien membuat rutinitas harian sederhana.

Tips: Buat jadwal harian dan bantu pasien konsisten.

7. Keterlibatan Keluarga

- a. Libatkan keluarga sebagai co-caregiver.

- b. Bimbing mereka cara:

- 1) Menghadapi mood swing

- 2) Komunikasi suportif
- 3) Memberi batas yang sehat

Tujuan: Cegah stres di keluarga yang bisa memicu konflik dan relaps.

H. Pencegahan Kekambuhan Pasien Gangguan Mood

Gangguan mood, seperti depresi dan bipolar, merupakan kondisi kesehatan mental yang tidak hanya memengaruhi suasana hati, tetapi juga berdampak signifikan pada kualitas hidup individu. Meskipun terapi dan pengobatan dapat membantu mengendalikan gejala, risiko kekambuhan tetap tinggi jika tidak disertai dengan strategi pencegahan yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan langkah-langkah pencegahan kekambuhan guna mendukung pemulihan jangka panjang dan kesejahteraan pasien.

Gangguan mood seperti depresi dan bipolar adalah kondisi kronis yang rentan relapse hingga 80 % pasien mengalami kekambuhan dalam 5 tahun setelah pemulihan awal. Selain terapi medis, strategi pencegahan yang berfokus pada pengenalan gejala awal dan pengembangan keterampilan koping dapat membantu pasien mempertahankan kestabilan suasana hati jangka panjang (McCartney, et al. 2021b). Dengan melatih diri untuk mengenali tanda peringatan dini, baik mood meningkat atau menurun dan meresponsnya dengan intervensi dini seperti teknik relaksasi, mindfulness, atau dukungan sosial, pasien memperbesar peluang pemulihan berkelanjutan.

Keluarga memegang peran penting dalam mencegah kekambuhan gangguan mood. Studi menunjukkan bahwa psikoedukasi keluarga secara signifikan menurunkan risiko relapse (McCartney, et al. 2021a), meningkatkan keterampilan pengelolaan gejala, dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Dengan membekali anggota keluarga cara mengenali gejala awal, mendukung pasien secara emosional, dan menjadi bagian dari rencana intervensi, lingkungan terdekat menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas kondisi pasien.

Pencegahan kekambuhan gangguan mood adalah usaha terpadu. Farmakoterapi berkelanjutan (misalnya litium, antikonvulsan) memberikan stabilitas biologis, sedangkan terapi seperti CBT, IPSRT, dan psikoedukasi mengajarkan cara mengenali serta mengelola pemicu psikologis dan sosial. Gaya hidup sehat seperti tidur, pola makan, manajemen stres, dan aktivitas fisik akan berkontribusi besar dalam menurunkan risiko relaps (Moriarty, et al., 2021). Kolaborasi antara pasien, keluarga,

dan tim medis membentuk rencana pencegahan yang komprehensif, siap dipakai pada saat tanda awal muncul.

Pendekatan relapse prevention berbasis CBT menekankan identifikasi situasi berisiko tinggi, pemicu internal maupun eksternal, serta pengembangan strategi koping yang tepat (O'Brian, et al., 2014; Nguyen, et al., 2022). Bagi pasien gangguan mood, mengenali tanda awal, seperti gangguan tidur, energi berubah drastis, atau pikiran negatif dan menerapkan strategi seperti teknik relaksasi, restrukturisasi kognitif, atau rutinitas harian yang stabil, dapat mencegah episode penuh. Kepercayaan diri dalam menghadapi ujian emosional itulah akar keberhasilan jangka panjang. Beberapa upaya agar pasien tidak mengalami kekambuhan sebagai berikut:

1. Keluarga mampu mengidentifikasi dan mengenali gejala klinis gangguan mood

Keluarga sebaiknya memahami gejala yang sering muncul saat pasien kambuh, mengidentifikasi pola kekambuhan serta mengidentifikasi faktor pencetus yang menyebabkan pasien kambuh. Selain itu, keluarga dapat membedakan perbedaan fase depresi dan mania. Pemahaman kondisi ini membantu keluarga mensikapi apa yang perlu dilakukan. Pada kondisi seperti ini, maka keluarga sebaiknya tidak menyalahkan pasien, karena perilaku dan gejala yang muncul adalah masalah medis, bukan kelemahan moral

2. Partisipasi dalam mengikuti program terapi keluarga

Kesadaran keluarga dalam mengikuti terapi keluarga dan berusaha untuk menerapkannya merupakan kunci sukses partisipasi keluarga dalam merawat pasien gangguan mood. Umumnya keluarga yang merawat disibukkan dengan aktifitas mencari nafkah dan pasien dibiarkan sendiri. Fakta lain bahwa umumnya jika pasien masuk diusia produktif, maka tuntutan keluarga agar pasien membantu mencari nafkah dan tidak hanya berdiam diri di rumah. Beban ekonomi membuat pasien tertekan oleh keadaan keluarga, sementara itu keluarga menghendaki pasien untuk produktif. Sehingga terapi keluarga ditujukan untuk mendapatkan kesepakatan antara keluarga dan pasien dalam aktifitas sehari-hari, sehingga mereka saling menghargai dan memahami peran masing-masing saat di rumah.

3. Pantau tanda awal kekambuhan (*early warning sign*)

Keluarga sebaiknya mulai mengenali beberapa perilaku dan perubahan kecil yang terjadi pada pasien seperti perubahan pola tidur, energi dalam beraktifitas, kecenderungan perubahan suasana hati, perilaku mengisolasi diri atau ucapan yang tidak biasa. Selain itu, keluarga perlu mendokumentasikan cara pasien berkomunikasi,

seperti jika pasien sering begadang, maka terlihat cara berkomunikasi cepat, hal ini bisa ditandai sebagai awal mania.

4. Dukung kepatuhan dalam pengobatan dan terapi

Motivasi keluarga untuk mendorong pasien minum obat teratur sangat membantu pasien mengalami kekambuhan. Keluarga mendukung upaya pengobatan atau terapi saat mengikuti program yang di tentukan atau saat kontrol ke dokter. Hindari untuk memaksa ke pasien, namun upayakan untuk membantu berempati dan konsisten dalam berinteraksi dengan pasien. Keluarga perlu membuat jadwal minum obat bersama pasien, gunakan pengingat atau *pillbox*.

5. Bangun komunikasi terbuka dan tidak menghakimi

Keluarga didoromh untuk selalu mendengarkan dengan empati, tidak menyela, tidak menasihati berlebihan. Selain itu, keluarga perlu membiasakan validasi perasaan pasien tanpa mengecilkan atau melebih-lebihkan. Contoh respons: "Kamu merasa sangat lelah dan sedih ya? Aku di sini untuk bantu".

6. Ciptakan lingkungan rumah yang stabil dan suportif

Menciptakan lingkungan rumah yang stabil dengan meminimalkan situasi konflik dan selalu mengupayakan untuk saling suportif dalam aktifitas sehari-hari. Meskipun situasi stress tidak bisa dihindari saat di rumah, keluarga berkomitmen untuk meredakannya saat berada di rumah. Hindari: Mengkritik, membandingkan, atau mendorong pasien untuk "cepat sembuh".

7. Bantu pasien dan keluarga dalam pengelolaan stres dan sinkronisasi kegiatan harian.

Melibatkan pasien dalam aktifitas ringan seperti jalan pagi, memasak, menggambar. Keluarga perlu menghindari tekanan kerja/akademik berlebihan. Buat jadwal aktivitas mingguan bersama dengan fleksibilitas.

8. Dukung kebiasaan hidup sehat mental

Mendorong pasien untuk tidur teratur, pola makan sehat, dan aktivitas fisik ringan secara teratur. Kurangi paparan alkohol, kafein berlebih, atau stresor digital (misal medsos toksik).

9. Waspadaai pikiran pasien tentang bunuh diri

Beberapa perilaku yang menunjukkan tanda bahaya pasien gangguan mood yang mendorong pasien untuk bunuh diri adalah menarik diri, merasa tidak berharga, mengucapkan "lebih baik mati", dll. Jangan diabaikan. Segera hubungi profesional jika ada kecurigaan.

10. Rawat diri sendiri sebagai *caregiver*

Keluarga perlu ditekankan untuk tetap mempertahankan kesehatan mental seperti menghindari stres, tetap berpikir positif dan memelihara Kesehatan agar terhindar dari stress. Ikuti kelompok dukungan keluarga jika tersedia. Keluarga yang sehat lebih mampu memelihara pasien secara konsisten.

I. Simpulan

Gangguan mood, seperti depresi mayor dan gangguan bipolar, merupakan kondisi kejiwaan serius yang ditandai oleh perubahan suasana hati ekstrem, yang secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup, fungsi sosial, emosional, dan fisik pasien. Penyebabnya bersifat multifaktorial, mencakup faktor biologis (neurotransmitter, genetik), perubahan struktur dan fungsi otak, stres kronis dan trauma, faktor medis, serta faktor sosial-ekonomi.

Penanganan gangguan mood membutuhkan pendekatan holistik yang meliputi terapi farmakologis, psikososial, self-help, intervensi gaya hidup, serta terapi maintenance. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi gejala, meningkatkan stabilitas mood, mencegah kekambuhan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

Peran keluarga dalam perawatan gangguan mood sangat penting, tetapi sering menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya pemahaman kondisi pasien, stigma sosial, komunikasi tidak efektif, beban emosional yang berat, kurangnya keterlibatan dalam terapi, serta harapan yang tidak realistis. Oleh karena itu, edukasi keluarga melalui psikoedukasi dan terapi keluarga penting untuk meningkatkan pemahaman, mengurangi stigma, meningkatkan empati, dan mendukung pemulihan pasien.

Pengkajian pasien secara terstruktur mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial, dengan menggunakan alat bantu berbasis bukti seperti PHQ-9, HAM-D, YMRS, MDQ, dan SRM untuk deteksi dini dan evaluasi risiko. Fokus utama pengkajian mencakup identifikasi perubahan mood, afek, perilaku, risiko bunuh diri, dan dampaknya terhadap kehidupan pasien.

Intervensi berbasis bukti seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), Interpersonal and Social Rhythm Therapy (IPSRT), serta intervensi self-help terbukti mampu menurunkan tingkat kekambuhan secara signifikan. Terapi gaya hidup juga memberikan manfaat besar dalam meningkatkan stabilitas mood melalui aktivitas fisik, nutrisi sehat, kualitas tidur, manajemen stres, serta dukungan sosial.

Perencanaan pulang (discharge planning) merupakan langkah penting yang melibatkan pendidikan pasien dan keluarga, penguatan kepatuhan pengobatan, tindak lanjut rawat jalan, rencana darurat, dukungan psikososial, manajemen gaya hidup sehat, dan keterlibatan aktif keluarga sebagai caregiver. Perencanaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pasien, mencegah komplikasi, dan meminimalisasi risiko kekambuhan.

Strategi pencegahan kekambuhan melibatkan pengenalan tanda-tanda awal, penerapan keterampilan koping, menjaga kepatuhan pengobatan, menciptakan lingkungan yang suportif, serta meningkatkan komunikasi yang terbuka dan empatik dalam keluarga. Peran keluarga sebagai caregiver juga perlu mendapat perhatian, termasuk menjaga kesehatan mental mereka sendiri agar mampu memberikan dukungan optimal kepada pasien dalam jangka panjang.

J. Referensi

- Ahsan, M. (2024). A review on the effectiveness of psychoeducation by mental health nurses in reducing relapse rates in bipolar affective disorder. *Journal of Mental Health, 1*(1), 14-18.
- Aktaş, Y., & Dülgerler, Ş. (2024). Effectiveness of interpersonal social rhythm therapy applied to individuals with bipolar disorder: A systematic review. *J Psy Nurs, 15*(1), 81-92. <https://doi.org/10.14744/phd.2024.26428>.
- American Psychiatric Association. (2022). *Practice guideline for the treatment of patients with major depressive disorder*.
- Applebaum, A. J., & Sannes, T. S. (2025). The importance of honoring Family caregiver burden: challenges in mental health care delivery. *Journal of clinical psychology in medical settings, 32*(2), 193-201.
- Ardan, M., Umar, Z., Kadir, A., & Ariestantia, D. R. (2021). Efektivitas Intervensi Spiritual Management Of Relaxation Therapy (Smarter) Dalam Upaya Mencegah Depresi Ibu Postpartum. *Sebatik, 25*(2), 405-410.
- Balikai, S. I., Rentala, S., Mudakavi, I. B., & Nayak, R. B. (2022). Impact of nurse-led medication adherence therapy on bipolar affective disorder: A randomized controlled trial. *Perspectives in Psychiatric Care, 58*(4), 2676-2686.

- Basak, M. M., Ray, A., Das, S., Saha, S., & Bhattacharya, S. (2025). Effect of Family Focused Therapy among Caregivers and Patients on Prognosis of Bipolar Disorder Patients: A Systematic Review and Meta Analysis. *Indian Journal of Public Health Research & Development*, 16(2).
- Bian, C., Zhao, W. W., Yan, S. R., Chen, S. Y., Cheng, Y., & Zhang, Y. H. (2023). Effect of interpersonal psychotherapy on social functioning, overall functioning and negative emotions for depression: A meta-analysis. *Journal of affective disorders*, 320, 230-240.
- Boland, R., Verdiun, M., & Ruiz, P. (2021). *Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry*. Lippincott Williams & Wilkins..
- Brujniks, S. J., van Bronswijk, S. C., DeRubeis, R. J., Delgadillo, J., Cuijpers, P., & Huibers, M. J. (2022). *Individual differences in response to once versus twice weekly sessions of CBT and IPT for depression* (Vol. 90, No. 1, p. 5). American Psychological Association.
- Buchwald, N., Terapi Mandiri: Bisakah Anda Menyembuhkan Diri Sendiri Tanpa Terapis?, 26 February, 2025. <https://manhattanmentalhealthcounseling.com/self-therapy-can-you-heal-yourself-without-a-therapist/>. Diakses, tanggal 24 Juli 2025, jam 14.05
- Casarez, R. L., Soares, J. C., & Meyer, T. D. (2021). Psychoeducation for caregivers of patients with bipolar disorder—Lessons learned from a feasibility study. *Journal of Affective Disorders*, 287, 367-371.
- Cham, C. Q., Ibrahim, N., Siau, C. S., Kalaman, C. R., Ho, M. C., Yahya, A. N., ... & Lee, K. W. (2022, November). Caregiver burden among caregivers of patients with mental illness: A systematic review and meta-analysis. In *Healthcare* (Vol. 10, No. 12, p. 2423). MDPI.
- Chen, C. H., Huang, M. C., Chiu, Y. H., Chen, I. M., Chen, C. H., Lu, M. L., ... & Kuo, P. H. (2022). Stress susceptibility moderates the relationship between eveningness preference and poor sleep quality in non-acute mood disorder patients and healthy controls. *Nature and Science of Sleep*, 711-723.

- Cheng, W. L., Chang, C. C., Griffiths, M. D., Yen, C. F., Liu, J. H., Su, J. A., ... & Pakpour, A. H. (2022). Quality of life and care burden among family caregivers of people with severe mental illness: mediating effects of self-esteem and psychological distress. *BMC psychiatry*, 22(1), 672.
- Clarke, K., Mayo-Wilson, E., Kenny, J., & Pilling, S. (2015). Can non-pharmacological interventions prevent relapse in adults who have recovered from depression? A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Clinical psychology review*, 39, 58–70. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.04.002>
- Clayton, D. A., & Burlingame, G. M. (2024). Evidence-based group therapy for mood disorders: Treatment for depression and bipolar disorders. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*.
- Cuijpers, P., Miguel, C., Ciharova, M., Harrer, M., Basic, D., Cristea, I. A., ... & Karyotaki, E. (2024). Absolute and relative outcomes of psychotherapies for eight mental disorders: A systematic review and meta-analysis. *World psychiatry*, 23(2), 267–275.
- De Angel, V., Lewis, S., White, K., Oetzmman, C., Leightley, D., Oprea, E., ... & Hotopf, M. (2022). Digital health tools for the passive monitoring of depression: a systematic review of methods. *NPJ digital medicine*, 5(1), 3.
- Dehbozorgi, R., Fereidooni-Moghadam, M., Shahriari, M., & Moghimi-Sarani, E. (2022). Barriers to family involvement in the care of patients with chronic mental illnesses: A qualitative study. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 995863.
- Giovannini, S., Tamburrano, A., Sganga, F., Serra, M. L., Loreti, C., Coraci, D., ... & Barillaro, C. (2021). A new model of multidimensional discharge planning: continuity of care for frail and complex inpatients. *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*, 25(24), 13009–13014.
- Girdhar, A., & Patil, R. (2023). Caregivers' burden in patients with bipolar disorder and schizophrenia and its relationship with anxiety and depression in caregivers: A narrative review. *Cureus*, 15(10).
- Gregg, L., Adderley, H., Calam, R., & Wittkowski, A. (2021). The implementation of family-focused practice in adult mental health services: A systematic review

- exploring the influence of practitioner and workplace factors. *International Journal of Mental Health Nursing*, 30(4), 885-906
- Hester, L., Dang, D., Barker, C. J., Heath, M., Mesiya, S., Tienabeso, T., & Watson, K. (2021). Evening wear of blue-blocking glasses for sleep and mood disorders: a systematic review. *Chronobiology International*, 38(10), 1375-1383
- Iwebo, J. (2024). *Training Nurse Practitioners and Providers in Primary Care to Screen for Bipolar Disorder* (Doctoral dissertation, Walden University).
- Johnson, M., et al. (2019). Family support and severity of mood disorder symptoms. *Journal of Psychology*, 22(3), 431-445.
- Kavitha, R. R., Kamalam, S., & Rajkumar, R. P. (2022). Effectiveness of family-focused nurse-led intervention on functional improvement of patients with bipolar disorder at a tertiary hospital in South India: A randomized controlled trial. *Indian journal of psychological medicine*, 44(2), 152-159.
- Keynejad, R., Spagnolo, J., & Thornicroft, G. (2021). WHO mental health gap action programme (mhGAP) intervention guide: updated systematic review on evidence and impact. *BMJ Ment Health*, 24(3), 124-130.
- Kim, S., & Lee, J. (2020). A systematic review of family interventions for mood disorders. *Journal of Family Therapy*, 18(2), 210-225.
- Koning, E., Vorstman, J., McIntyre, R. S., & Brietzke, E. (2022). Characterizing eating behavioral phenotypes in mood disorders: a narrative review. *Psychological Medicine*, 52(14), 2885-2898.
- Lemma, A., Hepworth, M., Fonagy, P., Luyten, P., & Abrahams, D. (2024). *Brief dynamic interpersonal therapy*. Oxford University Press.
- Levrat, V., Favre, S., & Richard-Lepouriel, H. (2024). Current practices of psychoeducation interventions with persons with bipolar disorders: a literature review. *Frontiers in psychiatry*, 14, 1320654.
- Lo, H. K., Ho, F. Y., Yeung, J. W., Ng, S. T., Wong, E. Y., & Chung, K. F. (2024). Self-help interventions for the prevention of relapse in mood disorder: a systematic review

and meta-analysis. *Family practice*, 41(5), 662–679.
<https://doi.org/10.1093/fampra/cmae036>

Malhi, G. S., Bell, E., Bassett, D., Boyce, P., Bryant, R., Hazell, P., ... & Murray, G. (2021). The 2020 Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for mood disorders. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 55(1), 7-117.

Marx, W., Manger, S. H., Blencowe, M., Murray, G., Ho, F. Y. Y., Lawn, S., ... & O'Neil, A. (2023). Clinical guidelines for the use of lifestyle-based mental health care in major depressive disorder: World Federation of Societies for Biological Psychiatry (WFSBP) and Australasian Society of Lifestyle Medicine (ASLM) taskforce. *The World Journal of Biological Psychiatry*, 24(5), 333-386.

McCartney, M., Nevitt, S., Lloyd, A., Hill, R., White, R., & Duarte, R. (2021b). Mindfulness-based cognitive therapy for prevention and time to depressive relapse: Systematic review and network meta-analysis. *Acta psychiatrica Scandinavica*, 143(1), 6–21.
<https://doi.org/10.1111/acps.13242>

Mekap, T. (2024). Family focused therapy on frequently relapsing bipolar disorder: A study of care giver's stress and quality of life. *Int J Psychiatry Res*, 6(2), 01-5.

Merlo, G., Ye, W., & Porter-Stransky, K. A. (2025). Lifestyle psychiatry for clinical care. *Psychiatric Annals*, 55(7), e155-e159.

mood disorders: A meta-analysis. *Journal of Clinical Psychology*, 25(1), 89-102

Moriarty, A. S., Robertson, L., Mughal, F., Cook, N., Gilbody, S., McMillan, D., ... & Meader, N. (2021). Interventions for preventing relapse or recurrence of major depressive disorder in adults in a primary care setting: a network meta-analysis. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2021(11), CD014832.

Nguyen, T., et al. (2022). The impact of family support on relapse rates in mood disorders. *Journal of Affective Disorders*, 30(4), 511-525.

Ong, H. S., Fernandez, P. A., & Lim, H. K. (2021). Family engagement as part of managing patients with mental illness in primary care. *Singapore medical journal*, 62(5), 213.

- Oud, M., Mayo-Wilson, E., Braidwood, R., Schulte, P., Jones, S. H., Morriss, R., ... Kendall, T. (2016). Psychological interventions for adults with bipolar disorder: systematic review and meta-analysis. *British Journal of Psychiatry*, 208(3), 213–222. doi:10.1192/bjp.bp.114.157123
- Petkari, E., Kaselionyte, J., Altun, S., & Giacco, D. (2021). Involvement of informal carers in discharge planning and transition between hospital and community mental health care: a systematic review. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 28(4), 521-530.
- Polhuis, D., & Grealish, A. (2022). Advanced Mental Health Nursing Assessment, Formulation and Decision-Making. In *Advanced Practice in Mental Health Nursing: A European Perspective* (pp. 91-121). Cham: Springer International Publishing.
- Putra, R. S. (2024). Psychoeducation In Families In Preventing Recurrence Of Patients With Mental Disorders (Literature Review). *Jurnal kesehatan dan pembangunan*, 14(2), 188-196.
- Ran, M. S., Hall, B. J., Su, T. T., Prawira, B., Breth-Petersen, M., Li, X. H., & Zhang, T. M. (2021). Stigma of mental illness and cultural factors in Pacific Rim region: a systematic review. *BMC psychiatry*, 21(1), 8.
- Rodriguez, D., et al. (2021). Family support and treatment outcomes for individuals with
- Saraf, G., Moazen-Zadeh, E., Pinto, J. V., Ziafat, K., Torres, I. J., Kesavan, M., & Yatham, L. N. (2021). Early intervention for people at high risk of developing bipolar disorder: a systematic review of clinical trials. *The Lancet Psychiatry*, 8(1), 64-75
- Schimmels, J., Groh, C., Neft, M., Wocial, L., Young, C., & Davidson, J. E. (2023). American Academy of Nursing Expert Panel Consensus Statement on leveraging equity in policy to improve recognition and treatment of mental health, substance use disorders, and nurse suicide. *Nursing outlook*, 71(3), 101970.
- Schuch, F. B., & Vancampfort, D. (2021). Physical activity, exercise, and mental disorders: it is time to move on. *Trends in psychiatry and psychotherapy*, 43(3), 177-184.

- Seshadhri, S., Rajavadivel, S., & Hariharasudhan, V. (2024). Family-focused therapy: An emerging approach on the treatment of bipolar disorder. *Biosciences Biotechnology Research Asia*, 21(1), 37-44.
- Shi, Z., Wang, S., Chen, M., Hu, A., Long, Q., & Lee, Y. (2024). The effect of music therapy on language communication and social skills in children with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 15, 1336421.
- Smith, A., & Brown, C. (2018). The role of family support in managing mood disorders. *Journal of Mental Health*, 15(4), 567-580
- Stangier, U., Hilling, C., Heidenreich, T., Risch, A. K., Barocka, A., Schlösser, R., Kronfeld, K., Ruckes, C., Berger, H., Röschke, J., Weck, F., Volk, S., Hambrecht, M., Serfling, R., Erkwow, R., Stirn, A., Sobanski, T., & Hautzinger, M. (2013). Maintenance cognitive-behavioral therapy and manualized psychoeducation in the treatment of recurrent depression: A multicenter prospective randomized controlled trial. *American Journal of Psychiatry*, 170(6), 624–632. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2013.12060734>
- Tabas, M. Y., Momeni, F., Bakhshani, N. M., Pourshahbaz, A., & Rezaei, O. (2023). Effectiveness of family-focused therapy in bipolar disorder: a randomized controlled trial. *Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences*, 17(4).
- Tol, W. A., Leku, M. R., Lakin, D. P., Carswell, K., Augustinavicius, J., Adaku, A., Au, T. M., Brown, F. L., Bryant, R. A., Garcia-Moreno, C., Musci, R. J., Ventevogel, P., White, R. G., & van Ommeren, M. (2020). Guided self-help to reduce psychological distress in South Sudanese female refugees in Uganda: a cluster randomised trial. *The Lancet Global Health*, 8(2), e254–e263. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30504-2](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30504-2)
- Wang, Q., Zhang, W., & An, S. (2023). A systematic review and meta-analysis of Internet-based self-help interventions for mental health among adolescents and college students. *Internet Interventions*, 34, 100690.
- Weintraub, M. J., Schneck, C. D., Posta, F., Merranko, J. A., Singh, M. K., Chang, K. D., & Miklowitz, D. J. (2022). *Effects of family intervention on psychosocial functioning*

and mood symptoms of youth at high risk for bipolar disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 90(2), 161.

WHO (2010). *mhGAP Intervention Guide: Mood Disorders*.
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44406/9789241548069_eng.pdf
diakses Senin, 28 Juli 2025

Yatham, L. N., Chakrabarty, T., Bond, D. J., Schaffer, A., Beaulieu, S., Parikh, S. V., ... & Post, R. (2021). Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) recommendations for the management of patients with bipolar disorder with mixed presentations. *Bipolar disorders, 23*(8), 767-788.

Zhang, F., & Yang, R. (2025). Parental expectations and adolescents' happiness: the role of self-efficacy and connectedness. *BMC psychology, 13*(1), 24.

K. Glosarium

Afek: Ekspresi emosi yang terlihat pada wajah atau perilaku seseorang, mencerminkan suasana hati yang dirasakan.

Antidepresan: Obat yang digunakan untuk mengatasi gejala depresi dengan menyeimbangkan zat kimia di otak, seperti serotonin dan norepinefrin.

CBT (Cognitive Behavioral Therapy): Terapi psikologis yang bertujuan mengubah pola pikir negatif dan perilaku maladaptif untuk meningkatkan kesehatan mental.

Depresi Mayor (Major Depressive Disorder): Kondisi gangguan mood serius yang ditandai suasana hati yang sangat sedih, hilangnya minat, perubahan tidur dan makan, serta pikiran tentang bunuh diri.

Discharge Planning: Proses sistematis dalam keperawatan untuk mempersiapkan pasien dan keluarga menghadapi perawatan lanjutan setelah keluar dari rumah sakit.

Episode Mania: Fase dalam gangguan bipolar yang ditandai dengan suasana hati euforia berlebihan, energi tinggi, impulsivitas, dan kadang disertai perilaku berisiko.

Farmakoterapi: Pengobatan gangguan jiwa dengan obat-obatan, seperti antidepresan, antipsikotik, mood stabilizer, dan lainnya.

Gangguan Bipolar: Gangguan suasana hati yang ditandai oleh pergantian episode antara mania atau hipomania dengan depresi berat.

Gangguan Mood: Kelompok gangguan mental yang ditandai oleh perubahan signifikan dalam suasana hati, termasuk depresi mayor dan gangguan bipolar.

Grandiositas: Perasaan atau keyakinan berlebihan mengenai kemampuan atau kepentingan diri, sering terjadi dalam fase mania gangguan bipolar.

Halusinasi: Persepsi palsu yang dialami oleh pasien, tanpa adanya rangsangan nyata dari luar.

Hipomania: Bentuk mania ringan yang gejalanya kurang berat dibandingkan mania, namun tetap mempengaruhi aktivitas harian.

Intervensi Psikososial: Pendekatan terapeutik yang melibatkan interaksi sosial dan psikologis seperti CBT, psikoedukasi, atau terapi keluarga untuk menangani gangguan mental.

Maintenance CBT: Terapi CBT jangka panjang yang bertujuan mencegah kekambuhan gangguan mood melalui penguatan keterampilan yang sudah dipelajari.

Mood Stabilizer: Obat yang digunakan untuk mengendalikan fluktuasi suasana hati ekstrem, terutama pada pasien gangguan bipolar.

Neurotransmitter: Zat kimia dalam otak yang mengirimkan sinyal antar-sel saraf, seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin, yang terkait dengan pengaturan suasana hati.

PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9): Alat skrining untuk mengidentifikasi gejala depresi dan tingkat keparahannya.

Relaps: Kekambuhan atau munculnya kembali gejala penyakit setelah periode perbaikan.

Self-help Therapy: Terapi mandiri menggunakan buku, aplikasi, atau kelompok dukungan, tanpa atau dengan sedikit bimbingan profesional untuk mengelola gangguan mental.

Stigma: Pandangan negatif atau diskriminasi yang muncul akibat kurangnya pemahaman tentang gangguan mental, menyebabkan pasien merasa terisolasi dan enggan mencari bantuan profesional.

Terapi Elektroconvulsif (ECT): Terapi medis yang melibatkan pemberian stimulus listrik ke otak untuk menangani gejala gangguan mental yang berat.

Young Mania Rating Scale (YMRS): Alat pengukuran tingkat keparahan gejala mania pada gangguan bipolar.

CHAPTER 6

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN KECEMASAN

Tsuwaibatul Islamiyah, S.Kep., Ns., M.S.

A. Pendahuluan/Prolog

Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis yang ditandai dengan perasaan cemas, khawatir, atau takut yang berlebihan, terus-menerus, serta sulit untuk dikendalikan oleh individu yang mengalaminya. Kondisi ini sering kali disertai gejala fisik seperti jantung berdebar, sesak napas, berkeringat dingin, gemetar, gangguan tidur, hingga gangguan pencernaan. Gangguan kecemasan bukan sekadar rasa cemas biasa yang muncul secara alami sebagai respons terhadap situasi tertentu, melainkan suatu kondisi patologis yang mengganggu fungsi dan aktivitas sehari-hari seseorang. Kondisi ini menjadi serius ketika intensitas dan durasi kecemasan tersebut tidak proporsional terhadap situasi yang dihadapi serta mengganggu kualitas hidup dan produktivitas individu yang bersangkutan.

Kecemasan sendiri sebenarnya adalah respons adaptif dan alamiah yang dimiliki oleh setiap manusia untuk melindungi diri dari bahaya yang mengancam. Namun, ketika respons kecemasan ini terjadi secara berlebihan, kronis, serta sulit dikendalikan, maka akan berubah menjadi gangguan kecemasan patologis. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan, terutama perawat, untuk mampu mengenali serta membedakan antara kecemasan yang bersifat adaptif dan kecemasan patologis sehingga mampu memberikan asuhan keperawatan yang tepat bagi pasien yang mengalami gangguan ini.

Dalam praktik klinis, gangguan kecemasan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yang masing-masing memiliki karakteristik klinis yang unik dan berbeda satu sama lain. Berdasarkan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)*, gangguan kecemasan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu gangguan kecemasan menyeluruh (*generalized anxiety disorder*), gangguan panik (*panic disorder*), fobia spesifik, fobia sosial atau *social anxiety disorder*, serta gangguan kecemasan perpisahan (*separation anxiety disorder*). Setiap kategori tersebut memiliki pola gejala dan manifestasi yang khas. Misalnya, gangguan

kecemasan menyeluruh ditandai dengan rasa khawatir dan cemas berlebihan terkait berbagai aspek kehidupan sehari-hari, sedangkan gangguan panik lebih dikenal dengan munculnya serangan panik mendadak yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan yang luar biasa dan sensasi fisik yang tidak nyaman.

Fobia spesifik adalah kecemasan yang ekstrem dan tidak rasional terhadap objek atau situasi tertentu seperti takut akan ketinggian, hewan, atau jarum suntik. Sebaliknya, fobia sosial berkaitan erat dengan kecemasan yang muncul ketika seseorang berada dalam situasi sosial atau di hadapan banyak orang karena takut dievaluasi atau dihakimi secara negatif. Gangguan kecemasan perpisahan biasanya terjadi pada masa kanak-kanak tetapi dapat berlanjut hingga dewasa, ditandai dengan kecemasan yang berlebihan ketika terpisah dari figur yang melekat dalam kehidupan seseorang seperti orang tua atau anggota keluarga dekat.

Dari sisi epidemiologi, gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang paling umum ditemui di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut laporan dari World Health Organization (WHO), sekitar 264 juta penduduk dunia mengalami gangguan kecemasan pada tahun-tahun terakhir, menunjukkan betapa signifikan prevalensi gangguan ini secara global. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi gangguan kecemasan cenderung meningkat setiap tahun, dipicu oleh berbagai faktor stresor yang kompleks dalam kehidupan modern.

Beberapa faktor risiko yang secara umum meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami gangguan kecemasan antara lain faktor genetik atau riwayat gangguan mental dalam keluarga, pengalaman traumatis di masa lalu, faktor neurobiologis seperti ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, serta lingkungan psikososial yang tidak mendukung seperti kekerasan, tekanan pekerjaan, atau konflik interpersonal yang berkepanjangan. Selain itu, pola hidup yang tidak sehat, kurangnya dukungan sosial, isolasi sosial, serta paparan stres kronis yang terus-menerus juga turut berkontribusi secara signifikan terhadap munculnya gangguan kecemasan.

B. Konsep Dasar Gangguan Kecemasan

Gangguan kecemasan merupakan kondisi psikologis kompleks yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari penyebab hingga dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari individu. Untuk memahami gangguan ini secara menyeluruh, penting bagi tenaga kesehatan, terutama perawat, untuk memahami konsep dasar yang meliputi etiologi,

patofisiologi, manifestasi klinis, hingga dampak gangguan kecemasan terhadap pasien secara holistik.

Etiologi gangguan kecemasan bersifat multifaktorial, artinya tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal saja, melainkan kombinasi berbagai faktor yang saling berinteraksi. Salah satu faktor yang sering disebut adalah faktor genetik. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan riwayat keluarga yang mengalami gangguan kecemasan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kondisi serupa. Hal ini disebabkan karena faktor genetik turut mempengaruhi struktur dan fungsi neurotransmitter di otak yang bertanggung jawab dalam pengaturan respons stres, emosi, serta kecemasan. Selain faktor genetik, faktor neurobiologis juga memainkan peranan penting, di antaranya ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan asam gamma aminobutirat (GABA), yang berperan penting dalam regulasi suasana hati dan respons stres seseorang.

Faktor psikologis dan lingkungan juga turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan gangguan kecemasan. Pengalaman traumatis, seperti kehilangan orang yang dicintai, pelecehan fisik atau emosional, dan paparan situasi stres berkepanjangan, sering kali mencetuskan terjadinya gangguan kecemasan pada seseorang. Lingkungan sosial yang tidak suportif, tekanan hidup yang berat, serta konflik interpersonal yang terus-menerus juga dapat menyebabkan seseorang rentan mengalami gangguan kecemasan. Interaksi antara faktor genetik, biologis, psikologis, dan lingkungan ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam memahami mekanisme dasar dari terjadinya gangguan kecemasan.

Secara patofisiologi, gangguan kecemasan melibatkan beberapa mekanisme kompleks di otak, terutama melibatkan sistem limbik yang terdiri dari amigdala, hipotalamus, dan hipokampus. Amigdala memainkan peran kunci dalam merespons ancaman dan bahaya. Pada individu yang mengalami gangguan kecemasan, sering kali terjadi hiperaktivitas pada amigdala, yang menyebabkan respons kecemasan menjadi berlebihan atau tidak proporsional terhadap situasi yang sebenarnya tidak mengancam. Selain itu, aktivasi berlebihan dari aksis hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA axis) juga menyebabkan pelepasan hormon stres kortisol secara berlebihan. Tingginya kadar kortisol yang persisten ini dapat menyebabkan gejala fisik dan psikologis yang khas pada pasien dengan gangguan kecemasan seperti perasaan tegang, takut, gangguan tidur, kelelahan kronis, hingga gangguan konsentrasi.

Manifestasi klinis gangguan kecemasan dapat berupa gejala psikologis maupun fisik, yang keduanya sering kali muncul bersamaan dan saling mempengaruhi. Gejala

psikologis yang paling umum adalah perasaan cemas yang intens, khawatir berlebihan, rasa takut yang tidak jelas penyebabnya, pikiran negatif yang terus-menerus, serta ketidakmampuan individu untuk mengendalikan kekhawatiran yang muncul. Individu dengan gangguan kecemasan juga kerap mengalami ketegangan, perasaan gelisah, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, serta mengalami gangguan tidur yang signifikan.

Sementara itu, gejala fisik yang umum dialami pasien gangguan kecemasan meliputi peningkatan denyut jantung (takikardia), palpitasi, nyeri dada, sesak napas, pusing, mual, gangguan pencernaan, keringat dingin, gemetar, dan otot-otot tubuh yang terasa tegang. Gejala-gejala ini sering kali membuat pasien semakin cemas karena takut mengalami penyakit yang lebih serius seperti gangguan jantung atau stroke, meskipun pada kenyataannya, gejala-gejala tersebut lebih terkait dengan gangguan kecemasan itu sendiri.

Gangguan kecemasan memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan pasien, yang tidak hanya terbatas pada aspek psikologis dan fisik, tetapi juga merambat ke berbagai aspek sosial, ekonomi, pekerjaan, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Individu yang mengalami gangguan kecemasan cenderung memiliki kualitas hidup yang rendah, terutama karena mereka sering mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, berinteraksi dengan orang lain, atau menjalankan tugas-tugas pekerjaan secara optimal. Mereka juga cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, menghindari berbagai situasi yang dianggap sebagai pemicu kecemasan, sehingga memperburuk kondisi isolasi sosial yang mereka alami.

Dalam konteks pekerjaan atau pendidikan, gangguan kecemasan dapat menyebabkan penurunan performa, absen yang meningkat, dan produktivitas yang rendah. Dalam aspek ekonomi, pasien dengan gangguan kecemasan juga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kesulitan finansial akibat keterbatasan produktivitas, kebutuhan biaya pengobatan yang tinggi, serta dampak kecemasan kronis yang mengganggu kemampuan mereka untuk bekerja secara efektif.

Selain dampak tersebut, gangguan kecemasan juga dapat menimbulkan masalah kesehatan lainnya seperti peningkatan risiko depresi, penyalahgunaan zat, hingga masalah kesehatan fisik seperti hipertensi, gangguan tidur kronis, dan gangguan sistem pencernaan. Semua dampak ini saling berkaitan, memperburuk kondisi pasien, dan menciptakan siklus yang sulit diputus tanpa adanya intervensi keperawatan yang komprehensif.

C. Pengkajian Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Kecemasan

Pengkajian merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kecemasan. Pengkajian keperawatan yang tepat dan komprehensif sangat menentukan keberhasilan dalam merancang intervensi keperawatan yang sesuai dan efektif. Dalam konteks gangguan kecemasan, pengkajian keperawatan tidak sekadar mengidentifikasi gejala atau keluhan yang tampak secara fisik, tetapi juga mencakup dimensi biopsikososial yang luas, identifikasi masalah keperawatan yang paling mendesak, serta penilaian tingkat kecemasan menggunakan instrumen pengkajian yang terstandar.

Pengumpulan data biopsikososial merupakan komponen utama dalam pengkajian keperawatan pasien dengan gangguan kecemasan. Proses ini melibatkan pemeriksaan atau wawancara mendalam terhadap pasien, keluarga, atau orang-orang terdekat yang relevan. Pengkajian bio (fisik) mencakup identifikasi tanda-tanda fisik yang muncul akibat kecemasan, seperti jantung berdebar, sesak napas, gemetar, gangguan tidur, nyeri kepala, ketegangan otot, mual, dan gangguan saluran pencernaan. Riwayat penyakit fisik yang mungkin memperberat kondisi kecemasan seperti gangguan tiroid, penyakit kardiovaskular, atau gangguan neurologis juga perlu dicatat dengan teliti.

Pada aspek psikologis, perawat harus mengkaji bagaimana pasien mengalami dan mengekspresikan kecemasan, termasuk intensitas kecemasan yang dirasakan, pola pikir pasien, respons emosional, serta mekanisme koping yang selama ini digunakan oleh pasien. Pasien dengan gangguan kecemasan sering menunjukkan pola pikir negatif, kekhawatiran yang berlebihan, ketidakmampuan mengontrol pikiran yang mengganggu, serta perasaan tidak berdaya dalam menghadapi kecemasan. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi apakah pasien memiliki riwayat masalah psikologis lain, seperti depresi, riwayat trauma, atau pengalaman kekerasan sebelumnya.

Dimensi sosial dari pengumpulan data mencakup evaluasi terhadap lingkungan pasien, baik keluarga maupun lingkungan sosial yang lebih luas. Dukungan keluarga, kondisi hubungan interpersonal, situasi ekonomi, pekerjaan atau sekolah, serta adanya stresor sosial seperti konflik dalam hubungan, isolasi sosial, atau kurangnya dukungan sosial, harus diperhatikan karena faktor-faktor tersebut sering kali memperburuk atau mencetuskan kondisi kecemasan pasien. Data biopsikososial yang akurat dan lengkap memungkinkan perawat memahami kondisi pasien secara holistik serta menentukan intervensi yang lebih personal dan tepat sasaran.

Setelah data biopsikososial terkumpul, perawat melakukan proses identifikasi masalah keperawatan utama. Proses ini dilakukan melalui analisis data yang terkumpul untuk menentukan prioritas masalah keperawatan yang memerlukan intervensi segera. Pada pasien dengan gangguan kecemasan, masalah keperawatan yang lazim ditemukan antara lain ansietas atau kecemasan itu sendiri, gangguan pola tidur, ketidakefektifan coping individu, gangguan interaksi sosial, isolasi sosial, serta risiko gangguan harga diri rendah. Perawat harus mampu menentukan mana di antara berbagai masalah tersebut yang paling mendesak untuk diatasi berdasarkan intensitas gejala, dampak terhadap kehidupan pasien, serta kemampuan pasien untuk mengelola situasi saat ini.

Masalah utama biasanya merupakan manifestasi kecemasan yang paling mengganggu pasien, misalnya pasien mungkin sangat terganggu dengan ketidakmampuan tidur sehingga menyebabkan kelelahan kronis, atau pasien merasa sangat cemas hingga tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Menentukan prioritas yang jelas membantu perawat dalam menyusun rencana asuhan yang fokus, efektif, serta terukur dalam evaluasinya.

Pengkajian tingkat kecemasan dengan instrumen standar merupakan langkah berikutnya yang penting dalam proses pengkajian keperawatan gangguan kecemasan. Penggunaan instrumen standar membantu perawat mengukur secara obyektif tingkat keparahan kecemasan yang dialami pasien, sehingga tidak hanya mengandalkan penilaian subjektif semata. Beberapa instrumen pengkajian tingkat kecemasan yang umum digunakan adalah Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), Zung Self-Rating Anxiety Scale, Beck Anxiety Inventory (BAI), serta Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7).

Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) merupakan instrumen yang paling sering digunakan oleh tenaga kesehatan karena mampu memberikan gambaran detail tentang intensitas kecemasan yang dialami pasien serta mudah digunakan dalam praktik klinis. Skala ini mengukur berbagai aspek kecemasan mulai dari gejala psikologis hingga gejala fisik. Demikian pula, Beck Anxiety Inventory (BAI) juga banyak dipakai karena kesederhanaannya serta efektivitasnya dalam menilai kecemasan subjektif yang dirasakan pasien secara cepat. Instrumen-instrumen ini mampu membantu perawat untuk secara lebih jelas menentukan derajat kecemasan, mulai dari ringan, sedang, hingga berat, sehingga intervensi yang dipilih pun menjadi lebih tepat dan proporsional terhadap kondisi pasien.

Dengan melakukan pengkajian biopsikososial secara komprehensif, mengidentifikasi masalah keperawatan secara jelas dan terukur, serta melakukan pengukuran tingkat kecemasan menggunakan instrumen yang terstandar, perawat akan mendapatkan gambaran klinis yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi pasien. Informasi ini menjadi dasar utama dalam menyusun rencana asuhan keperawatan yang efektif dan terarah, sehingga pasien dengan gangguan kecemasan dapat terbantu dalam mengelola gejala, meningkatkan kemampuan coping, serta akhirnya mencapai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

D. Diagnosis Keperawatan yang Lazim pada Pasien dengan Gangguan Kecemasan

Diagnosis keperawatan merupakan tahapan penting dalam proses asuhan keperawatan yang bertujuan untuk menentukan masalah utama yang dialami oleh pasien, terutama pada pasien yang mengalami gangguan kecemasan. Penentuan diagnosis keperawatan secara tepat akan memudahkan perawat dalam menyusun perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan keperawatan secara efektif. Pada pasien dengan gangguan kecemasan, terdapat beberapa diagnosis keperawatan yang lazim ditemukan, di antaranya adalah ansietas, gangguan pola tidur, risiko harga diri rendah kronis, isolasi sosial, dan ketidakefektifan coping individu.

Diagnosis keperawatan pertama yang paling sering muncul pada pasien dengan gangguan kecemasan adalah ansietas. Ansietas atau kecemasan adalah kondisi di mana seseorang mengalami rasa takut atau khawatir yang intens dan berlebihan terhadap situasi atau objek tertentu. Pasien seringkali merasa sulit untuk mengendalikan kecemasannya, dan cemas ini berlangsung secara persisten, bahkan tanpa sebab yang jelas. Manifestasi ansietas meliputi gejala fisik seperti jantung berdebar, nyeri dada, sesak napas, berkeringat, mual, tremor, dan ketegangan otot, serta gejala psikologis berupa perasaan gelisah, khawatir berlebihan, dan sulit berkonsentrasi. Diagnosis ini penting karena merupakan inti dari gangguan kecemasan, sehingga menjadi prioritas utama dalam perencanaan intervensi keperawatan.

Diagnosis keperawatan kedua adalah gangguan pola tidur. Gangguan pola tidur pada pasien dengan gangguan kecemasan umumnya ditandai dengan kesulitan dalam memulai tidur (insomnia awal), sering terbangun tengah malam (insomnia tengah), atau terbangun terlalu awal (insomnia akhir). Gangguan tidur ini terjadi karena pikiran cemas yang terus menerus, ketegangan fisik yang meningkat, serta kondisi emosional yang tidak stabil. Akibatnya, pasien mengalami kualitas tidur yang buruk, merasa tidak

segar saat bangun pagi, kelelahan di siang hari, dan penurunan produktivitas secara signifikan. Dalam jangka panjang, gangguan pola tidur juga berisiko menurunkan daya tahan tubuh dan memperburuk kondisi kecemasan yang sudah ada.

Diagnosis keperawatan berikutnya adalah risiko harga diri rendah kronis. Pasien dengan gangguan kecemasan sering kali memiliki pandangan negatif terhadap diri sendiri, terutama terkait ketidakmampuannya dalam mengelola kecemasan. Pasien merasa tidak kompeten, kurang percaya diri, tidak berguna, dan sering menyalahkan diri sendiri atas kondisi yang dialaminya. Secara kronis, harga diri yang rendah ini dapat memengaruhi hampir semua aspek kehidupan pasien, mulai dari interaksi sosial hingga pencapaian akademik dan profesional. Oleh karena itu, perawat perlu secara aktif mengidentifikasi dan mengelola risiko harga diri rendah pada pasien dengan gangguan kecemasan untuk mencegah dampak yang lebih serius, seperti depresi atau isolasi sosial yang lebih berat.

Diagnosis keperawatan lainnya yang umum terjadi pada pasien dengan gangguan kecemasan adalah isolasi sosial. Pasien dengan gangguan kecemasan cenderung menghindari interaksi sosial karena takut dikritik, ditolak, atau mengalami serangan kecemasan di depan umum. Mereka menarik diri dari lingkungan sosial dan aktivitas bersama orang lain sehingga mengalami kesepian dan isolasi. Isolasi sosial ini memperburuk gejala kecemasan yang sudah dialami, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Perawat perlu memberikan perhatian khusus terhadap diagnosis ini dengan intervensi yang bertujuan meningkatkan keterampilan sosial, meningkatkan keberanian pasien dalam berinteraksi, dan membantu pasien kembali membangun hubungan yang sehat dengan lingkungan sosialnya.

Diagnosis keperawatan terakhir yang lazim ditemukan pada pasien gangguan kecemasan adalah ketidakefektifan koping individu. Ketidakefektifan koping merujuk pada ketidakmampuan pasien dalam mengelola stres atau kecemasan secara efektif dan adaptif. Pasien biasanya memiliki mekanisme koping yang tidak sehat seperti menghindar, menunda-nunda penyelesaian masalah, menyalahgunakan zat atau alkohol, atau terlalu tergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Kondisi ini menyebabkan stres dan kecemasan menjadi semakin sulit dikendalikan dan justru memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk membantu pasien mengembangkan keterampilan koping yang efektif melalui pelatihan teknik relaksasi, penyelesaian masalah, serta edukasi strategi menghadapi kecemasan secara sehat.

E. Perencanaan Keperawatan

Perencanaan keperawatan merupakan tahapan sistematis dalam proses asuhan keperawatan yang dilakukan setelah pengumpulan data, analisis data, dan penentuan diagnosis keperawatan. Dalam konteks gangguan kecemasan, perencanaan keperawatan berperan penting dalam membantu pasien mencapai tujuan kesehatan yang optimal. Proses ini mencakup penetapan tujuan dan kriteria hasil yang jelas, penyusunan prioritas masalah keperawatan, serta penentuan strategi penatalaksanaan yang efektif dan berbasis bukti untuk mengatasi gangguan kecemasan secara holistik.

Langkah awal dalam perencanaan keperawatan adalah menetapkan tujuan dan kriteria hasil yang terukur dan spesifik. Tujuan yang ditetapkan harus realistis, relevan dengan kebutuhan pasien, serta memiliki kerangka waktu yang jelas. Misalnya, tujuan utama pada pasien gangguan kecemasan dapat berupa berkurangnya intensitas kecemasan hingga pasien mampu mengelola perasaan cemas secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Kriteria hasil yang tepat dalam konteks ini meliputi kemampuan pasien mengenali tanda-tanda kecemasan, menerapkan teknik koping positif secara mandiri, perbaikan pola tidur, peningkatan interaksi sosial, serta meningkatnya rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kriteria hasil ini, perawat dapat melakukan evaluasi yang obyektif dan terukur mengenai sejauh mana intervensi yang dilakukan telah berhasil dalam mengurangi gejala kecemasan pasien.

Setelah tujuan dan kriteria hasil ditetapkan, langkah selanjutnya dalam perencanaan keperawatan adalah menyusun prioritas masalah keperawatan. Prioritas masalah ditentukan berdasarkan tingkat urgensi, risiko komplikasi, intensitas gejala yang dialami pasien, serta dampaknya terhadap kualitas hidup pasien. Pada pasien dengan gangguan kecemasan, ansietas sering kali menjadi masalah utama yang membutuhkan perhatian segera, karena kecemasan yang tidak terkelola akan memperparah masalah lain seperti gangguan tidur, isolasi sosial, dan harga diri rendah. Sebagai contoh, pasien yang mengalami serangan panik yang intens dan berulang akan diprioritaskan dalam mengelola ansietasnya terlebih dahulu sebelum masalah lain seperti gangguan tidur atau harga diri rendah ditangani secara intensif. Menyusun prioritas secara jelas membantu perawat dalam menentukan intervensi yang lebih efektif dan efisien, sehingga pasien dapat segera merasakan manfaat intervensi dalam kesehariannya.

Langkah berikutnya adalah menentukan strategi penatalaksanaan gangguan kecemasan dalam asuhan keperawatan yang bersifat komprehensif dan multidimensi. Strategi penatalaksanaan ini melibatkan pendekatan biopsikososial yang mencakup

berbagai modalitas terapi, seperti intervensi psikososial, psikoedukasi, dukungan keluarga, teknik relaksasi, serta kolaborasi interprofesional.

Salah satu strategi penting yang umum diterapkan adalah intervensi psikososial seperti latihan relaksasi otot progresif, teknik napas dalam, meditasi, dan mindfulness. Intervensi tersebut bertujuan membantu pasien mengenali dan mengontrol respons fisiologis tubuh terhadap kecemasan. Teknik napas dalam, misalnya, terbukti efektif dalam mengurangi denyut jantung yang meningkat, ketegangan otot, dan membantu pasien merasakan ketenangan secara cepat. Selain itu, mindfulness atau latihan kesadaran penuh membantu pasien belajar menerima kondisi emosionalnya tanpa penilaian negatif, sehingga pasien secara bertahap mampu mengurangi rasa cemas yang berlebihan.

Strategi lainnya adalah pemberian psikoedukasi yang melibatkan edukasi tentang gangguan kecemasan secara komprehensif kepada pasien dan keluarganya. Melalui psikoedukasi, pasien diberikan pemahaman mengenai gejala-gejala kecemasan, penyebab, dampak, serta teknik pengelolaan kecemasan yang sehat. Psikoedukasi juga membantu mengurangi stigma negatif yang sering dialami pasien terhadap gangguan kecemasan serta meningkatkan motivasi pasien untuk terlibat aktif dalam proses pengobatan dan pemulihan.

Dukungan keluarga dan sosial juga menjadi bagian penting dalam strategi penatalaksanaan kecemasan. Perawat perlu melibatkan keluarga secara aktif untuk memahami kebutuhan emosional pasien, serta memberikan lingkungan yang mendukung proses penyembuhan. Keluarga yang teredukasi dengan baik akan mampu memberikan dukungan emosional, sosial, dan psikologis yang efektif, sehingga pasien merasa lebih aman dan nyaman dalam mengelola kecemasan.

Kolaborasi interprofesional juga merupakan strategi kunci dalam penatalaksanaan gangguan kecemasan. Perawat harus bekerja sama dengan tim kesehatan lain seperti dokter, psikolog, psikiater, atau pekerja sosial untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan kepada pasien benar-benar komprehensif dan terintegrasi. Misalnya, kerja sama dengan psikiater untuk pemberian terapi farmakologis yang sesuai seperti pemberian anxiolitik atau antidepresan bila diperlukan, serta kolaborasi dengan psikolog untuk terapi kognitif perilaku (CBT) yang efektif dalam mengatasi pola pikir negatif penyebab kecemasan.

F. Implementasi Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Kecemasan

Implementasi keperawatan merupakan langkah nyata dalam memberikan asuhan keperawatan yang terencana secara matang kepada pasien dengan gangguan kecemasan. Pada tahapan ini, berbagai intervensi yang telah dirancang sebelumnya mulai diaplikasikan secara langsung, sistematis, dan terukur guna mengurangi gejala kecemasan, memperbaiki fungsi psikologis pasien, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Beberapa intervensi penting dalam implementasi keperawatan yang sering digunakan antara lain terapi modalitas psikososial, psikoedukasi dan konseling individu, dukungan psikososial dari keluarga, intervensi farmakologi melalui kolaborasi dengan tim medis, serta terapi aktivitas kelompok (TAK) dan terapi kelompok dukungan.

Implementasi pertama yang esensial dalam penanganan pasien gangguan kecemasan adalah terapi modalitas psikososial, yang mencakup berbagai teknik seperti relaksasi progresif, teknik napas dalam (deep breathing exercise), serta mindfulness. Terapi relaksasi progresif membantu pasien mengidentifikasi ketegangan fisik yang dialaminya akibat kecemasan, kemudian mengajarkan teknik untuk melepaskan ketegangan tersebut secara bertahap dan sistematis melalui peregangan otot-otot tubuh. Teknik napas dalam merupakan metode sederhana namun sangat efektif untuk meredakan gejala fisiologis kecemasan seperti sesak napas, jantung berdebar, atau hiperventilasi. Teknik ini membantu mengembalikan keseimbangan fisiologis tubuh, sehingga pasien merasa lebih rileks, tenang, dan mampu berpikir lebih jernih dalam situasi yang menimbulkan kecemasan. Sementara itu, mindfulness adalah teknik meditasi berbasis kesadaran penuh yang melatih pasien untuk menerima dan mengobservasi gejala-gejala kecemasan yang dialami tanpa memberikan penilaian negatif, sehingga pasien mampu mengurangi respons emosional yang berlebihan terhadap kecemasannya.

Intervensi selanjutnya adalah pemberian psikoedukasi dan konseling individu secara intensif kepada pasien. Psikoedukasi merupakan langkah penting yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi gangguan kecemasan yang dialami pasien, termasuk penyebab, mekanisme kecemasan dalam tubuh, serta strategi praktis untuk mengelola dan mengurangi gejala kecemasan secara mandiri. Dalam sesi konseling individu, perawat secara aktif mendengarkan pasien, mengeksplorasi pola pikir negatif yang sering muncul saat kecemasan, serta membantu pasien mengembangkan pola pikir positif yang lebih realistis dan adaptif. Konseling ini juga menyediakan ruang aman bagi pasien untuk mengekspresikan

emosinya, mendorong pasien belajar mengelola kecemasan dengan strategi koping yang lebih efektif, serta membantu pasien dalam menetapkan tujuan realistis untuk pemulihannya.

Peran keluarga sebagai sumber dukungan psikososial juga merupakan bagian penting dalam implementasi keperawatan. Keluarga yang memahami kondisi pasien dengan baik dapat menjadi pilar utama dalam mendukung proses pemulihan pasien. Implementasi ini mencakup edukasi kepada keluarga tentang cara yang tepat dalam mendukung pasien, misalnya bagaimana merespons dengan tenang dan penuh empati ketika pasien mengalami episode kecemasan atau serangan panik. Perawat juga membantu keluarga memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung secara emosional, sehingga pasien merasa lebih terlindungi dan mampu lebih baik dalam mengelola kecemasan yang dialami. Dukungan keluarga juga membantu pasien mengurangi rasa isolasi sosial yang kerap menyertai gangguan kecemasan, sehingga mempercepat proses pemulihan.

Implementasi penting berikutnya adalah intervensi farmakologi, yang dilakukan melalui kolaborasi erat dengan tim medis, terutama psikiater atau dokter yang menangani pasien. Intervensi farmakologi biasanya digunakan untuk pasien dengan gangguan kecemasan sedang hingga berat, di mana terapi psikososial saja belum cukup efektif untuk mengontrol gejala. Jenis obat-obatan yang umum digunakan meliputi anxiolitik seperti benzodiazepin (diazepam atau alprazolam) untuk mengurangi gejala akut, serta obat antidepresan jenis Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) seperti sertraline atau fluoxetine yang digunakan dalam jangka panjang. Perawat memiliki peran penting dalam memastikan pasien memahami manfaat dan efek samping pengobatan, melakukan pemantauan ketat terhadap respon pasien terhadap obat, serta membantu pasien mematuhi regimen farmakologi yang telah ditentukan.

Terakhir, implementasi terapi aktivitas kelompok (TAK) dan terapi kelompok dukungan juga menjadi bagian penting dari asuhan keperawatan pada pasien gangguan kecemasan. Terapi aktivitas kelompok membantu pasien terlibat dalam berbagai aktivitas positif yang dapat mengurangi kecemasan, seperti seni, musik, atau kegiatan keterampilan tangan lainnya. Aktivitas tersebut tidak hanya menjadi media pengalihan perhatian dari rasa cemas, namun juga membantu pasien mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperbaiki hubungan interpersonalnya dengan sesama pasien yang memiliki masalah serupa. Sedangkan terapi kelompok dukungan merupakan forum yang memungkinkan pasien berbagi

pengalaman, saling mendukung, memberikan motivasi, serta memperkuat rasa kebersamaan dalam menghadapi kecemasan. Melalui terapi ini, pasien menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi gangguan kecemasan, yang kemudian mampu mengurangi rasa isolasi sosial dan meningkatkan motivasi pasien dalam menjalani proses pemulihan.

Implementasi keperawatan yang komprehensif seperti ini, dengan menggabungkan pendekatan psikososial, edukasi, dukungan keluarga, kolaborasi farmakologis, serta terapi kelompok, diharapkan mampu memberikan dampak yang maksimal dalam mengurangi gejala kecemasan, membantu pasien dalam mengembangkan keterampilan koping yang efektif, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Melalui proses implementasi yang tepat dan holistik ini, pasien diharapkan mampu mengelola gangguan kecemasannya secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga mampu kembali menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bermakna.

G. Evaluasi Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Kecemasan

Evaluasi merupakan tahapan akhir dari proses asuhan keperawatan yang bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan pada pasien dengan gangguan kecemasan. Evaluasi bukan hanya sekadar kegiatan akhir, tetapi sebuah proses kontinu yang membantu perawat menentukan apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai, apakah intervensi perlu dimodifikasi, atau apakah ada kebutuhan tambahan yang harus diperhatikan dalam penanganan pasien. Evaluasi dalam keperawatan gangguan kecemasan terdiri dari evaluasi proses dan hasil intervensi, dokumentasi serta pelaporan perkembangan kondisi pasien, dan tindak lanjut atau discharge planning yang tepat.

Langkah pertama dalam evaluasi adalah melakukan evaluasi proses dan hasil intervensi yang telah diberikan kepada pasien. Evaluasi proses dilakukan dengan melihat sejauh mana pelaksanaan intervensi keperawatan berjalan sesuai rencana. Misalnya, perawat mengevaluasi apakah pasien secara aktif berpartisipasi dalam sesi terapi relaksasi, konseling individu, atau terapi kelompok yang diberikan. Perawat juga menilai apakah pasien mengalami hambatan tertentu selama menjalani intervensi, seperti kesulitan dalam mempraktikkan teknik relaksasi atau masalah kepatuhan terhadap terapi farmakologis yang diberikan oleh tim medis. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua intervensi dilakukan secara efektif dan efisien, serta

menentukan apakah diperlukan perubahan pendekatan atau metode dalam intervensi selanjutnya.

Evaluasi hasil intervensi lebih fokus pada pencapaian tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada pasien dengan gangguan kecemasan, indikator keberhasilan bisa meliputi penurunan skor kecemasan pada instrumen standar seperti Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) atau Beck Anxiety Inventory (BAI), perbaikan pola tidur pasien, peningkatan kemampuan pasien dalam menggunakan teknik koping yang sehat, serta membaiknya interaksi sosial pasien. Misalnya, seorang pasien yang sebelumnya mengalami kesulitan tidur akibat kecemasan dievaluasi apakah sudah mulai menunjukkan pola tidur yang lebih baik, atau pasien yang tadinya menarik diri secara sosial sudah mulai aktif kembali dalam aktivitas sosial dan mampu berinteraksi dengan lingkungannya secara lebih nyaman. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi perawat untuk menentukan apakah intervensi telah berhasil atau perlu penyesuaian lebih lanjut.

Tahapan evaluasi berikutnya adalah dokumentasi dan pelaporan perkembangan kondisi pasien. Dokumentasi yang akurat dan lengkap merupakan bagian integral dari proses keperawatan, di mana setiap perkembangan pasien secara detail harus tercatat secara sistematis. Dokumentasi meliputi hasil observasi harian terhadap kondisi pasien, respons pasien terhadap intervensi yang diberikan, perubahan kondisi fisik maupun psikologis, serta semua data penting lainnya yang berkaitan dengan kecemasan pasien. Dokumentasi ini menjadi bahan informasi penting bagi semua anggota tim kesehatan, seperti dokter, psikiater, atau tenaga profesional lain yang terlibat dalam penanganan pasien. Selain itu, dokumentasi yang baik akan memudahkan evaluasi lanjutan dan memastikan kontinuitas asuhan keperawatan yang konsisten dan berkualitas.

Selain dokumentasi, perawat bertanggung jawab melakukan pelaporan secara berkala kepada tim kesehatan dan keluarga pasien mengenai perkembangan kondisi pasien. Pelaporan ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas mengenai kondisi terkini pasien, capaian yang telah diraih, hambatan yang muncul, serta kebutuhan tambahan yang harus dipenuhi dalam upaya pemulihan pasien. Dengan komunikasi yang baik, kolaborasi interprofesional dapat terjalin secara optimal, yang pada akhirnya akan mempercepat proses pemulihan pasien.

Komponen penting terakhir dalam evaluasi keperawatan adalah tindak lanjut dan discharge planning. Tindak lanjut melibatkan perencanaan lanjutan untuk memastikan pasien tetap mendapat dukungan setelah selesai menjalani program asuhan keperawatan di fasilitas kesehatan. Perawat harus memastikan bahwa pasien memiliki

pemahaman yang cukup untuk terus menerapkan teknik-teknik pengelolaan kecemasan secara mandiri di rumah, seperti teknik relaksasi, mindfulness, dan penggunaan obat secara benar bila masih diperlukan. Pasien juga diberikan edukasi mengenai tanda-tanda kambuhnya kecemasan agar mampu segera mengambil tindakan yang tepat dan cepat jika gejala muncul kembali.

Discharge planning secara khusus menyiapkan pasien dan keluarganya untuk transisi yang aman dan efektif dari fasilitas kesehatan kembali ke rumah atau komunitas. Rencana pemulangan mencakup edukasi terstruktur kepada keluarga tentang cara mendukung pasien di rumah, termasuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meminimalkan stres atau pencetus kecemasan, serta menjelaskan kapan pasien perlu mengakses bantuan profesional lagi. Perawat juga memastikan bahwa pasien memiliki jadwal kontrol rutin dengan tim medis atau psikolog untuk evaluasi lanjutan, serta memiliki akses terhadap dukungan komunitas seperti kelompok dukungan, jika tersedia.

Dengan melakukan evaluasi keperawatan secara komprehensif melalui evaluasi proses dan hasil intervensi, dokumentasi dan pelaporan yang akurat, serta perencanaan tindak lanjut yang matang, pasien dengan gangguan kecemasan akan lebih siap menghadapi kehidupan sehari-hari secara mandiri dan berkualitas. Tujuan akhir dari proses evaluasi ini adalah memastikan bahwa pasien benar-benar mendapatkan manfaat maksimal dari asuhan keperawatan yang diberikan, mampu mengelola kecemasan secara efektif dalam jangka panjang, serta meningkatkan kesejahteraan hidup secara menyeluruh.

H. Pencegahan dan Promosi Kesehatan Mental pada Pasien Gangguan Kecemasan

Upaya pencegahan dan promosi kesehatan mental merupakan aspek penting dalam penanganan gangguan kecemasan. Kedua upaya ini bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan kecemasan, memperkuat ketahanan individu terhadap stres, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam praktik keperawatan, pencegahan dan promosi kesehatan mental mencakup pendidikan kesehatan tentang pencegahan gangguan kecemasan, implementasi strategi promosi kesehatan mental di komunitas, serta manajemen stres berbasis bukti (evidence-based practice).

Langkah pertama dalam upaya ini adalah melalui pendidikan kesehatan tentang pencegahan gangguan kecemasan. Pendidikan kesehatan merupakan intervensi utama yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya mengenali dan mengelola stres secara efektif sebelum berkembang menjadi gangguan kecemasan yang lebih serius. Pendidikan kesehatan ini meliputi informasi mengenai tanda-tanda awal gangguan kecemasan, faktor risiko yang dapat memicu kecemasan, serta berbagai cara sederhana yang dapat diterapkan sehari-hari untuk mencegah munculnya gangguan tersebut.

Materi edukasi yang diberikan meliputi informasi mengenai pentingnya menjaga gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, konsumsi makanan seimbang, serta menjaga kualitas tidur yang baik. Masyarakat juga diajarkan tentang pentingnya memiliki keterampilan mengelola stres melalui berbagai teknik relaksasi, seperti teknik pernapasan dalam, meditasi, atau relaksasi progresif. Selain itu, edukasi juga mencakup cara-cara membangun pola pikir positif, mengembangkan kemampuan koping yang sehat, serta pentingnya membangun jaringan sosial yang suportif untuk menjaga keseimbangan emosi dan psikologis. Melalui pendidikan ini, masyarakat diharapkan memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mengenali stres sejak dini dan mampu mengambil langkah-langkah preventif sebelum gangguan kecemasan menjadi kronis dan sulit ditangani.

Langkah kedua yang tidak kalah penting adalah implementasi strategi promosi kesehatan mental di komunitas. Promosi kesehatan mental merupakan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, baik tenaga kesehatan, pemimpin komunitas, maupun masyarakat secara luas. Di komunitas, promosi kesehatan mental dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran mental yang melibatkan berbagai kegiatan, seperti seminar publik, workshop, sosialisasi melalui media sosial, atau kegiatan komunitas yang meningkatkan interaksi sosial yang positif. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, suportif, serta bebas stigma terhadap individu yang mengalami gangguan kecemasan atau gangguan mental lainnya.

Perawat, sebagai bagian integral dari tim kesehatan di komunitas, dapat bekerja sama dengan pemimpin masyarakat atau organisasi lokal untuk merancang berbagai program yang mampu meningkatkan kesehatan mental masyarakat secara luas. Misalnya, melalui pembentukan kelompok-kelompok dukungan komunitas yang rutin berkumpul dan berbagi pengalaman, atau dengan menyelenggarakan program edukasi di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau lingkungan sosial lainnya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Dengan menciptakan lingkungan komunitas yang suportif, stigma negatif terhadap gangguan

mental berkurang, sehingga individu yang mengalami kecemasan lebih mudah mengakses bantuan atau dukungan sosial tanpa takut dikucilkan atau dihakimi.

Langkah ketiga dalam pencegahan dan promosi kesehatan mental adalah penerapan manajemen stres berbasis bukti (evidence-based practice). Manajemen stres berbasis bukti adalah pendekatan yang menggunakan teknik-teknik yang telah terbukti secara ilmiah efektif dalam mengurangi stres dan kecemasan. Dalam praktik keperawatan, beberapa teknik yang terbukti efektif secara ilmiah meliputi terapi kognitif perilaku (CBT), latihan mindfulness-based stress reduction (MBSR), serta intervensi berbasis relaksasi seperti relaksasi otot progresif dan guided imagery.

Terapi kognitif perilaku (CBT) telah terbukti efektif dalam membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang sering kali menjadi penyebab kecemasan. Dalam CBT, pasien diajarkan untuk mengidentifikasi distorsi berpikir yang memicu kecemasan serta menggantinya dengan pola pikir yang lebih rasional dan adaptif. Demikian juga mindfulness-based stress reduction (MBSR), suatu pendekatan yang mengajarkan individu untuk lebih sadar dan menerima keadaan dirinya tanpa penilaian negatif, terbukti efektif dalam menurunkan kadar stres secara signifikan. Berbagai studi menunjukkan bahwa dengan latihan mindfulness yang rutin, individu dapat meningkatkan kemampuannya untuk merespons stres secara lebih tenang dan terkontrol.

Latihan relaksasi progresif dan guided imagery juga merupakan intervensi yang didukung bukti ilmiah dalam mengelola stres. Relaksasi progresif membantu individu mengidentifikasi dan melepaskan ketegangan fisik yang muncul akibat stres atau kecemasan secara sistematis, sedangkan guided imagery menggunakan imajinasi positif yang membantu individu menciptakan suasana relaksasi secara mental. Teknik-teknik ini telah banyak dipraktikkan dalam berbagai penelitian dan terbukti efektif dalam menurunkan gejala stres serta memperbaiki kondisi emosional secara menyeluruh.

I. Simpulan

Gangguan kecemasan merupakan kondisi psikologis serius yang ditandai dengan rasa cemas berlebihan, sulit dikontrol, dan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Penyebab gangguan kecemasan bersifat multifaktorial, melibatkan kombinasi faktor genetik, neurobiologis, psikologis, serta lingkungan sosial yang tidak mendukung. Patofisiologi gangguan kecemasan terutama terkait dengan hiperaktivitas amigdala dan ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, yang kemudian menyebabkan

berbagai manifestasi klinis berupa gejala fisik maupun psikologis seperti jantung berdebar, sesak napas, gelisah, gangguan tidur, serta pola pikir negatif.

Pengkajian keperawatan pada pasien gangguan kecemasan dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan biopsikososial, dengan menggunakan instrumen standar seperti Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) dan Beck Anxiety Inventory (BAI). Identifikasi masalah keperawatan yang sering muncul meliputi ansietas, gangguan pola tidur, risiko harga diri rendah kronis, isolasi sosial, dan ketidakefektifan koping individu.

Dalam perencanaan keperawatan, penting untuk menetapkan tujuan dan kriteria hasil yang spesifik serta menyusun prioritas masalah keperawatan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak terhadap kehidupan pasien. Strategi penatalaksanaan kecemasan dilakukan dengan pendekatan biopsikososial yang mencakup intervensi psikososial, psikoedukasi, dukungan keluarga, serta kolaborasi interprofesional dengan tim medis.

Implementasi keperawatan pada pasien gangguan kecemasan meliputi terapi modalitas psikososial seperti teknik relaksasi progresif, teknik napas dalam, mindfulness, pemberian psikoedukasi dan konseling individu, dukungan psikososial dari keluarga, intervensi farmakologis, serta terapi aktivitas kelompok (TAK) dan terapi kelompok dukungan. Seluruh intervensi tersebut bertujuan mengurangi gejala kecemasan, meningkatkan keterampilan koping pasien, serta memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh.

Evaluasi keperawatan dilakukan secara kontinu untuk menilai efektivitas intervensi yang diberikan, mencakup evaluasi proses dan hasil intervensi, dokumentasi serta pelaporan yang akurat, serta tindak lanjut dan perencanaan discharge planning yang tepat agar pasien mampu mengelola kecemasannya secara mandiri di rumah maupun di komunitas.

Selain itu, upaya pencegahan dan promosi kesehatan mental sangat penting dalam mengurangi risiko gangguan kecemasan di masyarakat. Pendekatan ini meliputi pendidikan kesehatan tentang pencegahan gangguan kecemasan, implementasi strategi promosi kesehatan mental secara aktif di komunitas, serta penggunaan teknik manajemen stres berbasis bukti seperti terapi kognitif perilaku (CBT), mindfulness-based stress reduction (MBSR), dan relaksasi progresif. Melalui upaya ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih sehat secara mental dan emosional serta mencegah berkembangnya gangguan kecemasan yang lebih serius.

J. Referensi

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Bandelow, B., Michaelis, S., & Wedekind, D. (2017). Treatment of anxiety disorders. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 19(2), 93–107. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2017.19.2/bbandelow>
- Beck, A. T., & Steer, R. A. (1993). *Beck Anxiety Inventory Manual*. Psychological Corporation, San Antonio.
- Craske, M. G., & Stein, M. B. (2016). Anxiety. *The Lancet*, 388(10063), 3048–3059. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)30381-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30381-6)
- Cuijpers, P., Cristea, I. A., Karyotaki, E., Reijnders, M., & Huibers, M. J. (2016). How effective are cognitive behavior therapies for major depression and anxiety disorders? A meta-analytic update of the evidence. *World Psychiatry*, 15(3), 245–258. <https://doi.org/10.1002/wps.20346>
- Hofmann, S. G., & Gómez, A. F. (2017). Mindfulness-based interventions for anxiety and depression. *Psychiatric Clinics of North America*, 40(4), 739–749. <https://doi.org/10.1016/j.psc.2017.08.008>
- Kementarian Kesehatan RI. (2018). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Leichsenring, F., & Leweke, F. (2017). Social Anxiety Disorder. *New England Journal of Medicine*, 376(23), 2255–2264. <https://doi.org/10.1056/NEJMcp1614701>
- Otte, C., Gold, S. M., Penninx, B. W., Pariente, C. M., Etkin, A., Fava, M., ... Schatzberg, A. F. (2016). Major depressive disorder. *Nature Reviews Disease Primers*, 2, 16065. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.65>
- Steimer, T. (2022). The biology of fear-and anxiety-related behaviors. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 4(3), 231–249. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2002.4.3/tsteimer>
- World Health Organization. (2017). *Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates*. World Health Organization.

Zhang, N., Zhang, Y., Wu, K., Zhu, Z., & Dyregrov, A. (2022). Factors influencing the risk of anxiety disorders: A meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 13, 839447. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.839447>

K. Glosarium

Amigdala: Struktur kecil dalam otak yang terlibat dalam pemrosesan emosi, terutama rasa takut dan respons terhadap ancaman.

Ansietas: Rasa takut atau khawatir yang intens, berlebihan, dan sulit dikendalikan terhadap situasi atau objek tertentu.

Anxiolitik: Obat yang digunakan untuk mengurangi kecemasan, misalnya benzodiazepin.

Beck Anxiety Inventory (BAI): Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan secara subjektif berdasarkan respons pasien terhadap sejumlah pertanyaan terkait gejala kecemasan.

Biopsikososial: Pendekatan yang melibatkan aspek biologis (fisik), psikologis (mental dan emosional), dan sosial dalam pengkajian dan intervensi kesehatan.

Cognitive Behavioral Therapy (CBT): Terapi psikologis yang bertujuan mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih adaptif dan rasional untuk mengurangi kecemasan.

Discharge Planning: Rencana terstruktur yang dibuat sebelum pasien pulang dari fasilitas kesehatan, meliputi edukasi dan persiapan transisi kembali ke rumah atau komunitas.

Evaluasi Keperawatan: Proses menilai efektivitas intervensi keperawatan yang telah dilakukan terhadap pasien untuk menentukan pencapaian tujuan keperawatan.

Fobia Sosial: Gangguan kecemasan yang ditandai dengan rasa takut yang intens terhadap situasi sosial karena takut dievaluasi atau dihakimi negatif oleh orang lain.

Fobia Spesifik: Gangguan kecemasan yang ditandai dengan ketakutan ekstrem dan tidak rasional terhadap objek atau situasi tertentu seperti ketinggian, hewan, atau jarum suntik.

Generalized Anxiety Disorder (GAD): Gangguan kecemasan yang ditandai dengan rasa khawatir dan cemas yang berlebihan terhadap berbagai aspek kehidupan sehari-hari, berlangsung secara persisten dan sulit dikontrol.

Guided Imagery: Teknik relaksasi yang menggunakan visualisasi imajinatif untuk menciptakan kondisi mental yang tenang dan rileks.

Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS): Instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat kecemasan pasien berdasarkan berbagai gejala psikologis dan fisik yang dialaminya.

Hiperaktivitas: Kondisi aktivitas yang berlebihan atau tidak proporsional, misalnya hiperaktivitas amigdala pada pasien gangguan kecemasan.

Intervensi Farmakologi: Penggunaan obat-obatan dalam penanganan gangguan kecemasan melalui kolaborasi dengan tenaga medis.

Isolasi Sosial: Kondisi di mana seseorang menarik diri dari lingkungan sosial, menghindari interaksi dengan orang lain karena kecemasan atau ketakutan yang berlebihan.

Ketidakefektifan Koping Individu: Ketidakmampuan seseorang dalam mengelola stres atau kecemasan secara efektif dan adaptif.

Mindfulness: Teknik meditasi berbasis kesadaran penuh, di mana individu dilatih untuk menerima dan mengamati emosi serta sensasi fisik tanpa memberikan penilaian negatif.

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR): Pendekatan manajemen stres yang menggunakan teknik mindfulness untuk membantu individu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.

Neurotransmitter: Zat kimia dalam otak yang berperan dalam mengirimkan sinyal antar neuron, berpengaruh dalam pengaturan suasana hati dan respons terhadap stres.

Patofisiologi: Studi tentang mekanisme fisik dan biologis yang mendasari suatu gangguan atau penyakit, dalam hal ini gangguan kecemasan.

Psikoedukasi: Intervensi yang melibatkan pemberian informasi tentang gangguan kecemasan, penyebab, dampak, serta teknik pengelolaan kepada pasien dan keluarga.

Relaksasi Otot Progresif: Teknik yang melibatkan peregangan dan pelepasan ketegangan otot secara sistematis untuk membantu individu mengurangi stres atau kecemasan.

Risiko Harga Diri Rendah Kronis: Kondisi di mana seseorang secara konsisten memiliki pandangan negatif terhadap dirinya sendiri, merasa tidak kompeten, tidak berguna, dan kurang percaya diri akibat gangguan kecemasan yang kronis.

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI): Jenis obat antidepresan yang digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan dengan cara meningkatkan kadar serotonin di otak.

Serangan Panik: Episode mendadak berupa rasa takut yang intens, disertai gejala fisik seperti sesak napas, jantung berdebar, dan pusing.

Social Anxiety Disorder: Gangguan kecemasan sosial yang ditandai dengan kecemasan ekstrem saat berada dalam situasi sosial akibat ketakutan akan evaluasi negatif dari orang lain.

Terapi Aktivitas Kelompok (TAK): Intervensi berupa kegiatan positif dalam kelompok, seperti seni atau keterampilan, untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan interaksi sosial pasien.

Zung Self-Rating Anxiety Scale: Instrumen pengukuran kecemasan yang berbasis self-report, digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan subjektif yang dialami individu.

CHAPTER 7

PENANGANAN KRISIS DAN INTERVENSI KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN PERILAKU BUNUH DIRI

Retno Puji Astuti, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Latar Belakang Masalah

Perilaku bunuh diri merupakan masalah serius dalam kesehatan masyarakat global yang menjadi perhatian utama berbagai kalangan, termasuk tenaga kesehatan khususnya perawat. Menurut laporan World Health Organization (WHO), setiap tahun hampir 800 ribu orang meninggal dunia akibat bunuh diri, menjadikan bunuh diri sebagai salah satu penyebab kematian utama di berbagai kelompok usia, terutama remaja dan dewasa muda. Di Indonesia sendiri, angka kejadian perilaku bunuh diri cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, masalah keluarga, gangguan mental, hingga stigma yang masih melekat kuat di masyarakat. Kondisi ini semakin kompleks karena banyak kasus bunuh diri yang tidak terdeteksi lebih dini akibat minimnya pemahaman masyarakat mengenai tanda-tanda krisis dan keterbatasan kemampuan petugas kesehatan dalam melakukan intervensi dini yang efektif.

Fenomena perilaku bunuh diri ini tidak hanya membawa dampak pada individu yang mengalami krisis, tetapi juga memberikan konsekuensi yang sangat berat bagi keluarga, teman, dan lingkungan sosialnya. Keluarga yang ditinggalkan sering kali mengalami trauma psikologis, rasa bersalah, serta isolasi sosial yang berkepanjangan. Di sisi lain, pasien yang mengalami perilaku bunuh diri sering kali mengalami rasa putus asa yang mendalam, kehilangan harapan, serta mengalami gangguan mental seperti depresi berat atau gangguan kecemasan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pentingnya penanganan krisis bunuh diri secara komprehensif menjadi sangat krusial untuk dilakukan dengan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai tenaga kesehatan, di antaranya perawat sebagai lini terdepan.

Dalam konteks keperawatan, peran perawat menjadi sangat vital karena mereka sering kali menjadi pihak pertama yang berinteraksi langsung dengan pasien dalam situasi krisis, terutama di layanan kesehatan primer, ruang gawat darurat, maupun

pelayanan kesehatan mental. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi perawat dalam mengelola pasien dengan risiko bunuh diri, seperti keterbatasan pengetahuan tentang teknik komunikasi terapeutik, kurangnya pemahaman dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal perilaku bunuh diri, serta keterampilan yang belum memadai dalam melakukan intervensi berbasis bukti. Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi yang mendalam, pelatihan khusus, serta pedoman praktis bagi perawat dalam mengelola pasien yang mengalami krisis bunuh diri agar mampu melakukan intervensi yang tepat, efektif, dan aman.

Tujuan Intervensi Keperawatan dalam Penanganan Krisis Bunuh Diri

Intervensi keperawatan dalam penanganan krisis bunuh diri bertujuan untuk mengurangi risiko pasien melakukan tindakan bunuh diri dengan memberikan dukungan secara cepat, tepat, dan efektif sejak dini. Secara spesifik, tujuan utama intervensi keperawatan ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, intervensi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi secara dini pasien yang memiliki risiko tinggi untuk melakukan tindakan bunuh diri. Identifikasi dini merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya bunuh diri, karena dengan mengenali gejala-gejala awal serta faktor risiko yang ada, perawat dapat segera mengambil langkah antisipatif berupa intervensi segera untuk melindungi keselamatan pasien.

Kedua, intervensi keperawatan bertujuan memberikan perlindungan fisik dan psikologis bagi pasien yang berada dalam kondisi krisis. Perlindungan fisik meliputi upaya menghilangkan atau meminimalkan akses pasien terhadap alat atau metode yang dapat digunakan untuk mencederai dirinya sendiri. Sementara perlindungan psikologis dilakukan melalui pemberian dukungan emosional, menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, serta memberikan ruang bagi pasien untuk mengekspresikan perasaan negatifnya secara terbuka dan tanpa rasa takut akan dihakimi.

Ketiga, intervensi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan koping pasien agar mampu mengelola stres dan tekanan hidup dengan lebih baik. Perawat memiliki peran penting dalam membantu pasien mengembangkan keterampilan koping yang efektif melalui pemberian edukasi, konseling, serta melatih pasien menerapkan teknik relaksasi, mindfulness, atau strategi lain yang relevan untuk mengurangi gejala kecemasan, depresi, serta perasaan putus asa yang menjadi pemicu utama munculnya perilaku bunuh diri.

Keempat, tujuan penting lainnya adalah memperkuat dukungan sosial pasien dengan melibatkan keluarga dan orang terdekat dalam proses pemulihan. Keluarga memiliki peran vital dalam mendukung pasien, baik selama proses perawatan di

fasilitas kesehatan maupun saat pasien kembali ke komunitas. Dengan melibatkan keluarga dalam intervensi keperawatan, diharapkan pasien mendapat dukungan yang lebih efektif, memperkuat rasa aman, dan mengurangi kemungkinan kekambuhan perilaku bunuh diri di masa depan.

Terakhir, intervensi keperawatan bertujuan menyediakan perencanaan pemulangan (discharge planning) yang aman dan efektif, serta strategi pencegahan jangka panjang agar pasien dapat mengelola krisis dengan lebih baik di masa mendatang. Discharge planning yang baik mencakup edukasi pasien dan keluarga tentang tanda-tanda peringatan kekambuhan, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan di rumah, serta pentingnya menjaga komunikasi rutin dengan tenaga kesehatan untuk pemantauan kondisi secara berkala.

B. Konsep Dasar Perilaku Bunuh Diri

1. Definisi dan Jenis Perilaku Bunuh Diri

Perilaku bunuh diri merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja oleh seseorang dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Perilaku ini mencerminkan rasa putus asa yang mendalam, tekanan emosional yang berat, serta ketidakmampuan individu untuk mengatasi perasaan negatif yang dialaminya. Dalam literatur kesehatan mental, perilaku bunuh diri tidak hanya terbatas pada tindakan bunuh diri yang telah berhasil (completed suicide), tetapi juga mencakup spektrum yang lebih luas, seperti percobaan bunuh diri (attempted suicide) serta ideasi bunuh diri (suicidal ideation).

Percobaan bunuh diri adalah tindakan yang dilakukan individu dengan niat yang jelas untuk mengakhiri hidup, tetapi belum berakhir dengan kematian karena berbagai alasan, seperti intervensi medis yang tepat waktu atau kurangnya letalitas metode yang digunakan. Di sisi lain, ideasi bunuh diri merujuk pada pemikiran, keinginan, atau rencana seseorang untuk mengakhiri hidup, yang meskipun belum diwujudkan dalam tindakan nyata, tetap membutuhkan perhatian serius karena berisiko tinggi berkembang menjadi percobaan bunuh diri yang nyata. Memahami jenis-jenis perilaku ini menjadi dasar penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam melakukan intervensi yang tepat sesuai tingkat risiko pasien.

2. Faktor Risiko dan Faktor Protektif Perilaku Bunuh Diri

Perilaku bunuh diri tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor risiko yang kompleks. Faktor-faktor risiko tersebut bisa bersifat individual, keluarga, sosial, maupun lingkungan. Beberapa faktor risiko yang

paling sering ditemukan antara lain adalah gangguan mental seperti depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, dan gangguan kecemasan; riwayat percobaan bunuh diri sebelumnya; isolasi sosial; penyalahgunaan zat seperti alkohol atau narkoba; pengalaman traumatis seperti kekerasan fisik atau seksual; serta kondisi ekonomi yang sulit dan tekanan hidup yang tinggi.

Sebaliknya, terdapat juga faktor-faktor protektif yang berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi individu terhadap risiko bunuh diri. Faktor protektif ini meliputi dukungan sosial yang kuat dari keluarga, teman, atau komunitas; keterampilan coping yang baik dalam menghadapi stres; keyakinan spiritual atau agama yang memberikan makna hidup; ketersediaan layanan kesehatan mental yang mudah diakses; serta adanya rasa tanggung jawab atau harapan terhadap masa depan. Dengan memahami secara jelas faktor risiko dan protektif, perawat dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi pasien yang rentan serta memberikan intervensi preventif yang lebih akurat.

3. Mekanisme Psikologis di Balik Perilaku Bunuh Diri

Secara psikologis, perilaku bunuh diri muncul akibat interaksi kompleks antara tekanan hidup yang berat, kondisi mental yang terganggu, serta ketidakmampuan individu dalam mengatasi rasa sakit emosional yang dirasakan. Mekanisme psikologis ini sering kali dimulai dengan perasaan putus asa (*hopelessness*) yang mendalam, yang kemudian berkembang menjadi rasa bahwa tidak ada solusi lain yang bisa menyelesaikan masalah selain mengakhiri hidup. Individu merasa terperangkap dalam situasi emosional yang tidak tertahankan, sehingga muncul keyakinan bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar dari penderitaannya.

Selain itu, teori interpersonal tentang bunuh diri yang dikemukakan oleh Thomas Joiner menjelaskan bahwa perilaku bunuh diri muncul ketika seseorang mengalami kombinasi dari dua kondisi psikologis utama, yaitu merasa sebagai beban bagi orang lain (*perceived burdensomeness*) serta perasaan terisolasi atau tidak terhubung secara sosial (*thwarted belongingness*). Ketika kedua kondisi ini terjadi bersamaan dan diperparah oleh adanya kemampuan atau keberanian individu untuk menyakiti dirinya sendiri (*acquired capability for suicide*), maka risiko terjadinya tindakan bunuh diri meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, perawat perlu memiliki pemahaman mendalam terhadap mekanisme psikologis ini agar dapat mengidentifikasi gejala serta memberikan intervensi yang sesuai untuk memutus siklus negatif tersebut.

4. Dampak Perilaku Bunuh Diri terhadap Pasien, Keluarga, dan Komunitas

Perilaku bunuh diri memberikan dampak yang sangat luas dan mendalam, tidak hanya terbatas pada individu yang melakukannya, tetapi juga pada keluarga, orang-orang terdekat, serta komunitas tempat mereka tinggal. Bagi pasien yang pernah melakukan percobaan bunuh diri namun selamat, dampak emosional yang ditimbulkan sering kali berupa rasa malu, rasa bersalah, stigma sosial, serta perasaan gagal yang justru dapat memperparah kondisi mentalnya. Pasien sering kali merasa dihakimi oleh lingkungannya, bahkan terkadang mengalami isolasi sosial lebih lanjut yang meningkatkan risiko kekambuhan perilaku tersebut.

Keluarga pasien yang meninggal akibat bunuh diri sering mengalami trauma yang mendalam, diiringi perasaan bersalah karena merasa gagal mencegah kejadian tersebut. Mereka mungkin merasa kebingungan, marah, sedih, dan malu secara bersamaan, yang secara signifikan dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Selain itu, stigma sosial yang masih kuat di masyarakat sering kali menyebabkan keluarga menutup diri atau menarik diri dari lingkungan sosialnya, sehingga memperparah isolasi dan trauma emosional yang dialami.

Di tingkat komunitas, perilaku bunuh diri dapat menciptakan efek domino yang serius, terutama jika tidak ditangani dengan baik. Kasus bunuh diri yang terjadi di suatu lingkungan tertentu berpotensi meningkatkan risiko munculnya kasus bunuh diri berikutnya, dikenal sebagai fenomena “contagion suicide” atau penularan perilaku bunuh diri. Hal ini terjadi ketika individu lain yang rentan secara psikologis melihat perilaku bunuh diri sebagai sebuah opsi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh sebab itu, penanganan perilaku bunuh diri tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif komunitas dalam membangun lingkungan sosial yang mendukung, edukasi yang berkelanjutan, serta akses layanan kesehatan mental yang mudah dijangkau.

C. Identifikasi Tanda-tanda dan Gejala Krisis Bunuh Diri

1. Tanda-tanda Awal dan Peringatan Risiko Bunuh Diri

Perilaku bunuh diri umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba atau tanpa peringatan. Hampir selalu terdapat sejumlah tanda atau gejala awal yang ditunjukkan oleh seseorang sebelum ia benar-benar melakukan tindakan bunuh diri. Mengenali tanda-tanda ini merupakan langkah kunci yang penting dalam upaya intervensi keperawatan yang efektif, karena deteksi dini dapat mencegah terjadinya tindakan fatal.

Tanda awal yang paling umum adalah munculnya ungkapan verbal tentang keinginan mati atau bunuh diri, seperti pernyataan langsung “saya ingin mati” atau pernyataan yang lebih samar seperti “lebih baik kalau saya tidak ada lagi”. Individu mungkin mulai sering berbicara atau menulis tentang kematian dan menunjukkan ketertarikan yang tidak biasa terhadap topik ini. Selain tanda verbal, perubahan perilaku yang signifikan juga perlu diwaspadai, seperti menarik diri secara drastis dari interaksi sosial, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya dinikmati, atau perubahan drastis dalam pola makan dan tidur.

Gejala emosional seperti rasa putus asa yang mendalam, merasa tidak berguna, atau merasa menjadi beban bagi orang lain juga merupakan peringatan penting. Kadang kala individu yang sedang dalam krisis mungkin secara tiba-tiba terlihat lebih tenang setelah periode panjang terlihat tertekan. Kondisi ini perlu perhatian khusus karena sering kali menandakan bahwa individu tersebut telah mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Tanda peringatan lain adalah munculnya perilaku berisiko seperti penggunaan alkohol atau narkoba secara berlebihan, perilaku agresif, atau mengatur segala urusan pribadinya secara mendadak, seperti memberikan barang-barang berharga kepada orang lain, atau meninggalkan pesan terakhir kepada keluarga dan teman.

Sebagai tenaga keperawatan, kemampuan mengenali tanda-tanda ini dengan cepat dan akurat merupakan faktor penentu keberhasilan dalam mencegah perilaku bunuh diri.

2. Instrumen Penilaian Risiko Bunuh Diri dalam Praktik Keperawatan

Untuk memastikan bahwa pasien yang berisiko mendapatkan penanganan yang tepat, perawat perlu menggunakan instrumen atau alat ukur yang terstandar untuk menilai risiko bunuh diri. Penggunaan instrumen ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih objektif, sistematis, dan akurat tentang tingkat risiko bunuh diri yang dihadapi pasien, serta membantu dalam membuat keputusan klinis yang efektif.

Salah satu instrumen yang sering digunakan dalam praktik keperawatan adalah Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS). Instrumen ini membantu tenaga kesehatan dalam mengukur tingkat keparahan ide bunuh diri, intensitas keinginan mati, dan riwayat tindakan bunuh diri sebelumnya. C-SSRS sangat membantu karena pertanyaannya yang terstruktur dengan jelas dan dapat digunakan pada berbagai usia, baik remaja maupun dewasa.

Instrumen lain yang juga umum digunakan adalah Suicide Assessment Five-step Evaluation and Triage (SAFE-T). Instrumen ini tidak hanya menilai tingkat risiko secara umum, tetapi juga mengintegrasikan identifikasi faktor risiko, faktor protektif, dan rencana keamanan (safety plan). Dengan menggunakan SAFE-T, perawat dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya secara lebih jelas, apakah pasien membutuhkan pengawasan intensif, intervensi segera, atau rujukan ke spesialis kesehatan mental.

Selain instrumen formal, pendekatan klinis melalui wawancara mendalam dan observasi perilaku pasien tetap penting. Kombinasi antara instrumen standar dengan keterampilan wawancara klinis memungkinkan perawat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pasien, sehingga intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran.

3. Pengkajian Biopsikososial Pasien dengan Risiko Bunuh Diri

Dalam proses identifikasi risiko bunuh diri, pengkajian biopsikososial menjadi komponen esensial yang harus dilakukan secara menyeluruh. Pengkajian ini melibatkan evaluasi berbagai aspek kehidupan pasien, meliputi dimensi biologis (fisik), psikologis (mental dan emosional), serta sosial (lingkungan sosial dan keluarga).

Dari aspek biologis, perawat harus melakukan pengkajian riwayat penyakit fisik kronis, adanya gangguan neurologis, riwayat penggunaan obat-obatan tertentu, serta riwayat penyalahgunaan zat. Gangguan fisik tertentu, seperti penyakit kronis yang menimbulkan rasa sakit berkepanjangan, sangat terkait dengan peningkatan risiko bunuh diri, demikian pula penyalahgunaan zat yang memperburuk stabilitas emosional pasien.

Pada aspek psikologis, pengkajian berfokus pada kondisi mental pasien seperti riwayat gangguan mental (depresi, kecemasan, gangguan bipolar, atau skizofrenia), riwayat percobaan bunuh diri sebelumnya, serta pola pikir pasien terkait harga diri, perasaan putus asa, dan perasaan sebagai beban bagi orang lain. Perawat juga perlu mengidentifikasi mekanisme koping yang digunakan pasien dalam menghadapi stres sehari-hari serta mengevaluasi pola pikir dan persepsi pasien terhadap masalah-masalah kehidupan yang dihadapi.

Pada aspek sosial, perawat perlu mengkaji kondisi keluarga, hubungan interpersonal pasien dengan keluarga dan lingkungannya, adanya dukungan sosial yang kuat atau justru isolasi sosial yang berat, serta status ekonomi dan pendidikan pasien. Lingkungan sosial yang tidak mendukung, konflik interpersonal yang

berkepanjangan, atau isolasi sosial menjadi faktor risiko yang signifikan untuk terjadinya perilaku bunuh diri.

D. Manajemen Krisis Bunuh Diri dalam Praktik Keperawatan

1. Penilaian Awal dan Triage Pasien dalam Krisis Bunuh Diri

Penanganan pasien dengan risiko bunuh diri memerlukan pendekatan yang cepat, tepat, dan terstruktur. Langkah pertama yang krusial dalam manajemen krisis ini adalah melakukan penilaian awal yang tepat serta triage pasien untuk menentukan tingkat risiko dan tindakan prioritas yang harus segera dilakukan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara cepat apakah pasien berada dalam kondisi bahaya yang mengancam nyawa sehingga perlu ditangani segera dengan pengawasan ketat, ataukah pasien masih dalam tahap ideasi bunuh diri tanpa rencana yang jelas, sehingga penanganannya dapat disesuaikan dengan tingkat urgensi yang lebih rendah.

Dalam penilaian awal, perawat wajib melakukan wawancara klinis secara empatik dan mendalam, namun tetap efisien, untuk mengevaluasi apakah pasien memiliki ide bunuh diri aktif, memiliki rencana atau cara spesifik untuk melakukannya, serta apakah tersedia alat atau metode untuk melakukan tindakan tersebut. Pertanyaan seperti "Apakah Anda berpikir ingin mati atau melukai diri sendiri?" atau "Apakah Anda sudah merencanakan bagaimana akan mengakhiri hidup Anda?" merupakan contoh pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan gambaran cepat mengenai tingkat risiko pasien.

Setelah melakukan penilaian awal ini, langkah berikutnya adalah triage pasien. Pasien dengan risiko tinggi yang sudah memiliki rencana jelas dan akses terhadap alat bunuh diri memerlukan tindakan segera berupa pengawasan ketat (one-on-one supervision), serta rujukan ke unit kesehatan mental akut atau fasilitas gawat darurat yang mampu menangani krisis psikologis. Pasien dengan risiko sedang atau rendah, meskipun tetap serius, dapat ditangani dengan intervensi yang bersifat suportif, edukasi intensif, serta rujukan ke layanan kesehatan mental lanjutan yang tidak bersifat darurat. Dengan demikian, penilaian awal dan triage yang tepat memungkinkan perawat mengambil keputusan klinis yang efektif untuk menjaga keselamatan pasien.

2. Intervensi Keperawatan Segera pada Pasien dengan Krisis Akut

Ketika pasien teridentifikasi berada dalam krisis akut bunuh diri, intervensi segera menjadi prioritas tertinggi dalam praktik keperawatan. Intervensi ini

bertujuan untuk melindungi pasien dari tindakan yang membahayakan diri sendiri serta memberikan dukungan emosional dan psikologis yang intensif untuk membantu pasien melewati periode kritis ini dengan aman.

Tindakan pertama yang harus dilakukan perawat adalah menciptakan lingkungan yang aman dengan menyingkirkan segala benda atau alat yang berpotensi digunakan oleh pasien untuk melukai dirinya sendiri. Pasien yang memiliki ideasi atau rencana aktif untuk bunuh diri memerlukan pengawasan secara intensif dan terus-menerus (observasi ketat setiap waktu atau one-on-one observation). Selama pengawasan ini, perawat perlu memastikan bahwa pasien selalu berada dalam jangkauan penglihatan dan akses langsung perawat, sehingga risiko cedera atau tindakan fatal dapat dihindari.

Selain intervensi keamanan fisik, perawat juga harus memberikan intervensi psikologis yang bersifat suportif melalui pendekatan komunikasi terapeutik yang efektif. Pasien dalam krisis akut biasanya berada dalam keadaan emosional yang sangat rentan, mengalami perasaan cemas, takut, putus asa, serta terisolasi secara emosional. Perawat harus mampu menawarkan empati, menenangkan pasien, serta memberikan validasi atas perasaan negatif yang dialaminya. Melalui pendekatan ini, pasien akan merasa lebih dipahami, sehingga lebih mudah menerima bantuan lebih lanjut.

Perawat juga harus berkoordinasi dengan tim kesehatan lainnya, seperti dokter atau psikiater, untuk menentukan apakah pasien membutuhkan intervensi farmakologis segera untuk mengatasi kondisi mental akutnya. Obat-obatan seperti anxiolitik atau antipsikotik mungkin diperlukan dalam kondisi krisis ekstrem untuk menstabilkan pasien secara cepat.

3. Strategi De-eskalasi dan Komunikasi Terapeutik

Dalam situasi krisis bunuh diri, perawat juga harus menguasai teknik de-eskalasi yang efektif. De-eskalasi merupakan pendekatan yang dirancang untuk menurunkan intensitas emosi negatif atau gejala emosional pasien yang sedang mengalami krisis, sehingga risiko tindakan bunuh diri dapat dikurangi. Strategi ini sangat penting dalam menjaga keselamatan pasien sekaligus menciptakan suasana yang kondusif untuk intervensi selanjutnya.

De-eskalasi biasanya dilakukan melalui komunikasi terapeutik yang menggunakan pendekatan verbal dan non-verbal yang lembut, empatik, tenang, dan tidak menghakimi. Perawat perlu secara aktif mendengarkan pasien, menunjukkan ketertarikan terhadap apa yang dikatakan pasien, serta secara verbal

maupun non-verbal menyampaikan bahwa pasien berada dalam lingkungan yang aman. Menjaga nada suara tetap tenang, volume suara sedang, serta memberikan ruang fisik yang nyaman bagi pasien juga menjadi bagian dari teknik de-eskalasi.

Selain itu, perawat dapat menggunakan teknik seperti validasi emosional, yaitu mengakui dan menghargai perasaan negatif yang dialami pasien tanpa menghakimi atau meremehkan perasaan tersebut. Kalimat seperti "Saya memahami bahwa Anda sedang merasa sangat berat menghadapi situasi ini" dapat membantu pasien merasa lebih didengar, dimengerti, serta merasa lebih nyaman untuk membuka diri.

Teknik lainnya adalah pendekatan pengalihan perhatian (distraction), di mana perawat mengajak pasien berbicara mengenai hal-hal yang tidak terkait langsung dengan krisis untuk sementara waktu, guna menurunkan intensitas emosional pasien. Namun, teknik ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan penuh sensitivitas agar tidak dianggap sebagai pengabaian terhadap masalah utama pasien.

E. Intervensi Keperawatan Komprehensif pada Pasien dengan Perilaku Bunuh Diri

1. Perencanaan Intervensi Keperawatan yang Berbasis Bukti

Perencanaan intervensi keperawatan bagi pasien dengan perilaku bunuh diri harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dengan mendasarkan seluruh tindakan pada praktik berbasis bukti (evidence-based practice). Intervensi yang dirancang harus mempertimbangkan hasil dari pengkajian awal, identifikasi faktor risiko dan protektif, serta evaluasi menyeluruh terhadap kondisi biopsikososial pasien. Rencana intervensi yang berbasis bukti ini membantu perawat dalam menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang yang realistis, terukur, serta relevan dengan kondisi pasien.

Perawat perlu menggunakan referensi atau pedoman praktik klinis terbaru yang telah terbukti efektif secara ilmiah dalam menangani pasien dengan risiko bunuh diri. Intervensi keperawatan berbasis bukti ini biasanya mencakup pendekatan terapeutik seperti terapi kognitif-perilaku (CBT), intervensi psikososial yang mendukung, penggunaan teknik mindfulness, terapi psikoedukasi, serta kolaborasi dengan tenaga profesional lainnya seperti psikiater dan psikolog. Rencana intervensi yang disusun secara jelas dan sistematis ini membantu perawat memastikan bahwa tindakan yang diberikan benar-benar memiliki efektivitas klinis yang tinggi dalam mencegah perilaku bunuh diri serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

2. Terapi Psikoedukasi dan Konseling Individu

Terapi psikoedukasi merupakan salah satu intervensi keperawatan utama yang bertujuan memberikan informasi secara komprehensif kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi yang dialami pasien, termasuk penyebab, tanda-tanda, dampak, serta strategi penanganan dan pencegahan bunuh diri. Psikoedukasi membantu pasien memahami bahwa ideasi bunuh diri merupakan bagian dari masalah kesehatan mental yang bisa diatasi dengan intervensi yang tepat, sehingga dapat mengurangi stigma yang sering dialami pasien maupun keluarganya.

Selain psikoedukasi, konseling individu juga menjadi komponen penting dalam intervensi komprehensif ini. Dalam konseling individu, perawat membantu pasien mengidentifikasi pola pikir negatif atau distorsi kognitif yang menjadi pemicu ideasi bunuh diri. Melalui proses ini, pasien belajar mengembangkan keterampilan koping yang efektif, membangun kepercayaan diri, serta memperkuat harapan akan masa depan yang lebih positif. Konseling individu ini memungkinkan pasien mendapatkan dukungan emosional secara intensif dan personal, sehingga pasien mampu secara bertahap mengatasi krisis yang dialami dan mencegah kekambuhan di masa depan.

3. Penerapan Teknik Mindfulness dan Relaksasi pada Pasien

Teknik mindfulness dan relaksasi telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat stres, kecemasan, serta mengelola gejala depresi yang sering kali menjadi pemicu perilaku bunuh diri. Mindfulness merupakan teknik meditasi berbasis kesadaran penuh, di mana pasien dilatih untuk menerima emosi negatif yang dirasakan tanpa memberi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Dengan rutin menerapkan mindfulness, pasien belajar untuk tetap berada dalam momen saat ini, mengurangi pikiran-pikiran negatif tentang masa depan atau masa lalu, serta meningkatkan stabilitas emosionalnya.

Selain mindfulness, teknik relaksasi seperti relaksasi otot progresif, teknik pernapasan dalam, serta guided imagery dapat membantu pasien mengurangi ketegangan fisik dan emosional yang dirasakan. Teknik-teknik ini mengajarkan pasien bagaimana mengendalikan respons fisiologis tubuh terhadap stres, menurunkan detak jantung yang tinggi, dan mengurangi sensasi fisik yang tidak nyaman yang sering dialami dalam situasi krisis bunuh diri. Implementasi mindfulness dan relaksasi secara teratur memungkinkan pasien merasakan manfaat nyata dalam mengelola gejala krisis dan membantu pasien merasa lebih tenang, stabil, serta lebih terkendali dalam menghadapi situasi sulit.

4. Dukungan Psikososial Keluarga dan Jaringan Sosial Pasien

Keluarga dan lingkungan sosial pasien memainkan peran yang sangat penting dalam proses pemulihan pasien yang berisiko bunuh diri. Intervensi keperawatan yang komprehensif tidak cukup hanya fokus pada pasien secara individual, tetapi juga harus melibatkan keluarga dan jaringan sosial pasien sebagai sumber utama dukungan psikososial. Keluarga yang memiliki pemahaman baik mengenai kondisi pasien akan mampu memberikan dukungan emosional yang lebih efektif, membantu pasien menjalani proses pengobatan dan pemulihan dengan lebih optimal.

Perawat perlu melakukan edukasi khusus kepada keluarga mengenai bagaimana cara menghadapi pasien yang mengalami krisis bunuh diri, bagaimana memberikan dukungan emosional yang tepat, serta bagaimana menciptakan lingkungan rumah yang aman dan suportif. Intervensi ini juga mencakup pelibatan keluarga dalam sesi konseling keluarga, yang bertujuan memperbaiki komunikasi antar anggota keluarga, membangun hubungan yang lebih harmonis, serta mengatasi berbagai konflik yang mungkin memperparah kondisi pasien.

Selain keluarga, jaringan sosial yang lebih luas seperti teman dekat atau komunitas juga harus diperkuat perannya sebagai bagian dari dukungan sosial yang integral. Dengan memiliki jaringan sosial yang kuat dan suportif, pasien akan merasa lebih diterima, dihargai, dan memiliki rasa keterikatan dengan komunitas, yang merupakan faktor protektif penting dalam mencegah kekambuhan perilaku bunuh diri.

5. Kolaborasi Interprofesional dalam Penanganan Pasien dengan Perilaku Bunuh Diri

Intervensi keperawatan pada pasien dengan perilaku bunuh diri tidak dapat dilakukan secara tunggal. Keberhasilan penanganan krisis ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai profesional kesehatan seperti perawat, psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, dan tenaga profesional lainnya. Kolaborasi interprofesional ini memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang menyeluruh, terintegrasi, dan komprehensif dari berbagai aspek kesehatan.

Dalam kolaborasi ini, perawat berperan penting sebagai koordinator yang bertanggung jawab memfasilitasi komunikasi antar profesional, memastikan bahwa informasi mengenai kondisi pasien terdokumentasi dengan baik dan dibagikan kepada semua pihak yang terlibat. Psikiater berperan dalam menentukan kebutuhan terapi farmakologis serta mengawasi respons pasien terhadap pengobatan. Psikolog

memberikan intervensi terapeutik lanjutan seperti terapi kognitif-perilaku, sementara pekerja sosial bertanggung jawab mengelola aspek sosial-ekonomi pasien yang sering kali mempengaruhi pemulihan pasien secara keseluruhan.

Melalui kolaborasi interprofesional yang efektif, intervensi keperawatan pada pasien dengan perilaku bunuh diri dapat berjalan lebih lancar dan terintegrasi, sehingga pasien mendapatkan manfaat maksimal dari berbagai pendekatan terapeutik yang tersedia. Proses kolaborasi ini juga memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang kontinu, mulai dari tahap akut hingga pemulihan jangka panjang, serta membantu pasien untuk kembali menjalani kehidupannya secara sehat dan produktif.

F. Evaluasi Efektivitas Intervensi Keperawatan pada Pasien dengan Perilaku Bunuh Diri

1. Indikator Keberhasilan Intervensi

Evaluasi dalam praktik keperawatan merupakan tahap yang penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan memberikan dampak positif yang nyata bagi pasien yang mengalami perilaku bunuh diri. Evaluasi efektivitas intervensi dilakukan dengan menggunakan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Indikator tersebut meliputi perubahan positif pada kondisi mental dan emosional pasien, penurunan intensitas dan frekuensi ideasi bunuh diri, peningkatan keterampilan coping, serta meningkatnya keterlibatan pasien dalam aktivitas sosial sehari-hari.

Secara lebih spesifik, indikator keberhasilan dapat dinilai dari berkurangnya atau hilangnya ideasi bunuh diri yang aktif, yang dapat diukur melalui wawancara klinis atau instrumen terstandardisasi seperti Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS). Pasien juga dianggap berhasil apabila mampu menerapkan teknik coping yang efektif secara mandiri dalam menghadapi situasi stres, terlihat dari kemampuan pasien untuk mengenali tanda-tanda krisis secara dini serta mampu mengimplementasikan strategi penanganan yang telah dipelajari melalui intervensi keperawatan sebelumnya.

Indikator lain yang tak kalah penting adalah peningkatan dukungan sosial pasien, yang terlihat dari hubungan interpersonal yang membaik dengan keluarga maupun lingkungannya. Keberhasilan intervensi juga tercermin dari meningkatnya kemampuan pasien dalam menjaga rutinitas harian secara mandiri, kembali melakukan aktivitas produktif seperti bekerja atau belajar, serta menunjukkan

motivasi yang positif terhadap masa depan. Dengan menggunakan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur ini, perawat dapat menilai efektivitas intervensi yang diberikan secara objektif dan konsisten.

2. Evaluasi dan Dokumentasi Respons Pasien

Evaluasi intervensi keperawatan pada pasien dengan perilaku bunuh diri tidak hanya terbatas pada pencapaian indikator keberhasilan semata, tetapi juga mencakup proses evaluasi yang sistematis terhadap respons pasien terhadap intervensi yang diberikan. Evaluasi respons pasien dilakukan secara berkala dan kontinu selama masa perawatan, baik melalui observasi langsung, wawancara klinis, maupun instrumen pengukuran psikometrik yang telah distandarisasi.

Dalam evaluasi ini, perawat mengobservasi dan mendokumentasikan bagaimana pasien merespons setiap intervensi yang diberikan, baik dalam hal perubahan perilaku, emosi, maupun pikiran. Misalnya, perawat mencatat bagaimana pasien menggunakan teknik mindfulness atau relaksasi yang diajarkan, sejauh mana pasien mampu berpartisipasi aktif dalam sesi konseling individu atau terapi kelompok, serta bagaimana perubahan emosional dan perilaku pasien dari waktu ke waktu.

Dokumentasi yang akurat dan rinci dari respons pasien menjadi bagian penting dalam evaluasi ini, karena informasi tersebut akan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan klinis selanjutnya. Dokumentasi yang baik juga memastikan bahwa informasi mengenai perkembangan kondisi pasien dapat diakses dengan mudah oleh seluruh anggota tim kesehatan yang terlibat, sehingga kontinuitas perawatan dapat terjamin.

3. Penyesuaian Rencana Asuhan Berdasarkan Evaluasi

Setelah mengevaluasi dan mendokumentasikan respons pasien terhadap intervensi keperawatan, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah penyesuaian atau modifikasi rencana asuhan sesuai hasil evaluasi tersebut. Tidak jarang, dalam praktik klinis, intervensi yang awalnya dianggap efektif ternyata belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasien atau masih memerlukan penyempurnaan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Penyesuaian rencana asuhan ini mencakup identifikasi aspek-aspek intervensi yang perlu ditingkatkan, ditambahkan, atau diubah berdasarkan hasil evaluasi. Misalnya, jika pasien masih mengalami kesulitan dalam menerapkan teknik koping tertentu, maka perawat harus menyediakan sesi tambahan untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan pasien dalam teknik tersebut. Demikian pula, jika

pasien menunjukkan kemajuan yang signifikan, perawat dapat mulai merencanakan transisi menuju intervensi yang lebih mandiri atau langkah-langkah yang lebih preventif seperti discharge planning.

Penyesuaian rencana asuhan yang bersifat dinamis ini merupakan bagian integral dalam proses keperawatan yang berorientasi pada pasien. Dengan melakukan evaluasi yang cermat dan kontinu serta penyesuaian yang tepat waktu, intervensi keperawatan akan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pasien, mengurangi risiko kekambuhan perilaku bunuh diri, serta memastikan bahwa pasien memperoleh dukungan yang optimal dalam menjalani pemulihan dan mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik.

G. Pencegahan Kekambuhan dan Perencanaan Pemulangan (Discharge Planning)

1. Strategi Pencegahan Kekambuhan Perilaku Bunuh Diri

Salah satu tujuan utama dalam penanganan pasien dengan risiko bunuh diri adalah mencegah terjadinya kekambuhan setelah pasien meninggalkan fasilitas perawatan kesehatan. Pencegahan kekambuhan perilaku bunuh diri merupakan langkah strategis yang harus dirancang secara komprehensif, dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan pasien, termasuk kondisi mental, emosional, sosial, dan lingkungan pasien di rumah atau komunitasnya.

Strategi pencegahan kekambuhan dimulai dengan memastikan pasien memiliki pemahaman mendalam tentang tanda-tanda awal krisis bunuh diri, sehingga pasien mampu mengenali dan mengatasi situasi stres sebelum berkembang menjadi situasi yang lebih serius. Perawat perlu membantu pasien menyusun rencana keamanan (safety plan) yang spesifik dan terstruktur, yang mencakup langkah-langkah praktis yang harus dilakukan pasien jika kembali mengalami ideasi bunuh diri atau stres emosional berat di masa depan. Rencana ini mencakup identifikasi pemicu stres, cara-cara mengelola stres secara mandiri seperti teknik mindfulness atau relaksasi, serta daftar kontak darurat yang dapat dihubungi jika pasien mengalami krisis.

Selain rencana keamanan, pasien juga didorong untuk terlibat secara aktif dalam kelompok pendukung atau terapi lanjutan yang dapat membantu mereka menjaga stabilitas emosional. Pasien yang terus mendapatkan dukungan psikososial secara rutin setelah pulang, baik dari keluarga, komunitas, maupun tenaga kesehatan mental, memiliki peluang lebih kecil untuk mengalami kekambuhan. Oleh

karena itu, memastikan kontinuitas perawatan, misalnya melalui kunjungan rutin ke klinik atau fasilitas kesehatan mental, menjadi aspek penting dalam strategi ini.

2. Edukasi Pasien dan Keluarga tentang Pengelolaan Risiko Bunuh Diri

Edukasi pasien dan keluarga merupakan aspek yang tak terpisahkan dari proses pencegahan kekambuhan perilaku bunuh diri. Perawat harus memastikan bahwa pasien maupun keluarga memiliki pemahaman yang memadai tentang perilaku bunuh diri, termasuk faktor-faktor risiko yang perlu diwaspadai, gejala-gejala peringatan awal, serta tindakan praktis yang dapat dilakukan dalam situasi krisis.

Dalam edukasi ini, perawat menjelaskan secara jelas dan mudah dipahami mengenai cara mengenali perubahan-perubahan perilaku yang menjadi tanda bahaya, seperti perubahan pola tidur, penarikan diri secara sosial, atau munculnya kembali ideasi bunuh diri. Pasien dan keluarga juga diajarkan mengenai teknik-teknik sederhana dalam mengelola stres sehari-hari seperti teknik pernapasan dalam, relaksasi otot progresif, atau aktivitas fisik ringan sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang dapat membantu menjaga stabilitas emosional pasien.

Edukasi terhadap keluarga secara khusus mencakup cara-cara efektif dalam berkomunikasi dengan pasien yang sedang mengalami krisis emosional, bagaimana mendukung pasien tanpa menghakimi atau memperburuk situasi, serta cara menciptakan lingkungan rumah yang aman dari benda-benda yang berpotensi digunakan untuk melukai diri. Dengan edukasi yang komprehensif, keluarga diharapkan mampu menjadi pendukung utama pasien dalam menjaga stabilitas emosionalnya serta mencegah risiko kekambuhan di masa depan.

3. Perencanaan Pemulangan yang Aman dan Terintegrasi

Perencanaan pemulangan atau discharge planning adalah langkah penting yang harus disusun secara hati-hati sebelum pasien meninggalkan fasilitas perawatan kesehatan. Perencanaan ini bertujuan memastikan bahwa pasien siap secara fisik, mental, dan sosial untuk kembali ke lingkungan rumah atau komunitasnya, serta memastikan bahwa semua aspek yang diperlukan untuk mencegah kekambuhan perilaku bunuh diri telah tersedia dan terintegrasi secara optimal.

Dalam perencanaan pemulangan yang aman, perawat harus berkolaborasi dengan keluarga dan berbagai tenaga profesional terkait untuk memastikan adanya kontinuitas perawatan yang terstruktur. Misalnya, perawat memastikan bahwa pasien memiliki jadwal kunjungan rutin untuk terapi lanjutan, memiliki akses yang

mudah untuk mendapatkan bantuan profesional jika diperlukan, serta memiliki kontak darurat yang dapat dihubungi kapan saja jika mengalami krisis emosional.

Selain itu, perawat harus memastikan bahwa lingkungan rumah pasien aman dari risiko melukai diri, misalnya dengan menyarankan keluarga untuk menyingkirkan benda-benda yang berpotensi berbahaya seperti senjata api, obat-obatan tertentu, atau benda tajam dari jangkauan pasien. Pasien juga disarankan memiliki rutinitas harian yang teratur serta aktivitas positif seperti olahraga, kegiatan sosial, atau aktivitas yang disukai sebagai bagian dari proses pemulihan yang berkelanjutan.

Melalui perencanaan pemulangan yang aman dan terintegrasi, pasien akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan di luar fasilitas kesehatan, sehingga risiko kekambuhan perilaku bunuh diri dapat dikurangi secara signifikan. Dengan memastikan pasien mendapatkan dukungan yang komprehensif setelah pulang, pasien memiliki kesempatan lebih besar untuk mencapai kestabilan jangka panjang, menjalani kehidupan yang sehat secara mental dan emosional, serta mampu menghadapi berbagai situasi kehidupan dengan lebih baik.

H. Tantangan dalam Penanganan Krisis Bunuh Diri dan Solusi Praktis

1. Hambatan dalam Pelaksanaan Intervensi Keperawatan

Dalam penanganan pasien dengan perilaku bunuh diri, perawat sering menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas intervensi keperawatan yang diberikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan perawat dalam mengidentifikasi risiko bunuh diri sejak dini. Banyak perawat yang masih belum memahami secara mendalam tentang tanda-tanda awal krisis bunuh diri, sehingga intervensi dini yang tepat sering kali terlambat dilakukan. Akibatnya, peluang untuk mencegah tindakan bunuh diri yang lebih serius menjadi semakin kecil.

Hambatan lain yang sering dialami adalah kurangnya sumber daya dan fasilitas yang mendukung dalam praktik klinis, seperti terbatasnya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi spesifik dalam bidang kesehatan jiwa, minimnya fasilitas kesehatan yang dilengkapi untuk menangani krisis bunuh diri, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental lanjutan, khususnya di daerah pedesaan atau terpencil. Kondisi ini sering kali menyebabkan pasien yang memerlukan perawatan intensif tidak mendapatkan bantuan yang memadai atau terlambat dalam menerima intervensi yang tepat.

Selain faktor sumber daya, stigma sosial terhadap pasien dengan masalah kesehatan mental dan perilaku bunuh diri juga menjadi hambatan besar dalam proses intervensi keperawatan. Pasien dan keluarga sering enggan mencari bantuan profesional akibat rasa malu, takut dikucilkan oleh masyarakat, atau khawatir dianggap lemah secara mental. Stigma ini dapat memperburuk kondisi pasien, memperlambat proses pemulihan, serta menyulitkan perawat dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif dengan pasien dan keluarganya.

Hambatan lain yang signifikan adalah ketidakefektifan koordinasi dan kolaborasi antarprofesional kesehatan. Kurangnya komunikasi yang jelas, buruknya koordinasi antar tim kesehatan, serta perbedaan dalam pendekatan penanganan pasien dapat menyebabkan intervensi yang dilakukan menjadi kurang terintegrasi, tidak optimal, serta menyebabkan kebingungan pasien dan keluarga dalam mengikuti proses perawatan yang telah direncanakan.

2. Strategi Mengatasi Tantangan dalam Praktik Klinis

Mengingat berbagai tantangan tersebut, perawat perlu menerapkan strategi praktis yang efektif untuk mengatasinya, sehingga kualitas pelayanan keperawatan bagi pasien dengan perilaku bunuh diri dapat meningkat secara signifikan. Strategi pertama yang dapat dilakukan adalah melalui pelatihan berkelanjutan (continuing education) khusus bagi perawat tentang manajemen krisis bunuh diri. Pelatihan ini meliputi cara mengenali tanda-tanda dini risiko bunuh diri, penggunaan instrumen penilaian risiko, serta teknik komunikasi terapeutik dan intervensi berbasis bukti. Dengan demikian, perawat akan lebih percaya diri, terampil, serta mampu bertindak cepat dan tepat dalam situasi krisis.

Selanjutnya, penguatan fasilitas dan sumber daya layanan kesehatan mental harus menjadi prioritas utama. Perawat dan institusi kesehatan dapat bekerja sama dengan pemerintah, lembaga non-profit, maupun sektor swasta untuk meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai, termasuk di daerah terpencil. Pengembangan layanan telehealth atau telemedicine juga menjadi alternatif efektif yang memungkinkan pasien di daerah terpencil mendapatkan bantuan profesional dengan lebih cepat.

Untuk mengatasi stigma sosial yang kuat, perawat harus aktif melakukan edukasi masyarakat dan advokasi kesehatan mental secara luas. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seminar, atau workshop untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan bagi pasien dengan perilaku bunuh diri serta menghilangkan persepsi negatif yang selama ini berkembang.

Dengan berkurangnya stigma, pasien dan keluarga akan lebih terbuka mencari bantuan profesional lebih dini dan secara rutin.

Strategi penting lainnya adalah memperkuat kolaborasi interprofesional. Perawat harus memfasilitasi komunikasi yang jelas, terstruktur, serta konsisten dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan pasien, seperti psikiater, psikolog, dokter umum, pekerja sosial, serta tenaga kesehatan lainnya. Pertemuan koordinasi rutin antar tim kesehatan perlu dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang diberikan, mengidentifikasi hambatan yang dialami, serta merancang rencana tindakan kolaboratif yang lebih baik dan terintegrasi di masa mendatang.

Dengan menerapkan strategi praktis ini secara konsisten dan terintegrasi, perawat akan lebih mampu mengatasi berbagai tantangan dalam penanganan pasien dengan krisis bunuh diri, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, aman, serta mendukung pemulihan pasien secara optimal. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan pasien mendapatkan dukungan yang lebih baik, risiko kekambuhan dapat dicegah, dan pasien mampu menjalani kehidupan dengan kualitas hidup yang jauh lebih baik.

I. Simpulan

Perilaku bunuh diri merupakan masalah kesehatan mental yang kompleks dan serius, dengan angka kejadian yang terus meningkat secara global maupun nasional. Fenomena ini memiliki dampak mendalam, tidak hanya bagi individu yang mengalami krisis, tetapi juga bagi keluarga dan komunitas sekitarnya. Penanganan perilaku bunuh diri memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidisiplin, di mana perawat memiliki peran penting sebagai lini terdepan dalam identifikasi dini dan intervensi cepat serta efektif.

Intervensi keperawatan dalam penanganan krisis bunuh diri bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini pasien berisiko tinggi, memberikan perlindungan fisik dan psikologis, meningkatkan keterampilan koping pasien, memperkuat dukungan sosial keluarga dan komunitas, serta melakukan perencanaan pemulangan (discharge planning) yang terintegrasi. Keberhasilan intervensi ini sangat bergantung pada kemampuan perawat untuk mengenali tanda-tanda awal risiko bunuh diri, menggunakan instrumen penilaian yang terstandar, dan melakukan pengkajian biopsikososial secara menyeluruh.

Secara psikologis, perilaku bunuh diri muncul akibat kombinasi perasaan putus asa yang mendalam, rasa tidak mampu mengatasi tekanan emosional, serta mekanisme psikologis berupa perasaan menjadi beban bagi orang lain dan perasaan terisolasi secara sosial. Adanya berbagai faktor risiko seperti gangguan mental, isolasi sosial, serta penyalahgunaan zat juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bunuh diri. Sebaliknya, faktor protektif seperti dukungan sosial, keterampilan koping yang baik, keyakinan spiritual, dan akses mudah ke layanan kesehatan mental memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya tindakan bunuh diri.

Dalam praktik keperawatan, manajemen krisis bunuh diri dimulai dari penilaian awal dan triage yang efektif, intervensi keperawatan segera dengan menciptakan lingkungan yang aman serta pengawasan ketat terhadap pasien, serta strategi de-eskalasi melalui komunikasi terapeutik yang empatik, tenang, dan tidak menghakimi. Pendekatan komprehensif berbasis bukti seperti terapi psikoedukasi, konseling individu, teknik mindfulness dan relaksasi, dukungan psikososial keluarga dan komunitas, serta kolaborasi interprofesional sangat diperlukan untuk mendukung pemulihan pasien secara optimal.

Evaluasi efektivitas intervensi dilakukan secara berkelanjutan dengan indikator keberhasilan yang jelas, meliputi penurunan ideasi bunuh diri, peningkatan kemampuan koping, perbaikan hubungan sosial, serta peningkatan kualitas hidup pasien. Dokumentasi respons pasien dan penyesuaian rencana asuhan berdasarkan hasil evaluasi merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa intervensi yang diberikan terus relevan dengan kebutuhan pasien.

Untuk mencegah kekambuhan perilaku bunuh diri, pasien dan keluarga perlu diberikan edukasi mendalam tentang pengelolaan risiko serta strategi menghadapi krisis di masa mendatang. Perencanaan pemulangan yang aman, yang mencakup rencana keamanan dan kontinuitas perawatan jangka panjang, menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas pasien setelah keluar dari fasilitas kesehatan.

Meski demikian, pelaksanaan intervensi dalam praktik keperawatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan, kurangnya sumber daya layanan kesehatan mental, stigma sosial yang masih kuat, serta kurang optimalnya kolaborasi interprofesional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan pelatihan berkelanjutan bagi perawat, penguatan fasilitas dan layanan kesehatan mental, edukasi dan advokasi untuk mengurangi stigma sosial, serta penguatan koordinasi antarprofesional kesehatan secara konsisten.

Dengan penerapan berbagai intervensi dan strategi tersebut secara sistematis dan terintegrasi, pasien dengan perilaku bunuh diri diharapkan dapat memperoleh dukungan yang efektif, mampu mengatasi krisis secara mandiri, mencegah kekambuhan, serta menjalani kehidupan yang lebih sehat, produktif, dan bermakna.

J. Referensi

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5)* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Bilsen, J. (2018). Suicide and youth: Risk factors. *Frontiers in Psychiatry*, 9, 540. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00540>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2018). Suicide rising across the US. *Vital Signs*. <https://www.cdc.gov/vitalsigns/suicide/index.html>
- Chu, C., Buchman-Schmitt, J. M., Stanley, I. H., Hom, M. A., Tucker, R. P., Hagan, C. R., ... & Joiner, T. E. (2017). The interpersonal theory of suicide: A systematic review and meta-analysis of a decade of cross-national research. *Psychological Bulletin*, 143(12), 1313–1345. <https://doi.org/10.1037/bul0000123>
- Joiner, T. E. (2005). *Why people die by suicide*. Harvard University Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Klonsky, E. D., May, A. M., & Saffer, B. Y. (2016). Suicide, suicide attempts, and suicidal ideation. *Annual Review of Clinical Psychology*, 12(1), 307–330. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-021815-093204>
- Posner, K., Brown, G. K., Stanley, B., Brent, D. A., Yershova, K. V., Oquendo, M. A., ... & Mann, J. J. (2011). The Columbia–Suicide Severity Rating Scale: Initial validity and internal consistency findings from three multisite studies with adolescents and adults. *American Journal of Psychiatry*, 168(12), 1266–1277. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2011.10111704>
- Stanley, B., & Brown, G. K. (2012). Safety planning intervention: A brief intervention to mitigate suicide risk. *Cognitive and Behavioral Practice*, 19(2), 256–264. <https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2011.01.001>

World Health Organization. (2019). Suicide in the world: Global health estimates. World Health Organization.

World Health Organization. (2021). Suicide prevention. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>

World Health Organization. (2022). Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/mental-health-and-psychosocial-considerations-during-the-covid-19-outbreak>

Zalsman, G., Hawton, K., Wasserman, D., van Heeringen, K., Arensman, E., Sarchiapone, M., ... & Zohar, J. (2016). Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic review. *The Lancet Psychiatry*, 3(7), 646–659. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30030-X](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30030-X)

K. Glosarium

Bunuh diri (Suicide)

Tindakan sengaja yang dilakukan individu untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena berbagai tekanan atau krisis yang tidak mampu diatasi.

Ideasi Bunuh Diri (Suicidal Ideation)

Pemikiran atau keinginan seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri, yang bisa bersifat sementara atau terus-menerus tanpa diikuti tindakan nyata.

Percobaan Bunuh Diri (Attempted Suicide)

Tindakan seseorang untuk mengakhiri hidupnya yang gagal berujung pada kematian, biasanya karena adanya intervensi medis yang tepat waktu atau metode yang digunakan kurang fatal.

Completed Suicide

Tindakan bunuh diri yang berhasil menyebabkan kematian individu.

Faktor Risiko Bunuh Diri

Kondisi atau situasi tertentu yang meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan tindakan bunuh diri, seperti gangguan mental, pengalaman traumatis, isolasi sosial, tekanan ekonomi, dan riwayat percobaan bunuh diri sebelumnya.

Faktor Protektif Bunuh Diri

Kondisi atau elemen yang membantu individu melindungi dirinya dari risiko bunuh diri, seperti dukungan sosial, keterampilan koping yang baik, keyakinan agama atau spiritual, serta akses terhadap layanan kesehatan mental yang efektif.

Intervensi Keperawatan

Tindakan profesional oleh perawat yang bertujuan untuk membantu pasien dalam mengatasi masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, termasuk mengurangi risiko bunuh diri dengan pendekatan terapeutik.

Intervensi Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice)

Intervensi atau praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru serta hasil penelitian terkini untuk memastikan efektivitas dan keamanan perawatan pasien.

Komunikasi Terapeutik

Teknik komunikasi khusus yang digunakan oleh tenaga kesehatan, terutama perawat, untuk membangun hubungan positif dengan pasien guna mencapai tujuan terapeutik, seperti memberikan dukungan emosional, mengurangi kecemasan, dan membantu pasien mengekspresikan perasaan secara terbuka.

Strategi De-eskalasi

Teknik komunikasi dan intervensi psikologis yang digunakan untuk menurunkan tingkat emosi negatif, ketegangan, atau perilaku agresif pada pasien yang sedang mengalami krisis akut.

Mindfulness

Teknik meditasi yang berfokus pada kesadaran penuh terhadap momen saat ini tanpa memberikan penilaian, yang bertujuan mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan stabilitas emosional.

Relaksasi Otot Progresif

Teknik relaksasi yang dilakukan dengan mengencangkan dan kemudian melemaskan kelompok otot tertentu secara bertahap, untuk mengurangi ketegangan fisik maupun emosional.

Guided Imagery

Teknik relaksasi yang memanfaatkan imajinasi atau visualisasi yang dipandu untuk menciptakan suasana nyaman, tenang, dan bebas stres, guna membantu mengurangi ketegangan dan kecemasan.

Dukungan Psikososial

Bantuan yang diberikan kepada pasien oleh keluarga, teman, komunitas, atau tenaga kesehatan untuk mendukung pemulihan mental dan emosional pasien dalam menghadapi krisis atau masalah kehidupan.

Pengkajian Biopsikososial

Proses evaluasi yang menyeluruh terhadap kondisi pasien yang mencakup aspek biologis (fisik), psikologis (mental dan emosional), serta sosial (keluarga, hubungan sosial, dan lingkungan) untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi pasien.

Instrumen Penilaian Risiko Bunuh Diri

Alat ukur atau skala standar yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat risiko bunuh diri pasien secara objektif dan akurat, seperti Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS) dan Suicide Assessment Five-step Evaluation and Triage (SAFE-T).

Perencanaan Pemulangan (Discharge Planning)

Persiapan sistematis yang dilakukan sebelum pasien meninggalkan fasilitas kesehatan, untuk memastikan bahwa pasien mendapat dukungan yang memadai, mampu mengelola krisis di rumah, serta memiliki akses terhadap layanan kesehatan lanjutan yang dibutuhkan.

Contagion Suicide

Fenomena psikologis dan sosial di mana terjadinya kasus bunuh diri dalam suatu komunitas atau kelompok dapat memicu kasus serupa pada individu lain yang secara psikologis rentan.

Kolaborasi Interprofesional

Kerjasama yang terintegrasi dan efektif antara berbagai profesional kesehatan (perawat, dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial, dll.) untuk memastikan pemberian perawatan yang komprehensif dan optimal kepada pasien.

Stigma Sosial

Penilaian negatif dari masyarakat terhadap individu yang mengalami gangguan mental atau perilaku tertentu seperti bunuh diri, yang sering menyebabkan individu merasa malu, enggan mencari bantuan, serta mengalami isolasi sosial.

Keterampilan Koping (Coping Skills)

Strategi atau kemampuan yang dimiliki individu untuk mengatasi stres, tekanan, atau masalah kehidupan secara efektif dan positif.

CHAPTER 8

TERAPI MODALITAS DALAM KEPERAWATAN JIWA

Ns Balbina Antonelda Marled Wawo, M.Kep., Sp.Kep.J.

A. Pendahuluan/Prolog

Lima masalah kesehatan jiwa terbanyak yang dialami manusia di dunia antara lain depresi, penyalahgunaan alkohol, shizofrenia, cedera kepala, dan bipolar (Murray & Lopez, 2020). Untuk itu asuhan keperawatan jiwa perlu dilakukan dengan tujuan membantu klien mengenali gangguan jiwanya, mengembangkan strategi untuk mengelola gejala, dan mencapai pemulihan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang gangguan kesehatan jiwa. Sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna dikaitkan dengan distress, menimbulkan disabilitas atau kecacatan pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia merupakan gangguan kesehatan jiwa. Fungsi jiwa atau kehidupan manusia yang terganggu meliputi fungsi biologis atau fisik, fungsi psikis, fungsi sosial dan spiritual; yang bisa terlihat dari cara berpenampilan, berkomunikasi dan berinteraksi, berpikir dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Kelainan tersebut juga didefinisikan sebagai salah satu penyakit yang terjadi di otak atau yang melibatkan neurobiologis kompleks sehingga berpengaruh pada kemampuan seseorang dalam memahami dan mengolah informasi. Gangguan jiwa (*American Psychiatric Association*, 2022) meliputi gangguan Skizofreniform, gangguan skizoafektif, gangguan waham, dan gangguan psikosis.

Psikosis adalah kelainan jiwa dengan manifestasi klinis adanya ketidakmampuan individu dalam memberikan penilaian terhadap realita yang ada. Psikosis diklasifikasikan ke dalam fase akut dan fase kronis. Dikategorikan akut jika kelainan yang didapat dalam waktu kurang atau sama dengan dua minggu ditandai dengan manifestasi klinik antara lain mendengar suara-suara yang tidak ada sumbernya, keyakinan atau ketakutan yang aneh atau tidak masuk akal, kebingungan atau disorientasi, perubahan perilaku, menjadi aneh atau menakutkan seperti menyendiri, kecurigaan berlebihan, mengancam diri sendiri, orang lain atau lingkungan, bicara dan tertawa serta marah-marah atau memukul tanpa alasan. Kondisi ini menggambarkan psikosis yang luas, mengganggu aktivitas kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Hal ini

dikarenakan kondisi akut ditunjukkan dengan sindrom yang khas, stress dengan tidak ada batasan waktu berlangsungnya.

Oleh karena itu untuk menyatakan bahwa klien terdiagnosa gangguan psikotik akut jika memiliki manifestasi sebagai berikut mendengar suara atau halusinasi, keyakinan yang salah atau waham, perilaku aneh, disorganisasi atau komunikasi yang kacau, dan iritabel atau labilnya status emosi. Sedangkan diagnosis bandingnya antara lain epilepsi, intoksikasi, febris, demensia dan delirium, mania dengan ciri-ciri memiliki emosional yang mudah tersinggung, bicara menjadi lebih cepat, gangguan proses pikir, kepercayaan diri yang tinggi; dan depresi meliputi adanya perasaan sedih dan suasana perasaan menurun. Terapi yang sering disarankan adalah antipsikotik: seperti haloperidol, Promazin atau klorpromazin, dan antiansietas.

Berbeda dengan psikosis kronis yang didefinisikan sebagai suatu kondisi shizofrenia yaitu pernah memiliki riwayat atau episode psikosis minimal satu kali, waham, dan halusinasi. karakteristik dari psikosis kronis di atas adalah tanda gejala negatif yang muncul lebih dari satu tahun. Dengan demikian untuk menyatakan bahwa klien mengalami gangguan psikosis kronis harus ada beberapa karakteristik antara lain menarik atau mengurung diri dari hubungan sosial, penurunan minat serta motivasi diri, kerusakan pola pikir, cuek atau apatis, tidak peduli terhadap penampilan dan kebersihan diri. Kondisi di atas kadang juga disertai dengan perubahan perilaku seperti tidak bisa berpikir cepat atau mengambil keputusan sederhana, sulit mempertahankan konsentrasi, mendengar suara dan melihat bayangan, mempertahankan keyakinan yang salah, keluhan fisik yang aneh, dan kesulitan melakukan pekerjaan atau pelajaran.

Sedangkan diagnosa banding antara lain depresi, gangguan bipolar atau mania, dan intoksikasi. Rentang respon neurobiologis (Videbeck, 2020) terdiri dari respon adaptif dan respon maladaptif. Respon adaptif meliputi berpikir rasional, ada kemampuan mengenal orientasi realita, konsisten mempertahankan emosi yang sesuai dengan situasi yang dihadapi, berperilaku yang sesuai, dan mampu berhubungan sosial. Sedangkan perilaku maladaptifnya meliputi gangguan kemampuan berpikir atau memiliki keyakinan yang salah namun dipertahankan secara kuat, mendengar suara atau melihat bayangan yang tidak nyata, kehilangan kemampuan mengendalikan emosi, inkoordinasi perilaku, dan kerusakan interaksi sosial. Respon maladaptif tersebut dapat dikelola untuk menjadi respon adaptif melalui pemberian beberapa modalitas terapi dalam keperawatan jiwa.

B. Konsep Terapi Modalitas

Adapun pengertian dari modalitas terapi yang ada di dalam pelayanan keperawatan jiwa adalah suatu model pendekatan yang bertujuan menangani pasien gangguan jiwa dengan kondisi klinis yang bervariasi, sehingga melalui pemberian modalitas terapi ini secara tidak langsung berpengaruh untuk mengubah perilaku pasien gangguan jiwa yaitu dari respon perilaku maladaptif menjadi respon perilaku yang lebih adaptif. Modalitas terapi yang ditawarkan dapat dilaksanakan dalam pelayanan keperawatan jiwa meliputi terapi individual, terapi lingkungan, terapi biologi atau terapi somatik, terapi kognitif, terapi keluarga, terapi kelompok, terapi perilaku, terapi bermain, terapi spiritual, terapi koping, dan Rehabilitasi. Berikut di bawah ini hanya akan dijelaskan tiga terapi dengan intensitas tertinggi dilakukan dalam pelayanan keperawatan jiwa, terapi-terapi tersebut antara lain terapi keluarga, terapi kelompok, dan terapi lingkungan.

1. Terapi keluarga

Modalitas terapi keluarga adalah salah satu pendekatan psikoterapi dengan berindikasi membantu anggota keluarga memperoleh wawasan yang mendalam untuk menyelesaikan permasalahan, meningkatkan komunikasi, mengatasi konflik dan meningkatkan fungsi masing-masing anggota keluarga dengan baik secara menyeluruh (Shives, 2012). Diasumsikan terapi keluarga memberikan pengaruh dari luar tubuh atau eksternal menjadi peran utama dalam perkembangan kepribadian dan aturan dalam kehidupan anggota keluarga. Terapi keluarga diindikasikan kepada keluarga dengan disfungsi keluarga, peristiwa dalam kehidupan yang penuh kekacauan dan penuh stres, banyak permintaan yang membutuhkan pengaturan yang sesuai, identifikasi gejala yang muncul pada klien, misalnya pada penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat, anggota keluarga yang didiagnosa gangguan mental misalnya skizofrenia), keluarga yang penuh dengan kekacauan yang tidak bisa terselesaikan. Klien yang dimaksud dalam terapi keluarga ini meliputi sistem keluarga secara keseluruhan daripada semua anggota keluarga.

Pendekatan terapi keluarga dalam melalui beberapa cara (Sadock et al., 2022):

a. Pendekatan integratif

Pendekatan ini berfokus pada nilai keluarga yaitu komponen biologis dan komponen psikososial dari permasalahan atau gangguan, artinya penyakit itu saling berkaitan satu sama lain, dimana permasalahan yang dialami individu ada kaitannya dengan interaksi neurotik dengan lingkungan keluarga dan sosial. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan mengurangi sumber masalah atau konflik

intrapersonal, meningkatkan komunikasi dan pemecahan masalah dan mempromosikan kepada keluarga hubungan keluarga yang sehat.

b. Pendekatan psikoanalitik

Pendekatan ini diyakini bahwa anggota keluarga dipengaruhi oleh munculnya psikologis anggota keluarga. Perilaku individu sangat dipengaruhi oleh sistem kehidupan keluarga.

Pendekatan Bowen

Pendekatan ini merupakan yang paling komprehensif saat melihat perilaku manusia dan permasalahan dari bentuk terapi keluarga. Keluarga terdiri dari sistem emosional dan relasional, serta diyakini bahwa perilaku individu adalah sebuah respon dari fungsi keluarga sebagai sistem secara keseluruhan. Konsepnya berasal dari perbedaan konsep diri. Hal ini ditujukan pada derajat individu yang mampu dibedakan antara proses perasaan dan proses intelektual dari diri seseorang tersebut, dengan demikian membuat keputusan dalam hidup berdasarkan pada pemikiran bukan perasaan.

Terapi yang digunakan yaitu memandu satu atau lebih anggota keluarga untuk menjadi lebih solid, menempatkan diri sendiri dengan dihadapkan pada kekuatan emosional yang dimunculkan dari pernikahan, anak atau asal keluarga. Hasilnya mendapatkan keuntungan yaitu kejelasan dan kepastian untuk membawa melewati posisi dia sekarang misal sebagai orang tua, pasangan atau anak yang masih tergantung.

c. Pendekatan Struktural

Keluarga sebagai sebuah sistem individu yang tetap ada sebagai bagian dari sistem sosial secara luas dan berisi subsistem sosial yang paling kecil dengan segala pembatasnya. Keluarga mengembangkan sebuah perangkat peraturan yang tidak terlihat dan hukum yang dikembangkan dan dipahami seluruh anggota keluarga. Sistem hirarki atau pengembangan struktur dalam keluarga, masalah muncul jika batasan dalam keluarga dilanggar. Permasalahan juga dapat muncul jika keluarga tidak mempunyai koping dengan perubahan.

Terapis dengan pendekatan struktural mengobservasi aktivitas dan fungsi dari anggota keluarga. Terapi dilakukan dalam jangka pendek dan aksi ditujukan dengan berfokus pada perubahan organisasi dalam keluarga dan konteks sosialnya. Gambaran secara holistik dari keluarga dikembangkan dengan berfokus pada pengaruh anggota keluarga untuk yang lainnya. Bimbingan

dengan diberikan ke depan mengembangkan batasan secara jelas untuk anggota secara individu dan perubahan dalam pola struktur keluarga.

d. Pendekatan interaksional atau strategi

Landasan dari pendekatan ini adalah teori komunikasi. Pada pendekatan ini, terapis belajar untuk berinteraksi diantara anggota keluarga, meyakinkan bahwa jika ada anggota keluarga mengalami sakit atau perubahan perilaku maka akan berpengaruh bagi anggota lainnya. Anggota keluarga mengembangkan sebuah pertimbangan atau tingkatan dan sistem umpan balik untuk menjaga homeostasis.

Terapi yang diberikan didasarkan pada konsep homeostasis, dimana sebagai anggota keluarga memperoleh keuntungan dan wawasan yang luas serta menjadi seseorang yang lebih baik sedangkan anggota keluarga yang lain mungkin lebih buruk. Komunikasi merupakan kunci dasar dari semua perilaku. Terapi sejalan dengan hubungan interpersonal diantara seluruh anggota keluarga dan berfokus pada alasan penyebab yang diberikan terapi adalah keluarga yang berdampak pada perubahan seluruh anggota keluarga.

e. Pendekatan jaringan sosial atau sistemik

Keluarga dijalankan sebagai jaringan sosial, mereka juga yakin bahwa proses penyembuhan berasal dari hubungan sosial. Permasalahan dapat terjadi jika jaringan sosial dalam keluarga kehilangan kemampuan untuk sembuh kembali secara cepat dari penyakit atau perubahan. Sebuah pendekatan sistem dapat digunakan tetapi hal ini juga tidak mampu menyelesaikan dengan sempurna. Model pertumbuhan digunakan untuk memahami kesulitan emosional yang muncul selama perubahan tahap perkembangan manusia.

Terapi menekankan pada kekuatan kesembuhan secara natural berasal dari keluarga. Hal ini sering dibawa pada beberapa orang secara bersama-sama sebagai jaringan sosial. Pada pertemuan pertama, hal ini mungkin mencakup orang-orang diluar keluarga yang mempunyai persamaan ide dan tujuan. Anggota keluarga dibantu untuk membuat tujuan secara optimal untuk mengatasi permasalahan.

f. Pendekatan perilaku

Sistem keluarga saling terkait satu sama lain sebagai sebuah tipe perilaku yang menjadi penyebab lainnya. Mereka menyangkal bahwa motivasi kekuatan internal tetapi meyakini bahwa individu memberikan reaksi terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi. Individu belajar bahwa mendapatkan kepuasan atau reward

berasal dari respon yang dapat dipercaya dari individu yang lainnya. Perilaku dapat dipelajari, masalah muncul saat perilaku maladaptif dipelajari dan mendapat umpan balik dari anggota keluarga yang merespon positif dan negatif. Terapi menekankan pada kekuatan kesembuhan secara natural berasal dari keluarga. Hal ini sering dibawa pada beberapa orang secara bersama-sama sebagai jaringan sosial. Pada pertemuan pertama, hal ini mungkin mencakup orang-orang diluar keluarga yang mempunyai persamaan ide dan tujuan. Anggota keluarga dibantu untuk membuat tujuan secara optimal untuk mengatasi permasalahan.

Pendekatan Terapi meliputi interpretasi perilaku anggota keluarga yang tidak membutuhkan perubahan, bagaimanapun pembatasan lingkungan interpersonal memungkinkan terjadinya perubahan. Oleh karena itu, terapi berdasarkan pada proses yang disadari dengan baik pada perubahan perilaku. Pendekatan terapeutik menggunakan prinsip teori pembelajaran sosial yang dipelajari, yang dipusatkan secara langsung dan jelas.

Upaya yang sudah dilakukan untuk melakukan perubahan diberikan sebuah reinforcement positif pada perilaku yang diharapkan. Keluarga mencakup dalam tujuan yang diharapkan dan kontrak dilakukan untuk membangun tujuan tersebut.

Tahap-tahap pelaksanaan terapi keluarga adalah sebagai berikut:

a. Tahap pre interaksi (*initial interview*)

- 1) Terapis memulai kontrak dengan menelepon untuk mengidentifikasi klien atau anggota keluarga lain berkenaan dengan identifikasi klien.
- 2) Orang yang mendapat telepon tersebut mengekspresikan perasaannya berkenaan dengan masalah atau gejala dan terapis keluarga mengatur perjanjian untuk wawancara awal dengan keluarga dan menganjurkan agar seluruh anggota keluarga dapat hadir dalam pertemuan tersebut.
- 3) Pada tahapan selanjutnya menjelaskan bahwa tidak seluruh keluarga harus hadir pada pada tiap sesi keluarga dan disini anak yang masih kecil tidak diikutsertakan).
- 4) Informasi yang sedikit demi sedikit yang dikumpulkan dari anggota keluarga saat wawancara awal ini sangat bermakna untuk sesi selanjutnya.
- 5) Selama sesi ini terapis mengumpulkan data berkenaan dengan riwayat keluarga dan ada pendapat lain bahwa terapis mengumpulkan peran dan fungsi keluarga.

- 6) Kerahasiaan sudah menjadi sebuah aturan meskipun tanpa adanya informed consent.

Prosedur dari tahap pra interaksi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pembuatan genogram keluarga
- 2) Deskripsikan hubungan keluarga dengan komunitas, berfokus pada budaya, kelas ekonomi, tingkat pendidikan dan agama
- 3) Deskripsikan masalah yang ada, berfokus pada persepsi masing-masing anggota keluarga untuk mengidentifikasi permasalahan
- 4) Identifikasi pola komunikasi yang berfokus pada siapa berbicara kepada siapa, nada suara, suasana perasaan/emosi dan ekspresi emosi masing-masing anggota keluarga
- 5) Identifikasi peran anggota keluarga sebagai pendukung, antagonis, kritis, korban, penyelamat, atau kekerasan, apakah diantara anggota keluarga saling bekerja sama, berpasangan, terdapat orang ketiga atau saling terpisahkan
- 6) Riwayat perkembangan keluarga secara umum dan saat ada permasalahan
- 7) Harapan keluarga terhadap terapi yang diberikan, apabila ada anggota keluarga yang malas datang pada tahap ini.
- 8) Terapis harus memberikan rasionalisasi alasan mengapa seluruh anggota keluarga harus datang dikarenakan permasalahan yang terjadi dipengaruhi oleh seluruh anggota keluarga.
- 9) Terapis juga bisa menjelaskan bahwa terapi tidak dapat berjalan efektif tanpa kehadiran dan masukan dari anggota keluarga.
- 10) Terapis mengkaji dan menyesuaikan semua informasi yang disampaikan oleh keluarga dan membuat perencanaan untuk intervensi membawa perubahan yang positif dalam pemecahan masalah yang diidentifikasi.

b. Tahap kerja (intervention)

Tahap ini bertujuan membantu keluarga agar dapat menerima dan beradaptasi terhadap perubahan yang dialami.

- 1) Petugas mengkaji kedalaman dari masalah yang dialami keluarga. Terapis menentukan potensi atau peluang mana dari keluarga saat mencari bantuan karena kekuatan ini sangat membantu keluarga untuk mengingat kembali saat mengalami permasalahan yang sama. Keluarga berperan banyak dalam fase intervensi ini dan terapis hanya berperan sebagai fasilitator dengan proses terapeutik.

- 2) Proses tiap sesinya membutuhkan kira-kira 1 jam. Beberapa anggota keluarga dapat memberikan motivasi dengan berpartisipasi membantu mengidentifikasi klien, sedangkan anggota keluarga yang lainnya mungkin ada yang malas untuk ikut berpartisipasi dikarenakan ketakutan rahasia keluarga dapat terungkap.
 - 3) Terapis dapat menanyakan kepada seluruh anggota keluarga bagaimana pandangannya terhadap permasalahan yang dialami, apa yang ingin dirubah serta perasaan dan pikirannya terhadap anggota keluarga yang lain. Teknik ini dapat digunakan oleh terapis agar dapat belajar dengan kesepakatan utama tentang permasalahan dan konflik yang terjadi dalam sistem keluarga.
 - 4) Keberlanjutan dari terapi ini adalah anggota keluarga mulai untuk merealisasikan bahwa hubungan atau permasalahan itu dapat diubah.
 - 5) Anggota keluarga menjadi lebih otonomi dengan perubahan yang positif seperti komunikasi terbuka dan perubahan dalam perilaku.
 - 6) Mereka juga harus diyakinkan bahwa perubahan harus sebanding dilakukan untuk semua anggota keluarga.
 - 7) Hal ini penting bahwa anggota keluarga merasa nyaman dengan peningkatan fungsi keluarga yang baru sebelum melakukan terminasi terapi.
- c. Tahap terminasi

Terkadang keluarga menginginkan terapi dihentikan lebih awal, mungkin mengindikasikan ada keinginan yang terlewatkan dari perilaku mereka.

Sebagai contoh anggota keluarga banyak yang telat datang atau malah tidak datang sama sekali saat pertemuan seperti yang sudah menjadi kesepakatan bahkan semua anggota keluarga tidak melanjutkan untuk berpartisipasi.

Pada saat ini terapis membutuhkan untuk mereview kembali dan mengidentifikasi permasalahan dengan keluarga serta melakukan negosiasi ulang kontrak dan waktu untuk tiap pertemuan. Review ini akan membantu mengenal permasalahan yang masih ada dan tujuan yang ingin dicapai.

Jika keluarga sudah mencapai tujuan yang ditetapkan dan dapat diidentifikasi permasalahan secara spesifik serta sudah teratasi maka saat inilah waktu yang tepat untuk dilakukan fase terminasi. Bagaimanapun, terapis harus mengingat bahwa tidak ada terminasi terapi tanpa ada pengalaman berbagai permasalahan. Pada beberapa keluarga mungkin juga malas untuk mengakhiri terapi karena kekhawatiran akan terjadi disfungsi perilaku keluarga kembali atau bisa juga tergantung dari terapis.

Akan tetapi terminasi harus terjadi. Keluarga harus belajar menyelesaikan masalahnya sendiri secara baik dan terus dikembangkan sehingga menjadi sistem pendukung internal dari keluarga tersebut. Selain itu juga belajar untuk komunikasi terbuka, saling menyayangi dan menyampaikan yang sebenarnya sehingga keluarga mampu menyelesaikan permasalahan rumah mereka tanpa bantuan terapis.

2. Terapi kelompok

Kelompok adalah sekumpulan orang atau individu yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, bergantung serta mempunyai norma yang sesuai. Pengertian lain dari kelompok yaitu beberapa individu yang berkumpul memiliki hubungan antara anggota yang saling bergantung dan memiliki aturan yang berlaku (Stuart & Laraia, 2013). Kelompok juga didefinisikan menurut Varcarolis (2022) sebagai individu dengan jumlah minimal dua atau lebih yang saling melakukan interaktif dalam berhubungan sosial sehingga memungkinkan dapat berbagi tujuan dan masalah dari antar anggota.

Definisi dari terapi kelompok adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang diberikan pada beberapa pasien secara bersama-sama melalui cara diskusi antara anggota kelompok dengan satu pemimpin dalam hal ini berperan sebagai terapis untuk memimpin dan mengarahkan jalannya diskusi. Pengertian lain dari terapi ini yaitu suatu pendekatan psikologi yang diberikan kepada sekumpulan orang bertujuan memberikan stimulasi bagi pasien dengan kerusakan interaksi sosial (Yosep, 2020).

Pentingnya intervensi ini diberikan pada pasien gangguan jiwa dikarenakan adanya gejala positif dan gejala negatif yang dimiliki pasien gangguan jiwa. Gejala positif atau perilaku normal yang berlebihan meliputi waham, halusinasi, perubahan dan pola pikir dan tingkah laku. Gejala negatif atau perilaku normal yang berkurang antara lain afek datar, alogia atau keterbatasan dalam berpikir dan berkomunikasi, kurangnya motivasi atau dorongan untuk mempertahankan perilaku yang sesuai, apatis atau sama dengan masa bodoh, anhedonia atau asosialitas yaitu berkurangnya kemampuan untuk merasakan kenikmatan atau ketidakmampuan menjaga interaksi sosial, defisit perhatian, *blocking*, kerusakan interaksi sosial, berkurangnya kemampuan dalam melakukan hubungan sosial kehidupan.

Tujuan dilakukan terapi kelompok (Suharto, 2009) adalah

a. Individualisasi

- b. Menciptakan kebersamaan dan rasa memiliki antar anggota kelompok (*sense of belonging*)
- c. meningkatkan kemampuan anggota untuk bekerja sama dan terlibat aktif dalam kelompok
- d. memberdayakan potensi anggota untuk turut ambil bagian dalam memberikan pendapat serta keputusan berdasarkan pikiran yang logis, bisa diterima serta rasional mengembangkan kepekaan dan berespon terhadap keberadaan anggota yang lain
- e. Menciptakan iklim sosial yang nyaman dan penuh penerimaan

Adapun bentuk-bentuk dari terapi kelompok (Tomb, 2006) adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok eksplorasi interpersonal

Bentuk kelompok ini merupakan tipe yang paling sering digunakan dan bertujuan meningkatkan penerimaan diri melalui kesadaran diri terhadap pola interaksi sosial yang sedang dijalani dan membutuhkan respon umpan balik serta koreksi dari anggota kelompok yang lain. Pasien merasa diterima di tengah kelompok dan termotivasi untuk mengembangkan kemampuan diri sehingga harga diri pasien meningkat.

- b. Kelompok Bimbingan-Inspirasi

Bentuk kelompok ini berkapasitas anggota kelompok yang besar, terstruktur, kosesif, dengan karakteristik anggotanya memiliki masalah yang sama atau homogenitas problem bertujuan memotivasi serta menonjolkan nilai diskusi dalam kelompok sehingga menimbulkan keterikatan antar anggota atau terjalin persahabatan.

- c. Terapi Berorientasi Psikoanalitik

Bentuk kelompok ini menggunakan tehnik kelompok dengan struktur yang lebih longgar yang mana terapis berperan mengidenifikasi konflik yang terjadi dalam kelompok, mengobservasi interaksi antar anggota kelompok, dan menginterpretasikan ke dalam kelompok.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan terapi kelompok antara lain pengalaman yang dimiliki oleh terapis, sensitivitas atau kepekaan terapis di dalam menanggapi kebutuhan anggota, kehangatan yang diciptakan selama aktivitas terapi berlangsung, kharisma yang dimiliki oleh pemimpin kelompok, dan teori yang digunakan. Konflik dan masalah yang terjadi dalam kelompok membantu meningkatkan kepercayaan diri, sensitifitas, dan keterampilan sosial dari anggota kelompok namun perlu lebih ditekankan pada hubungan timbal balik antar anggota

kelompok dengan difasilitasi oleh terapis. Dengan demikian terapi kelompok dapat secara terus menerus dilakukan tanpa terbatas waktu (Hibbert, 2009).

Tahapan pelaksanaan dari terapi kelompok dibagi ke dalam 5 tahap. Berikut dijelaskan tahap-tahap dari terapi tersebut:

a. Tahap penerimaan (Intake)

Dalam tahap ini dilakukan pengajuan kontrak atau mendapatkan persetujuan berupa komitmen bersama antara terapis dengan pasien untuk kesediaannya terlibat dalam kegiatan kelompok yang bertujuan mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Berdasarkan komitmen tersebut memberikan kesadaran dari terapis maupun pasien untuk mengungkapkan masalah yang dihadapi atau bisa juga masalah tersebut berasal dari hasil observasi terapis yang merupakan hasil telaah situasi.

b. Tahap Perencanaan (Asesmen)

Dalam tahap ini dilakukan beberapa teknis kegiatan yang merupakan peran dari terapis atau pemimpin kelompok bersama anggota untuk mengidentifikasi konflik dan masalah kelompok, tujuan kelompok yang selanjutnya menyusun intervensi sebagai tindakan dalam menyelesaikan masalah.

c. Tahap Seleksi Peserta

Dalam tahap ini dilakukan penyeleksian peserta sebagai calon anggota kelompok yang menjadi indikasi antara lain peserta memiliki masalah yang homogen atau sama dengan peserta lainnya sehingga peserta tersebut memperoleh manfaat terlibat di dalam kelompok. Manfaat tersebut bisa didapatkan dari pengalaman terlibat dalam struktur dan keaktifan dalam kegiatan kelompok.

d. Tahap Pengembangan Kelompok

Dalam tahap ini dijalankan peran dari terapis sebagai pemimpin kelompok yaitu aktif memberikan motivasi serta dukungan kepada anggota kelompok untuk terlibat aktif sehingga mampu mencapai tujuan atau harapan dari kelompok.

e. Tahap Evaluasi dan Terminasi

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan evaluasi yang mana terapis atau pemimpin kelompok mengidentifikasi dan mengukur ketercapaian proses dan hasil dari kegiatan kelompok secara menyeluruh. Berdasarkan pada hasil evaluasi itulah maka tahap terminasi dapat dilakukan.

3. Terapi Lingkungan

Tujuan lingkungan terapeutik (Stuart, 2016) antara lain di bawah ini:

a. Menetapkan batas perilaku yang mengganggu dan maladaptif

b. Mengajarkan keterampilan psikososial

Berikut macam-macam keterampilan psikososial yang perlu diketahui antara lain:

- a. Orientasi merupakan pengetahuan dan pemahaman klien tentang waktu, tempat, orang, dan tujuan
- b. Sikap tegas merupakan kemampuan untuk mengekspresikan diri secara tepat atau efektif menggunakan metode yang sering dilakukan terutama terkait menanggapi isu tertentu dan sudah dibuktikan keefektifannya sehingga bisa diterima/asertif secara sosial
- c. Okupasi merupakan perasaan percaya diri dan prestasi melalui kegiatan yang terus menerus dilakukan
- d. Rekreasi merupakan kemampuan terlibat dan menikmati waktu luang atau menikmati kesenangan dan relaksasi.

Fungsi dari lingkungan yang terapeutik (Stuart, 2016) antara lain:

- a. Pembatasan mengacu pada penyediaan kesejahteraan fisik klien meliputi makanan, tempat tinggal, perawatan medis, seklusi, dan restrain
- b. Dukungan mengacu pada upaya kesadaran staf untuk membantu klien merasa lebih baik dan harga diri mereka meningkat meliputi ruang nyaman (*comfort room*)
- c. Struktur mengacu pada semua aspek lingkungan yang menyediakan pengaturan waktu, tempat, dan orang yang dapat diprediksi meliputi jadwal harian
- d. Keterlibatan mengacu pada proses yang membantu klien untuk secara aktif hadir pada lingkungan sosial mereka dan berinteraksi di dalamnya seperti TAK
- e. Validasi mengacu pada pengakuan individualitas dan nilai dari masing-masing klien

C. Terapi Aktivitas Kelompok

1. Konsep

Manusia sebagai makhluk zoonpoliticon memberikan pengertian bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian namun saling berhubungan sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksudkan adalah kebutuhan sosial antara lain rasa dimiliki oleh orang lain, diakui di antara yang lain, dihargai, dan mampu menyatakan diri sendiri saat bersama yang lain. Kebutuhan sosial di atas menggambarkan model pendekatan kelompok yang secara alamiah manusia dapat hidup berkelompok. Misalnya dalam keluarga dimana antara anggota keluarganya

melakukan hubungan timbal balik. Dengan demikian model pendekatan kelompok inilah sebagai alasan dibutuhkan terapi kelompok yang bisa memberikan dampak positif dan pencegahan kekambuhan bagi klien dengan masalah kejiwaan. TAK yang adalah terapi aktivitas kelompok merupakan model modalitas berbentuk kelompok dengan karakteristik peserta yang homogen dari masalah kesehatan jiwanya, diberikan terapi sehingga antara peserta terapi terjadi hubungan timbal balik dalam memberikan dukungan, edukasi atau informasi kesehatan, kualitas hubungan interpersonal, dan kemampuan mengenal realita. Berdasarkan pernyataan tersebut maka TAK disimpulkan mampu memberikan pengaruh positif dalam mengubah perilaku negative atau maladaptif menjadi positif atau adaptif (Bahrudin et al., 2023).

2. Definisi

Definisi dari terapi aktivitas kelompok yang sering disingkat dengan TAK adalah salah satu bentuk dari terapi modalitas dalam keperawatan jiwa yang dilaksanakan oleh sekelompok perawat dan pasien dengan masalah keperawatan jiwa yang sama (Keliat & Pawirowiyono, 2021).

3. Tujuan

Adapun tujuan dari TAK yang dilakukan dalam pelayanan keperawatan jiwa antara lain:

- a. mengembangkan stimulasi kognitif dengan tipe biblioterapy yang merangsang serta meningkatkan hubungan bersama orang lain menggunakan artikel, sajak, buku, puisi, dan surat kabar.
- b. Meningkatkan stimulasi sensori melalui kegiatan yang dapat mengekspresikan perasaan dengan menggunakan musik, menari, seni dan relaksasi menggunakan teknik relaksasi napas dalam, latihan otot profresif, dan imajinasi.

4. Bentuk-bentuk terapi aktivitas kelompok

Berikut dijelaskan macam-macam TAK (Yusuf et al., 2020):

a. Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Kognitif atau Persepsi

TAK ini merupakan intervensi yang diberikan kepada kelompok pasien dengan indikasi adanya penurunan uji realitas dengan cara memberikan stimulus persepsi melalui pemberian edukasi, motivasi, dan proses berpikir sehingga meminimalkan perilaku maladaptif. Karakteristik dari pasien yang menjadi peserta TAK antara lain gangguan yang berkaitan dengan norma, menarik diri atau isolasi sosial, memiliki ide negatif, tidak ada kelainan fisik maupun ketidakmampuan dalam berkomunikasi.

Tujuan dari TAK stimulasi kognitif atau persepsi meliputi:

- 1) Mengembangkan kemampuan pasien menghadapi realitas
- 2) Mengembangkan kemampuan pasien agar lebih fokus
- 3) Mengembangkan kemampuan intelektual pasien
- 4) Mengembangkan kemampuan pasien dalam mengekspresikan dan menerima pendapat dari orang lain

Dalam pelaksanaannya, TAK stimulasi kognitif atau persepsi terbagi dalam empat sesi antara lain:

- 1) Sesi I: kelompok pasien diarahkan mengenal karakteristik halusinasinya meliputi isi yang mengindikasikan jenis halusinasi, frekuensi munculnya halusinasi, waktu munculnya halusinasi bisa pagi, siang, atau malam, situasi munculnya halusinasi bisa saat pasien sedang sendiri atau sedang bersama orang lain, dan respon pasien terhadap isi halusinasi.
 - 2) Sesi II: kelompok pasien diarahkan pada latihan mengontrol halusinasi meliputi latihan menghardik atau melawan halusinasi dan latihan bercakap-cakap untuk menumbuhkan rasa percaya diri pasien agar berani menyampaikan kepada orang lain tentang episode halusinasinya sehingga tidak ada periode untuk kambuh kembali.
 - 3) Sesi III: kelompok diarahkan pada kegiatan menyusun jadwal aktivitas harian dengan memasukkan latihan mengontrol halusinasi ke dalam jadwal aktivitas harian tersebut.
 - 4) Sesi IV: kelompok dijelaskan cara minum obat yang benar yang diarahkan pada prinsip lima benar meliputi pasien, obat, dosis, cara, dan waktu minum obat.
- b. Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Sensori
- TAK ini adalah terapi yang diberikan kepada sekelompok pasien yang berindikasi adanya penurunan fungsi sensori dengan cara memberikan stimulus sensori seperti suara bisa dengan musik.

5. Komponen kelompok TAK

Berikut dijabarkan komponen dari terapi aktivitas kelompok (Prabowo, 2017):

a. Struktur kelompok

- 1) Pemimpin
- 2) Anggota
- 3) Pemandu kegiatan
- 4) Kesepakatan kelompok

b. Ukuran kelompok

Kapasitas kelompok yaitu 10 – 12 orang

c. Waktu pelaksanaan

- 1) Lama berlangsung adalah 40-50 menit per sesi
- 2) Jumlah sesi disesuaikan dengan tujuan
- 3) Frekuensi satu atau dua kali setiap minggu

d. Komunikasi

- 1) Pemimpin mengamati dan menilai alur komunikasi yang berlangsung selama kegiatan
- 2) Umpan balik diberikan oleh pemimpin sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap dinamika kelompok
- 3) Hambatan, konflik interpersonal, tingkat kompetisi, dan keterlibatan serta keaktifan anggota kelompok diobservasi dan dinilai oleh pemimpin kelompok

e. tugas kelompok

- 1) berperan aktif menjaga berlangsungnya proses dan fungsi kelompok (*maintenance roles*)
- 2) Penyelesaian tugas (*task roles*)
- 3) Peran masing-masing anggota kelompok (*individual roles*) dan distraksi dalam kelompok

f. Potensi kelompok

Potensi kelompok merupakan *personal ability* yang dimiliki masing-masing anggota dalam menunjukkan kontribusi atau keaktifan dalam kelompok. Pemimpin kelompok mengidentifikasi secara individual mana anggota yang aktif mendengar serta yang mampu membuat keputusan.

g. Aturan kelompok

Aturan yang dibuat kelompok untuk mengatur kelompok dengan harapan perilaku kelompok sesuai dengan aturan yang berlaku.

h. Kekohesifan

Kerjasama sama dan menciptakan situasi kondusif selama kegiatan TAK berlangsung. Identifikasi kepuasan anggota kelompok setiap akhir sesi.

6. Langkah pelaksanaan

a. Penyusunan proposal TAK

b. Seleksi anggota kelompok dengan kriteria:

- 1) Sehat jasmani
- 2) Bisa membaca dan menulis
- 3) Masalah kesehatan jiwa yang sama

- 4) Sudah melewati terapi generalis dengan masalah kesehatan jiwa: isolasi sosial, halusinasi, marah, defisit perawatan diri, dan gangguan konsep diri
- c. Laksanakan kegiatan setiap sesi, dimulai dengan menjelaskan tujuan dari sesi yang diikuti, cara pencapaiannya dan bentuk reward bagi anggota kelompok
- d. Evaluasi kelompok secara individual terhadap pencapaian tujuan dari sesi yang dilakukan

7. Evaluasi efektivitas

Efektivitas pelaksanaan TAK berdasarkan hasil riset penelitian yang telah dilakukan.

- a. Hasil riset Manzilina et al (2023) bahwa TAK efektif meningkatkan kemampuan kognitif (p-value: 0,001) dan kemampuan psikomotor (p-value: 0,000) klien halusinasi
- b. Hasil riset Ni Made Sumartyawati et al (2019) bahwa TAK stimulasi persepsi berbeda keefektifitasnya dengan terapi religius dzikir dibuktikan dengan t hitung TAK adalah $3.250 > 1.73406$ dan t hitung $2.449 > 1.73406$ terapi religius pada nilai kemaknaan 0,05 (5%).
- c. Hasil riset Murni Aritonang (2021) bahwa TAKSP signifikan meningkatkan kemampuan mengontrol halusinasi pendengaran dibuktikan dengan uji t dependent didapatkan nilai p adalah 0,01 ($p < 0,05$).
- d. Hasil riset Januarti Isnaeni (2008) bahwa TAK stimulasi persepsi halusinasi signifikan menurunkan kecemasan klien halusinasi pendengaran dibuktikan dengan hasil uji t berpasangan menunjukkan nilai t sebesar 6,859 dengan nilai p 0,000.
- e. Hasil riset Bettina Hearn et al (2025) bahwa terapi kelompok signifikan menurunkan gejala depresi pada remaja

D. Terapi Kognitif-Perilaku Sederhana dalam Praktik Keperawatan Jiwa

Terapi Kognitif Perilaku (*Cognitive Behavioral Therapy*) digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang kronis atau telah lama terjadi. *Cognitive Behavioral Therapy* memberikan pemahaman kepada klien tentang pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah (Beck, 2021). *Cognitive Behavioral Therapy* merupakan suatu pendekatan psikoterapi yang berkriteria aktif, direktif, batasan waktu, teratur, dan berorientasi ke klien untuk mengubah aspek kognitif, emosi, dan tingkah laku.

Terapi kognitif perilaku dipandang sebagai salah satu model psikoterapi yang mengajak klien untuk mengubah dan menentukan perilaku baru melalui modalitas

terapi dimodifikasi dengan teori terkait perilaku sebagai indikasi terhadap asumsi bahwa emosi dan kognitif berperan sebagai penyebab menimbulkan perilaku yang salah. Terapi kognitif perilaku mengindikasikan kerusakan pola pikir sehingga arah dari terapi kognitif perilaku yaitu mengubah distorsi kognitif. Karakteristik dari distorsi kognitif antara lain menyatakan keputusan yang tidak konsisten, *selective abstraction*, *labeling* dan *mislabeled*, serta pola pikir yang tidak sesuai (Gusman Lesmana, 2021).

Terapi perilaku kognitif memiliki prinsip dasar yaitu mengajarkan kepada pasien bahwa kepercayaan dan pemikiran irasional merupakan penyebab dari gangguan emosional serta tingkah laku. Teknik untuk melakukan CBT (Alfeus Manuntung, 2018) antara lain

1. Menata keyakinan atau kepercayaan yang tidak rasional
2. Asertif menerima kondisi emosional sebagai bagian dari diri sendiri yang bisa dipotensikan
3. Latihan aktualisasi diri secara berulang dengan metode *role play* bersama terapis
4. Latihan aktualisasi diri pada situasi yang berbeda-beda
5. Menilai perasaan menggunakan skala ukur

E. Evaluasi hasil Terapi Modalitas Berbasis Evidence-based practice (EBP)

1. Kombinasi terapi musik dengan terapi perilaku kognitif pada klien dengan gejala kecemasan sosial. Kombinasi kedua metode ini terbukti lebih efektif daripada penggunaan terapi perilaku kognitif saja. Lebih lanjut, meta-analisis dari tiga studi lain dengan jelas menunjukkan efektivitas terapi musik dalam mengurangi keparahan gejala depresi pascapersalinan. Efek menguntungkan dari terapi musik juga menangani individu yang terpapar stres berat, yang kemudian mengalami gangguan stres pascatrauma (Andrzej Witusik et al., 2019).
2. Pengalaman perawat jiwa dalam memfasilitasi terapi kelompok konstruktif bagi pasien dengan gangguan suasana hati. Studi ini mengungkapkan bahwa perawat jiwa merasakan bahwa terapi kelompok konstruktif bermanfaat dalam menciptakan ruang aman bagi pasien untuk berbagi dan menghadapi tantangan mereka, sehingga mendorong fungsi optimal di luar lingkungan rumah sakit. Selain itu, terapi kelompok konstruktif mendorong peningkatan keterampilan pribadi dan profesional perawat psikiatri. Pentingnya perawat jiwa dalam merawat pasien dengan gangguan suasana hati dan memastikan pengalaman dan hasil positif bagi pasien (Hester Visagie, 2024).

F. Kesimpulan

Modalitas terapi dalam pelayanan keperawatan jiwa menjadi serangkaian intervensi yang bertujuan meminimalkan perilaku maladaptif atau negatif dan memaksimalkan perilaku adaptif atau positif pasien, dengan memanfaatkan potensi pasien. Pasien diberdayakan untuk mengelola masalah kesehatan mental yang dialami dengan cara meningkatkan kualitas hidup. Modalitas terapi meliputi terapi individu, kelompok, keluarga, lingkungan, biologis, kognitif, okupasi dan rehabilitasi. Penerapan terapi modalitas disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Perawat berperan dalam memilih dan menerapkan terapi serta membimbing pasien dalam proses terapi.

G. Referensi

- Alfeus Manuntung. (2018). *Terapi Perilaku Kognitif Pada Pasien Hipertensi*. Malang: Wineka Media
- Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras. (2019). Music therapy as a complementary form of therapy for mental disorders, *Pol Merkur Lekarski*. 2019 Dec 27;47(282):240-243
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text revision; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
- Beck, J. S. (2021). *Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond* (3rd ed.). New York: The Guilford Press.
- Bettina Hearn, Monica Biscaldi, Reinhold Rauh, Christian Fleischhaker. (2025). Feasibility and effectiveness of a group therapy combining physical activity, surf therapy and cognitive behavioral therapy to treat adolescents with depressive disorders: a pilot study, *Front Psychol*. 2025 Feb 12;16:1426844. doi: 10.3389/fpsyg.2025.1426844. eCollection 2025.
- Bahrudin, Syamsir, Takko Podding, Abd Rahman. (2023). *Keperawatan Jiwa Terapi Aktivitas Kelompok dan Asuhan Keperawatan pasien Perilaku Kekerasan*. Makasar: PT. Nas Media Indonesia
- Gusman Lesmana. (2021). *Teori dan Pendekatan Konseling*. Medan: UMSU Press

- Hester Visagie, Annie Temane, Marie Popgenpoel. (2024). Psychiatric nurses' experiences implementing a model for constructive group therapy in mood disorders, *Curationis* . 2024 Sep 25;47(1):e1-e11. doi: 10.4102/curationis.v47i1.2577.
- Hibbert, P. (2009). *Cognitive behavioural therapy in groups* (1st ed.). Chichester, UK: John Wiley & Sons.
- Januarti Isnaeni, Rahayu Wijayanti, Arif Setyo Upoyo. (2008). Efektivitas Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Persepsi Halusinasi terhadap Penurunan Kecemasan Klien Halusinasi Pendengaran di Ruang Sakuran RSUD Banyumas, *Jurnal Keperawatan Soedirman*, Vol.03(1)
- Keliat, B. A. (2021). *Terapi Aktivitas Kelompok: Konsep dan Aplikasi dalam Keperawatan Jiwa*. Jakarta: EGC.
- Manzilina Hani, Christin Wibowo, Erna Agustina Yudiati. (2023). EFEKTIVITAS TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK DISTRAKSI HALUSINASI PADA KLIEN DENGAN HALUSINASI AUDITORI DI RUMAH PEMULIHAN EFATA PROVINSI JAWA TENGAH, *Jurnal LINK*, 19 (2), 2023, 102 - 106 DOI: 10.31983/link.v19i2.9847
- Murray, C. J. L., Aravkin, A. Y., Zheng, P., Abbafati, C., Abbas, K. M., Abbasi-Kangevari, M., ... & Lopez, A. D. (2020). *Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019*. *The Lancet*, 396(10258), 1223–1249. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30752-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30752-2)
- Murni Aritonang. (2021). EFEKTIFITAS TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK STIMULASI TERHADAP KEMAMPUAN MENGONTROL HALUSINASI PENDENGARAN PADA PASIEN RUANG CEMPAKA DI RSJ PROF. DR. M. ILDREM MEDAN TAHUN 2019, *Jurnal Kesehatan surya Nusantara*, Vol.09(1)
- Ni Made Sumartyawati, I Made Eka Santosa, Ewi Nor Sapria Susanti. (2019). EFEKTIVITAS TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK STIMULASI PERSEPSI DAN TERAPI RELIGIUS TERHADAP FREKUENSI HALUSINASI, *Prina* e-ISSN : 2621-5152 ISSN : 2477-0604 Volume 5 No. 1 2019 | 46-52

- Prabowo, Y. (2017). *Terapi Aktivitas Kelompok: Teori dan Aplikasi dalam Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2022). *Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry* (12th ed.). Wolters Kluwer.
- Shives, L.R. (2012). *Basic concepts of psychiatric-mental health nursing* (8th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Stuart, G. W. (2013). *Principles and practice of psychiatric nursing* (10th ed.). Elsevier Mosby
- Suharto, E. (2009). *Psikologi sosial untuk keperawatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Tomb, D. A. (2006). *Concise guide to group psychotherapy* (2nd ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing
- Varcarolis, E. M., & Halter, M. J. (2022). *Foundations of psychiatric-mental health nursing: A clinical approach* (9th ed.). Elsevier.
- Videbeck, S. L. (2020). *Psychiatric-mental health nursing* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Yosep, I. Y. (2020). *Keperawatan jiwa: Terapi aktivitas kelompok* (Ed. revisi). Bandung: Refika Aditama.
- Yusuf Efendi, Errix Kristian J. (2020). Buku Saku Macam-macam Terapi Keperawatan Jiwa. Guepedia.com, https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Saku_Macam_Macam_Terapi_Keperawatan/
- Zastrow, C. H. (2020). *Introduction to social work and social welfare: Empowering people* (13th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

H. Glosarium

Adaptif:

Kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan atau tuntutan lingkungan dengan perilaku yang tepat dan sehat.

Afek datar:

Penurunan ekspresi emosi yang ditunjukkan melalui wajah atau nada suara, sering ditemukan pada pasien gangguan jiwa seperti skizofrenia.

Alosia:

Keterbatasan dalam berpikir dan berkomunikasi, ditandai oleh bicara yang minim atau sulit mengungkapkan kata-kata.

Anhedonia:

Kehilangan kemampuan untuk merasakan kesenangan atau kebahagiaan terhadap aktivitas yang sebelumnya dianggap menyenangkan.

Antipsikotik:

Golongan obat yang digunakan untuk mengelola gejala psikotik seperti halusinasi dan waham (contoh: haloperidol, promazin, klorpromazin).

Asertif:

Kemampuan mengekspresikan pendapat atau perasaan secara jelas, tepat, dan menghormati orang lain.

Biblioterapi:

Pendekatan terapi yang menggunakan bacaan seperti buku, puisi, atau artikel untuk membantu pemulihan mental pasien.

Cognitive Behavioral Therapy (CBT):

Terapi psikologis yang mengubah pola pikir dan perilaku maladaptif dengan pendekatan aktif, direktif, terstruktur, dan berbatas waktu.

Delusi (Waham):

Keyakinan salah yang dipertahankan secara kuat meskipun bertentangan dengan bukti nyata.

Disorganisasi berpikir:

Gangguan proses berpikir yang menyebabkan pasien tidak dapat menyusun ide atau bicara secara koheren dan logis.

Distorsi kognitif:

Kesalahan atau pola pikir negatif yang menyebabkan interpretasi realitas secara keliru, misalnya generalisasi berlebihan atau melabel diri secara negatif.

Evaluasi keperawatan:

Proses penilaian efektivitas intervensi keperawatan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Gangguan bipolar:

Gangguan jiwa yang ditandai oleh perubahan suasana hati ekstrem antara episode mania dan depresi.

Gangguan psikotik akut:

Gangguan mental yang muncul tiba-tiba dengan gejala psikotik berat berlangsung kurang dari dua minggu.

Gangguan psikotik kronis:

Gangguan mental yang menetap lebih dari satu tahun dengan gejala seperti menarik diri, apatis, halusinasi, dan waham.

Gangguan skizoafektif:

Gangguan yang menggabungkan gejala skizofrenia dengan gangguan mood, seperti mania atau depresi berat.

Gangguan skizofreniform:

Gangguan psikotik dengan gejala serupa skizofrenia tetapi durasinya lebih pendek (1 hingga 6 bulan).

Halusinasi:

Persepsi sensorik palsu yang muncul tanpa rangsangan nyata, seperti mendengar suara atau melihat bayangan yang tidak nyata.

Homeostasis keluarga:

Keseimbangan dalam hubungan antar anggota keluarga yang cenderung dipertahankan meskipun maladaptif.

Isolasi sosial:

Kondisi seseorang menarik diri dan menghindari interaksi sosial dengan lingkungan sekitar.

Komunikasi terapeutik:

Teknik komunikasi yang empatik, suportif, terbuka, dan tidak menghakimi yang digunakan perawat untuk memfasilitasi pemulihan pasien.

Maladaptif:

Perilaku atau respons yang tidak tepat terhadap stres atau perubahan lingkungan, sering menyebabkan gangguan fungsi sehari-hari.

Modalitas terapi:

Berbagai pendekatan terapi keperawatan jiwa untuk membantu pasien mencapai pemulihan dan perubahan perilaku positif.

Okupasi:

Aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan pencapaian pada pasien gangguan jiwa.

Psikosis:

Gangguan jiwa yang ditandai oleh ketidakmampuan menilai realitas secara benar, ditandai oleh halusinasi atau delusi.

Rehabilitasi:

Proses pemulihan keterampilan sosial dan fungsi hidup sehari-hari pasien gangguan jiwa agar kembali mandiri di masyarakat.

Respon adaptif:

Perilaku positif dan sehat dalam menghadapi situasi stres atau perubahan lingkungan.

Respon maladaptif:

Perilaku negatif atau tidak sehat dalam menghadapi stres, yang mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari.

TAK (Terapi Aktivitas Kelompok):

Intervensi keperawatan jiwa berbentuk aktivitas kelompok dengan tujuan mengubah perilaku maladaptif pasien menjadi adaptif.

Terapi keluarga:

Pendekatan psikoterapi yang melibatkan seluruh anggota keluarga untuk menyelesaikan konflik, meningkatkan komunikasi, dan memperbaiki fungsi keluarga secara keseluruhan.

Terapi kelompok:

Pendekatan psikoterapi di mana sekelompok pasien berdiskusi bersama seorang pemimpin untuk mengatasi masalah kejiwaan.

Terapi lingkungan (Milieu Therapy):

Pendekatan terapi yang menciptakan lingkungan terapeutik untuk mendukung perubahan perilaku positif pada pasien.

Terapi spiritual:

Pendekatan yang melibatkan aspek spiritual pasien sebagai bagian dari proses pemulihan kesehatan jiwa.

Validasi lingkungan:

Proses pengakuan terhadap nilai, keunikan, dan perasaan klien dalam lingkungan terapeutik.

CHAPTER 9

KEPERAWATAN JIWA BERBASIS KOMUNITAS

Syaiful, Skep., Ns., MPd., MKes.

A. Pendahuluan/Prolog

Keperawatan jiwa berbasis komunitas merupakan salah satu pendekatan penting dalam upaya meningkatkan kesehatan mental masyarakat secara luas. Pendekatan ini menekankan pemberdayaan komunitas sebagai unit utama dalam memberikan asuhan keperawatan, sehingga intervensi tidak hanya terfokus pada individu, tetapi juga memperhatikan lingkungan sosial yang berperan besar dalam pemulihan dan pencegahan gangguan jiwa. Dalam konteks ini, peran perawat jiwa yang mampu bekerja secara komprehensif dengan pendekatan berbasis bukti atau evidence-based practice (EBP) menjadi sangat krusial. EBP memastikan bahwa asuhan yang diberikan berdasarkan pada bukti ilmiah yang valid dan terbaru, sehingga hasilnya efektif dan berkualitas (Melnik & Fineout-Overholt, 2019).

Asuhan keperawatan jiwa berbasis komunitas adalah proses pemberian pelayanan keperawatan kesehatan jiwa yang dilaksanakan di lingkungan komunitas dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, tenaga kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengkajian yang holistik, intervensi yang tepat sasaran, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan kesehatan mental (Woody, 2016; O'Connell, 2016).

Pentingnya Evidence-Based Practice (EBP) dalam keperawatan jiwa berbasis komunitas bukan hanya meningkatkan kualitas asuhan, tetapi juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan klinis yang didasarkan pada penelitian dan data terkini. Hal ini membantu perawat jiwa untuk memilih intervensi yang paling efektif dan sesuai dengan konteks komunitas serta karakteristik pasien (Townsend, 2014; Melnyk & Fineout-Overholt, 2019). Dengan demikian, EBP memfasilitasi praktik keperawatan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan kesehatan mental masyarakat

B. Konsep Dasar Keperawatan Komunitas

1. Definisi Keperawatan Komunitas

Keperawatan komunitas adalah suatu pendekatan dalam praktik keperawatan yang berfokus pada upaya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dilakukan di lingkungan komunitas. Keperawatan ini menempatkan komunitas sebagai subjek utama yang aktif dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatannya, bukan semata-mata sebagai objek perawatan. Dengan demikian, perawat komunitas berperan sebagai pendidik, fasilitator, advokat, dan pemberdaya dalam mempromosikan kesehatan dan mencegah penyakit (Varcarolis & Halter, 2017; Woody, 2016).

2. Prinsip-Prinsip Dasar Keperawatan Jiwa Berbasis Komunitas

Dalam keperawatan jiwa berbasis komunitas, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Holistik: Memperhatikan berbagai aspek kesehatan pasien jiwa secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.
- b. Partisipatif: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan intervensi kesehatan jiwa.
- c. Berorientasi pada pencegahan : Mengutamakan pencegahan gangguan jiwa melalui edukasi, deteksi dini, serta intervensi yang tepat waktu.
- d. Kolaboratif: Melakukan kerjasama lintas sektor dan berbagai pihak, termasuk keluarga, kader, dan institusi kesehatan.
- e. Berbasis Bukti (EBP) : Setiap tindakan keperawatan didasarkan pada bukti ilmiah yang valid dan praktik yang sudah teruji (Townsend, 2014; Melnyk & Fineout-Overholt, 2019).

3. Model dan Teori yang Mendasari Keperawatan Komunitas

Berbagai model dan teori keperawatan komunitas mendasari praktik keperawatan jiwa berbasis komunitas guna memberikan panduan dalam pelaksanaan asuhan yang efektif. Beberapa model yang sering digunakan antara lain:

- a. Model Health Belief yang menekankan pentingnya persepsi individu dan komunitas dalam mengambil tindakan kesehatan.
- b. Model Transkultural Leininger yang memperhatikan aspek budaya sebagai faktor penting dalam perawatan pasien jiwa di komunitas.
- c. Model Nursing Process yang sistematis mulai dari pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi intervensi keperawatan.

- d. Teori ecological systems yang menunjukkan interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan sosial-dukungan yang mendukung kesehatan jiwa (Sharf, 2016; Woody, 2016).

Dengan pemahaman konsep-konsep dasar ini, perawat jiwa mampu merancang dan melaksanakan asuhan komprehensif yang sesuai dengan karakteristik komunitas dan kebutuhan pasien.

C. Strategi Pengkajian Gangguan Jiwa di Tingkat Komunita

1. Pendekatan dan Metode Pengkajian

Pengkajian gangguan jiwa di tingkat komunitas memerlukan pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Pendekatan yang umum digunakan adalah pendekatan holistik yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Metode pengkajian dapat berupa survei komunitas, wawancara terstruktur dan observasi partisipatif. Penggunaan pendekatan yang partisipatif dimana masyarakat dan tenaga kesehatan bersama-sama melakukan pengkajian dianggap sangat efektif dalam mengidentifikasi masalah kesehatan jiwa yang ada di komunitas (Townsend, 2014; Varcarolis & Halter, 2017).

Metode Pengkajian Gangguan Jiwa di Tingkat Komunitas

a. Survei Komunitas

Survei merupakan metode pengumpulan data kuantitatif yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner atau instrumen standar kepada anggota komunitas. Survei ini berguna untuk mendapatkan gambaran prevalensi gangguan jiwa, faktor risiko, serta kebutuhan layanan kesehatan jiwa secara luas. Metode ini efektif apabila sampel yang dipilih representatif sehingga hasil dapat digeneralisasi ke populasi komunitas (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019).

b. Wawancara Terstruktur dan Semi-Terstruktur

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang memungkinkan pendalaman informasi secara kualitatif.

- 1) Wawancara Terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang sudah ditetapkan sehingga data menjadi komparatif antar subjek.
- 2) Wawancara Semi-Terstruktur memberi fleksibilitas agar narasumber bisa menjelaskan lebih leluasa.

Kedua metode ini penting untuk menggali kondisi psikologis, kebutuhan, dan dinamika sosial penderita serta keluarga dalam komunitas (Townsend, 2014).

c. Observasi Partisipatif

Observasi bukan hanya sekedar melihat, melainkan melibatkan diri dalam aktivitas komunitas untuk mengamati perilaku, interaksi sosial, dan respon komunitas terhadap isu kesehatan jiwa. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih natural dan kontekstual, serta membantu mengidentifikasi tanda-tanda awal gangguan jiwa yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara (Woody, 2016).

d. Focus Group Discussion (FGD)

FGD merupakan diskusi kelompok terarah yang melibatkan anggota komunitas, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan untuk mendapatkan perspektif kolektif tentang masalah kesehatan jiwa. FGD sangat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan komunitas, hambatan dalam pelayanan kesehatan jiwa, dan solusi yang potensial (Varcarolis & Halter, 2017).

e. Penggunaan Alat Skrining Standar

Penggunaan alat skrining yang valid dan reliabel sangat penting untuk mengidentifikasi kasus gangguan jiwa secara dini. Contohnya:

- 1) General Health Questionnaire (GHQ) untuk screening gangguan mental umum.
- 2) MINI International Neuropsychiatric Interview (MINI) yang terstruktur untuk diagnosis gangguan psikiatri.
- 3) Alat ini memudahkan tenaga kesehatan komunitas dalam melakukan penapisan cepat dan membuat rujukan tepat waktu (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019).

Keseluruhan metode ini akan lebih efektif jika dilaksanakan dengan melibatkan komunitas secara aktif — dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan validitas data, tetapi juga menguatkan pemberdayaan komunitas dalam mengelola kesehatan jiwa mereka (Townsend, 2014).

2. Peran Serta Masyarakat dan Tenaga Kesehatan dalam Pengkajian

Keberhasilan pengkajian gangguan jiwa di komunitas sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pengkajian, tetapi juga sebagai mitra yang membantu dalam identifikasi masalah kesehatan jiwa dan pelaksanaan intervensi. Tenaga kesehatan, khususnya perawat jiwa komunitas, bertugas memfasilitasi proses pengkajian, memberikan edukasi, serta membangun kepercayaan dengan masyarakat. Peran kader kesehatan dan tokoh masyarakat juga sangat penting

untuk mengoptimalkan jangkauan dan akurasi data pengkajian (Varcarolis & Halter, 2017; Woody, 2016).

D. Intervensi Keperawatan Komunitas yang Efektif untuk Pasien Gangguan Jiwa

1. Pendekatan Intervensi Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)

Intervensi keperawatan dalam komunitas untuk pasien gangguan jiwa harus didasarkan pada bukti ilmiah yang valid dan relevan, dikenal sebagai Evidence-Based Practice (EBP). Pendekatan EBP mengintegrasikan pengetahuan klinis, keahlian profesional, dan preferensi pasien serta konteks komunitas dalam pengambilan keputusan intervensi (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019). EBP memastikan bahwa tindakan yang dilakukan efektif, sesuai kebutuhan, dan mengurangi risiko kesalahan penanganan. Dalam praktik keperawatan jiwa berbasis komunitas, EBP memperhatikan faktor-faktor lingkungan sosial, budaya, dan sumber daya yang tersedia untuk mengoptimalkan hasil intervensi.

2. Contoh Intervensi Psikososial, Farmakologis dan Rehabilitatif

a. Intervensi Psikososial

Intervensi psikososial berfokus pada dukungan emosional, penguatan kemampuan sosial, edukasi kesehatan jiwa, dan pemberdayaan pasien serta keluarganya. Contohnya meliputi konseling kelompok, terapi kognitif perilaku (CBT), dukungan sebaya (peer support), serta program edukasi mengenai stigma dan kesehatan mental (Townsend, 2014; Varcarolis & Halter, 2017).

b. Intervensi Farmakologis

Farmakoterapi adalah bagian integral dari penanganan gangguan jiwa yang biasanya dilakukan oleh tenaga medis. Perawat komunitas berperan dalam pemantauan kepatuhan pengobatan, edukasi pasien dan keluarganya mengenai efek samping obat, serta deteksi dini masalah terkait penggunaan obat (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019).

c. Intervensi Rehabilitatif

Intervensi rehabilitatif bertujuan meningkatkan fungsi sosial dan produktivitas pasien melalui program Rehabilitasi Psikososial, pelatihan keterampilan hidup (life skills training), dan dukungan kerja/transisi kembali ke masyarakat. Pendekatan ini membantu pasien menyesuaikan diri dengan lingkungan komunitas dan mengurangi risiko kekambuhan (Woody, 2016).

3. Pendekatan Kolaboratif dalam Intervensi

Keberhasilan intervensi keperawatan komunitas sangat bergantung pada pendekatan kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan (perawat, dokter, psikolog), masyarakat, keluarga, dan lembaga sosial. Kolaborasi ini memastikan intervensi komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Peran perawat komunitas adalah sebagai fasilitator dan penghubung antara pasien dengan sistem layanan kesehatan serta komunitas, agar intervensi dapat berjalan optimal dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Varcarolis & Halter, 2017).

E. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesehatan Jiwa dan Strategi Mengatasi dalam

1. Strategi Edukasi yang Efektif untuk Masyarakat

Edukasi kesehatan jiwa bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku positif masyarakat terhadap gangguan jiwa. Strategi edukasi efektif harus adaptif dengan konteks budaya dan sosial komunitas serta memanfaatkan berbagai media komunikasi. Pendekatan partisipatif dan interaktif seperti diskusi kelompok, lokakarya, serta pemanfaatan media sosial terbukti lebih berhasil dibanding penyuluhan satu arah (Jorm, 2012). Penting juga mengembangkan materi yang mudah dipahami dengan bahasa lokal dan visual yang menarik agar semua kalangan dapat mengakses informasi dengan baik (Corrigan et al., 2012).

2. Program Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas Komunitas

Pemberdayaan komunitas di bidang kesehatan jiwa menekankan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengenali tanda gangguan jiwa, melakukan dukungan sosial, dan mengakses layanan kesehatan secara mandiri. Program pelatihan kader kesehatan jiwa, pembentukan kelompok dukungan sebaya, dan pengembangan sistem rujukan komunitas adalah contoh intervensi pemberdayaan yang efektif (Wong et al., 2010). Pendekatan bottom-up ini memperkuat rasa memiliki dan keberlanjutan intervensi kesehatan jiwa berbasis komunitas (Campbell & Jovchelovitch, 2000).

3. Peran Kampanye Kesehatan Mental dan Pengurangan Stigma

Stigma terhadap gangguan jiwa merupakan salah satu hambatan utama akses pelayanan dan pemulihan pasien. Kampanye kesehatan mental yang dirancang untuk menurunkan stigma menggunakan pendekatan edukasi, narasi personal, dan keterlibatan tokoh masyarakat atau selebritas dapat mengubah persepsi negatif menjadi dukungan positif (Thornicroft et al., 2016). Pelibatan media massa dan

digital juga penting untuk menjangkau audiens luas dan membangun budaya keterbukaan serta empati terhadap kesehatan jiwa (Corrigan et al., 2012).

F. Peran Kader dan Keluarga dalam Mendukung Keperawatan Jiwa Berbasis Komunitas

1. Definisi dan Fungsi Kader Kesehatan Jiwa

Kader kesehatan jiwa adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pelatihan khusus untuk mendeteksi, memberikan dukungan awal, dan mengarahkan pasien gangguan jiwa ke layanan kesehatan profesional. Kader berperan sebagai jembatan antara komunitas dan sistem kesehatan, memudahkan akses pelayanan serta memperkuat pengawasan terhadap kondisi pasien di lingkungan sosialnya (Wierenga & Van Bruggen, 2011). Fungsi kader meliputi edukasi masyarakat tentang kesehatan jiwa, pemantauan kondisi pasien, serta pemberian dukungan psiko-sosial yang berkelanjutan (Rahman et al., 2016).

2. Keterlibatan Keluarga sebagai Dukungan Utama

Keluarga memegang peran sentral dalam proses pemulihan pasien gangguan jiwa di komunitas. Keterlibatan keluarga tidak hanya menyediakan dukungan emosional dan sosial, tetapi juga membantu pengawasan terapi dan deteksi dini tanda-tanda kekambuhan (Jansen et al., 2015). Pelibatan keluarga harus meliputi edukasi kesehatan jiwa, pemberdayaan untuk mengelola stres caregiving, serta fasilitasi komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan (Chan & Yu, 2014). Pendekatan ini meningkatkan kualitas hidup pasien dan memperkuat jaringan pendukung sosial di sekitar mereka.

3. Model Kerja Sama antara Kader, Keluarga dan Tenaga Profesional

Model kerja sama yang efektif mengintegrasikan peran kader kesehatan jiwa, keluarga, dan tenaga profesional kesehatan melalui komunikasi yang berkelanjutan dan koordinasi tugas. Kader sebagai ujung tombak di lapangan bertugas melakukan deteksi awal dan intervensi ringan, sementara tenaga profesional memberikan dukungan klinis dan supervisi (Petersen et al., 2011). Keluarga menjadi mitra dalam perawatan harian dan pengambilan keputusan. Model kolaboratif ini meningkatkan efektivitas asuhan keperawatan jiwa berbasis komunitas, memberikan pendekatan holistik yang responsif terhadap kebutuhan pasien (Patel et al., 2010).

G. Simpulan

1. Ringkasan Poin-Poin Utama

Keperawatan jiwa berbasis komunitas merupakan pendekatan yang komprehensif dan holistik dalam menangani gangguan jiwa dengan memberdayakan masyarakat, keluarga, dan tenaga kesehatan. Melalui strategi pengkajian yang melibatkan partisipasi aktif komunitas, intervensi berbasis evidence-based practice, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat, pendekatan ini mampu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan jiwa. Peran kader kesehatan jiwa dan keluarga sebagai pendukung utama, serta model kerja sama yang kolaboratif antara ketiga pihak, terbukti efektif dalam mendukung pemulihan pasien secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

2. Implikasi bagi Praktik Keperawatan Komunitas

Implementasi keperawatan jiwa berbasis komunitas menuntut keterampilan pengkajian yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya, kemampuan intervensi yang berbasis bukti, serta komunikasi efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Perawat komunitas harus mampu berperan sebagai penghubung antara pasien, keluarga, dan sistem kesehatan serta sebagai agen perubahan dalam mengurangi stigma dan meningkatkan literasi kesehatan jiwa di masyarakat. Pendekatan kolaboratif dan pemberdayaan komunitas merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas layanan kesehatan jiwa.

3. Rekomendasi untuk Penelitian dan Pengembangan Ke Depan

Penelitian ke depan disarankan untuk mengembangkan metode pengkajian dan intervensi yang lebih responsif terhadap keragaman budaya dan sumber daya lokal serta mengeksplorasi model-model pemberdayaan komunitas yang inovatif dan adaptif di berbagai setting. Perlu juga peningkatan evaluasi dampak jangka panjang dari intervensi keperawatan komunitas untuk gangguan jiwa serta optimalisasi peran kader dan keluarga dalam mendukung pasien. Pengembangan sumber daya manusia keperawatan jiwa komunitas yang kompeten serta penerapan teknologi digital sebagai alat bantu edukasi dan pemantauan juga menjadi fokus penting dalam pengembangan praktik dan penelitian di masa mendatang.

H. Referensi

- Campbell, C., & Jovchelovitch, S. (2000). Health, community and development: Towards a social psychology of participation. **Journal of Community & Applied Social Psychology**, 10(4), 255-270.
- Chan, S. W., & Yu, D. S. (2014). The psychological distress and caregiving burdens of Chinese family caregivers of patients with schizophrenia. **Community Mental Health Journal**, 50(3), 303-311.
- Corrigan, P. W., Morris, S. B., Michaels, P. J., Rafacz, J. D., & Rüsch, N. (2012). Challenging the public stigma of mental illness: A meta-analysis of outcome studies. **Psychiatric Services**, 63(10), 963–973.
- Jansen, J. E., Gleeson, J., & Killackey, E. (2015). Family involvement in early psychosis intervention services: Barriers and strategies for engagement. **Early Intervention in Psychiatry**, 9(5), 369-374.
- Jorm, A. F. (2012). Mental health literacy: Empowering the community to take action for better mental health. **American Psychologist**, 67(3), 231–243.
- Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare. New York: Wolters Kluwer; 2019.
- O'Connell MJ. Community-Based Mental Health Services. New York: Springer; 2016.
- Patel, V., Belkin, G. S., Chockalingam, A., Cooper, J., Saxena, S., & Unützer, J. (2010). Grand challenges: Integrating mental health services into priority health care platforms. **PLoS Medicine**, 7(5), e1000195.
- Petersen, I., Lund, C., Bhana, A., & Flisher, A. J. (2011). A task shifting approach to primary mental health care for adults in South Africa: Human resource requirements and costs for rural settings. **Health Policy and Planning**, 26(3), 220-231.
- Rahman, A., Malik, A., Sikander, S., Roberts, C., & Creed, F. (2016). Cognitive behaviour therapy-based intervention by community health workers for mothers with depression and their infants in rural Pakistan: A cluster-randomised controlled trial. **The Lancet**, 372(9642), 902-909.

- Sharf, R. S. (2016). **Theories of Psychotherapy & Counseling: Concepts and Cases**. Cengage Learning.
- Thornicroft, G., Mehta, N., Clement, S., Evans-Lacko, S., Doherty, M., Rose, D., ... & Henderson, C. (2016). Evidence for effective interventions to reduce mental-health-related stigma and discrimination. **The Lancet**, 387(10023), 1123-1132.
- Townsend MC. *Psychiatric Nursing: Contemporary Practice*. Philadelphia: F.A. Davis Company; 2014.
- Townsend, M. C. (2014). **Psychiatric Nursing: Contemporary Practice**. F.A. Davis Company.
- Varcarolis EM, Halter MJ. *Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing*. St. Louis: Elsevier; 2017.
- Varcarolis, E. M., & Halter, M. J. (2017). **Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing**. Elsevier.
- Wierenga, A., & Van Bruggen, S. (2011). Community mental health care in low- and middle-income countries. **Global Mental Health**, 2, e6.
- Wong, S. T., Powis, B. E., Stewart, D. E., & Cabo, R. (2010). Core competencies for mental health practice in community settings. **Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing**, 17(4), 316-324.
- Woody RH. *Community Mental Health: A Handbook for Professionals*. New York: Routledge; 2016.
- Woody, R. H. (2016). **Community Mental Health: A Handbook for Professionals**. RoutledgeRoutledge

I. Glosarium

EBP (Evidence-Based Practice): Pendekatan keperawatan yang menggabungkan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, dan nilai-nilai pasien.

RBM (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat): Model pemulihan bagi pasien dengan gangguan jiwa yang dilaksanakan di lingkungan komunitas.

ACT (Assertive Community Treatment): Intervensi berbasis tim yang proaktif, untuk mendukung pasien gangguan jiwa kronis di komunitas.

CMHT (Community Mental Health Team): Tim multidisiplin untuk perawatan kesehatan jiwa berbasis komunitas.

Stigma: Label negatif terhadap individu dengan gangguan jiwa yang dapat menyebabkan diskriminasi dan isolasi sosial.

PROFIL PENULIS



Ns. Mutianingsih, M.Kep Lahir di Kuningan, 10 desember 1988 dan merupakan staff pengajar di Akepr RS Efarina. Penulis merupakan lulusan Sarjana Keperawatan dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran tahun 2011 dan menyelesaikan Pendidikan Profesi Ners dari kampus yang sama pada tahun 2012. Penulis melanjutkan Pendidikan magister pada tahun 2017 di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia peminatan Keperawatan Jiwa dan lulus pada tahun 2019.

Penulis saat ini aktif sebagai staff pengajar di Akper RS Efarina dan mengampu mata Kuliah Keperawatan Jiwa, Keperawatan Gerontik dan Keperawatan Keluarga. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, dan publikasi ilmiah baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi.

PROFIL PENULIS



Wittin Khairani, S.Pd., M.P.H. Lahir di Jambi, 21 Nov 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu diawali dari jenjang Pendidikan D3 Keperawatan (1993), dilanjutkan jenjang S1 pada Program Studi Administrasi/Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Padang tahun (2000). Kemudian melanjutkan pendidikan S2 tahun (2007), pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan: Perilaku dan Promosi Kesehatan dan lulus tahun pada tahun 2009. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1993 (**Staf pengajar Tetap pada SPK Kesdam II Sriwijaya Sumsel-Jambi (1993-1998), Staf Yankes di Dinas Kesehatan Propinsi Jambi (1998-1999), Dosen Tetap pada Poltekkes Kemenkes Bandar Lampung (1999-2002), Dosen Tetap pada STIKES Harapan Ibu, Jambi (2010-2016), Dosen Tetap Poltekkes Kemenkes Jambi (2002-2021), Dosen Tetap Poltekkes Kemenkes Yogyakarta (2021-sekarang).** Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Perawatan Jiwa, Psikologi, Komunikasi, Pemberdayaan Masyarakat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri-Dharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku dengan judul: Bebas Pasung pada ODGJ (2021), Publikasi Nasional 5 tahun terakhir, sebagai berikut : Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok Dengan Stimulasi Persepsi Terhadap Kemampuan Mengontrol Halusinasi Pada Pasien Skizofrenia (2019), Pengaruh Therapi Kognitif Behavior Terhadap Perilaku Merokok: Kajian (2019), Daya Tilik Diri (Self Insight), Harga Diri (Self Esteem) dan Stigma Diri (Self Stigma) serta kualitas hidup Pasien Skizofrenia di Klinik Jiwa RS Jiwa Daerah Jambi (2020), Pengaruh Peran Keluarga Dalam Pencegahan dan Penanganan Perilaku Agresif Pre-Hospital Pada Orang Dengan Kelainan Jiwa (2022), Hubungan Spiritualitas dengan Tingkat Kecemasan Menghadapi Masa Tua pada Lansia di Panti Sosial Tresna Wedha (2023), Pengaruh Peran Keluarga dengan Intervensi Manajemen Kesehatan diri efektif terhadap Pencegahan Komplikasi Pada Pasien Hypertensi (2023), Pengaruh Social Support Dengan Peer Leader Untuk meningkatkan Self Management Diabetic Pada Sesama Penderita DM Tipe II di Posyandu Lansia (2023) dan Publikasi Internasional dengan judul : The Effect Of Self- Management Intervention On Behavioral Intention Among Woman Passive Smokers (2021), seminar, yang diikuti sebagai berikut: Update Kegawatdaruratan pada Pasien Psikiatri, Pencegahan dan Tatalaksana Resiko Bunuh Diri Pada ODGJ dan Pasien Kronis, Workshop Gerakan Sejuta Soal VI, AIPIVIKI. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: khairaniwittin@gmail.com

Motto: **"Happiness is not by chance but by choice"**

PROFIL PENULIS



Dr. Abdul Ghofur, SKp.M.Kes. Lahir di Kendal, 10 Januari 1971. Pendidikan tertinggi yang telah di tempuh yaitu PSIK-FKUI tahun 1995, Magister Kesehatan di FKMK-UGM 2024, Doktor Keperawatan di FKMK UGM 2020. Riwayat pekerjaan diawali menjadi Dosen Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dari tahun 2000. Saat ini penulis menjadi Dosen Keperawatan jiwa untuk Prodi DIII dan DIV keperawatan, Mengajar Metodologi penelitian dan Statistik Kesehatan, mengajar evidence base nursing (EBN) di Prodi DIV keperawatan, mengajar evidence base practice (EBP) di Prodi Diploma III Keperawatan. Saat ini penulis aktif sebagai reviewer nasional untuk penelitian dan pengabmas untuk Poltekkes Kemenkes. Menjadi peneliti di bidang keilmuan keperawatan jiwa dan perawatan dasar. pada tahun dari tahun 2003- saat ini Penulis menjadi editor di beberapa jurnal di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, menjadi reviewer penelitian internal maupun eksternal melalui simlibtakes, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:abdghofur1071@gmail.com.



Deasti Nurmaguphita Lahir di Bantul, Yogyakarta. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Keperawatan Jiwa di Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2014. Serta melanjutkan jenjang Spesialis Keperawatan Jiwa di Universitas Indonesia dan menyelesaikan studi pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 menjadi Koordinator Alumni dan Pengembangan Karier, Sekretaris program studi keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners serta menjadi Ketua Program studi keperawatan sampai dengan tahun 2024. Saat Ini penulis bekerja Di Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan workshop. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: deastinurma@unisayogya.ac.id

PROFIL PENULIS



Tsuwaibatul Islamiyah, S. Kep., Ns., M.S Lahir di Nganjuk, 14 April 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi pada tahun 2011 di Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2019 di National Cheng Kung University Taiwan dan lulus pada tahun 2021 dengan konsentrasi topik terkait Kesehatan Jiwa pada Remaja. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan dari tahun 2024 – sekarang, di Departemen Keperawatan Jiwa. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui email: tsuwaibatul@ulm.ac.id

Motto: *"A healthy mind is the foundation of a meaningful life—spreading positivity and good vibes only"*



Retno Puji Astuti, S. Kep., Ns., M. Kep

Lahir di Banyuwangi, 20 Mei 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh adalah jenjang S1 Keperawatan di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan tahap Profesi Ners di Universitas Jember Tahun 2016. Tahun 2018, penulis melanjutkan jenjang pendidikan S2 Keperawatan di Universitas Airlangga. Saat ini penulis bekerja di STIKes Rajekwesi Bojonegoro mengampu mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia dan Keperawatan Psikiatri. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ayapujib@gmail.com.

Motto: "proses paling utama, nilai itu bonus"

PROFIL PENULIS



Balbina Antonelda Marled Wawo, Ns., M.Kep., Sp.Kep.J Lahir di Ende, Flores Nusa Tenggara Timur, 13 Juni 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Denpasar Bali tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan profesi Ners Spesialis pada Program Studi Pascasarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 di Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Citra Bangsa Kupang. Saat ini penulis bekerja di Universitas

Kristen Indonesia khususnya pada Program Studi Keperawatan Fakultas Vokasi dan mengampu mata kuliah keperawatan jiwa, praktik klinik keperawatan jiwa, komunikasi, psikologi, etika dan hukum kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis dan editor buku, publikasi, seminar, dan peneliti. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: balbina.antonelda@uki.ac.id

Motto: "Living your life well"



Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes. Lahir di kota Bima-NTB, , 23 Mei 1968, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Adibwana Surabaya dengan gelar M.Pd pada tahun 2009 sedangkan gelar M.Kes diraih pada universitas Badaruddin Lombok Tengah NTB lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 Prodi Keperawatan Bima Akper Depkes Mataram NTB sampai saat ini sudah dikonversi menjadi Poltekkes Kememkes Mataram. Saat ini

penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Mataram-NTB mengampu mata kuliah Metodologi penelitian, Konsep Dasar Keperawatan, Manajemen Keperawatan, Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Keluarga/Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi Ilmiah, nara sumber berbagai seminar dan workshop, dll, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: syaiful6823mpd@gmail.com

Motto: Belajar Bukan Sekedar Menghafal, Tetapi Melalui Pengalaman Dan Pemahaman Mendalam (Albert Einstein).

Sinopsis

Buku "Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Jiwa Komprehensif: Pendekatan Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)" disusun sebagai sumber referensi utama yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa yang menyeluruh dan berbasis bukti ilmiah. Buku ini sangat relevan bagi perawat, mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi kesehatan jiwa, dan berbagai pihak yang berkecimpung dalam bidang kesehatan mental.

Setiap bab dalam buku ini menghadirkan pembahasan mendalam terkait konsep-konsep dasar, pendekatan klinis, serta intervensi praktis dalam keperawatan jiwa. Materi yang disajikan didukung oleh hasil penelitian terbaru dan rekomendasi praktik klinis yang telah terbukti efektif, sehingga dapat menjadi acuan yang dapat diimplementasikan secara langsung dalam situasi klinis sehari-hari. Buku ini mengulas secara sistematis tahapan asuhan keperawatan jiwa, mulai dari pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi hasil intervensi.

Buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus nyata yang memberikan gambaran jelas tentang penerapan teori ke dalam praktik nyata. Selain itu, buku ini secara khusus membahas tantangan yang dihadapi dalam praktik keperawatan jiwa, termasuk strategi efektif untuk mengatasi tantangan tersebut melalui pendekatan evidence-based practice. Pentingnya kemampuan perawat dalam memberikan dukungan emosional, psikososial, dan terapeutik yang sensitif terhadap kebutuhan pasien dan keluarganya juga mendapat perhatian khusus dalam buku ini.

Diharapkan, buku ini mampu berperan penting dalam mendorong peningkatan kualitas asuhan keperawatan jiwa, membantu perawat dalam mengembangkan kompetensi klinis dan interprofesional, serta memperkuat komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarganya. Dengan pendekatan berbasis bukti ini, buku ini bertujuan menciptakan praktik keperawatan jiwa yang lebih aman, efektif, dan berorientasi pada hasil terbaik bagi pasien dan komunitas. Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi acuan penting yang mendukung peningkatan standar pelayanan kesehatan mental di Indonesia secara komprehensif dan berkelanjutan.

Buku "Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Jiwa Komprehensif: Pendekatan Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)" disusun sebagai sumber referensi utama yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa yang menyeluruh dan berbasis bukti ilmiah. Buku ini sangat relevan bagi perawat, mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi kesehatan jiwa, dan berbagai pihak yang berkecimpung dalam bidang kesehatan mental.

Setiap bab dalam buku ini menghadirkan pembahasan mendalam terkait konsep-konsep dasar, pendekatan klinis, serta intervensi praktis dalam keperawatan jiwa. Materi yang disajikan didukung oleh hasil penelitian terbaru dan rekomendasi praktik klinis yang telah terbukti efektif, sehingga dapat menjadi acuan yang dapat diimplementasikan secara langsung dalam situasi klinis sehari-hari. Buku ini mengulas secara sistematis tahapan asuhan keperawatan jiwa, mulai dari pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi hasil intervensi.

Buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus nyata yang memberikan gambaran jelas tentang penerapan teori ke dalam praktik nyata. Selain itu, buku ini secara khusus membahas tantangan yang dihadapi dalam praktik keperawatan jiwa, termasuk strategi efektif untuk mengatasi tantangan tersebut melalui pendekatan evidence-based practice. Pentingnya kemampuan perawat dalam memberikan dukungan emosional, psikososial, dan terapeutik yang sensitif terhadap kebutuhan pasien dan keluarganya juga mendapat perhatian khusus dalam buku ini. Diharapkan, buku ini mampu berperan penting dalam mendorong peningkatan kualitas asuhan keperawatan jiwa, membantu perawat dalam mengembangkan kompetensi klinis dan interprofesional, serta memperkuat komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarganya. Dengan pendekatan berbasis bukti ini, buku ini bertujuan menciptakan praktik keperawatan jiwa yang lebih aman, efektif, dan berorientasi pada hasil terbaik bagi pasien dan komunitas. Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi acuan penting yang mendukung peningkatan standar pelayanan kesehatan mental di Indonesia secara komprehensif dan berkelanjutan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

